

ΟΙ

100

ΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πλήρης έκδοση 100 ερωτήσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι 100 ερωτήσεις

Q1	Πώς προσεγγίζετε έναν νέο ψυχιατρικό ασθενή και πώς οργανώνετε την αρχική εκτίμηση;	1
Q2	Πώς διακρίνετε μια παραληρητική ιδέα, μια υπερτιμημένη ιδέα και μια ιδεοληψία;	4
Q3	Όταν εμφανίζονται ψυχιατρικά συμπτώματα για πρώτη φορά, πότε πρέπει να υποψιαστείτε ιατρικό, νευρολογικό, φαρμακευτικό ή σχετιζόμενο με ουσίες αίτιο;	6
Q4	Πώς εκτιμάτε την αυτοκτονική πρόθεση και τον άμεσο κίνδυνο αυτοκτονίας;	8
Q5	Ένας ασθενής επέζησε από απόπειρα αυτοκτονίας. Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο επανάληψης;	10
Q6	Πώς εκτιμάτε τον κίνδυνο βίας ή επιθετικότητας;	12
Q7	Πώς αντιμετωπίζετε τη σοβαρή διέγερση στα επείγοντα;	14
Q8	Πώς εκτιμάτε αν ένας ασθενής μπορεί να δώσει έγκυρη ενημερωμένη συναίνεση;	16
Q9	Πότε μπορεί ένας ασθενής να νοσηλευτεί ακούσια στην Ελλάδα και ποια είναι η διαδικασία;	18
Q10	Πώς αναγνωρίζετε την κατατονία και πώς την αντιμετωπίζετε;	21
Q11	Ασθενής 23 ετών προσέρχεται με διωκτικές ιδέες, ακουστικές ψευδαισθήσεις και κοινωνική απόσυρση. Πώς προσεγγίζετε το περιστατικό;	24
Q12	Περιγράψτε την κλινική εικόνα και τη διάγνωση της σχιζοφρένειας.	27
Q13	Πώς διακρίνετε τη σχιζοφρένεια από τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και τη διαταραχή διάθεσης με ψυχωσικά χαρακτηριστικά;	30
Q14	Τι γνωρίζουμε για τη νευροβιολογία της σχιζοφρένειας;	32
Q15	Τι καθορίζει την πρόγνωση στη σχιζοφρένεια;	35
Q16	Πώς αντιμετωπίζετε ένα οξύ επεισόδιο σχιζοφρένειας;	38
Q17	Πώς αντιμετωπίζετε τη σχιζοφρένεια μακροχρόνια;	40
Q18	Πότε χαρακτηρίζετε τη σχιζοφρένεια ως ανθεκτική στη θεραπεία και τι πρέπει να αποκλείσετε πρώτα;	43
Q19	Μιλήστε μου για την κλοζαπίνη: ενδείξεις, κύριοι κίνδυνοι και παρακολούθηση.	45
Q20	Ποια είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά, η διάγνωση και οι σημαντικές διαφορικές διαγνώσεις της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής;	48
Q21	Πώς αντιμετωπίζετε ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο;	51
Q22	Πώς αντιμετωπίζετε την ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη;	54
Q23	Πώς διαγιγνώσκετε τη διπολική διαταραχή και πώς τη διαφοροδιαγιγνώσκετε από σημαντικές εναλλακτικές διαγνώσεις;	57
Q24	Πώς αντιμετωπίζετε την οξεία μανία;	60
Q25	Πώς αντιμετωπίζετε τη διπολική κατάθλιψη;	63
Q26	Πώς διαχειρίζεστε μακροχρόνια τη διπολική διαταραχή;	66
Q27	Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε την επιλόχεια ψύχωση;	69
Q28	Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή πανικού και την αγοραφοβία;	72
Q29	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή;	74
Q30	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή κοινωνικού άγχους;	76
Q31	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή;	79
Q32	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή μετατραυματικού στρες;	82
Q33	Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την οξεία διαταραχή στρες από τη διαταραχή προσαρμογής;	85
Q34	Ποιες είναι οι κύριες διασχιστικές διαταραχές και πώς τις αξιολογείτε;	87

Q35	Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε τη διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων από τη διαταραχή άγχους ασθένειας;	90
Q36	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη λειτουργική νευρολογική διαταραχή;	92
Q37	Πώς αξιολογείτε και πώς διατυπώνετε μια διαταραχή χρήσης ουσιών;	95
Q38	Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη στέρηση αλκοόλ;	98
Q39	Πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης αλκοόλ μετά τη στέρηση;	101
Q40	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης οπιοειδών;	104
Q41	Ποια ψυχιατρικά σύνδρομα σχετιζόμενα με την κάνναβη πρέπει να αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης κάνναβης;	107
Q42	Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τις διαταραχές που σχετίζονται με διεγερτικά;	110
Q43	Πώς αντιμετωπίζετε την εξάρτηση και τη στέρηση από βενζοδιαζεπίνες;	112
Q44	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή τυχερών παιχνιδιών;	114
Q45	Πώς αναγνωρίζετε, πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε το ντελίριο;	116
Q46	Πώς αξιολογείτε έναν ασθενή με υποψία μείζονος νευρογενετικής διαταραχής / άνοιας;	119
Q47	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη νόσο Alzheimer;	122
Q48	Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την άνοια με σωματίδια Lewy από την άνοια στη νόσο Parkinson;	125
Q49	Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη μετωποκροταφική άνοια;	128
Q50	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε την αγγειακή γνωστική διαταραχή / αγγειακή άνοια;	130
Q51	Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα της άνοιας (BPSD);	132
Q52	Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε τη σοβαρή παραμέληση εαυτού ή τις συνθήκες ρυπαρότητας όταν ο ασθενής αρνείται βοήθεια;	135
Q53	Πότε πρέπει να υποψιαστείτε αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα σε μια ψυχιατρική εικόνα και τι κάνετε;	138
Q54	Ποια ψυχιατρικά προβλήματα συνδέονται με την επιληψία και πώς τα προσεγγίζετε;	141
Q55	Ποιες ψυχιατρικές και συμπεριφορικές συνέπειες μπορεί να ακολουθήσουν μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση;	144
Q56	Πώς προσεγγίζετε μια εκτίμηση διασυνδετικής ψυχιατρικής σε νοσηλευόμενο σωματικά πάσχοντα ασθενή;	147
Q57	Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την απάθεια από την κατάθλιψη;	150
Q58	Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε το σύνδρομο Charles Bonnet από την ψύχωση, το ντελίριο και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα;	152
Q59	Πώς διαγιγνώσκετε τη ΔΕΠ-Υ ενηλίκων και πώς τη διαφοροδιαγιγνώσκετε από συχνές μιμητικές καταστάσεις;	154
Q60	Πώς αξιολογείτε τον αυτισμό σε έναν ενήλικα;	157
Q61	Πώς αξιολογείτε νέα ψυχιατρικά ή συμπεριφορικά συμπτώματα σε ενήλικα με διαταραχή διανοητικής ανάπτυξης;	159
Q62	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε την ψυχογενή ανορεξία;	162
Q63	Πώς αντιμετωπίζετε την ψυχογενή ανορεξία με σοβαρή σωματική επιβάρυνση;	165
Q64	Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε την ψυχογενή βουλιμία;	168
Q65	Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε τη χρόνια αϋπνία;	170
Q66	Πώς αξιολογείτε την υπερβολική ημερήσια υπνηλία και πώς αναγνωρίζετε τη ναρκοληψία;	173
Q67	Ποια είναι τα κύρια στάδια του ύπνου και ποια τα χαρακτηριστικά τους στο ΗΕΓ;	176
Q68	Πώς ταξινομείτε και πώς διατυπώνετε μια διαταραχή προσωπικότητας;	178

Q69	Πώς αντιμετωπίζετε την οριακή διαταραχή προσωπικότητας (BPD);	181
Q70	Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας από την ψυχοπάθεια;	184
Q71	Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε τη σεξουαλική δυσλειτουργία;	186
Q72	Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε μια παραφιλική διαταραχή και τον σχετιζόμενο κίνδυνο;	189
Q73	Πώς προσεγγίζετε τη δυσφορία φύλου ή την ασυμβατότητα φύλου σε έναν ενήλικα;	192
Q74	Ποιες βασικές φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές αρχές έχουν σημασία στην ψυχοφαρμακολογία;	195
Q75	Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλληλεπιδράσεις ψυχοτρόπων φαρμάκων;	198
Q76	Πώς επιλέγετε ένα αντιψυχωσικό;	201
Q77	Ποιες εξωπυραμидικές ανεπιθύμητες ενέργειες προκαλούν τα αντιψυχωσικά και πώς τις αντιμετωπίζετε;	203
Q78	Ποιες μεταβολικές, ενδοκρινικές και καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιψυχωσικών πρέπει να παρακολουθείτε;	206
Q79	Πώς επιλέγετε ένα αντικαταθλιπτικό;	208
Q80	Ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις των αντικαταθλιπτικών έχουν σημασία και πώς τα αλλάζετε ή τα διακόπτετε με ασφάλεια;	211
Q81	Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη συνταγογράφηση και την παρακολούθηση του λιθίου;	213
Q82	Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το βαλπροϊκό στην ψυχιατρική;	216
Q83	Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη λαμοτριγίνη στη διπολική διαταραχή;	219
Q84	Ποιες είναι οι βασικές αρχές για τη συνταγογράφηση βενζοδιαζεπινών και υπνωτικών;	221
Q85	Πώς χρησιμοποιείτε φαρμακευτική αγωγή στη ΔΕΠ-Υ ενηλίκων;	223
Q86	Πώς προσεγγίζετε την ψυχοφαρμακολογία στην εγκυμοσύνη και στην αναπαραγωγική περίοδο;	226
Q87	Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο και το σεροτονινεργικό σύνδρομο;	229
Q88	Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε την υπερδοσολογία τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών;	231
Q89	Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την ηλεκτροσπασμοθεραπεία;	233
Q90	Τι είναι η CBT και πώς χρησιμοποιείται στην ψυχιατρική;	236
Q91	Τι είναι η μεταβίβαση και η αντιμεταβίβαση και γιατί έχουν κλινική σημασία;	238
Q92	Τι είναι η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία και πότε είναι χρήσιμη;	241
Q93	Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση και πώς βελτιώνει την ψυχιατρική θεραπεία;	243
Q94	Ποια μετωποϋποφλοιώδη και μεταιχμιακά κυκλώματα είναι σημαντικότερα για την ψυχιατρική;	245
Q95	Ποιες είναι οι κύριες ντοπαμινεργικές οδοί και ποια είναι η κλινική τους σημασία;	247
Q96	Τι σημαίνουν η κληρονομησιμότητα, ο οικογενειακός κίνδυνος και ο πολυγονιδιακός κίνδυνος στην ψυχιατρική;	249
Q97	Πώς αξιολογείτε κριτικά μια ψυχιατρική μελέτη και αποφασίζετε αν πρέπει να αλλάξει την κλινική πρακτική;	251
Q98	Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ψυχιάτρου ως προς το ιατρικό απόρρητο στην Ελλάδα;	253
Q99	Πώς προσεγγίζει το ελληνικό δίκαιο τον ποινικό καταλογισμό και πώς διαφέρει αυτό από την κλινική ψυχιατρική εκτίμηση;	257
Q100	Ποιες είναι οι αρχές της κοινοτικής φροντίδας για ενήλικες με σοβαρή ψυχική νόσο;	260

Πώς προσεγγίζετε έναν νέο ψυχιατρικό ασθενή και πώς οργανώνετε την αρχική εκτίμηση;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ασφάλεια και πλαίσιο εξέτασης
- 2 Αιτία προσέλευσης και διαχρονικό ιστορικό
- 3 Ετεροαναφορικές πληροφορίες και αξιοπιστία
- 4 Εξέταση παρούσας ψυχικής κατάστασης
- 5 Σωματική/νευρολογική εξέταση και στοχευμένος παρακλινικός έλεγχος
- 6 Ρητή εκτίμηση κινδύνου
- 7 Διατύπωση περίπτωσης, διαφορική διάγνωση και πλάνο

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αρχική ψυχιατρική εκτίμηση έχει τρεις αλληλένδετους στόχους: να αναγνωρίσω το σύνδρομο και τη διαφορική διάγνωση, να κατανοήσω γιατί το συγκεκριμένο πρόβλημα εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο άτομο αυτή τη χρονική στιγμή και να δημιουργήσω μια θεραπευτική σχέση που θα επιτρέψει να προχωρήσουν η αξιολόγηση και η θεραπεία. Η εκτίμηση πρέπει να είναι δομημένη, αλλά να καθοδηγείται από κλινικές υποθέσεις, με την ασφάλεια να εξετάζεται από την αρχή και με τελική σύνθεση των ευρημάτων, όχι απλή απαρίθμηση ασύνδετων στοιχείων.

Πρώτα εκτιμώ αν υπάρχει **άμεσο επείγον ζήτημα** που αλλάζει το πλαίσιο ή τον ρυθμό της εξέτασης: κίνδυνος για τον εαυτό ή άλλους, σοβαρή διέγερση, αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, τοξίκωση ή σύνδρομο στέρησης, ντελίριο ή ιατρική αστάθεια. Αν χρειάζεται άμεση προστασία ή ιατρική αντιμετώπιση, αυτή προηγείται, ενώ η ψυχιατρική εκτίμηση συνεχίζεται παράλληλα.

Το ιστορικό αρχίζει από την **αιτία προσέλευσης και το ιστορικό του τρέχοντος προβλήματος**: έναρξη, πορεία, βαρύτητα, διακυμάνσεις, εκλυτικά γεγονότα και επίδραση στη λειτουργικότητα. Στη συνέχεια λαμβάνω προηγούμενο ψυχιατρικό ιστορικό, ιατρικό και νευρολογικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή —συμπεριλαμβανομένων μη συνταγογραφούμενων ή άλλων σκευασμάτων—, χρήση ουσιών, οικογενειακό ιστορικό και το σχετικό αναπτυξιακό, ατομικό, κοινωνικό, επαγγελματικό και διαπροσωπικό ιστορικό. Δικαστικό ή ποινικό ιστορικό λαμβάνεται όταν είναι κλινικά σχετικό. Σε όλη τη διάρκεια ελέγχω υποθέσεις και δεν συλλέγω απλώς συμπτώματα· η απουσία ενός αναμενόμενου χαρακτηριστικού μπορεί να είναι εξίσου πληροφοριακή με την παρουσία του.

Οι **ετεροαναφορικές πληροφορίες** είναι συχνά απαραίτητες. Τις αναζητώ ιδιαίτερα όταν η εναισθησία, η γνωστική λειτουργία, η αξιοπιστία της αφήγησης ή ο κίνδυνος είναι αβέβαια, επειδή ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να μην αποτυπώνει πλήρως μεταβολές στη συμπεριφορά, επιδείνωση της λειτουργικότητας ή πρόσφατη επικίνδυνη συμπεριφορά.

Η **εξέταση παρούσας ψυχικής κατάστασης** δίνει την εγκάρσια εικόνα. Την οργανώνω σε εμφάνιση και συμπεριφορά, ομιλία, διάθεση και συναίσθημα, μορφή

και περιεχόμενο της σκέψης, αντίληψη, γνωστικές λειτουργίες και εναισθησία. Τα ευρήματα ερμηνεύονται φαινομενολογικά και μέσα στο κλινικό τους πλαίσιο· δεν μετατρέπονται αυτομάτως σε διαγνώσεις.

Η ψυχιατρική εκτίμηση περιλαμβάνει και τη σωματική υγεία. Η **σωματική και νευρολογική εξέταση** είναι αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης, ιδίως σε πρώτη εμφάνιση, σε άτυπη κλινική εικόνα ή όταν υποψιάζομαι δευτεροπαθή αιτία. Ο παρακλινικός έλεγχος πρέπει να καθοδηγείται από το ιστορικό και την εξέταση και όχι να εφαρμόζεται το ίδιο, μη στοχευμένο πακέτο εξετάσεων σε κάθε ψυχιατρικό ασθενή.

Πάντοτε κάνω την **εκτίμηση κινδύνου ρητή**: αυτοκτονία και αυτοτραυματισμός, βία ή επιθετικότητα, ευαλωτότητα, αυτοπαραμέληση και οποιοδήποτε άλλο άμεσο ζήτημα ασφάλειας σχετίζεται με την κλινική εικόνα. Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να οδηγεί άμεσα στο πλάνο αντιμετώπισης.

Τέλος, συνθέτω τις πληροφορίες σε **λίστα προβλημάτων, διαφορική διάγνωση και διατύπωση περίπτωσης (formulation)**. Η διατύπωση συνδέει προδιαθεσικούς, εκλυτικούς και διαιωνιστικούς βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, μαζί με προστατευτικούς παράγοντες και την τρέχουσα λειτουργικότητα. Από αυτήν προκύπτουν το άμεσο θεραπευτικό πλάνο, ο περαιτέρω έλεγχος που χρειάζεται, η παρακολούθηση και μια προκαταρκτική εκτίμηση της πρόγνωσης. Η διαδικασία είναι επαναληπτική: όσο προστίθενται ετεροαναφορικές πληροφορίες, ευρήματα από την εξέταση και στοιχεία από τη διαχρονική πορεία, αναθεωρώ τη διατύπωση και τη διάγνωση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ένα πρακτικό σχήμα της εξέτασης παρούσας ψυχικής κατάστασης είναι: **εμφάνιση/συμπεριφορά, ομιλία, διάθεση και συναίσθημα, μορφή/περιεχόμενο σκέψης, αντίληψη, γνωστικές λειτουργίες και εναισθησία**. Είναι οργανωτικό πλαίσιο, όχι νομική ή διαγνωστική απαίτηση για συγκεκριμένο αριθμό πεδίων.
- Χρήσιμο σχήμα διατύπωσης είναι τα **4Ps**: προδιαθεσικοί, εκλυτικοί, διαιωνιστικοί και προστατευτικοί παράγοντες, εξεταζόμενοι σε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.
- **Κανένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό μιας παραληρητικής ιδέας δεν είναι παθογνωμονικό** ψυχικής διαταραχής. Οι παραληρητικές ιδέες αξιολογούνται φαινομενολογικά και μέσα στο πολιτισμικό και κλινικό πλαίσιο.
- **ΚΛΑΣΙΚΟ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ**: Ο Jaspers διέκρινε το Verstehen —την ενσυναισθητική κατανόηση του υποκειμενικού νοήματος— από το Erklären —την αιτιώδη εξήγηση. Παραμένει χρήσιμη εννοιολογική γλώσσα για προφορικές εξετάσεις, όχι σύγχρονο διαγνωστικό κριτήριο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ο ασθενής αναφέρει ότι ακούει μια φωνή ενώ είναι πλήρως ξύπνιος. Πώς διακρίνετε μια πραγματική ψευδαίσθηση από παραίσθηση, οργανικό/ουσιοεπαγόμενο φαινόμενο ή φαινόμενο αισθητηριακής στέρησης;

Η ψευδαίσθηση είναι εμπειρία αντίληψης που εμφανίζεται χωρίς εξωτερικό ερέθισμα· η παραίσθηση είναι εσφαλμένη αντίληψη ή ερμηνεία πραγματικού ερεθίσματος. Θα περιέγραφα την αισθητηριακή τροπικότητα —ακουστική, οπτική κ.λπ.—, τη σαφήνεια, τη θέση και τη σχέση με τον εξωτερικό χώρο, τη χρονική εμφάνιση, τους εκλυτικούς παράγοντες, το επίπεδο συνείδησης, την εναισθησία και τα συνοδά συμπτώματα.

Οργανική αιτία ή ντελίριο υποστηρίζονται από διαταραχή της προσοχής ή της συνείδησης, αποπροσανατολισμό, διακύμανση της γνωστικής λειτουργίας, οξεία έναρξη, διαταραχή του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, οπτικές παραϊσθήσεις ή εσφαλμένες αντιλήψεις και κάποιο ιατρικό εκλυτικό αίτιο. Για ουσίες ή φάρμακα, εξετάζω τη χρονική σχέση με τοξίκωση, στέρηση ή έκθεση, χωρίς να θεωρώ ότι η έκθεση αποδεικνύει από μόνη της αιτιότητα. Αισθητηριακή έκπτωση μπορεί επίσης να προκαλέσει ψευδαισθήσεις, επομένως ελέγχω όραση, ακοή και το πλαίσιο αισθητηριακής στέρησης. Μία ψευδαίσθηση από μόνη της δεν τεκμηριώνει σχιζοφρένεια· ερμηνεύεται μέσα στο συνολικό σύνδρομο.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι εννοείτε με τον όρο διαταραχή της μορφής της σκέψης και πώς διαφέρουν οι βασικές διαταραχές;

Η διαταραχή της μορφής της σκέψης αφορά την οργάνωση και τη ροή της σκέψης όπως εκφράζονται στον λόγο, όχι το περιεχόμενο της σκέψης. Σχετικές διαταραχές είναι η επιτάχυνση ή η ιδεοφυγή, η χαλάρωση συνειρμών ή ο εκτροχιασμός, η εφαπτομενικότητα, η υπερλεπτομερειακή σκέψη, η ανακοπή σκέψης, η εμμένουσα απάντηση ή εμμένουσα σκέψη, η ασυναρτησία ή σαλάτα λέξεων και, όπου υπάρχουν, νεολογισμοί ή ιδιοσυγκρασιακή χρήση της γλώσσας.

Η μορφή της σκέψης πρέπει να παραμένει διακριτή από το περιεχόμενο: οι παραληρητικές ιδέες και οι ιδεοληψίες είναι φαινόμενα περιεχομένου. Επίσης αποφεύγω να υπερδιαγιγνώσκω διαταραχή της μορφής της σκέψης όταν ο λόγος είναι απλώς φλύαρος, πολιτισμικά ασυνήθης ή ιδιόμορφος αλλά παραμένει συνεκτικός μέσα στο πλαίσιο.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση της εκτίμησης ως άκαμπτης λίστας χωρίς σύνθεση.
- Παράλειψη ετεροαναφορικών πληροφοριών ή σωματικής εξέτασης.
- Διάγνωση από ένα μεμονωμένο σύμπτωμα.
- Σύγχυση της μορφής με το περιεχόμενο της σκέψης.
- Αντιμετώπιση ενός κλασικού ψυχοπαθολογικού πλαισίου ως σύγχρονου διαγνωστικού κανόνα.

Πώς διακρίνετε μια παραληρητική ιδέα, μια υπερτιμημένη ιδέα και μια ιδεοληψία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αναγνωρίστε τη μορφή του φαινομένου
- 2 Εκτιμήστε βεβαιότητα και ακαμψία
- 3 Παρεισφρητική σκέψη έναντι πεποίθησης που το άτομο αποδέχεται
- 4 Εγωδυστονικότητα και αντίσταση
- 5 Κατανοητότητα και πλαίσιο
- 6 Η εναισθησία βρίσκεται σε συνεχές

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διάκριση είναι πρωτίστως **φαινομενολογική**. Δεν ταξινομώ μια εμπειρία από το περιεχόμενό της μόνο· εξετάζω τον βαθμό και την ποιότητα της βεβαιότητας, αν η σκέψη εισβάλλει ανεπιθύμητα ή γίνεται αποδεκτή ως αληθινή, πώς σχετίζεται με την αίσθηση του εαυτού, αν το άτομο προσπαθεί να της αντισταθεί και κατά πόσο η πεποίθηση είναι κατανοητή με βάση το συναίσθημα, τις αξίες και το πλαίσιο ζωής του.

Μια **παραληρητική ιδέα** είναι εσφαλμένη πεποίθηση την οποία το άτομο υποστηρίζει με παραληρητική βεβαιότητα, η οποία κατά κανόνα δεν μεταβάλλεται με αντεπιχειρήματα και δεν συνάδει με το πολιτισμικό ή υποπολιτισμικό του πλαίσιο. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η παθολογική μορφή και η ποιότητα της βεβαιότητας, όχι απλώς το ότι η πεποίθηση είναι ασυνήθιστη ή παράδοξη. Μια παράδοξη πεποίθηση δεν είναι αυτομάτως παραληρητική, ούτε μια παραληρητική ιδέα χρειάζεται να είναι παράδοξη.

Η **υπερτιμημένη ιδέα** είναι διαφορετική. Πρόκειται για μια ψυχολογικά κατανοητή και συναισθηματικά φορτισμένη πεποίθηση που μπορεί να κυριαρχήσει στη σκέψη και τη συμπεριφορά, χωρίς όμως να έχει την ίδια άκαμπτη, ποιοτικά παραληρητική βεβαιότητα. Μπορεί να γίνεται κατανοητή σε σχέση με την προσωπικότητα, τις αξίες, τη συναισθηματική κατάσταση ή τις περιστάσεις. Το άτομο την υποστηρίζει έντονα και η συμπεριφορά του μπορεί να οργανώνεται γύρω από αυτήν, αλλά συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη ψυχολογική συνέχεια ανάμεσα στην πεποίθηση και την υπόλοιπη ψυχική του ζωή απ' ό,τι σε μια παραληρητική ιδέα.

Η **ιδεοληψία** είναι επαναλαμβανόμενη παρεισφρητική σκέψη, εικόνα ή παρόρμηση που βιώνεται ως προϊόν του ίδιου του νου. Είναι ανεπιθύμητη ή προκαλεί δυσφορία και το άτομο συνήθως προσπαθεί να της αντισταθεί, να την εξουδετερώσει ή να την αναγνωρίσει σε κάποιο βαθμό ως υπερβολική ή παράλογη. Μπορεί να εκτελεί καταναγκασμούς για να μειώσει το άγχος ή να αποτρέψει ένα φοβούμενο αποτέλεσμα. Το να λέει κάποιος «ξέρω ότι είναι παράλογο, αλλά δεν μπορώ να διώξω τη σκέψη» είναι φαινομενολογικά πολύ διαφορετικό από το να υποστηρίζει μια πεποίθηση με παραληρητική βεβαιότητα.

Η βασική δυσκολία είναι η **εναισθησία**. Στις ιδεοψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις η

εναισθησία κυμαίνεται σε συνεχές, επομένως η πτωχή εναισθησία δεν μετατρέπει αυτόματα μια ιδεοληψία σε παραληρητική ιδέα. Δεν βασίζομαι λοιπόν σε ένα μόνο χαρακτηριστικό. Ρωτώ: Πόσο βέβαιος είστε; Θα μπορούσατε να κάνετε λάθος; Η σκέψη έρχεται παρά τη θέλησή σας ή σας φαίνεται αληθινή και δικαιολογημένη; Προσπαθείτε να της αντισταθείτε; Τι συμβαίνει αν δεν ενεργήσετε σύμφωνα με αυτήν; Είναι η πεποίθηση κατανοητή με βάση τη συναισθηματική σας κατάσταση ή τις αξίες σας;

Η πρακτική διάκριση είναι επομένως η εξής: η παραληρητική ιδέα χαρακτηρίζεται από παραληρητική βεβαιότητα και ακαμψία· η υπερτιμημένη ιδέα είναι έντονα υποστηριζόμενη αλλά ψυχολογικά κατανοητή κυρίαρχη πεποίθηση χωρίς την ίδια παραληρητική ποιότητα· και η ιδεοληψία είναι κατά κανόνα παρεισφρητική, ανεπιθύμητη και το άτομο προσπαθεί σε κάποιο βαθμό να της αντισταθεί, παρότι η εναισθησία μπορεί να είναι πτωχή. Η συνολική φαινομενολογία είναι πιο αξιόπιστη από το θέμα της ιδέας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ορισμός της παραληρητικής ιδέας απλώς ως «εσφαλμένης πεποίθησης».
- Χαρακτηρισμός κάθε έντονα υποστηριζόμενης πεποίθησης ως υπερτιμημένης ιδέας.
- Υπόθεση ότι οι ιδεοληψίες συνοδεύονται πάντοτε από πλήρη εναισθησία.
- Ταξινόμηση του φαινομένου μόνο από το παράδοξο περιεχόμενό του.

Όταν εμφανίζονται ψυχιατρικά συμπτώματα για πρώτη φορά, πότε πρέπει να υποψιαστείτε ιατρικό, νευρολογικό, φαρμακευτικό ή σχετιζόμενο με ουσίες αίτιο;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Οξεία, άτυπη ή ασυνήθης έναρξη
- 2 Προσοχή, συνείδηση και γνωστικές λειτουργίες
- 3 Νευρολογικά και συστηματικά σημεία συναγερμού
- 4 Φάρμακα, τοξίκωση και σύνδρομο στέρησης
- 5 Σωματική και νευρολογική εξέταση
- 6 Στοχευμένος παρακλινικός έλεγχος
- 7 Έλεγχος της αιτιολογικής χρονικής αλληλουχίας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε μια πρώτη ψυχιατρική εκδήλωση δεν πρέπει να θεωρώ ότι πρόκειται για πρωτοπαθή ψυχιατρική διαταραχή μόνο και μόνο επειδή τα συμπτώματα φαίνονται ψυχιατρικά. Η υποψία δευτεροπαθούς αιτίας αυξάνεται όταν η έναρξη, η πορεία ή τα συνοδά ευρήματα είναι άτυπα — ιδίως σε οξεία ή υποξεία έναρξη, διακύμανση, διαταραχή της προσοχής ή της συνείδησης, γνωστική μεταβολή, νευρολογικά σημεία, επιληπτικές κρίσεις, αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, παθολογικά ζωτικά σημεία, συστηματικά συμπτώματα, ασυνήθη ηλικία έναρξης ή ταχεία επιδείνωση.

Το πιο επείγον που πρέπει να αποκλειστεί είναι το **ντελίριο**, επειδή αποτελεί ιατρικό επείγον. Αναζητώ διαταραχή της προσοχής ή της συνείδησης με οξεία και διακυμαινόμενη πορεία, συχνά μαζί με αποπροσανατολισμό, διακύμανση της γνωστικής λειτουργίας, διαταραχή του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, παραισθήσεις ή οπτικές ψευδαισθήσεις. Ένας ασθενής με έντονη διέγερση ή ψυχωσική εικόνα μπορεί παρ' όλα αυτά να βρίσκεται σε ντελίριο· επομένως η συμπεριφορική διαταραχή δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από το επίπεδο συνείδησης και την ικανότητα συγκέντρωσης.

Στη συνέχεια αναζητώ **νευρολογικές και συστηματικές ενδείξεις**: νέα εστιακά ή άλλα νευρολογικά σημεία, επιληπτικές κρίσεις, ενδοκρινικά ή μεταβολικά συμπτώματα, λοίμωξη, υποξία, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή ταχέως μεταβαλλόμενη γνωστική κατάσταση. Το φαινομενολογικό προφίλ ενός δευτεροπαθούς συνδρόμου μπορεί να μοιάζει με πρωτοπαθή ψυχιατρική διαταραχή, οπότε η διάκριση συχνά βασίζεται περισσότερο στη χρονική πορεία και στα συνοδά σωματικά ευρήματα παρά στην ψυχιατρική φαινομενολογία αυτή καθαυτή.

Είναι απαραίτητο ένα προσεκτικό **ιστορικό φαρμάκων και ουσιών**. Ελέγχω τη συνταγογραφούμενη αγωγή, πρόσφατες αλλαγές, μη συνταγογραφούμενα ή εναλλακτικά σκευάσματα, τοξίκωση, σύνδρομο στέρησης και άλλη έκθεση σε ουσίες. Η χρονική συσχέτιση έχει σημασία, αλλά η έκθεση από μόνη της δεν

αποδεικνύει αιτιότητα.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει **σωματική και νευρολογική εξέταση** όταν μια δευτεροπαθής αιτία είναι εύλογη, και οι εξετάσεις πρέπει να επιλέγονται με βάση την κλινική υπόθεση. Δεν χρειάζεται κάθε ψυχιατρική παρουσίαση το ίδιο εξαντλητικό πακέτο εξετάσεων. Ανάλογα με την εικόνα, ενδεικτικά αίτια προς διερεύνηση είναι νευρολογική νόσος ή επιληψία, νευροεκφυλιστική νόσος, ενδοκρινικές ή μεταβολικές διαταραχές, λοίμωξη ή εγκεφαλίτιδα, αυτοάνοσες ή μεταιχμιακές διεργασίες, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, υποξία, φαρμακευτική τοξικότητα και καταστάσεις σχετιζόμενες με ουσίες.

Για να κρίνω αν ένας ιατρικός παράγοντας ή μια ουσία είναι πραγματικά αιτιολογικός, χρησιμοποιώ μια απλή **αιτιολογική αλληλουχία**: υπάρχει νόσος ή έκθεση που μπορεί να προκαλέσει το σύνδρομο; είναι εύλογη η χρονική σχέση; βελτιώνεται το ψυχιατρικό σύνδρομο καθώς υποχωρεί το αίτιο; υπάρχει καλύτερη πρωτοπαθής ψυχιατρική εξήγηση; Κανένα από αυτά δεν αρκεί μεμονωμένα.

Η πρακτική αρχή είναι λοιπόν στοχευμένη κλινική υποψία και όχι άκριτος παρακλινικός έλεγχος. Οξεία διακύμανση, διαταραχή της προσοχής, νευρολογικές ή συστηματικές ανωμαλίες, σαφής χρονική σχέση με φάρμακα ή ουσίες και άτυπη πορεία μεταφέρουν τα δευτεροπαθή αίτια ψηλά στη διαφορική διάγνωση και υπαγορεύουν τον κατάλληλο ιατρικό έλεγχο.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Υπόθεση ότι μια κλινική εικόνα που μοιάζει ψυχιατρική είναι αναγκαστικά πρωτοπαθής ψυχιατρική διαταραχή.
- Παράβλεψη ντελίριου σε διεγερμένο ή ψυχωσικό ασθενή.
- Παράβλεψη αλλαγών στη φαρμακευτική αγωγή, τοξίκωσης ή συνδρόμου στέρησης.
- Άκριτος παρακλινικός έλεγχος χωρίς συγκεκριμένη κλινική υπόθεση.

Πώς εκτιμάτε την αυτοκτονική πρόθεση και τον άμεσο κίνδυνο αυτοκτονίας;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αυτοκτονικός ιδεασμός
- 2 Πρόθεση
- 3 Σχέδιο, προπαρασκευή και πρόσβαση σε μέσα
- 4 Προηγούμενη αυτοκτονική συμπεριφορά
- 5 Ψυχική κατάσταση, ουσίες και οξείς στρεσογόνοι παράγοντες
- 6 Προστατευτικοί παράγοντες και δυνατότητα συνεργασίας
- 7 Δυναμική διατύπωση κινδύνου, πλαίσιο περαιτέρω φροντίδας και πλάνο ασφάλειας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εκτιμώ τον κίνδυνο αυτοκτονίας άμεσα και συγκεκριμένα, χωρίς να ισχυρίζομαι ότι μπορώ να προβλέψω την αυτοκτονία ενός συγκεκριμένου ατόμου. Στόχος είναι να διαπιστώσω την τρέχουσα αυτοκτονική πρόθεση και τη δυνατότητα υλοποίησης μιας αυτοκτονικής πράξης, να κατανοήσω γιατί ο κίνδυνος μπορεί να είναι αυξημένος τώρα, να διαχωρίσω τις σταθερές ευαλωτότητες από τους δυναμικούς παράγοντες και να μετατρέψω αυτή τη διατύπωση σε άμεσο πλάνο ασφάλειας και αντιμετώπισης.

Ξεκινώ ρωτώντας καθαρά για τις **τρέχουσες αυτοκτονικές σκέψεις**: τη συχνότητα, την επιμονή και το πόσο ελέγχονται, αν το άτομο επιθυμεί να πεθάνει και αν υπάρχει πρόθεση να ενεργήσει. Στη συνέχεια διερευνώ **σχέδιο και προπαρασκευή** — μέθοδο, χρονικό σχεδιασμό, βήματα που έχουν ήδη γίνει, πρόσβαση σε μέσα, ενέργειες για να μην γίνει αντιληπτό και πόσο θανατηφόρα θεωρεί το άτομο τη μέθοδο. Πρόσφατη αυτοκτονική συμπεριφορά ή πρόβα της πράξης μεταβάλλει ουσιαστικά την εκτίμηση.

Κρίσιμο ιστορικό στοιχείο είναι οι **προηγούμενες απόπειρες ή ο αυτοτραυματισμός**. Εξετάζω τι συνέβη, σε ποιο πλαίσιο και πόσο μοιάζει η σημερινή κατάσταση με προηγούμενες. Ρωτώ επίσης ρητά για πρόσβαση σε θανατηφόρα μέσα και για προβλέψιμα γεγονότα στο άμεσο μέλλον που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Η ευρύτερη **ψυχική κατάσταση** είναι καθοριστική, επειδή ο αυτοκτονικός κίνδυνος συχνά επηρεάζεται από δυναμικά στοιχεία του κλινικού συνδρόμου. Εκτιμώ απελπισία, κατάθλιψη, ψύχωση, σοβαρή διέγερση, τοξίκωση ή σύνδρομο στέρησης, προβληματική χρήση ουσιών, παρορμητικότητα, οξείς διαπροσωπικούς ή άλλους στρεσογόνους παράγοντες, καθώς και τυχόν ιατρικές συνέπειες αυτοτραυματισμού που χρειάζονται αντιμετώπιση. Εξετάζω επίσης τα διαθέσιμα υποστηρικτικά πρόσωπα και αν ο ασθενής μπορεί και θέλει να συνεργαστεί σε ένα ρεαλιστικό πλάνο ασφάλειας.

Παράλληλα αναζητώ **προστατευτικούς παράγοντες και λόγους για να ζει**: σχέσεις, ευθύνες, μελλοντικά σχέδια, πεποιθήσεις, συνεργασία με τη θεραπεία ή

άλλους παράγοντες που πράγματι μειώνουν τον κίνδυνο στη συγκεκριμένη κατάσταση. Οι προστατευτικοί παράγοντες δεν ακυρώνουν σοβαρά προειδοποιητικά σημεία· εντάσσονται στη συνολική διατύπωση.

Το τελικό βήμα είναι μια **δυναμική διατύπωση κινδύνου**, όχι μια βαθμολογία. Περιγράφω τις στατικές ή χρόνιες ευαλωτότητες, τους τρέχοντες τροποποιήσιμους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, πιθανά βραχυπρόθεσμα σενάρια, τι μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και ποιες παρεμβάσεις είναι πιθανό να μειώσουν τον κίνδυνο. Γενικές ετικέτες όπως «χαμηλός», «μέτριος» ή «υψηλός» κίνδυνος και αριθμητικές βαθμολογίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν να προβλέπουν την αυτοκτονία ή να καθορίζουν από μόνες τους την απόφαση εξιτηρίου.

Η απόφαση για το **πλαίσιο της περαιτέρω φροντίδας** προκύπτει από αυτή τη διατύπωση. Συνεκτιμώ την άμεση ασφάλεια, την τρέχουσα ψυχική κατάσταση, τοξίκωση ή ιατρικά προβλήματα, τη δυνατότητα συνεργασίας, τα διαθέσιμα στηρίγματα, την πρόσβαση σε μέσα και αν το προτεινόμενο πλάνο ασφάλειας μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί. Η τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει τις αυτοκτονικές σκέψεις και την πρόθεση, το σχέδιο και τα διαθέσιμα μέσα, την προηγούμενη συμπεριφορά, τους δυναμικούς παράγοντες, τους προστατευτικούς παράγοντες, τις ενέργειες περιορισμού της πρόσβασης σε μέσα, το πλάνο ασφάλειας και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την παρακολούθηση. Μια γυμνή καταγραφή «χαμηλός κίνδυνος» δεν αποτελεί επαρκή εκτίμηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Οι κλίμακες αυτοκτονικού κινδύνου και οι γενικές κατηγορίες κινδύνου **δεν παρέχουν αξιόπιστη εξατομικευμένη πρόβλεψη** και δεν πρέπει να καθορίζουν αποφάσεις εξιτηρίου ή θεραπείας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Να ρωτήσετε μόνο «Έχετε αυτοκτονικές σκέψεις;».
- Να θεωρήσετε την άρνηση τρέχοντος ιδεασμού επαρκώς καθησυχαστική.
- Να χρησιμοποιήσετε κατηγορίες χαμηλού/μέτριου/υψηλού κινδύνου σαν να προβλέπουν την έκβαση.
- Να παραθέσετε παράγοντες κινδύνου χωρίς να τους συνδέσετε με την άμεση αντιμετώπιση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διατύπωση κινδύνου: Παλαιότερες προσεγγίσεις συχνά άθροιζαν παράγοντες κινδύνου και κατέληγαν σε μια κατηγορία κινδύνου. Η σύγχρονη πρακτική δίνει μεγαλύτερο βάρος σε εξατομικευμένη, δυναμική διατύπωση που εξηγεί τι αυξάνει τον κίνδυνο τώρα και κατευθύνει τη διαχείριση, χωρίς να ισχυρίζεται ότι προβλέπει την αυτοκτονία.

Ένας ασθενής επέζησε από απόπειρα αυτοκτονίας. Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο επανάληψης;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Έγκαιρη ψυχοκοινωνική εκτίμηση
- 2 Αντιμετώπιση της υποκείμενης ψυχιατρικής διαταραχής και της χρήσης ουσιών
- 3 Συνεργατικό πλάνο ασφάλειας
- 4 Μείωση της πρόσβασης σε θανατηφόρα μέσα
- 5 Συνέχεια της φροντίδας, σαφής ανάληψη ευθύνης και έγκαιρη παρακολούθηση
- 6 Στοχευμένη ψυχολογική παρέμβαση
- 7 Δυναμική επανεκτίμηση του κινδύνου

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, η πρόληψη της επανάληψης αρχίζει με προσεκτική ψυχοκοινωνική εκτίμηση και ενεργό πλάνο συνέχειας της φροντίδας, όχι απλώς με εξιτήριο όταν αντιμετωπιστούν οι άμεσες ιατρικές συνέπειες. Διερευνώ τη λειτουργία και το πλαίσιο της απόπειρας, την τρέχουσα αυτοκτονική πρόθεση, τους συνεχιζόμενους ψυχιατρικούς ή σχετιζόμενους με ουσίες παράγοντες, τα διαθέσιμα στηρίγματα και τις ευαλωτότητες και στη συνέχεια καταρτίζω μαζί με τον ασθενή ένα πλάνο που μειώνει τον άμεσο κίνδυνο και εξασφαλίζει γρήγορη παρακολούθηση.

Η ψυχοκοινωνική εκτίμηση πρέπει να γίνεται **το συντομότερο δυνατό, όταν είναι κλινικά κατάλληλο**. Ανασυνθέτω τι οδήγησε στην πράξη, πόσο σχεδιασμένη ήταν και ποια ήταν η πρόθεση, τι περίμενε το άτομο ότι θα συμβεί, την τρέχουσα ψυχική κατάσταση, αν παραμένει αυτοκτονικός ιδεασμός και τι έχει αλλάξει μετά την απόπειρα. Παράλληλα αναζητώ δυνάμεις, υποστηρικτικές σχέσεις και πρακτικά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Κάθε υποκείμενη ψυχιατρική διαταραχή ή διαταραχή χρήσης ουσιών χρειάζεται ενεργή θεραπεία. Η φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιείται όταν ενδείκνυται για την υποκείμενη διαταραχή και δεν παρουσιάζεται ως γενική θεραπεία του αυτοτραυματισμού καθαυτού.

Κεντρική παρέμβαση είναι ένα **συνεργατικό πλάνο ασφάλειας**. Πρέπει να περιλαμβάνει προειδοποιητικά σημεία και εκλυτικούς παράγοντες, στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνος του ο ασθενής, πρόσωπα ή μέρη που παρέχουν στήριξη, συγγενείς ή φίλους που μπορούν να βοηθήσουν, επαφές σε κρίση ή εκτός ωραρίου και συγκεκριμένα βήματα για το τι θα κάνει αν ενταθούν οι αυτοκτονικές παρορμήσεις. Το πλάνο πρέπει να είναι πραγματικά χρηστικό για τον ασθενή και όχι απλώς να υπάρχει ως καταχώριση στον φάκελο.

Αντιμετωπίζω ειδικά και σε συνεργασία με τον ασθενή την **πρόσβαση σε θανατηφόρα μέσα**. Τα μέτρα περιορισμού της πρόσβασης πρέπει να

προσαρμόζονται στη συγκεκριμένη μέθοδο, στην πραγματική πρόσβαση και στα προβλέψιμα σενάρια του ατόμου και όχι να μένουν σε γενικές συμβουλές.

Η συνέχεια της φροντίδας είναι ιδιαίτερα σημαντική μετά από απόπειρα. Πριν από εξιτήριο ή μεταφορά πρέπει να υπάρχει σαφές πλάνο αντιμετώπισης, συγκεκριμένο πρόσωπο ή υπηρεσία που αναλαμβάνει την παρακολούθηση και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Όταν εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια, **επανεκτίμηση και συνέχιση της φροντίδας εντός 48 ωρών** αποτελεί χρήσιμο σύγχρονο χρονικό σημείο αναφοράς. Υποστηρίζεται επίσης μια δομημένη, προσωποκεντρική **παρέμβαση βασισμένη στη CBT και προσαρμοσμένη στον αυτοτραυματισμό**: μια τυπική σύσταση είναι περίπου **4–10 συνεδρίες**, προσαρμοσμένες στις ανάγκες.

Ο κίνδυνος παραμένει δυναμικός. Επανεκτιμώ μεταβολές στην πρόθεση, στους στρεσογόνους παράγοντες, στη χρήση ουσιών, στην πρόσβαση σε μέσα, στη συνεργασία με τη θεραπεία και στους προστατευτικούς παράγοντες, αντί να χρησιμοποιώ μια κατηγορία ή βαθμολογία κινδύνου ως κριτήριο εξιτηρίου. Στόχος είναι να μειωθεί η πιθανότητα της επόμενης κρίσης, να αναγνωριστεί νωρίτερα αν εμφανιστεί και να γνωρίζει ο ασθενής ακριβώς πώς θα ζητήσει βοήθεια.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου αυτοκτονίας και πώς διαφέρει ο κίνδυνος μεταξύ ψυχιατρικών διαταραχών;

Ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες είναι προηγούμενη απόπειρα ή αυτοτραυματισμός, τρέχουσα πρόθεση ή σχέδιο, απελπισία, σοβαρά ή επιδεινούμενα ψυχιατρικά συμπτώματα, προβληματική χρήση ουσιών ή τοξίκωση, κοινωνική απομόνωση, οξείες διαπροσωπικές, οικονομικές ή νομικές κρίσεις, χρόνια ή επώδυνη σωματική νόσος, πρόσφατο εξιτήριο ή μετάβαση μεταξύ υπηρεσιών φροντίδας και πρόσβαση σε θανατηφόρα μέσα.

Διακρίνω τις χρόνιες ή στατικές ευαλωτότητες από τους δυναμικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο στο μέλλον και από τους προστατευτικούς παράγοντες. Οι διαταραχές διάθεσης, οι ψυχωσικές διαταραχές, οι διαταραχές χρήσης ουσιών και η παθολογία προσωπικότητας συνδέονται όλες με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας, αλλά δεν θα έδινά άκαμπτη ιεράρχηση ανά διάγνωση ούτε παλαιά ποσοστά «δια βίου» κινδύνου ως εξεταστικές σταθερές. Η διάγνωση συμβάλλει στη διατύπωση· δεν προβλέπει την έκβαση για το συγκεκριμένο άτομο.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χρήση «συμβολαίου μη αυτοκτονίας» ή γενικής καθησύχησης αντί για συγκεκριμένο πλάνο ασφάλειας.
- Εξιτήριο χωρίς σαφή ανάληψη ευθύνης για την παρακολούθηση.
- Γενικές συμβουλές για περιορισμό μέσων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η πιθανή μέθοδος και η πραγματική πρόσβαση του συγκεκριμένου ασθενούς.
- Παράθεση διαγνωστικών ποσοστών δια βίου αυτοκτονίας σαν να προβλέπουν τον ατομικό κίνδυνο.

Πώς εκτιμάτε τον κίνδυνο βίας ή επιθετικότητας;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Προηγούμενη βία
- 2 Τρέχοντα συμπτώματα και ουσίες
- 3 Απειλές, μέσα και πιθανοί στόχοι
- 4 Εκλυτικοί παράγοντες και συνθήκες της κατάστασης
- 5 Στατικοί και δυναμικοί παράγοντες κινδύνου
- 6 Διατύπωση βασισμένη σε πιθανά σενάρια
- 7 Σαφές και εφαρμόσιμο πλάνο διαχείρισης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εκτίμηση κινδύνου βίας πρέπει να είναι **δομημένη, βασισμένη σε πιθανά σενάρια και προσανατολισμένη στη διαχείριση**. Η προηγούμενη βία αποτελεί σημαντικό ιστορικό στοιχείο, αλλά κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν καθορίζει την έκβαση. Το ζητούμενο είναι να αναγνωρίσω εύλογα βραχυπρόθεσμα σενάρια, τι τα καθιστά περισσότερο ή λιγότερο πιθανά και ποιες παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο.

Ξεκινώ με το ιστορικό **προηγούμενης επιθετικότητας ή βίας**: τι συνέβη, πόσο σοβαρό ήταν, ποια ήταν τα θύματα ή οι στόχοι, ποιοι ήταν οι εκλυτικοί παράγοντες, αν υπήρχε τοξίκωση, ποιες ήταν οι συνέπειες και αν διακρίνεται επαναλαμβανόμενο πρότυπο. Στη συνέχεια αξιολογώ την τρέχουσα ψυχική κατάσταση, συμπτώματα που μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά, χρήση ουσιών ή τοξίκωση, παρορμητικότητα, γνωστικές ή επικοινωνιακές δυσκολίες, συμμόρφωση με τη θεραπεία και τρέχοντες κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες.

Οι τρέχουσες **απειλές και η πρόθεση** πρέπει να διερευνώνται άμεσα. Πρωτό αν υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα στην οποία επικεντρώνεται ο ασθενής, αν υπάρχει πρόσβαση σε όπλα ή άλλα μέσα, πόσο άμεση είναι η απειλή και ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πράξη. Όταν είναι σχετικό, λαμβάνω υπόψη και την ασφάλεια πιθανών θυμάτων.

Το πλαίσιο είναι εξίσου σημαντικό με τη διάγνωση. Αναζητώ **δυναμικούς και περιβαλλοντικούς εκλυτικούς παράγοντες**, όπως συγκρούσεις, συνωστισμό, αντιλαμβανόμενη πρόκληση, διαθεσιμότητα ουσιών ή έναν τρόπο αλληλεπίδρασης που στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε κλιμάκωση της διέγερσης ή της επιθετικότητας. Πρωτό επίσης τι έχει βοηθήσει προηγουμένως: περισσότερος χώρος, συγκεκριμένη προσέγγιση από το προσωπικό, υποστηρικτικά πρόσωπα, φαρμακευτική αγωγή, απομάκρυνση ενός εκλυτικού παράγοντα ή άλλη στρατηγική αποκλιμάκωσης.

Διακρίνω τους σχετικά **στατικούς ή χρόνιους παράγοντες** από τους δυναμικούς παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν τώρα. Η διατύπωση πρέπει να χρησιμοποιεί σταθμισμένη γλώσσα: ποιο σενάριο βίας είναι εύλογο, πόσο άμεσο φαίνεται, ποια θα ήταν η πιθανή σοβαρότητα και ο στόχος και ποιοι τροποποιήσιμοι παράγοντες λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Αποφεύγω απόλυτες

διατυπώσεις ότι ο ασθενής «θα» ή «δεν θα» γίνει βίαιος.

Δομημένα εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν την εκτίμηση σε συγκεκριμένα πλαίσια. Βραχυπρόθεσμα ενδονοσοκομειακά εργαλεία όπως το **BVC** ή το **DASA-IV** μπορούν να είναι χρήσιμα συμπληρώματα, αλλά δεν αντικαθιστούν την κλινική διατύπωση και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ντετερμινιστικά.

Η εκτίμηση πρέπει να καταλήγει σε **σαφές και εφαρμόσιμο πλάνο διαχείρισης**: γνωστοί εκλυτικοί παράγοντες και προειδοποιητικά σημεία, προτιμώμενες μέθοδοι αποκλιμάκωσης, τρόπος παρακολούθησης και επαφής με τον ασθενή, αντιμετώπιση τοξίκωσης ή χρήσης ουσιών, μέτρα προστασίας πιθανών θυμάτων και σαφείς ενέργειες αν ο κίνδυνος αυξηθεί. Οι σχετικές πληροφορίες κινδύνου και το σκεπτικό του πλάνου τεκμηριώνονται και διαβιβάζονται στις ομάδες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα.

Η βασική αρχή είναι ότι η εκτίμηση κινδύνου έχει αξία μόνο αν αλλάζει τη διαχείριση. Μια λίστα ιστορικών παραγόντων χωρίς εύλογο σενάριο και σχέδιο μείωσης των τροποποιησιμων παραγόντων είναι ελλιπής.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Εξίσωση της ψυχικής νόσου με την επικινδυνότητα.
- Αντιμετώπιση μιας δομημένης ή αναλογιστικής βαθμολογίας ως ντετερμινιστικής.
- Παράθεση παραγόντων κινδύνου χωρίς μετατροπή τους σε πλάνο διαχείρισης.
- Παράβλεψη περιβαλλοντικών και διαπροσωπικών εκλυτικών παραγόντων.

Πώς αντιμετωπίζετε τη σοβαρή διέγερση στα επείγοντα;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Άμεση ασφάλεια και ιατρική σταθερότητα
- 2 Αναζήτηση της αιτίας
- 3 Λεκτική και περιβαλλοντική αποκλιμάκωση
- 4 Το λιγότερο περιοριστικό μέτρο που επαρκεί
- 5 Ταχεία καταστολή μόνο όταν απαιτείται
- 6 Στενή παρακολούθηση ζωτικών και επιπέδου συνείδησης
- 7 Ανασκόπηση μετά το συμβάν

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η σοβαρή διέγερση είναι **σύμπτωμα και επείγον πρόβλημα διαχείρισης, όχι διάγνωση**. Πρώτα εξασφαλίζω την άμεση ασφάλεια και ταυτόχρονα διερευνώ ιατρικό ή τοξικολογικό αίτιο, χρησιμοποιώ λεκτική και περιβαλλοντική αποκλιμάκωση όταν αυτό είναι εφικτό και περνώ σε περιοριστικά μέτρα ή ταχεία καταστολή μόνο όταν το απαιτεί η κλινική κατάσταση.

Αρχικά εκτιμώ τον **άμεσο κίνδυνο, τη διαθέσιμη στελέχωση και το περιβάλλον**, αν κινδυνεύει ο ασθενής ή άλλοι και αν υπάρχει ιατρική αστάθεια που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Παράλληλα εξετάζω ντελίριο, τοξίκωση ή σύνδρομο στέρησης, υποξία, υπογλυκαιμία, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, επιληπτική κρίση ή μετακριτική κατάσταση, λοίμωξη, μεταβολική διαταραχή, φαρμακευτική τοξικότητα, μανία, ψύχωση και άλλα αίτια της συμπεριφορικής διαταραχής. Η καταστολή της διέγερσης δεν πρέπει να υποκαθιστά τη διάγνωση του αιτίου.

Όταν μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια, η **αποκλιμάκωση είναι η πρώτη παρέμβαση**. Χρησιμοποιώ ήρεμη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, αποφεύγω την πρόκληση, μειώνω τα ερεθίσματα, διατηρώ επαρκή προσωπικό χώρο και, αν είναι δυνατό, μεταφέρω τον ασθενή σε πιο ήσυχο περιβάλλον. Η προσέγγιση πρέπει να διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια και να ενισχύει όσο γίνεται το αίσθημα ελέγχου του ασθενούς.

Κάθε **περιοριστική παρέμβαση** αποτελεί λύση έσχατης ανάγκης: χρησιμοποιείται το λιγότερο περιοριστικό μέτρο που επαρκεί, για τον συντομότερο αναγκαίο χρόνο, με διατήρηση της σωματικής ασφάλειας και της αξιοπρέπειας. Οι ακριβείς νομικές και διαδικαστικές απαιτήσεις για καθήλωση ή απομόνωση ακολουθούν το ισχύον πλαίσιο και δεν αυτοσχεδιάζονται.

Αν απαιτείται επείγουσα φαρμακευτική καταστολή και η από του στόματος αγωγή δεν είναι εφικτή ή κατάλληλη, η **ταχεία καταστολή (rapid tranquillisation)** σημαίνει επείγουσα παρεντερική χορήγηση για άμεσο έλεγχο της κρίσης. Δεν είναι συνήθης θεραπεία της σχιζοφρένειας ή της μανίας. Στους ενήλικες, τρέχουσες επιλογές είναι **IM λοραζεπάμη μόνη της ή IM αλοπεριδόλη μαζί με IM προμεθαζίνη**. Όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, ο ασθενής δεν έχει προηγούμενη έκθεση σε αντιψυχωσικά, υπάρχει καρδιαγγειακή ή QT

ανησυχία ή δεν είναι διαθέσιμο ΗΚΓ, προτιμάται η λοραζεπάμη. Οι ακριβείς δόσεις ακολουθούν το ισχύον τοπικό πρωτόκολλο και την **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SmPC)**.

Η αρχική αγωγή χορηγείται ως **μία δόση** και δεν επαναλαμβάνεται πριν εκτιμηθεί το κλινικό αποτέλεσμα. Μετά την ταχεία καταστολή, η παρακολούθηση είναι μέρος της θεραπείας: ανεπιθύμητες ενέργειες, σφυγμός, αρτηριακή πίεση, αναπνευστικός ρυθμός, θερμοκρασία, ενυδάτωση και επίπεδο συνείδησης ελέγχονται τουλάχιστον ανά ώρα. **Παρακολούθηση ανά 15 λεπτά** είναι κατάλληλη σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου, όπως σημαντική καταστολή ή ύπνος, χρήση αλκοόλ ή παράνομων ουσιών, προβλήματα σωματικής υγείας, τραυματισμός κατά τη διάρκεια περιοριστικού μέτρου ή ανησυχία για τη μέγιστη δοσολογία.

Όταν υποχωρήσει η άμεση κρίση, κάνω **ανασκόπηση μετά το συμβάν**: τι πυροδότησε τη διέγερση, ποιες στρατηγικές αποκλιμάκωσης δοκιμάστηκαν, αν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανεπιθύμητες ενέργειες από τα φάρμακα και τι πρέπει να αλλάξει στο μελλοντικό πλάνο διαχείρισης κινδύνου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η ταχεία καταστολή είναι **ξεχωριστή επείγουσα παρέμβαση**, όχι συνήθης αντιψυχωσική θεραπεία.
- Τρέχουσες επιλογές για ενήλικες: **IM λοραζεπάμη** ή **IM αλοπεριδόλη + IM προμεθαζίνη**. Η ακριβής δοσολογία ακολουθεί το ισχύον τοπικό πρωτόκολλο και την ΠΧΠ/SmPC.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Καταστολή πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο ντελίριου ή άλλης ιατρικής αιτίας.
- Επανάληψη φαρμακευτικής αγωγής πριν εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της πρώτης δόσης.
- Παράθεση μη επαληθευμένων ακριβών δόσεων σαν να ήταν καθολικές.
- Χρήση καθήλωσης ως τιμωρίας ή συνήθους μέσου ελέγχου της συμπεριφοράς.

Πώς εκτιμάτε αν ένας ασθενής μπορεί να δώσει έγκυρη ενημερωμένη συναίνεση;

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επαρκής ενημέρωση
- 2 Ικανότητα συναίνεσης για τη συγκεκριμένη απόφαση
- 3 Εκούσιος χαρακτήρας της απόφασης
- 4 Ειδική συναίνεση και δυνατότητα ανάκλησης
- 5 Υποκατάστατη συναίνεση όταν ο ασθενής δεν μπορεί να συναινέσει
- 6 Εξαίρεση σε επείγουσα ανάγκη
- 7 Ψυχιατρική αυτονομία: η ακούσια νοσηλεία δεν ισοδυναμεί με γενική συναίνεση στη θεραπεία

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο ελληνικό ιατρικό δίκαιο, ο βασικός κανόνας είναι ότι μια ιατρική πράξη απαιτεί **προηγούμενη έγκυρη συναίνεση** του ασθενούς. Στην πράξη εξετάζω τρία βασικά ζητήματα: έχει ο ασθενής λάβει επαρκή και κατανοητή ενημέρωση, μπορεί να συναινέσει ουσιαστικά στη συγκεκριμένη απόφαση και είναι η απόφασή του ελεύθερη και ειδική, χωρίς εξαναγκασμό, πλάνη ή εξαπάτηση;

Πρώτον, η **ενημέρωση** πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και κατανοητή σε βαθμό που να επιτρέπει πραγματικά ενημερωμένη απόφαση. Περιλαμβάνει την κατάσταση της υγείας, την προτεινόμενη παρέμβαση, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τις προβλέψιμες συνέπειες και τους κινδύνους, τις εναλλακτικές επιλογές και την αναμενόμενη πορεία ανάρρωσης. Η εξήγηση πρέπει να προσαρμόζεται σε ό,τι ο συγκεκριμένος ασθενής μπορεί πράγματι να κατανοήσει.

Δεύτερον, εκτιμώ την **ικανότητα για συναίνεση** λειτουργικά και σε σχέση με τη συγκεκριμένη απόφαση. Το ελληνικό δίκαιο δεν κωδικοποιεί το τετραμερές τεστ του βρετανικού Mental Capacity Act, επομένως δεν παρουσιάζω το «κατανόηση, συγκράτηση, χρήση ή στάθμιση, επικοινωνία» ως ελληνικά νομοθετικά κριτήρια. Κλινικά, όμως, πρέπει να διαπιστώσω αν ο ασθενής μπορεί να κατανοήσει επαρκώς το πρόβλημα, την προτεινόμενη παρέμβαση, τους σχετικούς κινδύνους και τις συνέπειες και τις διαθέσιμες εναλλακτικές, ώστε η συναίνεση να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Η ικανότητα αφορά τη **συγκεκριμένη απόφαση και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή**, όχι τη διάγνωση γενικά. Ψυχιατρική διάγνωση, ψύχωση, ακούσια νοσηλεία ή διαφωνία με τη σύστασή μου δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ανικανότητα. Το ερώτημα είναι αν το άτομο μπορεί να συναινέσει στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη τώρα.

Τρίτον, η συναίνεση πρέπει να είναι **εκούσια και ειδική**. Πρέπει να αφορά την προτεινόμενη ιατρική πράξη και να μην έχει δοθεί λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Μπορεί επίσης να ανακληθεί.

Αν ένας ενήλικας δεν μπορεί να δώσει έγκυρη συναίνεση, εφαρμόζεται το ελληνικό πλαίσιο υποκατάστατης συναίνεσης. Όπου έχει διοριστεί **δικαστικός**

συμπαραστάτης με σχετική αρμοδιότητα, αυτός παρέχει τη συναίνεση· όταν δεν υπάρχει, ο Κώδικας αναφέρεται γενικότερα στους **οικείους**. Δεν επινοώ ιεράρχηση μεταξύ συγγενών που το πλαίσιο δεν ορίζει. Ακόμη και όταν απαιτείται υποκατάστατη συναίνεση, ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται όσο είναι εφικτό και να συμμετέχει στη λήψη της απόφασης στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με αναζήτηση της γνώμης και της συγκατάθεσής του (assent).

Για τους **ανηλίκους**, η συναίνεση παρέχεται από εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ενώ η άποψη του ίδιου του ανηλίκου λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με την ωριμότητα και την κατανόησή του.

Υπάρχει επίσης **εξαίρεση σε επείγουσα ανάγκη**. Η αναγκαία θεραπεία μπορεί να προχωρήσει όταν δεν είναι δυνατό να ληφθεί κατάλληλη συναίνεση και υπάρχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη· η απόπειρα αυτοκτονίας περιλαμβάνεται ρητά σε αυτή την εξαίρεση.

Στην ψυχιατρική, η βασική αρχή είναι ότι η ψυχική διαταραχή δεν καταργεί την αξιοπρέπεια, τις προτιμήσεις ή την αυτονομία. Η ακούσια νοσηλεία και η συναίνεση σε συγκεκριμένη θεραπεία είναι διαφορετικά νομικά ζητήματα. Η ακούσια νοσηλεία δεν εξουσιοδοτεί αυτομάτως κάθε ιατρική παρέμβαση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Το ελληνικό δίκαιο δεν περιλαμβάνει το βρετανικό νομοθετικό τετραμερές τεστ ικανότητας.
- Η ψυχιατρική διάγνωση ή η ακούσια νοσηλεία δεν ισοδυναμούν με γενική ανικανότητα για συναίνεση.
- Αν ένας ενήλικας δεν μπορεί να συναινέσει: όπου υπάρχει αρμόδιος **δικαστικός συμπαραστάτης**, αυτός παρέχει τη συναίνεση· διαφορετικά ο Κώδικας αναφέρεται στους **οικείους**, χωρίς να δικαιολογείται επινοημένη σειρά προτεραιότητας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Εισαγωγή του βρετανικού Mental Capacity Act και παρουσίασή του ως ελληνικού δικαίου.
- Εξίσωση της ψύχωσης με ανικανότητα για συναίνεση.
- Αντιμετώπιση της ακούσιας νοσηλείας ως γενικής εξουσιοδότησης για οποιαδήποτε θεραπεία.

Πότε μπορεί ένας ασθενής να νοσηλευτεί ακούσια στην Ελλάδα και ποια είναι η διαδικασία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Οι δύο εναλλακτικές νόμιμες βάσεις
- 2 Ποιος μπορεί να κινήσει τη διαδικασία
- 3 Οι απαιτούμενες ιατρικές γνωματεύσεις
- 4 Η διαδικασία εξέτασης εντός 48 ωρών όταν δεν είναι δυνατή προηγούμενη εξέταση
- 5 Εισαγγελικές και δικαστικές προθεσμίες
- 6 Δικαιώματα του ασθενούς, διάρκεια και επανεξέταση
- 7 Μεταφορά υπό υγειονομική ευθύνη και νοσηλεία ≠ γενική συναίνεση στη θεραπεία

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην Ελλάδα, η ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία εξακολουθεί να ρυθμίζεται ουσιαστικά από το πλαίσιο του Ν. 2071/1992, όπως έχει τροποποιηθεί. Υπάρχουν **δύο εναλλακτικές νόμιμες βάσεις**, επομένως η επικινδυνότητα δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Η διαδικασία περιλαμβάνει ιατρικές, εισαγγελικές και δικαστικές εγγυήσεις, ενώ το σύγχρονο μοντέλο μεταφοράς είναι κατά βάση υγειονομικό και όχι αστυνομικό.

Η πρώτη βάση απαιτεί **και τα τρία στοιχεία**: το άτομο έχει ψυχική διαταραχή· εξαιτίας αυτής δεν είναι σε θέση να κρίνει το συμφέρον της υγείας του· και χωρίς νοσηλεία είτε θα αποκλειόταν η θεραπεία είτε θα επιδεινωνόταν η υγεία του. Η δεύτερη βάση είναι εναλλακτική: υπάρχει ψυχική διαταραχή και η νοσηλεία είναι αναγκαία για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του ίδιου ή άλλων. Η απλή κοινωνική, ηθική ή πολιτική μη συμμόρφωση δεν συνιστά ψυχική διαταραχή.

Τη διαδικασία μπορούν να κινήσουν τα **πρόσωπα που ορίζει ο νόμος**, δηλαδή ο/η σύζυγος, οι προβλεπόμενοι συγγενείς ή το πρόσωπο που έχει τη φροντίδα του ασθενούς. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο πρόσωπο, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών μπορεί, σε επείγουσα περίπτωση, να ενεργήσει αυτεπαγγέλτως.

Κατά κανόνα απαιτούνται **δύο αιτιολογημένες γραπτές ιατρικές γνωματεύσεις**. Συνήθως προέρχονται από δύο ψυχιάτρους ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, από έναν ψυχίατρο και έναν ιατρό συναφούς ειδικότητας. Οι γνωματεύσεις πρέπει να τοποθετούνται ως προς τα νόμιμα κριτήρια και οι εξετάζοντες ιατροί δεν πρέπει να είναι συγγενείς του αιτούντος ή του ασθενούς.

Αν η προηγούμενη εξέταση δεν μπορεί να γίνει επειδή ο ασθενής αρνείται να εξεταστεί, ή στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης διαδικασίας, ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει τη μεταφορά του σε **δημόσια ψυχιατρική κλινική για εξέταση**. Η παραμονή για αυτή την εξέταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις **48 ώρες**. Το 48ωρο αφορά τη διαδικαστική εγγύηση της εξέτασης· δεν είναι το ανώτατο όριο της ακούσιας νοσηλείας.

Όταν οι δύο γνωματεύσεις συμφωνούν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ο εισαγγελέας διατάσσει τη μεταφορά και την εισαγωγή. Αν οι γνωματεύσεις διαφωνούν, η μεταφορά μπορεί και πάλι να πραγματοποιηθεί και το ζήτημα να κριθεί δικαστικά. Ο εισαγγελέας πρέπει να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο εντός **3 ημερών** από τη διαταγή μεταφοράς, και το δικαστήριο συνεδριάζει εντός **10 ημερών**. Ο ασθενής πρέπει να κλητευθεί τουλάχιστον **48 ώρες πριν από τη συζήτηση** και μπορεί να παραστεί με δικηγόρο και ψυχίατρο ως τεχνικό σύμβουλο. Η διαδικασία γίνεται κεκλεισμένων των θυρών και η απόφαση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο ασθενής λαμβάνει άμεσα εξιτήριο.

Το αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είναι σήμερα το **Μονομελές Πρωτοδικείο**. Παλαιότερη διατύπωση της νομοθεσίας μπορεί να αναφέρει το Πολυμελές Πρωτοδικείο, αλλά αυτή δεν αποτυπώνει τη σημερινή διαδικαστική αρμοδιότητα.

Η νοσηλεία πρέπει να τερματίζεται μόλις πάψουν να συντρέχουν τα νόμιμα κριτήρια. Η συνήθης ανώτατη νόμιμη διάρκεια είναι **6 μήνες**, με προβλεπόμενες εγγυήσεις επανεξέτασης και αναφοράς, μεταξύ άλλων έκθεση μετά τους πρώτους **3 μήνες** και ειδικές προϋποθέσεις για παράταση.

Έχει επίσης αλλάξει το μοντέλο της μεταφοράς. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει **μεταφορά υπό υγειονομική ευθύνη και με διαφύλαξη της αξιοπρέπειας**. Η εμπλοκή της αστυνομίας στην περαιτέρω μεταφορά είναι εξαιρετική και συνδέεται με τις νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων έγγραφη εκτίμηση ψυχιάτρου όταν επικείμενος κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποκλιμάκωση. Η πραγματική διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, αλλά η αστυνομική μεταφορά δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως το συνήθες πρότυπο.

Τέλος, η ακούσια νοσηλεία **δεν εξουσιοδοτεί αυτομάτως κάθε θεραπεία**. Το νομικό καθεστώς της νοσηλείας και η συναίνεση σε συγκεκριμένη ιατρική παρέμβαση είναι διαφορετικά ζητήματα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Οδός I:** ψυχική διαταραχή + αδυναμία κρίσης του συμφέροντος της ίδιας της υγείας + χωρίς νοσηλεία η θεραπεία θα αποκλειόταν ή η υγεία θα επιδεινωνόταν.
- **Οδός II:** ψυχική διαταραχή + η νοσηλεία είναι αναγκαία για την αποτροπή πράξεων βίας κατά του ίδιου ή άλλων.
- **Κρίσιμες προθεσμίες:** παραμονή για εξέταση ≤ 48 ώρες όταν δεν είναι δυνατή προηγούμενη εξέταση· εισαγγελέας προς δικαστήριο εντός 3 ημερών· συνεδρίαση δικαστηρίου εντός 10 ημερών· κλήτευση ≥ 48 ώρες πριν από τη συζήτηση.
- **Σημερινό πρωτοβάθμιο δικαστήριο:** Μονομελές Πρωτοδικείο.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Θεώρηση της επικινδυνότητας ως μοναδικού νόμιμου κριτηρίου.
- Σύγχυση του 48ώρου εξέτασης με τη διάρκεια της ακούσιας νοσηλείας.
- Παρουσίαση της αστυνομικής μεταφοράς ως του συνήθους σύγχρονου μοντέλου.
- Σύγχυση της ακούσιας νοσηλείας με απεριόριστη ακούσια θεραπεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ενημέρωση για δικαστήριο και μεταφορά: Παλαιότερες διατυπώσεις μπορεί να αναφέρουν το Πολυμελές Πρωτοδικείο και να περιγράφουν αστυνομικοκεντρική μεταφορά. Σήμερα η πρωτοβάθμια αρμοδιότητα ανήκει στο **Μονομελές Πρωτοδικείο** και το νομοθετικό μοντέλο μεταφοράς είναι υγειονομικό, με αστυνομική εμπλοκή μόνο κατ' εξαίρεση και υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Μη θεσπισμένη πρόταση μεταρρύθμισης δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ισχύον δίκαιο.

Πώς αναγνωρίζετε την κατατονία και πώς την αντιμετωπίζετε;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αναγνωρίστε τουλάχιστον τρία κατατονικά σημεία
- 2 Σκεφτείτε διαγνωστικά πέρα από μία μόνο κατηγορία
- 3 Αναζητήστε ιατρικά, νευρολογικά, τοξικολογικά αίτια και σύνδρομα στέρησης
- 4 Αντιμετωπίστε παράλληλα τις σωματικές επιπλοκές
- 5 Λοραζεπάμη / δοκιμασία λοραζεπάμης
- 6 Κλιμάκωση σε ECT όταν χρειάζεται
- 7 Προσοχή στα αντιψυχωσικά, ιδιαίτερα σε κακοήθη εικόνα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κατατονία είναι **διαδιαγνωστικό ψυχοκινητικό σύνδρομο**, όχι υπότυπος της σχιζοφρένειας. Την αναγνωρίζω από συνδυασμό χαρακτηριστικών κινητικών, συμπεριφορικών και γλωσσικών/ομιλητικών διαταραχών, αναζητώ ενεργά ψυχιατρικά και ιατρικά αίτια, αντιμετωπίζω ταυτόχρονα τις σωματικές επιπλοκές και ξεκινώ έγκαιρα θεραπεία με βενζοδιαζεπίνη, με πρώιμη προσφυγή σε ECT όταν η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής ή η κατάσταση είναι σοβαρή.

Ένα πρακτικό σύγχρονο διαγνωστικό όριο είναι η παρουσία **τριών ή περισσότερων κατατονικών σημείων**. Η εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει μειωμένη δραστηριότητα, όπως εμβροντησία και αλαλία· χαρακτηριστικά ψυχοκινητικά φαινόμενα όπως κατατονική στάση, καταληψία ή κηρώδη ευκαμψία, αρνητισμό, μανιερισμούς, στερεοτυπίες, μορφασμούς και ηχωφαινόμενα· ή μια **διεγερμένη μορφή**. Η τελευταία είναι σημαντική, γιατί η κατατονία μπορεί να διαφύγει αν ο κλινικός περιμένει μόνο έναν ακίνητο ασθενή. Μια δομημένη εξέταση ή κλίμακα όπως η **BFCRS** μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση και παρακολούθηση των σημείων, αλλά δεν αντικαθιστά την κλινική διάγνωση και τη διερεύνηση της αιτιολογίας.

Η κατατονία μπορεί να εμφανιστεί σε **διαταραχές διάθεσης, ψυχωσικές διαταραχές, αυτισμό, νευρολογικές και άλλες ιατρικές παθήσεις, καθώς και σε καταστάσεις που σχετίζονται με ουσίες ή φάρμακα**. Γι' αυτό λαμβάνω ετεροαναφορικές πληροφορίες, κάνω σωματική και νευρολογική εξέταση και ζητώ στοχευμένο παρακλινικό έλεγχο ανάλογα με την κλινική εικόνα, με ειδική αναζήτηση ιατρικών, νευρολογικών, τοξικολογικών αιτίων και συνδρόμων στέρησης.

Παράλληλα αντιμετωπίζω τις **ιατρικές και υποστηρικτικές ανάγκες**. Ανάλογα με τον ασθενή, μπορεί να υπάρχουν αφυδάτωση ή ανεπαρκής θρέψη, επιπλοκές της ακινησίας, κατακλίσεις, εισρόφηση, θρομβοεμβολή και άλλοι ιατρικοί κίνδυνοι. Η θεραπεία της κατατονίας και η αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου προχωρούν παράλληλα.

Οι βενζοδιαζεπίνες και η ECT είναι θεραπείες πρώτης γραμμής. Η λοραζεπάμη χρησιμοποιείται συχνά και μια δοκιμασία λοραζεπάμης μπορεί να υποστηρίξει τη

διάγνωση και να δείξει θεραπευτική ανταπόκριση. Το επαληθευμένο εύρος της δοκιμασίας είναι **1–2 mg IV ή IM, ή 2 mg από του στόματος**. Η δοκιμασία είναι χρήσιμη αλλά όχι υποχρεωτική: η μη ανταπόκριση δεν αποκλείει την κατατονία και δεν πρέπει να καθυστερεί τη θεραπεία.

Η ECT ενδείκνυται όταν οι βενζοδιαζεπίνες είναι αναποτελεσματικές ή ανεπαρκείς, όταν η κατάσταση είναι σοβαρή ή ενέχει σημαντικό ιατρικό κίνδυνο και ιδιαίτερα στην κακοήθη κατατονία. Οι ανταγωνιστές ντοπαμίνης και τα αντιψυχωσικά χρειάζονται προσοχή στην κατατονία, ιδίως όταν υπάρχει πιθανότητα κακοήθους κατατονίας ή κακοήθους νευροληπτικού συνδρόμου (NMS).

Αν ο ασθενής εμφανίζει **πυρετό, αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος και δυσκαμψία**, αντιμετωπίζω την κατάσταση ως ιατρικό επείγον. Εξετάζω κακοήθη κατατονία και το σημαντικό επικαλυπτόμενο ενδεχόμενο του NMS, διακόπτω τους ανταγωνιστές ντοπαμίνης όταν υποψιάζομαι κακοήθη κατατονία, παρέχω άμεση ιατρική και υποστηρικτική φροντίδα και χορηγώ λοραζεπάμη. Αν η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, η κλιμάκωση σε ECT πρέπει να γίνει γρήγορα και όχι να καθυστερήσει· οι **48–72 ώρες** αποτελούν το σχετικό χρονικό σημείο αναφοράς για την επείγουσα κλιμάκωση σε κακοήθη εικόνα.

Το βασικό είναι να μη περιμένω πλήρη νοσολογική βεβαιότητα ενώ ο ασθενής επιδεινώνεται. Η αναγνώριση του συνδρόμου, η διερεύνηση και θεραπεία δευτεροπαθών αιτίων, η υποστηρικτική φροντίδα και η έγκαιρη θεραπεία με λοραζεπάμη ή ECT πρέπει να προχωρούν μαζί.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό σύγχρονο διαγνωστικό όριο: **≥3 κατατονικά σημεία**.
- Δοκιμασία λοραζεπάμης: **1–2 mg IV/IM ή 2 mg από του στόματος**.
- Κακοήθης κατατονία: διακόπτετε τους ανταγωνιστές ντοπαμίνης, χορηγείτε άμεσα λοραζεπάμη και κλιμακώνετε γρήγορα σε ECT αν η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής· οι **48–72 ώρες** είναι το τρέχον χρονικό σημείο αναφοράς για την επείγουσα κλιμάκωση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι αλλάζει αν ο ασθενής έχει επίσης πυρετό, αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος και δυσκαμψία;

Αντιμετωπίζω την κατάσταση ως επείγον επιπέδου κακοήθους κατατονίας/NMS. Χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση και υποστηρικτική φροντίδα, διακοπή ανταγωνιστών ντοπαμίνης όταν υπάρχει υποψία κακοήθους κατατονίας και άμεση έναρξη λοραζεπάμης. Αν η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, κλιμακώνω γρήγορα σε ECT αντί να περιμένω· οι **48–72 ώρες** είναι το σχετικό χρονικό σημείο αναφοράς για την επείγουσα κλιμάκωση.

Το NMS είναι σημαντική επικαλυπτόμενη διαφορική διάγνωση. Ελέγχω πρόσφατη έκθεση σε ανταγωνιστές ντοπαμίνης ή διακοπή ντοπαμινεργικών παραγόντων, δυσκαμψία, υπερθερμία, αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, CK και άλλες ιατρικές επιπλοκές, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει σημαντική κλινική επικάλυψη. Σε ασθενή που επιδεινώνεται ιατρικά, η οριστική αντιμετώπιση δεν

πρέπει να καθυστερεί μέχρι να υπάρξει απόλυτη διαγνωστική βεβαιότητα.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Περιορισμός της κατατονίας στη σχιζοφρένεια.
- Παράβλεψη διεγερμένης κατατονίας επειδή ο ασθενής δεν είναι σε εμβροντησία.
- Αντανακλαστική χορήγηση αντιψυχωσικών πριν εξεταστούν κακοήθης κατατονία ή NMS.
- Καθυστέρηση της ECT σε ιατρικά ασταθή κακοήθη εικόνα.

Ασθενής 23 ετών προσέρχεται με διωκτικές ιδέες, ακουστικές ψευδαισθήσεις και κοινωνική απόσυρση. Πώς προσεγγίζετε το περιστατικό;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Πρώτα η ασφάλεια — κίνδυνος, διέγερση, αυτοπαραμέληση, τοξίκωση/στέρηση, ντελίριο/κατατονία, ιατρική αστάθεια.
- 2 Ορίστε το σύνδρομο και την πορεία — ψυχωσικά, αρνητικά, συναισθηματικά, αποδιοργανωτικά και κατατονικά στοιχεία.
- 3 Ετεροαναφορικές πληροφορίες, ουσίες και φάρμακα — χρονική σχέση, έκθεση και λειτουργικότητα.
- 4 Σωματική/νευρολογική εκτίμηση — στοχευμένη διερεύνηση δευτεροπαθών αιτίων.
- 5 Διαφορική διάγνωση — πρωτοπαθής ψύχωση, ψύχωση στο πλαίσιο διαταραχής διάθεσης, επαγόμενη από ουσίες/φάρμακα, ιατρική/νευρολογική αιτία.
- 6 Έγκαιρη σύνδεση με θεραπεία και παρέμβαση — υπηρεσία πρώιμης παρέμβασης, αντιψυχωσικό και ψυχολογική/οικογενειακή φροντίδα.
- 7 Διαχρονική διάγνωση — πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο δεν σημαίνει αυτομάτως σχιζοφρένεια.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα το αντιμετωπίζα ως **πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο**, όχι ως ήδη τεκμηριωμένη σχιζοφρένεια. Πρώτα πρέπει να διαπιστώσω αν υπάρχει άμεσο πρόβλημα ασφάλειας ή ιατρικό επείγον, στη συνέχεια να ορίσω το σύνδρομο και την πορεία του, να αναζητήσω ενεργά δευτεροπαθή αίτια, να ξεκινήσω την κατάλληλη πρώιμη θεραπεία και να κρατήσω την τελική διάγνωση ανοιχτή μέχρι να αποσαφηνιστεί η διαχρονική εικόνα.

Η άμεση εκτίμηση περιλαμβάνει **κίνδυνο για τον εαυτό ή άλλους**, σοβαρή διέγερση, αυτοπαραμέληση ή αδυναμία βασικής αυτοφροντίδας, τοξίκωση ή σύνδρομο στέρησης, καθώς και σημεία ντελίου, κατατονίας ή άλλης ιατρικής αστάθειας. Η ανάγκη για επείγουσα προστασία ή εισαγωγή καθορίζεται από την κλινική ανάγκη και τον κίνδυνο, όχι από τη διαγνωστική ετικέτα.

Στη συνέχεια λαμβάνω πλήρες ψυχιατρικό ιστορικό και κάνω λεπτομερή εξέταση παρούσας ψυχικής κατάστασης. Προσδιορίζω την έναρξη και την εξέλιξη των διωκτικών ιδεών, των ψευδαισθήσεων και της κοινωνικής απόσυρσης και αναζητώ συστηματικά άλλα θετικά συμπτώματα, αποδιοργάνωση, αρνητικά συμπτώματα, συμπτώματα διάθεσης και κατατονικά στοιχεία. Η εναισθησία, η μεταβολή στην κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα και ο βαθμός διαταραχής της συμπεριφοράς έχουν ιδιαίτερη σημασία. Οι **ετεροαναφορικές πληροφορίες** είναι συχνά απαραίτητες, ιδίως για τον χρόνο έναρξης της επιδείνωσης, τη χρήση ουσιών, τη λειτουργικότητα και πιθανά προηγούμενα επεισόδια.

Είναι απαραίτητο ένα προσεκτικό **ιστορικό ουσιών και φαρμάκων**. Διερευνώ τι έχει χρησιμοποιηθεί, με ποιο πρότυπο και ένταση και ποια είναι η χρονική σχέση της έκθεσης με την ψύχωση. Ένα θετικό τοξικολογικό αποτέλεσμα τεκμηριώνει

έκθεση, αλλά δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι η ουσία προκάλεσε την ψύχωση.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης **σωματική και νευρολογική εξέταση**, με παρακλινικό έλεγχο που καθοδηγείται από το ιστορικό, την εξέταση και την κλινική υποψία δευτεροπαθούς αιτίας. Η δομική απεικόνιση εγκεφάλου ρουτίνας δεν απαιτείται σε κάθε κατά τα άλλα ανεπίπλεκτο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο.

Η βασική διαφορική διάγνωση είναι μεταξύ πρωτοπαθούς διαταραχής του φάσματος της σχιζοφρένειας, διαταραχής διάθεσης με ψυχωσικά συμπτώματα ή σχιζοσυναισθηματικής εικόνας, ψύχωσης επαγόμενης από ουσίες ή φάρμακα και ιατρικής ή νευρολογικής αιτίας. Η διάκριση βασίζεται κυρίως στη χρονική αλληλουχία, στο ευρύτερο σύνδρομο και στην πορεία και όχι στο περιεχόμενο μιας ψευδαίσθησης ή μιας παραληρητικής ιδέας μόνο.

Όπου υπάρχει δυνατότητα, συνδέω τον ασθενή **χωρίς καθυστέρηση με υπηρεσία πρώιμης παρέμβασης στην ψύχωση** και εξασφαλίζω πολυεπιστημονική αξιολόγηση. Όταν έχει τεκμηριωθεί πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, η θεραπεία συνδυάζει από του στόματος αντιψυχωσικό με ψυχολογική και οικογενειακή παρέμβαση. Η επιλογή του αντιψυχωσικού γίνεται με **από κοινού λήψη αποφάσεων**, με αρχές δοσολογίας προς το χαμηλότερο άκρο του εγκεκριμένου εύρους και παρακολούθηση ανταπόκρισης, ανεκτικότητας και συνεργασίας με τη θεραπεία.

Τέλος, κρατώ τη διάγνωση ρητά **διαχρονική**. Στην πρώτη παρουσίαση μπορεί να υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να αναγνωρίσω ψύχωση, όχι όμως απαραίτητα για να καθορίσω την τελική διαταραχή. Η εξέλιξη των συμπτωμάτων, τα επεισόδια διάθεσης, η σχέση με ουσίες, η λειτουργική πορεία και η επιμονή των συμπτωμάτων στον χρόνο μπορεί να μεταβάλουν τη διαγνωστική κατηγορία.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Υπάρχει βαριά χρήση κάνναβης. Πότε θα μιλούσατε για ψύχωση επαγόμενη από ουσία και πότε για πρωτοπαθή ψυχωσική διαταραχή;

Μια διάγνωση επαγόμενη από ουσία προϋποθέτει εύλογη χρονική σχέση της ψύχωσης με τοξίκωση ή στέρηση από κάνναβη, με συμπτώματα που υπερβαίνουν τα συνήθη παροδικά φαινόμενα της τοξίκωσης ή της στέρησης. Πρωτοπαθής ψυχωσική διαταραχή γίνεται πιθανότερη αν η ψύχωση σαφώς προϋπήρχε της σχετικής έκθεσης στην κάνναβη, επιμένει για σημαντικό διάστημα μετά τη διακοπή ή έχουν υπάρξει προηγούμενα ψυχωσικά επεισόδια ανεξάρτητα από την κάνναβη. Εξετάζω το πρότυπο και την ένταση της χρήσης, την πορεία κατά την αποχή, ετεροαναφορικές πληροφορίες και το συνολικό διαχρονικό φαινότυπο. Δεν υπάρχει ένα καθολικό χρονικό διάστημα αποχής που πρέπει να απαγγέλλεται μηχανικά.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Άμεσος χαρακτηρισμός της εικόνας ως σχιζοφρένειας.
- Απόδοση αιτιότητας στην κάνναβη μόνο από ένα θετικό δείγμα ούρων.
- Δομική απεικόνιση εγκεφάλου ρουτίνας χωρίς κλινική ένδειξη.
- Θεώρηση της ψυχολογικής και οικογενειακής παρέμβασης ως κάτι που αφορά μόνο χρόνια νόσο.

Περιγράψτε την κλινική εικόνα και τη διάγνωση της σχιζοφρένειας.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Σύνδρομο ανά πεδίο — θετικά, αρνητικά, αποδιοργανωτικά και γνωστικά συμπτώματα.
- 2 Κλινική έκφραση — στην οξεία φάση συχνά προεξάρχουν θετικά συμπτώματα και αποδιοργάνωση· μακροπρόθεσμα μπορεί να κυριαρχούν αρνητικά συμπτώματα και γνωστική δυσλειτουργία.
- 3 Διαχρονική διάγνωση — πρότυπο, πορεία, διάρκεια και λειτουργικότητα.
- 4 Αποκλεισμός εναλλακτικών εξηγήσεων — διαταραχές διάθεσης, ουσίες/φάρμακα, ιατρικά/νευρολογικά αίτια.
- 5 Κλασική ψυχοπαθολογία στο σωστό πλαίσιο — συμπτώματα πρώτης τάξης και ιστορικοί υπότυποι.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η σχιζοφρένεια είναι ένα ετερογενές πρωτοπαθές ψυχωσικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συνδυασμούς θετικών, αρνητικών, αποδιοργανωτικών και γνωστικών διαταραχών. Η διάγνωση είναι συνδρομική και διαχρονική και δεν στηρίζεται σε ένα μεμονωμένο ψυχωσικό σύμπτωμα: σημασία έχουν το συνολικό πρότυπο, η επιμονή και η πορεία της νόσου, η επίδραση στη λειτουργικότητα και ο αποκλεισμός εναλλακτικών αιτίων. Επομένως, ένα πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο δεν είναι αυτομάτως σχιζοφρένεια.

Στο πεδίο των **θετικών συμπτωμάτων** ανήκουν οι παραληρητικές ιδέες και οι ψευδαισθήσεις. Οι ακουστικές ψευδαισθήσεις είναι συχνές και κλασικά προεξάρχουν, αλλά δεν είναι ειδικές για τη σχιζοφρένεια. Τα φαινόμενα παθητικότητας και διατάραξης της κυριότητας της σκέψης —όπως παρεμβολή ξένων σκέψεων, απόσυρση της σκέψης ή εκπομπή της σκέψης— είναι επίσης κλασικά στοιχεία της σχιζοφρενικής ψυχοπαθολογίας, χωρίς κανένα από αυτά να επαρκεί μόνο του για τη διάγνωση.

Η **αποδιοργάνωση** περιλαμβάνει διαταραχή της μορφής της σκέψης ή αποδιοργανωμένο λόγο, καθώς και αποδιοργανωμένη ή απρόσφορη συμπεριφορά· μπορεί επίσης να υπάρχει απρόσφορο ή ασύμφωνο συναίσθημα. Η κλινική εικόνα επομένως δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο της σκέψης και την αντίληψη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και εκφράζονται η σκέψη και η συμπεριφορά.

Το πεδίο των **αρνητικών συμπτωμάτων** έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή μπορεί να καθορίζει σημαντικό μέρος της επίμονης λειτουργικής έκπτωσης. Τα βασικά πεδία είναι η μειωμένη συναισθηματική έκφραση ή το αμβλύ συναίσθημα, η αλογία, η αβουλία, η ανηδονία και η ασυναισθησία/μειωμένη κοινωνική κινητοποίηση. Φαινομενικά αρνητικά συμπτώματα δεν πρέπει να θεωρούνται αυτομάτως πρωτοπαθή: κοινωνική απόσυρση, αδράνεια ή μειωμένη έκφραση μπορεί να οφείλονται σε κατάθλιψη, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, ενεργό ψύχωση ή περιβαλλοντική αποστέρηση.

Η **γνωστική δυσλειτουργία** είναι επίσης συχνή και λειτουργικά σημαντική και μπορεί να αφορά την προσοχή, τη μνήμη εργασίας, τη μάθηση και τη μνήμη, τις εκτελεστικές λειτουργίες και την κοινωνική γνωσία. Μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργική έκπτωση, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της διαγνωστικό κριτήριο για τη σχιζοφρένεια. Μπορούν επίσης να εμφανιστούν συμπτώματα διάθεσης και ψυχοκινητικά ή κατατονικά φαινόμενα, τα οποία ερμηνεύονται μέσα στο συνολικό σύνδρομο.

Η σχετική βαρύτητα αυτών των πεδίων ποικίλλει. Στις οξείες φάσεις συχνά προεξάρχουν τα θετικά συμπτώματα και η αποδιοργάνωση, ενώ η μακροχρόνια λειτουργική έκπτωση μπορεί να κυριαρχείται από αρνητικά και γνωστικά προβλήματα. Πρόκειται για χρήσιμη περιγραφή της κλινικής έκφρασης και όχι για άκαμπτο σύστημα υποτύπων ή σταδιοποίησης.

Η διάγνωση απαιτεί **διαχρονική αξιολόγηση**. Πρέπει να υπάρχει επίμονο χαρακτηριστικό σύνδρομο και όχι παροδικό ή μεμονωμένο ψυχωσικό φαινόμενο, με συνεκτίμηση της πορείας, της διάρκειας και της σχετικής μεταβολής στη λειτουργικότητα. Τα σύγχρονα διαγνωστικά συστήματα διαφέρουν στην ακριβή δομή τους· ως συγκεκριμένο σημείο αναφοράς του DSM-5-TR, η σχιζοφρένεια απαιτεί συνολική διάρκεια διαταραχής τουλάχιστον **6 μηνών**, με ενεργό φάση μέσα σε αυτό το διάστημα. Το χρονικό αυτό όριο είναι χρήσιμο για τις εξετάσεις, αλλά η διάγνωση εξακολουθεί να εξαρτάται από ολόκληρη την κλινική εικόνα και όχι από τη διάρκεια μόνη της.

Πρέπει να αποκλείω ενεργά εναλλακτικές εξηγήσεις. Έντονα ή παρατεταμένα σύνδρομα διάθεσης εγείρουν την πιθανότητα ψύχωσης στο πλαίσιο διαταραχής διάθεσης ή σχιζοσυναισθηματικής εικόνας, ενώ πρέπει να εξετάζονται καταστάσεις επαγόμενες από ουσίες ή φάρμακα και ιατρικά ή νευρολογικά αίτια. Η εξέλιξη ενός πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου στον χρόνο είναι συχνά διαγνωστικά καθοριστική.

Τέλος, τα **συμπτώματα πρώτης τάξης κατά Schneider** παραμένουν σημαντική κλασική ψυχοπαθολογία, αλλά δεν είναι παθογνωμονικά ούτε έχουν προνομιακή διαγνωστική θέση στις σύγχρονες ταξινομήσεις. Αντίστοιχα, οι παλαιοί υπότυποι —παρανοειδής, ηβηφρενικός, κατατονικός και υπολειμματικός— είναι ιστορικοί· σήμερα προτιμάται διαστατική και διαχρονική περιγραφή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Κλασικά φαινόμενα Schneider που πρέπει να αναγνωρίζονται** — οι ιστορικές λίστες ποικίλλουν, αλλά βασικές ομάδες είναι:
- ακουστές ή ηχητικά επαναλαμβανόμενες σκέψεις,
- φωνές σε γ' πρόσωπο που σχολιάζουν ή συζητούν,
- παρεμβολή ξένων σκέψεων, απόσυρση της σκέψης ή εκπομπή της σκέψης,
- σωματική παθητικότητα,
- παραληρητική αντίληψη,
- επιβαλλόμενες εμπειρίες/παθητικότητα που αφορούν συναίσθημα, παρόρμηση ή πράξη.

Πρόκειται για κλασικά περιγραφικά φαινόμενα, όχι παθογνωμονικά σημεία.

- **Χρονικό σημείο αναφοράς του DSM-5-TR:** συνολική διαταραχή διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, με ενεργό φάση συμπτωμάτων.
- **Κλασικοί υπότυποι:** οι όροι παρανοειδής, ηβηφρενικός, κατατονικός και υπολειμματικός είναι ιστορικοί και όχι σημερινοί επίσημοι υπότυποι.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χαρακτηρισμός των συμπτωμάτων πρώτης τάξης ως παθογνωμονικών.
- Διάγνωση σχιζοφρένειας από ένα μόνο εγκάρσιο ψυχωσικό επεισόδιο.
- Παρουσίαση των κλασικών υποτύπων ως σημερινών επίσημων διαγνώσεων.
- Εξίσωση της κοινωνικής απόσυρσης ή αδράνειας με πρωτοπαθή αρνητικά συμπτώματα.
- Αντιμετώπιση της γνωστικής δυσλειτουργίας ως διαγνωστικού κριτηρίου.
- Μετατροπή της Q12 σε πλήρη διαφορική διάγνωση σχιζοφρένειας έναντι σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής και ψύχωσης στο πλαίσιο διαταραχών διάθεσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

- **Εξέλιξη της ταξινόμησης:** Παλαιότερες ταξινομήσεις χρησιμοποιούσαν κλασικούς υποτύπους της σχιζοφρένειας. Οι σύγχρονες ταξινομήσεις δεν διατηρούν αυτό το σχήμα· χρησιμοποιούμε διαστατική και διαχρονική περιγραφή, αλλά αναγνωρίζουμε τους ιστορικούς όρους αν ζητηθούν.
- **Συμπτώματα πρώτης τάξης:** Ιστορικά είχαν μεγάλη διαγνωστική βαρύτητα. Παραμένουν χρήσιμη περιγραφική ψυχοπαθολογία και κλασικό εξεταστικό υλικό, αλλά οι σύγχρονες ταξινομήσεις δεν τα θεωρούν παθογνωμονικά ούτε διαγνωστικά προνομιακά.

Πώς διακρίνεται τη σχιζοφρένεια από τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και τη διαταραχή διάθεσης με ψυχωσικά χαρακτηριστικά;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Χαρτογραφήστε τη διαχρονική σχέση ψύχωσης και επεισοδίων διάθεσης.
- 2 Υπάρχει πλήρες σύνδρομο σχιζοφρένειας;
- 3 Η ψύχωση εμφανίζεται μόνο μέσα σε επεισόδια διάθεσης; — σκεφτείτε διαταραχή διάθεσης με ψυχωσικά χαρακτηριστικά.
- 4 Συνυπάρχουν πλήρες σύνδρομο σχιζοφρένειας και πλήρες σύνδρομο διάθεσης; — εξετάστε σχιζοσυναισθηματική διαταραχή.
- 5 Δηλώστε το σύστημα ταξινόμησης — ICD-11 και DSM-5-TR χρησιμοποιούν διαφορετική λογική.
- 6 Επανεκτιμήστε διαχρονικά καθώς αποσαφηνίζεται η πορεία.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η βασική διάκριση είναι **διαχρονική**, όχι διάκριση με βάση το περιεχόμενο ή τη βαρύτητα ενός μεμονωμένου ψυχωσικού συμπτώματος. Χαρτογραφώ τότε υπάρχει ψύχωση σε σχέση με καταθλιπτικά, μανιακά ή μεικτά επεισόδια, αν πληρούνται πλήρες σύνδρομο σχιζοφρένειας, αν η ψύχωση εμφανίζεται αποκλειστικά κατά τα επεισόδια διάθεσης και αν πλήρες σύνδρομο σχιζοφρένειας και πλήρες σύνδρομο διάθεσης συνυπάρχουν. Για τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή εφαρμόζω ένα σύστημα ταξινόμησης κάθε φορά και δεν αναμειγνύω ICD-11 και DSM-5-TR.

Στη **σχιζοφρένεια**, μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα διάθεσης, αλλά τα επεισόδια διάθεσης δεν οργανώνουν την πορεία της νόσου. Η κλινική εικόνα είναι πρωτίστως σύνδρομο σχιζοφρένειας και η διάγνωση βασίζεται στη χαρακτηριστική διαχρονική πορεία, όχι στο αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν καταθλιπτικά συμπτώματα σε μια συγκεκριμένη εξέταση.

Σε **διαταραχή διάθεσης με ψυχωσικά χαρακτηριστικά**, η ψύχωση εμφανίζεται μέσα στο επεισόδιο διάθεσης. Εκτός του καταθλιπτικού ή μανιακού επεισοδίου δεν τεκμηριώνεται το ψυχωσικό σύνδρομο που απαιτείται για τη σχιζοφρένεια. Το είδος της παραληρητικής ιδέας ή της ψευδαίσθησης δεν διακρίνει αξιόπιστα τις διαγνώσεις· αυτό που έχει σημασία είναι η χρονική σχέση της ψύχωσης με το σύνδρομο διάθεσης.

Η **σχιζοσυναισθηματική διαταραχή** είναι η δυσκολότερη ενδιάμεση κατηγορία, και εδώ πρέπει να αποφεύγεται η ανάμειξη διαγνωστικών συστημάτων. Στο ICD-11 η λογική είναι επεισοδιακή: ο ασθενής πρέπει να πληροί πλήρως τις απαιτήσεις για σχιζοφρένεια και ταυτόχρονα να έχει μέτριο ή σοβαρό καταθλιπτικό, μανιακό ή μεικτό επεισόδιο που συνυπάρχει για τουλάχιστον **1 μήνα**, με τα δύο σύνδρομα να ξεκινούν περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Το ICD-11 **δεν απαιτεί** περίοδο ψύχωσης χωρίς συμπτώματα διάθεσης.

Το DSM-5-TR χρησιμοποιεί διαφορετική, διαχρονική λογική για όλη την πορεία της

νόσου. Απαιτεί κάποια περίοδο τουλάχιστον 2 εβδομάδων παραληρητικών ιδεών ή ψευδαισθήσεων χωρίς μείζον επεισόδιο διάθεσης, ενώ τα μείζονα επεισόδια διάθεσης πρέπει να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής διάρκειας της νόσου. Ο γνωστός κανόνας των δύο εβδομάδων είναι επομένως ειδικός για το DSM-5-TR και δεν αποτελεί καθολικό ορισμό της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής.

Πρέπει επίσης να κρατώ καθαρά τα χρονικά κριτήρια. Η λογική του ICD-11 για ταυτόχρονο επεισόδιο ενός μήνα δεν πρέπει να συγχέεται με το πλαίσιο του DSM για τη σχιζοφρένεια, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής διάρκειας διαταραχής έξι μηνών.

Στις πρώιμες φάσεις η διάγνωση μπορεί να παραμένει αβέβαιη επειδή δεν έχει ακόμη διαφανεί η απαραίτητη χρονική πορεία. Η επανειλημμένη αξιολόγηση των επεισοδίων διάθεσης, της ψύχωσης, της συνολικής πορείας και της λειτουργικότητας είναι συχνά αυτή που λύνει τη διαγνωστική αβεβαιότητα. Η πιο ασφαλής προσέγγιση είναι να φτιάξω πρώτα το χρονοδιάγραμμα, να προσδιορίσω ποια πλήρη σύνδρομα υπάρχουν και τότε επικαλύπτονται και μετά να εφαρμόσω με συνέπεια το επιλεγμένο σύστημα ταξινόμησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR — σχιζοσυναισθηματική διαταραχή:** τουλάχιστον 2 εβδομάδες παραληρητικών ιδεών ή ψευδαισθήσεων χωρίς μείζον επεισόδιο διάθεσης σε κάποιο σημείο της νόσου, με τα μείζονα επεισόδια διάθεσης να καταλαμβάνουν την πλειονότητα της συνολικής διάρκειας της νόσου.
- **ICD-11 — σχιζοσυναισθηματική διαταραχή:** πλήρες σύνδρομο σχιζοφρένειας μαζί με μέτριο/σοβαρό καταθλιπτικό, μανιακό ή μεικτό επεισόδιο που συνυπάρχουν για τουλάχιστον 1 μήνα, με περίπου ταυτόχρονη έναρξη· δεν απαιτείται ψύχωση εκτός επεισοδίου διάθεσης.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χρήση του περιεχομένου της ψύχωσης για να διακριθούν οι διαγνώσεις.
- Χαρακτηρισμός κάθε συμπτώματος διάθεσης στη σχιζοφρένεια ως «σχιζοσυναισθηματικού».
- Εφαρμογή του κανόνα των 2 εβδομάδων του DSM σαν να ήταν απαίτηση του ICD-11.
- Ανάμειξη χρονικών κανόνων ICD-11 και DSM στο ίδιο διαγνωστικό σκεπτικό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαφορά ταξινομητικών συστημάτων: Ο κλασικός κανόνας «δύο εβδομάδες ψύχωσης χωρίς συμπτώματα διάθεσης» ανήκει στο DSM-5-TR, όχι στο ICD-11. Το ICD-11 χρησιμοποιεί ορισμό βασισμένο σε ταυτόχρονα επεισόδια. Το ίδιο διαχρονικό ιστορικό μπορεί επομένως να ταξινομηθεί διαφορετικά ανάλογα με το σύστημα που εφαρμόζεται· δηλώστε ποιο σύστημα χρησιμοποιείτε και μείνετε συνεπείς σε αυτό.

Τι γνωρίζουμε για τη νευροβιολογία της σχιζοφρένειας;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Πολυγονιδιακή ευαλωτότητα και νευροανάπτυξη
- 2 Περιβαλλοντικοί και αναπτυξιακοί παράγοντες κινδύνου
- 3 Διαταραχές κυκλωμάτων και συνδεσιμότητας
- 4 Απορρύθμιση της ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα
- 5 Υποθέσεις γλουταμινικού/NMDA
- 6 Άλλα αλληλεπιδρώντα συστήματα
- 7 Δεν υπάρχει ατομικός διαγνωστικός βιοδείκτης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η σχιζοφρένεια κατανοείται καλύτερα ως βιολογικά ετερογενής, έντονα πολυγονιδιακή διαταραχή με νευροαναπτυξιακές και κυκλωματικές ανωμαλίες, όχι ως νόσος που εξηγείται από ένα γονίδιο, έναν νευροδιαβιβαστή ή μία εγκεφαλική περιοχή. Το ισχυρότερο σύγχρονο μοντέλο είναι πολυεπίπεδο: η γενετική ευαλωτότητα αλληλεπιδρά με αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, με αποτέλεσμα μεταβολές σε εγκεφαλικά συστήματα που συμβάλλουν στην ψύχωση, στη γνωστική δυσλειτουργία και στα αρνητικά συμπτώματα. Κανένα από αυτά τα ευρήματα δεν αποτελεί σήμερα διαγνωστικό βιοδείκτη για τον μεμονωμένο ασθενή.

Γενετικά, η σχιζοφρένεια είναι έντονα πολυγονιδιακή. Η ευαλωτότητα κατανέμεται σε πολλές κοινές γενετικές παραλλαγές μικρού μεμονωμένου αποτελέσματος, μαζί με σπανιότερες παραλλαγές και παραλλαγές αριθμού αντιγράφων (CNVs) που σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επίδραση. Χρήσιμο παράδειγμα είναι η μικροέλλειψη 22q11.2, αλλά ούτε αυτή ούτε οποιαδήποτε άλλη μεμονωμένη παραλλαγή είναι αναγκαία ή επαρκής για την τυπική σχιζοφρένεια. Το κλινικό μήνυμα είναι γενετική ευαλωτότητα, όχι γενετικό πεπρωμένο.

Το νευροαναπτυξιακό πλαίσιο παραμένει χρήσιμο, επειδή διαταραχές σε αναπτυξιακές και συναπτικές διεργασίες μπορεί να προηγούνται του πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου. Γνωστικές, κοινωνικές ή κινητικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν πριν από την έκδηλη ψύχωση. Περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές συσχετίσεις περιλαμβάνουν έκθεση σε κάναβη, μετανάστευση ή στρες μειονότητας, διαβίωση σε αστικό περιβάλλον (urbanicity), αντιξοότητες της παιδικής ηλικίας και μαιευτικές ή άλλες αναπτυξιακές εκθέσεις. Πρόκειται για πιθανολογικές συσχετίσεις κινδύνου, όχι για ντετερμινιστικές αιτίες.

Σε νευροχημικό επίπεδο, το πιο σταθερό εύρημα παραμένει η **απορρύθμιση της ντοπαμίνης**, ιδίως η αυξημένη προσυναπτική σύνθεση και απελευθέρωση ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα στην ψύχωση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σχέση με τα θετικά συμπτώματα και την παθολογική απόδοση σημασίας (aberrant salience). Είναι ακριβέστερο από το να λέμε ότι η σχιζοφρένεια οφείλεται σε «υπερβολική ντοπαμίνη παντού», επειδή οι ντοπαμινεργικές ανωμαλίες εξαρτώνται από την οδό

και την κλινική κατάσταση και δεν εξηγούν ολόκληρο το σύνδρομο.

Σημαντικά είναι επίσης τα **μοντέλα γλουταμινεργικής δυσλειτουργίας και υπολειτουργίας των υποδοχέων NMDA**. Μια επιδραστική υπόθεση προτείνει υπολειτουργία των NMDA υποδοχέων σε φλοιώδη ανασταλτικά ενδονευρωνικά κυκλώματα, με επακόλουθη άρση αναστολής των κυκλωμάτων και επιδράσεις στη ντοπαμίνη του ραβδωτού σώματος. Πρόκειται για χρήσιμο μηχανιστικό μοντέλο, όχι για αποδεδειγμένη μοναδική αιτιολογική αλυσίδα. Αντίστοιχα, GABAεργικά, σεροτονινεργικά και ανοσολογικά/φλεγμονώδη συστήματα μπορεί να συμβάλλουν, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως ανεξάρτητα αποδεδειγμένες αιτίες.

Η δομική και λειτουργική νευροαπεικόνιση δείχνει αναπαραγώγιμες **διαφορές σε επίπεδο ομάδων**, όπως διεύρυνση κοιλιών, μεταβολές στη φαιά ουσία του φλοιού, στον ιππόκαμπο και στον θάλαμο και ευρύτερες διαταραχές συνδεσιμότητας. Υπάρχει όμως σημαντική επικάλυψη με υγιή άτομα και με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, επομένως η MRI ή η λειτουργική απεικόνιση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικό τεστ σχιζοφρένειας στον μεμονωμένο ασθενή.

Το κλινικά χρήσιμο συμπέρασμα είναι ότι η σχιζοφρένεια έχει ισχυρή βιολογική βάση αλλά μεγάλη ετερογένεια: πολυγονιδιακή ευαλωτότητα, νευροανάπτυξη, μοντέλα ντοπαμίνης και γλουταμινικού και κατανεμημένες διαταραχές κυκλωμάτων συμβάλλουν στη σημερινή κατανόηση, ενώ κανένας μεμονωμένος μηχανισμός ή βιοδείκτης δεν αρκεί.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η σχιζοφρένεια είναι **έντονα πολυγονιδιακή**: συμβάλλουν πολλές κοινές παραλλαγές μικρού αποτελέσματος και σπανιότερες παραλλαγές/CNVs.
- Η **μικροέλλειψη 22q11.2** είναι ιδιαίτερα χρήσιμο παράδειγμα σπάνιου CNV για τις εξετάσεις, αλλά δεν πρέπει να απομνημονεύεται ένα σταθερό ποσοστό διεισδυτικότητας ως διαγνωστικός κανόνας.
- Το ισχυρότερο νευροχημικό εύρημα είναι η **προσυναπτική απορρύθμιση της ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα**, με ιδιαίτερη σχέση με τη θετική ψύχωση.
- Η υπολειτουργία NMDA αποτελεί σημαντική **μηχανιστική υπόθεση**, όχι αποδεδειγμένη μοναδική αιτιολογική οδό.
- Διαφορές στις κοιλίες, στον φλοιό, στον ιππόκαμπο και σε άλλα συστήματα είναι **ερευνητικά ευρήματα σε επίπεδο ομάδων**, όχι ατομικά διαγνωστικά τεστ.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς θα συνδέατε τις υποθέσεις γλουταμινικού και ντοπαμίνης;

Ένα χρήσιμο μοντέλο είναι ότι η **υπολειτουργία των υποδοχέων NMDA** στον φλοιό, ιδιαίτερα σε ανασταλτικά ενδονευρωνικά κυκλώματα, μπορεί να προκαλεί αποδιοργάνωση της φλοιώδους αναστολής και να μεταβάλλει στη συνέχεια τη μεσοραβδωτή/ραβδωτή ντοπαμινεργική σηματοδότηση. Αυτό βοηθά να κατανοήσουμε πώς μια γλουταμινεργική διαταραχή μπορεί να συνυπάρχει με τα σταθερά ευρήματα απορρύθμισης της ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα. Θα το παρουσίαζα ως **υπόθεση που συνδέει δύο συστήματα**, όχι ως αποδεδειγμένη γραμμική αιτιολογική αλυσίδα σε κάθε ασθενή.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Να λέτε ότι η σχιζοφρένεια είναι απλώς «υπερβολική ντοπαμίνη παντού».
- Παράθεση μεταβαλλόμενων αριθμών γενετικών τόπων GWAS ή ενός ποσοστού κληρονομικότητας σαν διαχρονικά σταθερών εξεταστικών δεδομένων.
- Παρουσίαση περιβαλλοντικών συσχετίσεων ως ντετερμινιστικών αιτίων.
- Αντιμετώπιση ενός ευρήματος MRI/PET ως διαγνωστικού.
- Παρουσίαση της σχέσης γλουταμινικού–ντοπαμίνης ως πλήρως εδραιωμένου μηχανισμού.

Τι καθορίζει την πρόγνωση στη σχιζοφρένεια;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Η πρόγνωση είναι πολυδιάστατη
- 2 Προνοσηρή και συνήθης λειτουργικότητα
- 3 Διάρκεια μη θεραπευόμενης ψύχωσης (DUP)
- 4 Αρνητικά συμπτώματα και γνωστική δυσλειτουργία
- 5 Συμμόρφωση, συνεργασία με τη θεραπεία και ουσίες
- 6 Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
- 7 Σωματική υγεία και αυτοκτονία
- 8 Πιθανολογική, όχι ντετερμινιστική πρόγνωση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πρόγνωση στη σχιζοφρένεια είναι **πολυδιάστατη, ετερογενής και πιθανολογική**. Δεν την περιορίζω στο αν υποχωρούν οι ψευδαισθήσεις και οι παραληρητικές ιδέες. Η συμπτωματική ύφεση και υποτροπή, η επαγγελματική και κοινωνική ανάκαμψη, η επίμονη επιβάρυνση από αρνητικά και γνωστικά συμπτώματα, η σωματική υγεία, η θνησιμότητα και ο κίνδυνος αυτοκτονίας μπορεί να ακολουθούν διαφορετική πορεία στον ίδιο ασθενή.

Κεντρική διάκριση είναι αυτή μεταξύ **συμπτωματικής βελτίωσης και λειτουργικής αποκατάστασης**. Τα θετικά συμπτώματα μπορεί να ανταποκρίνονται στη θεραπεία, ενώ η επαγγελματική, κοινωνική ή αυτόνομη λειτουργικότητα να παραμένει επηρεασμένη. Καλύτερη προνοσηρή και συνήθης λειτουργικότητα συνδέεται γενικά με ευνοϊκότερη έκβαση, ενώ μεγαλύτερο συνολικό φορτίο νόσου, επανειλημμένες νοσηλείες και επίμονη λειτουργική έκπτωση συνδέονται με δυσμενέστερα λειτουργικά αποτελέσματα.

Η **διάρκεια μη θεραπευόμενης ψύχωσης (DUP)** είναι σημαντικός προγνωστικός συσχετισμός. Μεγαλύτερη DUP σχετίζεται με δυσμενέστερη συμπτωματική και λειτουργική έκβαση. Έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία επειδή η έγκαιρη αναγνώριση και η γρήγορη σύνδεση του ασθενούς με τις υπηρεσίες είναι τροποποιήσιμοι στόχοι του συστήματος φροντίδας. Θα περιέγραφα όμως τη DUP ως συσχέτιση και όχι ως αποδεδειγμένη ανεξάρτητη αιτία κακής έκβασης σε κάθε ασθενή.

Τα επίμονα **αρνητικά συμπτώματα και η γνωστική δυσλειτουργία** αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της μακροχρόνιας λειτουργικής έκπτωσης. Είναι επίσης απαραίτητο να διακρίνονται τα πρωτοπαθή ή επίμονα αρνητικά συμπτώματα από δευτεροπαθή αρνητικά συμπτώματα που οφείλονται σε ενεργό ψύχωση, κατάθλιψη, εξωπυραμидικές ανεπιθύμητες ενέργειες, καταστολή, χρήση ουσιών ή περιβαλλοντική αποστέρηση, επειδή ορισμένοι από αυτούς τους δευτεροπαθείς παράγοντες είναι θεραπεύσιμοι.

Η **συμμόρφωση και η διατήρηση συνεργασίας με τη θεραπεία και τις υπηρεσίες** επηρεάζουν σημαντικά την πορεία. Πτωχή συμμόρφωση, απομάκρυνση από τη φροντίδα και προβληματική χρήση ουσιών αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής, ενώ σταθερή θεραπευτική συνεργασία και μείωση της αποσταθεροποίησης που σχετίζεται με ουσίες είναι ευνοϊκά στοιχεία. Έχουν επίσης σημασία οι

οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες: υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα συνδέεται με υποτροπή, ενώ σταθερή υποστήριξη, ουσιαστική δραστηριότητα και αποκατάσταση μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα.

Ορισμένα κλασικά προγνωστικά στοιχεία —όπως οξεία έναρξη, καλύτερη προνοσηρή λειτουργικότητα, λιγότερα επίμονα αρνητικά συμπτώματα και καλή συνεργασία με τη θεραπεία— παραμένουν χρήσιμα ως **πιθανολογικοί συσχετισμοί**, όχι ως ντετερμινιστικό σύστημα βαθμολόγησης. Οι κατανομές έκβασης διαφέρουν πολύ ανάλογα με τον πληθυσμό, την εποχή θεραπείας και τον ορισμό της ανάρρωσης, επομένως το παλαιό σχήμα «καλή/ενδιάμεση/χρόνια έκβαση σε τρίτα» δεν πρέπει να διδάσκεται ως σημερινή πραγματικότητα.

Η πρόγνωση περιλαμβάνει επίσης **σωματική υγεία και θνησιμότητα**. Η σχιζοφρένεια συνδέεται με σαφώς αυξημένη θνησιμότητα και σημαντικά μειωμένο προσδόκιμο ζωής, λόγω τόσο φυσικών νοσημάτων όσο και μη φυσικών αιτιών, μεταξύ των οποίων η αυτοκτονία. Ως ευρύ σύγχρονο σημείο αναφοράς αναφέρεται συχνά μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά περίπου **10–20 έτη**, αλλά το ακριβές μέγεθος διαφέρει μεταξύ πληθυσμών και δεν αποτελεί σταθερή πρόβλεψη για το συγκεκριμένο άτομο. Ο κίνδυνος αυτοκτονίας έχει ιδιαίτερη σημασία νωρίς στην πορεία της νόσου και μετά από αποσταθεροποιητικά γεγονότα.

Συνολικά, την πρόγνωση τη διατυπώνουμε και προσπαθούμε να την τροποποιήσουμε. Έγκαιρη θεραπεία, συμμόρφωση, μείωση της χρήσης ουσιών, αντιμετώπιση δευτεροπαθών αρνητικών συμπτωμάτων, φροντίδα της σωματικής υγείας, οικογενειακή παρέμβαση και αποκατάσταση έχουν όλα σημασία. Οι προγνωστικοί παράγοντες καθοδηγούν τις πιθανότητες και τις θεραπευτικές προτεραιότητες· δεν καθορίζουν το μέλλον του ασθενούς.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η πρόγνωση έχει **συμπτωματικές, λειτουργικές, γνωστικές/αρνητικών συμπτωμάτων, σωματικής υγείας και θνησιμότητας** διαστάσεις.
- Μεγαλύτερη DUP συνδέεται με δυσμενέστερη συμπτωματική και λειτουργική έκβαση.
- Καλύτερη προνοσηρή/συνήθης λειτουργικότητα, καλή συνεργασία με τη θεραπεία και λιγότερα επίμονα αρνητικά συμπτώματα είναι ευνοϊκοί συσχετισμοί.
- Θεραπεία συντήρησης, αντιμετώπιση χρήσης ουσιών, οικογενειακή/κοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση επηρεάζουν τροποποιήσιμες διαστάσεις της έκβασης.
- Η σχιζοφρένεια συνοδεύεται από **σημαντικά αυξημένη θνησιμότητα**· ακριβή ποσοστά θνησιμότητας ή αυτοκτονίας δεν πρέπει να απομνημονεύονται ως καθολικοί εξεταστικοί κανόνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ποιοι προγνωστικοί παράγοντες είναι πραγματικά τροποποιήσιμοι;

Σημαντικοί τροποποιήσιμοι στόχοι είναι η **διάρκεια μη θεραπευόμενης ψύχωσης σε επίπεδο υπηρεσιών, η συμμόρφωση και η συνεργασία με τη φροντίδα, η χρήση ουσιών, η θεραπεία της ενεργού ψύχωσης και των δευτεροπαθών αρνητικών συμπτωμάτων, ο κίνδυνος για τη σωματική υγεία, το οικογενειακό**

περιβάλλον και η πρόσβαση σε αποκατάσταση ή ουσιαστική απασχόληση. Τα αρχικά χαρακτηριστικά του ασθενούς μπορούν να βοηθούν στη διατύπωση, αλλά η κλινική αξία της πρόγνωσης βρίσκεται κυρίως στον εντοπισμό παραγόντων που μπορούμε να αλλάξουμε και όχι στην πρόβλεψη ενός προκαθορισμένου μέλλοντος.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Εξίσωση της συμπτωματικής ύφεσης με τη λειτουργική αποκατάσταση.
- Παράθεση σταθερών «τριτημορίων έκβασης» σαν να αποτελούν σύγχρονη αλήθεια.
- Αντιμετώπιση ενός δημογραφικού χαρακτηριστικού ως κυρίαρχου ντετερμινιστικού προγνωστικού παράγοντα.
- Παρουσίαση της DUP ως αποδεδειγμένης ανεξάρτητης αιτίας αντί για ισχυρό προγνωστικό συσχετισμό.
- Παράθεση ενός ποσοστού θνησιμότητας ή αυτοκτονίας σαν να ισχύει για κάθε πληθυσμό.

Πώς αντιμετωπίζετε ένα οξύ επεισόδιο σχιζοφρένειας;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επανεκτίμηση διάγνωσης, κινδύνου και πλαισίου φροντίδας
- 2 Από κοινού επιλογή ενός αντιψυχωσικού
- 3 Έναρξη χαμηλά και σταδιακή τιτλοποίηση
- 4 Επαρκής δοκιμή 4-6 εβδομάδων
- 5 Ξεχωριστή αντιμετώπιση της σοβαρής διέγερσης
- 6 CBTp και οικογενειακή παρέμβαση
- 7 Παρακολούθηση και επανεκτίμηση πριν αλλάξει η στρατηγική

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αντιμετώπιση ενός οξέος επεισοδίου αρχίζει με **επανεκτίμηση**, όχι απλώς με αύξηση της δόσης του αντιψυχωσικού. Επιβεβαιώνω τη διάγνωση και το τρέχον σύνδρομο, εκτιμώ τη βαρύτητα και τον άμεσο κίνδυνο, επανεξετάζω τη χρήση ουσιών, πιθανά ιατρικά αίτια, τη συμμόρφωση και την τρέχουσα αγωγή και αποφασίζω αν ο ασθενής χρειάζεται νοσηλεία, αντιμετώπιση σε πλαίσιο κρίσης ή μπορεί να αντιμετωπιστεί κατ' οίκον, ανάλογα με την κλινική ανάγκη και τον κίνδυνο.

Η επιλογή του αντιψυχωσικού γίνεται με **από κοινού λήψη αποφάσεων**. Μετρούν η προηγούμενη ανταπόκριση και οι προτεραιότητες του ασθενούς, ιδίως η ατομική ευαλωτότητα σε μεταβολικές ανεπιθύμητες ενέργειες, εξωπυραμιδικά συμπτώματα, καρδιαγγειακές ή QT επιδράσεις, υπερπρολακτιναιμία ή άλλες ορμονικές ανεπιθύμητες ενέργειες και η υποκειμενική ανεκτικότητα. Στόχος είναι ένα από του στόματος αντιψυχωσικό που ο ασθενής μπορεί ρεαλιστικά να λάβει και να συνεχίσει.

Το χρησιμοποιώ ως **σαφή θεραπευτική δοκιμή**: ξεκινώ στο χαμηλότερο μέρος του εγκεκριμένου δοσολογικού εύρους, τιτλοποιώ σταδιακά, ορίζω τα συμπτώματα-στόχους και παρακολουθώ ανεπιθύμητες ενέργειες και συμμόρφωση. Αν το φάρμακο είναι ανεκτό, η συνήθης δοκιμή αξιολογείται στη βέλτιστη ανεκτή δόση για περίπου **4-6 εβδομάδες**. Η πρώιμη βελτίωση γύρω στις 2 εβδομάδες έχει προγνωστική αξία, αλλά η μη επίτευξη ενός σταθερού ορίου βελτίωσης 20% σε αυτό το σημείο δεν αποτελεί από μόνη της υποχρεωτικό λόγο αλλαγής αγωγής.

Αποφεύγω τη ρουτίνα **ταχείας νευροληπτοποίησης, τη φόρτιση με υψηλές αρχικές δόσεις και την αντιψυχωσική πολυφαρμακία**. Μια σύντομη επικάλυψη κατά την αλλαγή αντιψυχωσικού είναι διαφορετικό ζήτημα από τη μακροχρόνια διατήρηση δύο αντιψυχωσικών χωρίς σαφή αιτιολόγηση.

Η σοβαρή διέγερση που απαιτεί **ταχεία καταστολή** είναι ξεχωριστό επείγον πρόβλημα και δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνήθη φαρμακολογική θεραπεία της σχιζοφρένειας. Οι υψηλές δόσεις αντιψυχωσικού δεν πρέπει απλώς να χρησιμοποιούνται για καταστολή, και οι βενζοδιαζεπίνες δεν αποτελούν συνήθη θεραπεία ενίσχυσης του ίδιου του συνδρόμου της σχιζοφρένειας.

Η φαρμακευτική αγωγή είναι μόνο ένα μέρος της οξείας αντιμετώπισης. Τόσο στο πρώτο επεισόδιο όσο και στις οξείες υποτροπές, η αντιψυχωσική θεραπεία συνδυάζεται με **CBT για ψύχωση (CBTp) και οικογενειακή παρέμβαση**. Η ψυχολογική δουλειά δεν χρειάζεται να περιμένει τη χρόνια ή πλήρως σταθεροποιημένη φάση· μπορεί να αρχίσει μέσα στο οξύ επεισόδιο, ανάλογα με την ικανότητα και την κλινική ανάγκη του ασθενούς.

Η σωματική υγεία και οι **ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται κατά τη θεραπεία** παρακολουθούνται από την αρχή. Αν η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, ελέγχω πρώτα αν η δοκιμή ήταν πράγματι επαρκής: δόση, διάρκεια, συμμόρφωση και πραγματική έκθεση στο φάρμακο, διαγνωστική ακρίβεια, συνεχιζόμενη χρήση ουσιών και άλλοι δευτεροπαθείς παράγοντες πρέπει να επανεξεταστούν πριν αλλάξω ή κλιμακώσω τη στρατηγική. Επαναλαμβανόμενες επαρκείς αποτυχίες μεταφέρουν το πρόβλημα προς τη **διαχείριση της ανθεκτικής στη θεραπεία σχιζοφρένειας**, όχι προς ατέρμονες εμπειρικές αλλαγές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Επαρκής οξεία δοκιμή αντιψυχωσικού:** περίπου 4–6 εβδομάδες στη βέλτιστη ανεκτή δόση, εφόσον το φάρμακο είναι ανεκτό.
- **Πρώιμη ανταπόκριση:** βελτίωση περίπου στις 2 εβδομάδες έχει προγνωστική αξία, αλλά σταθερό όριο μη ανταπόκρισης 20% δεν αποτελεί υποχρεωτικό κανόνα αλλαγής.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιψυχωσική πολυφαρμακία ρουτίνας.
- Χρήση υψηλών δόσεων αντιψυχωσικού κυρίως για καταστολή.
- Σύγχυση της σοβαρής διέγερσης με τη συνήθη αντιψυχωσική θεραπεία.
- Καθυστέρηση ψυχολογικής και οικογενειακής παρέμβασης μέχρι τη χρόνια φάση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Πρώιμη μη ανταπόκριση: Παλαιότερη διδασκαλία μετέτρεπε μερικές φορές το εύρημα των 2 εβδομάδων/20% σε άκαμπτο κανόνα αλλαγής. Είναι προτιμότερο να θεωρείται προγνωστικός δείκτης μεταγενέστερης ανταπόκρισης, ενώ μια κατά τα άλλα κατάλληλη και ανεκτή δοκιμή αξιολογείται συνήθως σε 4–6 εβδομάδες στη βέλτιστη ανεκτή δόση.

Πώς αντιμετωπίζετε τη σχιζοφρένεια μακροχρόνια;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Κοινό διαχρονικό πλάνο ανάρρωσης και πρόληψης υποτροπών
- 2 Αντιψυχωσική θεραπεία συντήρησης
- 3 Διάρκεια θεραπείας και αποφάσεις διακοπής
- 4 Συμμόρφωση και LAIs
- 5 Παρακολούθηση σωματικής υγείας
- 6 Ψυχολογική, οικογενειακή και επαγγελματική αποκατάσταση
- 7 Επανεκτίμηση της επίμονης απόσυρσης πριν χαρακτηριστεί πρωτοπαθές αρνητικό σύμπτωμα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μακροχρόνια αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας πρέπει να είναι ένα **κοινά συμφωνημένο, διαχρονικό πλάνο ανάρρωσης και πρόληψης υποτροπών**, όχι απλώς συνέχιση της συνταγογράφησης. Παρακολουθώ το ατομικό πρότυπο πρώιμων προειδοποιητικών σημείων υποτροπής, τη συμμόρφωση, τη χρήση ουσιών, τον κίνδυνο αυτοκτονίας, την κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα, τις ανάγκες οικογένειας ή φροντιστών και τους προσωπικούς στόχους ανάρρωσης, και προσαρμόζω τη θεραπεία καθώς αυτά μεταβάλλονται στον χρόνο.

Μετά τη βελτίωση, ένα αποτελεσματικό **αντιψυχωσικό σχήμα συντήρησης** συνήθως συνεχίζεται, με το χαμηλότερο αποτελεσματικό και ανεκτό σχήμα και όχι με διαλείπουσα ή θεραπεία μόνο όταν επανεμφανίζονται συμπτώματα. Η διάρκεια εξατομικεύεται. Οι σύγχρονες συστάσεις διατυπώνουν διαφορετικά τη συντήρηση μετά από πρώτο επεισόδιο: μία δίνει τουλάχιστον **7–12 μήνες μετά την ύφεση**, ενώ άλλη τονίζει ότι ο κίνδυνος υποτροπής παραμένει υψηλός αν η θεραπεία διακοπεί μέσα στα πρώτα **1–2 έτη**. Αυτά δεν είναι αντικρουόμενες ημερομηνίες διακοπής αλλά διαφορετικά σημεία αναφοράς που πρέπει να εντάσσονται σε εξατομικευμένα, από κοινού λήψη αποφάσεων.

Σε υποτροπιάζουσα νόσο συνήθως ενοείται **μακρύτερη θεραπεία συντήρησης**, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τη βαρύτητα των επεισοδίων, τις συνέπειες προηγούμενων υποτροπών, τα υπολειμματικά συμπτώματα, τη συμμόρφωση, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις προτιμήσεις του ασθενούς. Αν επιλεγεί διακοπή, το αντιψυχωσικό μειώνεται σταδιακά και ο ασθενής παρακολουθείται στενά. Χρήσιμο πρακτικό σημείο αναφοράς είναι παρακολούθηση για τουλάχιστον **2 έτη μετά τη διακοπή**.

Η συμμόρφωση συζητείται ανοιχτά. Τα **ενέσιμα αντιψυχωσικά μακράς δράσης (LAIs)** αποτελούν επιλογή τόσο όταν τα προτιμά ο ασθενής όσο και όταν η πτωχή, μη εμφανής ή αβέβαιη συμμόρφωση είναι σημαντικό κλινικό ζήτημα. Δεν πρέπει να παρουσιάζονται μόνο ως μέσο επιβολής της θεραπείας. Οι απαιτήσεις έναρξης και τυχόν από του στόματος συγχορήγησης διαφέρουν ανά σκεύασμα και ακολουθούνται για το συγκεκριμένο προϊόν.

Η μακροχρόνια φροντίδα περιλαμβάνει και τη **σωματική υγεία**. Παρακολουθώ βάρος και περίμετρο μέσης, αρτηριακή πίεση και σφυγμό, γλυκόζη ή HbA1c, λιπίδια, προλακτίνη, κινητικές διαταραχές και γενικότερα τη σωματική υγεία, με ΗΚΓ όταν ενδείκνυται κλινικά ή από την ΠΧΠ/SmPC. Η μακροχρόνια έκβαση αφορά τη σωματική νοσηρότητα και θνησιμότητα, όχι μόνο την πρόληψη των υποτροπών.

Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις αποτελούν βασικό μέρος της φροντίδας. CBT για ψύχωση, οικογενειακή παρέμβαση και ψυχοεκπαίδευση, συντονισμένη εξειδικευμένη ή πρώιμη φροντίδα για ψύχωση, επαγγελματική αποκατάσταση ή υποστηριζόμενη απασχόληση και παρεμβάσεις κοινωνικής αποκατάστασης εντάσσονται στο μακροχρόνιο πλάνο.

Η επίμονη απόσυρση ή αδράνεια χρειάζεται προσεκτική επανεκτίμηση. Πριν τη χαρακτηρίσω πρωτοπαθές ή επίμονο αρνητικό σύνδρομο, αναζητώ υπολειμματικά θετικά συμπτώματα, κατάθλιψη, EPS ή παρκινσονισμό, καταστολή ή άλλες φαρμακευτικές επιδράσεις, χρήση ουσιών, γνωστική δυσλειτουργία και περιβαλλοντική αποστέρηση ή έλλειψη ερεθισμάτων. Φαινομενικά αρνητικά συμπτώματα που οφείλονται σε αυτούς τους παράγοντες απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ανθεκτικότητα στην αντιψυχωσική θεραπεία.

Η γνωστική δυσλειτουργία είναι κλινικά σημαντική, αλλά δεν υπάρχει καθιερωμένη φαρμακευτική αγωγή ρουτίνας που να τη διορθώνει ειδικά. Η αποκατάσταση και η λειτουργική υποστήριξη παραμένουν επομένως σημαντικά στοιχεία της φροντίδας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Μετά την ύφεση πρώτου επεισοδίου:** χρήσιμο σύγχρονο ελάχιστο σημείο αναφοράς είναι 7–12 μήνες θεραπείας συντήρησης.
- **Πρώιμη διακοπή:** ο κίνδυνος υποτροπής είναι υψηλός αν η θεραπεία διακοπεί μέσα στα πρώτα 1–2 έτη.
- **Αν επιλεγεί διακοπή:** σταδιακή απόσυρση και στενή παρακολούθηση· τουλάχιστον 2 έτη παρακολούθησης μετά τη διακοπή είναι χρήσιμο σημείο αναφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ο ασθενής παραμένει κοινωνικά αποσυρμένος και αδρανής παρότι η ψύχωση έχει βελτιωθεί. Τι εξετάζετε;

Αναζητώ πρώτα δευτεροπαθείς εξηγήσεις πριν διαγνώσω πρωτοπαθές αρνητικό σύνδρομο: υπολειμματικά θετικά συμπτώματα → κατάθλιψη → EPS/παρκινσονισμός → καταστολή ή άλλες φαρμακευτικές επιδράσεις → ουσίες → γνωστική δυσλειτουργία → περιβαλλοντική αποστέρηση ή έλλειψη ερεθισμάτων → και μόνο τότε πρωτοπαθή/επίμονα αρνητικά συμπτώματα.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Παρουσίαση των LAIs μόνο ως μέσου εξαναγκασμού ή επιβολής συμμόρφωσης.
- Εξίσωση της επίμονης απόσυρσης με αποτυχία της αντιψυχωσικής θεραπείας.
- Χαρακτηρισμός αρνητικών συμπτωμάτων χωρίς αποκλεισμό δευτεροπαθών καταστάσεων που τα μιμούνται.
- Παράβλεψη της σωματικής νοσηρότητας και θνησιμότητας στη μακροχρόνια φροντίδα.

Πότε χαρακτηρίζετε τη σχιζοφρένεια ως ανθεκτική στη θεραπεία και τι πρέπει να αποκλείσετε πρώτα;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ορίστε ποια συμπτώματα επιμένουν
- 2 Επιβεβαιώστε 2 επαρκείς δοκιμές αντιψυχωσικών
- 3 Ελέγξτε δόση και διάρκεια
- 4 Επαληθεύστε συμμόρφωση και πραγματική έκθεση
- 5 Επανεκτιμήστε διάγνωση, ουσίες, αλληλεπιδράσεις και ιατρικά αίτια
- 6 Αντιμετωπίστε ψυχοκοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες
- 7 Σε γνήσια TRS, προχωρήστε σε κλοζαπίνη

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα χαρακτηρίζω τη σχιζοφρένεια ως **ανθεκτική στη θεραπεία** όταν κλινικά σημαντικά συμπτώματα επιμένουν παρά τουλάχιστον **δύο επαρκείς δοκιμές αντιψυχωσικών**, εφόσον η φαινομενική μη ανταπόκριση δεν εξηγείται καλύτερα από ψευδοανθεκτικότητα. Επομένως, ο ορισμός δεν είναι απλώς «δύο φάρμακα που απέτυχαν»· πρέπει να έχει τεκμηριωθεί επαρκής θεραπευτική έκθεση για τα σωστά συμπτώματα-στόχους.

Πρώτα αποσαφηνίζω **τι ακριβώς επιμένει**. Επίμονα θετικά ψυχωσικά συμπτώματα δεν είναι το ίδιο με πρωτοπαθή αρνητικά συμπτώματα, γνωστική δυσλειτουργία, καταθλιπτική ή άλλη συναισθηματική παθολογία και σύνδρομα που δεν αναμένεται να ανταποκριθούν με τον ίδιο τρόπο σε περαιτέρω αντιψυχωσική θεραπεία. Πριν αποδώσω την ετικέτα της ανθεκτικότητας, επανεκτιμώ και την ίδια τη διάγνωση.

Στη συνέχεια εξετάζω κάθε προηγούμενη δοκιμή ως προς **δόση, διάρκεια και πραγματική έκθεση**. Χρήσιμο πρακτικό σημείο αναφοράς είναι τουλάχιστον **6 εβδομάδες σε θεραπευτική δόση για κάθε αντιψυχωσικό**. Δύο διαδοχικές ανεπιτυχείς αλλά επαρκείς δοκιμές παραμένουν το βασικό κλινικό όριο· μία σύγχρονη κατευθυντήρια διατύπωση αναφέρεται σε δύο διαφορετικά αντιψυχωσικά, με τουλάχιστον το ένα να είναι μη-κλοζαπινικό αντιψυχωσικό δεύτερης γενιάς.

Το επόμενο κρίσιμο ζήτημα είναι η **συμμόρφωση**, επειδή η μη συμμόρφωση αποτελεί σημαντική αιτία ψευδοανθεκτικότητας. Την ελέγχω συστηματικά αντί να θεωρώ δεδομένο ότι ο ασθενής είχε επαρκή έκθεση. Όπου είναι εφικτό, επίπεδα πλάσματος και/ή ένα ενέσιμο μακράς δράσης ή άμεσα επιτηρούμενη λήψη μπορούν να μειώσουν την αβεβαιότητα, αλλά δεν αποτελούν καθολικές κανονιστικές προϋποθέσεις για τη διάγνωση TRS.

Επανεξετάζω επίσης **φαρμακοκινητικούς παράγοντες και αλληλεπιδράσεις**, συνεχιζόμενη **χρήση ουσιών** και σχετικές ιατρικές παθήσεις. Η φαινομενική αναποτελεσματικότητα μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή φαρμακευτική έκθεση, συνεχιζόμενη χρήση ουσιών, αλληλεπίδραση ή δευτεροπαθές κλινικό πρόβλημα

και όχι σε γνήσια ανθεκτικότητα.

Πρέπει επίσης να έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα οι **ψυχοκοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και λειτουργικοί παράγοντες**. Επίμονα συμπτώματα ή αναπηρία σε ασθενή με ανεπαρκή υποστήριξη δεν αρκούν από μόνα τους για να χαρακτηριστεί η νόσος ανθεκτική.

Όταν έχουν γίνει αυτοί οι έλεγχοι και εξακολουθούν να υπάρχουν κλινικά σημαντικά συμπτώματα παρά δύο πραγματικά επαρκείς δοκιμές, πρόκειται για γνήσια ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια και ο ασθενής πρέπει να προχωρήσει **στη θεραπευτική στρατηγική με κλοζαπίνη**. Δεν είναι σωστό να συνεχίζονται διαδοχικές δοκιμές επιπλέον μη-κλοζαπινικών αντιψυχωσικών απλώς για να αναβληθεί η κλοζαπίνη όταν η TRS έχει τεκμηριωθεί.

Η πρακτική ακολουθία είναι: ορίζω τα συμπτώματα-στόχους, αποδεικνύω δύο επαρκείς δοκιμές, αποκλείω συστηματικά την ψευδοανθεκτικότητα και στη συνέχεια ενεργώ βάσει της διάγνωσης αντί να συνεχίζω επ' αόριστον αλλαγές αντιψυχωσικών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Κεντρικό όριο:** επίμονα κλινικά σημαντικά συμπτώματα παρά **τουλάχιστον 2 επαρκείς δοκιμές αντιψυχωσικών**, αφού αποκλειστεί η ψευδοανθεκτικότητα.
- **Πρακτικό σημείο αναφοράς TRRIP για τη διάρκεια:** **τουλάχιστον 6 εβδομάδες σε θεραπευτική δόση για κάθε αντιψυχωσικό.**
- Το αυστηρότερο ερευνητικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης επίμονα συμπτώματα τουλάχιστον μέτριας βαρύτητας και λειτουργική έκπτωση κατά την περίοδο επαρκούς θεραπείας· δεν χρειάζεται να αντικαθιστά τον πρακτικό κλινικό ορισμό στην προφορική εξέταση.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χαρακτηρισμός της δυσανεξίας ως «ανθεκτικότητας» χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής δοκιμή αποτελεσματικότητας.
- Διάγνωση TRS χωρίς έλεγχο συμμόρφωσης και έκθεσης.
- Σύγχυση πρωτοπαθών αρνητικών ή γνωστικών συμπτωμάτων με επίμονη θετική ψύχωση.
- Συνέχιση πολλών επιπλέον μη-κλοζαπινικών αντιψυχωσικών αφού έχει τεκμηριωθεί γνήσια TRS.

Μιλήστε μου για την κλοζαπίνη: ενδείξεις, κύριοι κίνδυνοι και παρακολούθηση.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ενδειξη
- 2 Αιματολογικά — όρια ANC και πρόγραμμα παρακολούθησης
- 3 Καρδιακά — μυοκαρδίτιδα/μυοκαρδιοπάθεια
- 4 Γαστρεντερικά — υποκινητικότητα/δυσκοιλιότητα
- 5 Νευρολογικά και άλλα — σπασμοί, μεταβολικές επιδράσεις, καταστολή, υπερσιελόρροια
- 6 Έκθεση/TDM — κάπνισμα, λοίμωξη, αλληλεπιδρώντα φάρμακα
- 7 Διακοπή και επανέναρξη — >2 ημέρες απαιτεί επανατιτλοποίηση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κλοζαπίνη είναι η βασική θεραπεία για ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια μετά από δύο επαρκείς αποτυχίες αντιψυχωσικών, αλλά απαιτεί ενεργή διαχείριση της ασφάλειας επειδή ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Η κύρια κλινική ένδειξη είναι η ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια. Η ευρωπαϊκή Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SmPC) περιλαμβάνει επίσης σχιζοφρένεια με **σοβαρές μη αντιμετωπίσιμες νευρολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες** από άλλα αντιψυχωσικά και ψύχωση στη νόσο Parkinson μετά από αποτυχία της συνήθους θεραπείας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες υποστηρίζουν επίσης τη χρήση κλοζαπίνης όταν επιμένει σημαντικός κίνδυνος αυτοκτονίας παρά άλλες θεραπείες, ενώ επίμονη σημαντική επιθετικότητα μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση της. Αυτές οι χρήσεις που υποστηρίζονται από κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να διακρίνονται από τις επίσημες ενδείξεις της ΠΧΠ.

Τα κύρια ζητήματα ασφάλειας οργανώνονται πρακτικά σε έξι ομάδες.

Αιματολογικά: το τρέχον ευρωπαϊκό πλαίσιο βασίζεται στο ANC και όχι σε συνδυασμένη παρακολούθηση WBC και ANC. Η θεραπεία μπορεί να αρχίσει με ANC τουλάχιστον $1,5 \times 10^9/L$, ή τουλάχιστον $1,0 \times 10^9/L$ σε επιβεβαιωμένη καλοήγη εθνοτική ή Duffy-null ουδετεροπενία. Στον γενικό πληθυσμό, ANC κάτω από $1,0 \times 10^9/L$ απαιτεί άμεση διακοπή χωρίς επανέκθεση· σε επιβεβαιωμένη BEN/Duffy-null ουδετεροπενία το αντίστοιχο όριο είναι κάτω από $0,5 \times 10^9/L$. Ήπια ουδετεροπενία $1,0-1,5 \times 10^9/L$ μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενισχυμένη παρακολούθηση στο αναθεωρημένο πλαίσιο. Η τακτική παρακολούθηση ANC είναι **εβδομαδιαία για τις πρώτες 18 εβδομάδες, μηνιαία για τις επόμενες 34 εβδομάδες έως τον 1ο χρόνο, κάθε 12 εβδομάδες μετά τον 1ο χρόνο εφόσον δεν έχει υπάρξει ουδετεροπενία και ετησίως μετά τα 2 έτη εφόσον δεν υπήρξε ουδετεροπενία στα πρώτα 2 έτη**. Νέα συμπτώματα λοίμωξης απαιτούν άμεση κλινική εκτίμηση και άμεσο ANC.

Καρδιακά: η μυοκαρδίτιδα είναι ιδιαίτερα σημαντική νωρίς στη θεραπεία, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο στους πρώτους δύο μήνες. Επίμονη ανεξήγητη ταχυκαρδία, θωρακικό άλγος, δύσπνοια, συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας ή γριπώδης

εικόνα πρέπει να εγείρουν υποψία. Σε ύποπτη μυοκαρδίτιδα απαιτείται άμεση διακοπή και επείγουσα καρδιολογική εκτίμηση. Αρχικός και εβδομαδιαίος έλεγχος CRP και τροπονίνης για περίπου τις πρώτες 4 εβδομάδες αποτελεί χρήσιμη στρατηγική βάσει **συναίνεσης ειδικών**, αλλά δεν είναι ένα καθολικά υποχρεωτικό ευρωπαϊκό εργαστηριακό πρόγραμμα.

Γαστρεντερικά: η γαστρεντερική υποκινητικότητα και η δυσκοιλιότητα μπορεί να εξελιχθούν σε κοπρόσταση, ειλεό, megacolon ή ισχαιμία. Ρωτώ ενεργά για τη λειτουργία του εντέρου και αντιμετωπίζω τη δυσκοιλιότητα, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου ή αντιχολινεργικά ή οπιοειδή φάρμακα.

Νευρολογικές και άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες: ο κίνδυνος σπασμών σχετίζεται με τη δόση ή την έκθεση. Μεταβολικές επιδράσεις και αύξηση βάρους, καταστολή και υπερσιελόρροια αποτελούν επίσης σημαντικά πρακτικά προβλήματα.

Αλληλεπιδράσεις που μεταβάλλουν την έκθεση και TDM: ο καπνός του τσιγάρου επάγει το CYP1A2, επομένως η απότομη διακοπή του καπνίσματος μπορεί να αυξήσει τις συγκεντρώσεις κλοζαπίνης, ενώ η επανέναρξη μπορεί να μειώσει την έκθεση. Σοβαρή λοίμωξη, ιδίως πνευμονία, μπορεί μέσω της φλεγμονής να καταστείλει το CYP1A2 και να αυξήσει σημαντικά την έκθεση· λοίμωξη και ταυτόχρονη διακοπή καπνίσματος μπορούν να αθροίσουν τις επιδράσεις τους. Η θεραπευτική παρακολούθηση συγκεντρώσεων (TDM) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε φαινομενική μη ανταπόκριση, αβεβαιότητα συμμόρφωσης, τοξικότητα, αλλαγή καπνιστικής συνήθειας, αλληλεπιδρώντα φάρμακα και σοβαρή λοίμωξη.

Διακοπή και επανέναρξη: αν έχουν περάσει περισσότερες από 2 ημέρες από την τελευταία δόση, η κλοζαπίνη επανεκκινείται με 12,5 mg μία ή δύο φορές την 1η ημέρα και στη συνέχεια επανατιτλοποιείται ανάλογα με την ανεκτικότητα. Δεν επαναχορηγείται απλώς η προηγούμενη πλήρης δόση, λόγω κινδύνου υπότασης και κυκλοφορικής κατάρρευσης. Οι αιματολογικοί κανόνες επανέναρξης είναι διαφορετικό ζήτημα από τη φαρμακολογική επανατιτλοποίηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **ANC για έναρξη:** $\geq 1,5 \times 10^9/L$ σε επιβεβαιωμένη BEN/Duffy-null ουδετεροπενία $\geq 1,0 \times 10^9/L$.
- **ANC για διακοπή χωρίς επανέκθεση:** γενικός πληθυσμός $< 1,0 \times 10^9/L$ επιβεβαιωμένη BEN/Duffy-null ουδετεροπενία $< 0,5 \times 10^9/L$.
- **Τακτικό πρόγραμμα ANC:** εβδομαδιαία 18 εβδομάδες → μηνιαία έως τον 1ο χρόνο → κάθε 12 εβδομάδες μετά τον 1ο χρόνο αν δεν υπήρξε ουδετεροπενία → ετησίως μετά τα 2 έτη αν δεν υπήρξε ουδετεροπενία στα πρώτα 2 έτη.
- **Επανάναρξη μετά από >2 ημέρες χωρίς κλοζαπίνη:** 12,5 mg μία ή δύο φορές την 1η ημέρα και έπειτα επανατιτλοποίηση ανάλογα με την ανεκτικότητα.
- **Πριν χαρακτηριστεί μη ανταπόκριση στην κλοζαπίνη:** σημείο αναφοράς TRRIP για βέλτιστη έκθεση είναι κατώτατη συγκέντρωση $\geq 350 \text{ ng/mL}$ · δεν αποτελεί καθολικό όριο τοξικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ**Ο ασθενής εμφανίζει πνευμονία και διακόπτει απότομα το κάπνισμα. Τι συμβαίνει με την κλοζαπίνη;**

Και οι δύο μεταβολές μπορούν να αυξήσουν ταυτόχρονα την έκθεση στην κλοζαπίνη: η φλεγμονή καταστέλλει το CYP1A2 και η διακοπή καπνίσματος αφαιρεί την επαγωγή του CYP1A2 από τον καπνό. Η τοξικότητα μπορεί να εμφανιστεί γρήγορα, με καταστολή, σύγχυση ή ντελίριο, υπερσιελόρροια και κίνδυνο εισρόφησης, υπόταση ή σπασμούς, και να επιδεινώσει την πνευμονία.

Προτεραιότητες είναι η άμεση ιατρική εκτίμηση και θεραπεία της λοίμωξης, ANC, μέτρηση συγκέντρωσης κλοζαπίνης όπου είναι δυνατό και έλεγχος αλληλεπιδρώντων αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων. Η κλοζαπίνη μειώνεται άμεσα ή διακόπτεται προσωρινά ανάλογα με την κλινική βαρύτητα, αντί να συνεχίζεται αμετάβλητη η δόση που λάμβανε ο ασθενής πριν από τη νόσο και ενώ κάπνιζε. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση και στη συνέχεια νέα προσαρμογή της δόσης ή επανατιτλοποίηση καθώς υποχωρεί η φλεγμονή και σταθεροποιείται το κάπνισμα.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χρήση παλαιών ευρωπαϊκών κανόνων με συνδυασμένο WBC+ANC ή ισόβιο μηνιαίο έλεγχο.
- Επανεναρξη της προηγούμενης πλήρους δόσης μετά από διακοπή >2 ημερών.
- Εστίαση μόνο στην ακοκκιοκυτταραιμία και παράβλεψη μυοκαρδίτιδας ή γαστρεντερικής υποκινητικότητας.
- Παράβλεψη της διακοπής καπνίσματος και της σοβαρής λοίμωξης ως σημαντικών αιτιών οξείας τοξικότητας από κλοζαπίνη.
- Μηχανική εφαρμογή ποσοστιαίων μειώσεων δόσης από κείμενα συναίνεσης ειδικών χωρίς κλινική εκτίμηση ή πλαίσιο TDM.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ενημέρωση αιματολογικής παρακολούθησης: Παλαιότερη ευρωπαϊκή διδασκαλία χρησιμοποιούσε διαφορετικά αιματολογικά όρια και ισόβια μηνιαία παρακολούθηση. Το σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο χρησιμοποιεί παρακολούθηση μόνο του ANC, με τα αναθεωρημένα όρια και αραιότερη παρακολούθηση μετά από παρατεταμένη θεραπεία χωρίς ουδετεροπενία.

Ποια είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά, η διάγνωση και οι σημαντικές διαφορικές διαγνώσεις της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Σύνδρομο και λειτουργική έκπτωση
- 2 Συναισθηματικά, γνωστικά, βιολογικά και ψυχοκινητικά χαρακτηριστικά
- 3 Κίνδυνος αυτοκτονίας και ψυχωσική βαρύτητα
- 4 Σύγχρονο διαγνωστικό σημείο αναφοράς
- 5 Έλεγχος για διπολικότητα
- 6 Αποκλεισμός ουσιών/φαρμάκων και ιατρικών αιτίων
- 7 Διαχρονική διάγνωση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κατάθλιψη είναι **σύνδρομο**, όχι απλώς χαμηλή διάθεση. Η βασική εικόνα είναι επίμονη καταθλιπτική διάθεση και/ή απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης, μαζί με κλινικά σημαντική μεταβολή στη λειτουργικότητα και ένα ευρύτερο σύνολο γνωστικών, βιολογικών και ψυχοκινητικών συμπτωμάτων. Η διάγνωση πρέπει να είναι διαχρονική και να περιλαμβάνει ενεργή εκτίμηση κινδύνου αυτοκτονίας, ψύχωσης, διπολικότητας και δευτεροπαθών αιτίων.

Κλινικά οργανώνω το σύνδρομο σε τέσσερα πεδία. Τα **συναισθηματικά συμπτώματα** περιλαμβάνουν καταθλιπτική διάθεση, ανηδονία, μειωμένη συναισθηματική αντιδραστικότητα και, σε ορισμένους ασθενείς, έντονο άγχος ή ευερεθιστότητα. Τα **γνωστικά συμπτώματα** περιλαμβάνουν απαισιοδοξία και απελπισία, υπερβολική ενοχή ή αναξιότητα, δυσκολία συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων και επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας. Η αυτοκτονικότητα απαιτεί ξεχωριστή, άμεση εκτίμηση της πρόθεσης, του σχεδίου και του άμεσου κινδύνου και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα ακόμη στοιχείο μιας λίστας συμπτωμάτων.

Τα **βιολογικά ή σωματικά χαρακτηριστικά** περιλαμβάνουν διαταραχή ύπνου, μεταβολή της όρεξης ή του βάρους, απώλεια ενέργειας ή κόπωση, μειωμένη libido και, μερικές φορές, ημερήσια διακύμανση. Η **ψυχοκινητική μεταβολή** μπορεί να είναι επιβράδυνση ή διέγερση· σε πολύ σοβαρή κατάθλιψη, η επιβράδυνση μπορεί να φτάσει μέχρι εμβροντησία.

Η βαρύτητα έχει σημασία επειδή η κατάθλιψη μπορεί να γίνει **ψυχωσική**. Παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις μπορεί να είναι σύμφωνες ή ασύμφωνες με τη διάθεση, ενώ οι μηδενιστικές ιδέες ή φαινόμενα τύπου Cotard αποτελούν κλασικό χαρακτηριστικό σοβαρής ψυχωσικής κατάθλιψης. Η ψυχωσική κατάθλιψη αλλάζει τόσο την επείγουσα βαρύτητα όσο και τη θεραπευτική προσέγγιση. Μελαγχολικά και άτυπα χαρακτηριστικά είναι επίσης χρήσιμοι κλινικοί περιγραφείς, αλλά δεν αντικαθιστούν τη διάγνωση του υποκείμενου καταθλιπτικού επεισοδίου.

Στο σύγχρονο ICD-11, ένα καταθλιπτικό επεισόδιο απαιτεί τουλάχιστον 5 από 10 συμπτώματα για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, με παρουσία είτε καταθλιπτικής διάθεσης είτε σαφώς μειωμένου ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης, μαζί με κλινικά σημαντική λειτουργική έκπτωση και τους κατάλληλους αποκλεισμούς. Χρειάζεται επίσης καθαρή ορολογία: η **μείζων καταθλιπτική διαταραχή** είναι όρος του DSM, ενώ το ICD-11 χρησιμοποιεί καταθλιπτική διαταραχή μοναδικού επεισοδίου ή υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή ανάλογα με τη διαχρονική πορεία.

Πριν χαρακτηρίσω την εικόνα μονοπολική, αναζητώ ενεργά οποιοδήποτε δια βίου ιστορικό μανίας ή υπομανίας, μεικτά μανιακά συμπτώματα, ετεροαναφορικές πληροφορίες και επεισόδια που εμφανίστηκαν κατά τη θεραπεία με αντικαταθλιπτικό. Σοβαρή, υποτροπιάζουσα ή ακόμη και ψυχωσική κατάθλιψη από μόνη της δεν τεκμηριώνει διπολική διαταραχή.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει διπολική κατάθλιψη, εικόνες σχετιζόμενες με προσαρμογή ή πένθος, κατάθλιψη επαγόμενη από ουσίες ή φάρμακα, ενδοκρινικές, μεταβολικές, νευρολογικές και άλλες ιατρικές αιτίες και καταθλιπτικά συμπτώματα στο πλαίσιο άλλων ψυχιατρικών διαταραχών. Η διάγνωση επομένως συνδυάζει ιστορικό και εξέταση παρούσας ψυχικής κατάστασης με σωματική και νευρολογική αξιολόγηση και στοχευμένο παρακλινικό έλεγχο όταν η εικόνα υποδηλώνει δευτεροπαθές αίτιο, αντί να βασίζεται μόνο στην καταμέτρηση συμπτωμάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Μείζων καταθλιπτικό επεισόδιο DSM-5-TR:** τουλάχιστον 5 από 9 συμπτώματα για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, με καταθλιπτική διάθεση ή απώλεια ενδιαφέροντος/ευχαρίστησης ως τουλάχιστον ένα πυρηνικό σύμπτωμα. Πρόκειται για πλαίσιο ειδικό του DSM και όχι διατύπωση του ICD-11.
- **Καταθλιπτικό επεισόδιο ICD-11:** τουλάχιστον 5 από 10 συμπτώματα για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, με καταθλιπτική διάθεση ή απώλεια ενδιαφέροντος/ευχαρίστησης μεταξύ αυτών.
- **Ορολογία:** «μείζων καταθλιπτική διαταραχή» είναι όρος του DSM· το ICD-11 χρησιμοποιεί καταθλιπτική διαταραχή μοναδικού επεισοδίου ή υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή ανάλογα με την πορεία.
- **Μελαγχολικά έναντι άτυπων χαρακτηριστικών:** στις μελαγχολικές εικόνες είναι χαρακτηριστικά η έντονη ανηδονία ή μειωμένη αντιδραστικότητα της διάθεσης μαζί με βιολογικά/ψυχοκινητικά στοιχεία· στις άτυπες εικόνες διατηρείται χαρακτηριστικά η αντιδραστικότητα της διάθεσης και μπορεί να υπάρχουν υπερυπνία, αυξημένη όρεξη/βάρος, μολυβδώδης παράλυση και ευαισθησία στην απόρριψη. Είναι περιγραφείς φαινοτύπου, όχι ξεχωριστές διαταραχές.
- **Μηδενιστικές παραληρητικές ιδέες τύπου Cotard:** κλασικό φαινόμενο σοβαρής ψυχωσικής κατάθλιψης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ**Πώς διακρίνετε την PMDD από την προεμμηνορρυσιακή επιδείνωση μιας άλλης διαταραχής;**

Το βασικό είναι αν υπάρχει πραγματικό **κυκλικό πρότυπο έναρξης και ύφεσης**. Στην PMDD ή σε πυρηνική προεμμηνορρυσιακή διαταραχή, τα συμπτώματα εμφανίζονται στην ωχρινική ή προεμμηνορρυσιακή φάση, βελτιώνονται μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως και είναι ελάχιστα ή απουσιάζουν στο μετεμμηνορρυσιακό θυλακικό διάστημα, με σαφή λειτουργική επίπτωση.

Στην **προεμμηνορρυσιακή επιδείνωση**, υπάρχει υποκείμενη ψυχιατρική ή ιατρική διαταραχή σε όλο τον κύκλο, η οποία απλώς επιδεινώνεται προεμμηνορρυσιακά. Επίμονα σημαντικά συμπτώματα στη θυλακική φάση επομένως ευνοούν PME ή συννοσηρότητα αντί για καθαρή PMDD.

Όταν χρειάζεται διαγνωστική βεβαιότητα, η αναδρομική ανάκληση δεν αρκεί. Η προοπτική καθημερινή καταγραφή συμπτωμάτων σε **τουλάχιστον δύο διαδοχικούς συμπτωματικούς κύκλους** αποτελεί τη βασική μέθοδο επιβεβαίωσης· το DRSP είναι ένα από τα συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία.

Άξονας ανάκλησης follow-up: κυκλικό on/off → διάστημα με ελάχιστα συμπτώματα στη θυλακική φάση → επίμονη υποκείμενη διαταραχή υποστηρίζει PME → προοπτικές καταγραφές για 2 κύκλους.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση κατάθλιψης από τη θλίψη μόνο.
- Παράλειψη δια βίου ελέγχου για μανία ή υπομανία πριν χαρακτηριστεί η υποτροπιάζουσα κατάθλιψη μονοπολική.
- Αντιμετώπιση μελαγχολικών ή άτυπων χαρακτηριστικών ως ξεχωριστών διαταραχών.
- Παράβλεψη ψύχωσης, αυτοκτονικότητας ή ιατρικών/ουσιοεπαγόμενων αιτίων.
- Ανάμειξη των αριθμητικών διαγνωστικών πλαισίων DSM και ICD.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Εξέλιξη της ταξινόμησης: Παλαιότερη διδασκαλία μπορεί να χρησιμοποιεί την ιεραρχία ICD-10 «2 από 3 πυρηνικά συμπτώματα». Το σύγχρονο ICD-11 χρησιμοποιεί διαφορετικό πλαίσιο για το καταθλιπτικό επεισόδιο· η παλαιά ιεραρχία δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως σημερινό διαγνωστικό δεδομένο.

Πώς αντιμετωπίζετε ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επανεκτίμηση διάγνωσης, βαρύτητας και άμεσου κινδύνου
- 2 Από κοινού επιλογή πλαισίου και θεραπείας
- 3 Ψυχοθεραπεία, αντικαταθλιπτικό ή συνδυασμός
- 4 Ψυχωσική κατάθλιψη και ECT
- 5 Επανεκτίμηση ανταπόκρισης περίπου στις 4 εβδομάδες
- 6 Αλλαγή ή ενίσχυση ανάλογα με την ανταπόκριση
- 7 Συνέχιση θεραπείας και πρόληψη υποτροπών

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αντιμετώπιση αρχίζει με επιβεβαίωση του τι ακριβώς θεραπεύω και πόσο επείγουσα είναι η κατάσταση. Επανεκτιμώ τον κίνδυνο αυτοκτονίας, την παρουσία ψύχωσης, κατατονίας ή σοβαρής ψυχοκινητικής επιβράδυνσης, την αυτοπαραμέληση, τη σίτιση και την ενυδάτωση, τη χρήση ουσιών, πιθανά σωματικά αίτια, την προηγούμενη ανταπόκριση σε θεραπεία, την τήρηση της αγωγής και το διαθέσιμο υποστηρικτικό δίκτυο. Το κατάλληλο πλαίσιο θεραπείας καθορίζεται από την ασφάλεια και τη δυνατότητα ασφαλούς διαχείρισης του ασθενούς και όχι μόνο από τη διάγνωση.

Το επόμενο βήμα είναι η **από κοινού επιλογή της θεραπείας**. Η βαρύτητα έχει σημασία, αλλά η σύγχρονη πρακτική δεν ακολουθεί μια άκαμπτη κλίμακα όπου η ηπιότερη κατάθλιψη σημαίνει πάντοτε ψυχοθεραπεία και η σοβαρότερη αυτομάτως συνδυασμό θεραπειών. Η προηγούμενη ανταπόκριση, η συννοσηρότητα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον ασθενή, οι προτιμήσεις του και η διαθεσιμότητα των θεραπειών επηρεάζουν την επιλογή.

Στην **ηπιότερη κατάθλιψη**, συχνά προτιμώνται αρχικά τεκμηριωμένες ψυχολογικές ή συμπεριφορικές παρεμβάσεις και δεν απαιτείται αυτόματα αντικαταθλιπτικό, εκτός αν το προτιμά ο ασθενής ή υπάρχει άλλος κλινικός λόγος. Στη **σοβαρότερη κατάθλιψη**, τόσο η δομημένη ψυχοθεραπεία όσο και η αντικαταθλιπτική αγωγή αποτελούν θεμιτές επιλογές πρώτης γραμμής, ενώ ο συνδυασμός τους είναι ιδιαίτερα ελκυστικός όταν η νόσος είναι βαρύτερη ή χρόνια, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος ή έχει υπάρξει ατελής ανταπόκριση σε μία μόνο θεραπευτική μέθοδο. Η CBT αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα δομημένης τεκμηριωμένης ψυχοθεραπείας και δεν πρέπει να παρουσιάζεται απλώς ως συμπλήρωμα της φαρμακοθεραπείας.

Όταν επιλέγεται φάρμακο, το αντικαταθλιπτικό εξατομικεύεται με βάση προηγούμενο όφελος, ανεκτικότητα, τοξικότητα σε υπερδοσολογία, αλληλεπιδράσεις, συννοσηρότητα και προτίμηση του ασθενούς και όχι με βάση μια άκαμπτη καθολική ιεραρχία.

Η **ψυχωσική κατάθλιψη** απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Η βασική

φαρμακολογική προσέγγιση είναι συνδυασμός αντικαταθλιπτικού και αντιψυχωσικού. Αν ο ασθενής αρνηθεί το αντιψυχωσικό, μπορεί να εξεταστεί μονοθεραπεία με αντικαταθλιπτικό, αλλά ο συνδυασμός αποτελεί γενικά την ισχυρότερη απάντηση. Η ECT πρέπει να εξετάζεται όταν χρειάζεται ταχεία ανταπόκριση επειδή η κατάθλιψη είναι απειλητική για τη ζωή, για παράδειγμα με άρνηση λήψης τροφής ή υγρών, ή όταν σοβαρά ψυχωσικά ή κατατονικά χαρακτηριστικά καθιστούν σημαντική την ταχεία θεραπεία. Είναι επίσης κατάλληλη μετά από αποτυχία θεραπείας ή όταν υπάρχει ισχυρή προηγούμενη ανταπόκριση ή σαφής προτίμηση του ασθενούς· δεν πρέπει να παρουσιάζεται μόνο ως ύστατη λύση.

Αν δεν υπάρχει ή υπάρχει μόνο περιορισμένη βελτίωση, επανεκτιμώ τη θεραπεία περίπου στις **4 εβδομάδες σε αναγνωρισμένη θεραπευτική δόση**. Πριν αλλάξω στρατηγική, ελέγχω την τήρηση της αγωγής, την ανεκτικότητα, τη διάγνωση, ψυχοκοινωνικούς και σωματικούς παράγοντες και αν η θεραπευτική δοκιμή ήταν πράγματι επαρκής. Οι τέσσερις εβδομάδες είναι σημείο επανεκτίμησης και όχι ορισμός της ανθεκτικής κατάθλιψης.

Μετά από ανεπαρκή δοκιμή, η **αλλαγή** είναι πιο λογική όταν δεν υπήρξε ουσιαστικά όφελος ή η ανεκτικότητα είναι κακή. Η **ενίσχυση ή προσθήκη θεραπείας** είναι πιο ελκυστική όταν έχει υπάρξει ουσιαστική μερική ανταπόκριση σε ένα καλά ανεκτό αντικαταθλιπτικό. Μπορεί επίσης να προστεθεί ή να τροποποιηθεί η ψυχοθεραπεία.

Μετά την ύφεση, η αποτελεσματική θεραπεία πρέπει να **συνεχίζεται και όχι να διακόπτεται απότομα**. Ένα παραδοσιακό χρονικό σημείο αναφοράς είναι περίπου **6 μήνες μετά την ύφεση**, χωρίς να αποτελεί καθολικό κανόνα διακοπής. Η μακροχρόνια πρόληψη υποτροπών δικαιολογείται όλο και περισσότερο όσο αυξάνονται τα προηγούμενα επεισόδια, η βαρύτητα, τα υπολειμματικά συμπτώματα, η συννοσηρότητα και άλλοι παράγοντες υποτροπής. Η διακοπή πρέπει να είναι σταδιακή και να συνοδεύεται από σχέδιο πρόληψης υποτροπής και παρακολούθηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Επανεκτίμηση ανταπόκρισης:** περίπου 4 εβδομάδες σε θεραπευτική δόση είναι χρήσιμο σημείο επανεξέτασης· δεν ορίζει από μόνο του TRD.
- **Συνέχιση:** η θεραπεία συνεχίζεται μετά την ύφεση. Περίπου 6 μήνες είναι χρήσιμο παραδοσιακό/ελάχιστο σημείο αναφοράς, ενώ η μακροχρόνια συντήρηση εξατομικεύεται ανάλογα με τον κίνδυνο υποτροπής.
- Ο κίνδυνος υποτροπής αυξάνεται με προηγούμενα επεισόδια και υπολειμματικά συμπτώματα· δεν χρησιμοποιούμε τον παλαιό πίνακα 50/70/90 ως σύγχρονη αλήθεια.
- **CBT:** εντοπίζει και ελέγχει δυσπροσαρμοστικές εκτιμήσεις και συμπεριφορικά μοτίβα που συντηρούν την κατάθλιψη.
- **Συμπεριφορική ενεργοποίηση:** αντιστρέφει την απόσυρση και την αποφυγή μέσω προγραμματισμένης επανασύνδεσης με ενισχυτικές, προσανατολισμένες σε στόχους δραστηριότητες.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Έναρξη θεραπείας χωρίς έλεγχο διπολικότητας, ψύχωσης ή αυτοκτονικού κινδύνου.
- Παθητική αναμονή παρά την απουσία ανταπόκρισης ή σημαντικά προβλήματα ανεκτικότητας.
- Χαρακτηρισμός της μη ανταπόκρισης στις 4 εβδομάδες ως «ανθεκτικής κατάθλιψης».
- Παρουσίαση της ECT ως απόλυτα ύστατης λύσης σε απειλητική για τη ζωή, ψυχωσική ή κατατονική κατάθλιψη.
- Άμεση διακοπή αντικαταθλιπτικού μετά την ύφεση.
- Παράθεση σταθερών ποσοστών υποτροπής ή μίας καθολικής διάρκειας συντήρησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Επιλογή θεραπείας: η παλαιότερη διδασκαλία μπορεί να χρησιμοποιεί άκαμπτη κλιμακωτή προσέγγιση ανάλογα με τη βαρύτητα. Η σύγχρονη πρακτική είναι περισσότερο εξατομικευμένη: η βαρύτητα παραμένει σημαντική, αλλά ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία μπορούν να είναι πρώτης γραμμής σε κατάλληλους ασθενείς, με τον κίνδυνο, την προηγούμενη ανταπόκριση, την προτίμηση και την πρόσβαση να καθορίζουν την επιλογή.

Πώς αντιμετωπίζετε την ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επιβεβαίωση αποτυχίας τουλάχιστον 2 επαρκών αντικαταθλιπτικών θεραπειών
- 2 Αποκλεισμός ψευδοανθεκτικότητας
- 3 Επανεκτίμηση διάγνωσης, βαρύτητας και κινδύνου
- 4 Αλλαγή μετά από μη ανταπόκριση· ενίσχυση μετά από μερική ανταπόκριση
- 5 Ενίσχυση με επιλεγμένο αντιψυχωσικό ή λίθιο
- 6 ECT και rTMS
- 7 Εσκεταμίνη ως εξειδικευμένη επιλογή με άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ
- 8 Μακροχρόνια διαχείριση της δυσθεράπευτης κατάθλιψης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πρώτα επιβεβαιώνω ότι πρόκειται για πραγματική ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη και όχι για φαινομενική ανθεκτικότητα. Ένας πρακτικός ορισμός είναι η παραμονή κλινικά σημαντικής κατάθλιψης παρά τουλάχιστον δύο επαρκείς αντικαταθλιπτικές θεραπείες στο τρέχον επεισόδιο. Οι δύο θεραπείες δεν χρειάζεται να ανήκουν σε διαφορετικές φαρμακολογικές κατηγορίες. Πριν κλιμακώσω τη θεραπεία, αναζητώ συστηματικά ψευδοανθεκτικότητα και επανεξετάζω τη συνολική διατύπωση της περίπτωσης.

Πρώτο ερώτημα είναι αν η διάγνωση είναι σωστή, ιδίως αν υπάρχει μη αναγνωρισμένη διπολική διαταραχή. Ελέγχω αν οι προηγούμενες θεραπείες ήταν πράγματι επαρκείς ως προς δόση και διάρκεια, αν λαμβάνονταν με συνέπεια, αν οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιόρισαν την πραγματική έκθεση και αν η θεραπεία ολοκληρώθηκε ή εφαρμόστηκε επαρκώς. Η χρήση ουσιών, η ψυχιατρική συννοσηρότητα, σωματικά νοσήματα ή άλλα φάρμακα και σοβαρές ψυχοκοινωνικές αντιξοότητες μπορεί να συντηρούν τα συμπτώματα και πρέπει να αντιμετωπίζονται αντί να προστίθεται απλώς ακόμη ένα φάρμακο.

Επανεκτιμώ επίσης το ίδιο το καταθλιπτικό σύνδρομο: ποια συμπτώματα επιμένουν, πόσο σοβαρή είναι η λειτουργική έκπτωση και αν υπάρχει ενεργός αυτοκτονικός κίνδυνος, ψύχωση ή κατατονία που αλλάζει την επείγουσα αντιμετώπιση και την επιλογή θεραπείας.

Στη συνέχεια αποφασίζω ανάμεσα σε αλλαγή και ενίσχυση. Αν ένα αντικαταθλιπτικό δεν έχει προσφέρει ουσιαστικά κανένα όφελος ή είναι κακώς ανεκτό, η αλλαγή είναι συνήθως πιο λογική. Αν έχει υπάρξει σαφής μερική ανταπόκριση και το φάρμακο είναι καλά ανεκτό, η ενίσχυση ή προσθήκη θεραπείας είναι πιο ελκυστική. Τεκμηριωμένες στρατηγικές ενίσχυσης περιλαμβάνουν επιλεγμένα αντιψυχωσικά δεύτερης γενιάς και λίθιο. Δεν υπάρχει ένα καθολικό επίπεδο λιθίου για augmentation ούτε ένας ενιαίος πίνακας δόσεων αντιψυχωσικών που πρέπει να αποστηθίζεται.

Σε σοβαρή, επείγουσα ή ιδιαίτερα ανθεκτική νόσο, η ECT παραμένει η

σημαντικότερη σωματική θεραπεία, ιδίως όταν συνυπάρχουν ψύχωση, κατατονία, σοβαρή αυτοκτονικότητα ή απειλητική για τη ζωή άρνηση λήψης τροφής ή υγρών. Ο **rTMS** αποτελεί επίσης καθιερωμένη μη επεμβατική θεραπεία για κατάθλιψη που δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στη συνήθη θεραπεία και δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως περιθωριακή ή πειραματική μέθοδος.

Η **ενδορρινική εσκεταμίνη** έχει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ για επιλεγμένους ενήλικες με TRD, σε συνδυασμό με από του στόματος αντικαταθλιπτικό και με επιβλεπόμενη χορήγηση και παρακολούθηση. Η ρυθμιστική έγκριση δεν σημαίνει ότι κάθε κατευθυντήρια οδηγία τη συνιστά, ότι κάθε σύστημα υγείας την αποζημιώνει ή ότι είναι διαθέσιμη ως θεραπεία ρουτίνας στην Ελλάδα. Το NICE, για παράδειγμα, δεν τη συνιστά για χρήση στο NHS. Η ενδοφλέβια ρακεμική κεταμίνη αποτελεί διαφορετικό ζήτημα και δεν έχει εγκεκριμένη αντικαταθλιπτική ένδειξη στην ΕΕ.

Τέλος, δεν αντιμετωπίζω τη χρόνια δύσκολη κατάθλιψη ως απλή αλληλουχία αλλαγών φαρμάκων. Η ευρύτερη έννοια της **difficult-to-treat depression (DTD)** είναι χρήσιμη όταν παραμένει σημαντική επιβάρυνση παρά αρκετές εύλογες θεραπείες, επειδή στρέφει την προσοχή στο μερικό όφελος, τη χρονιότητα, τη λειτουργικότητα, την πρόληψη υποτροπών, τη συννοσηρότητα και τους στόχους του ασθενούς αντί για μια απλή δυαδική ετικέτα «ανθεκτική/μη ανθεκτική».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Συμβατικός άξονας TRD:** αποτυχία τουλάχιστον 2 επαρκών αντικαταθλιπτικών θεραπειών στο τρέχον επεισόδιο, με επιβεβαιωμένη λήψη/έκθεση· δεν απαιτείται να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.
- **Ενίσχυση:** λίθιο και επιλεγμένα αντιψυχωσικά δεύτερης γενιάς αποτελούν τεκμηριωμένες επιλογές· αποφεύγουμε ένα καθολικό επίπεδο λιθίου ή άκαμπτη κλίμακα δόσεων SGA.
- **rTMS:** καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή μετά από ανεπαρκή ανταπόκριση στη συνήθη θεραπεία.
- **Εσκεταμίνη:** έχει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ για επιλεγμένη χρήση σε TRD μαζί με από του στόματος αντικαταθλιπτικό, αλλά άδεια κυκλοφορίας, σύσταση κατευθυντήριων οδηγιών και αποζημίωση είναι διαφορετικά ζητήματα.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χαρακτηρισμός ανεπαρκούς θεραπείας ή μη τήρησης της αγωγής ως TRD.
- Απαίτηση δύο διαφορετικών κατηγοριών αντικαταθλιπτικών στον βασικό ορισμό της TRD.
- Παράβλεψη διπολικής διαταραχής.
- Αυτόματη προσθήκη φαρμάκου μετά από μηδενική ανταπόκριση χωρίς επανεκτίμηση στρατηγικής.
- Παράθεση κάθε νεότερης παρέμβασης αντί για σαφή θεραπευτική αλληλουχία.
- Θεώρηση της ευρωπαϊκής άδειας κυκλοφορίας ως απόδειξης συνήθους διαθεσιμότητας ή αποζημίωσης στην Ελλάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη: οι κλασικές απαντήσεις συχνά σταματούν στην αλλαγή φαρμάκου, στην ενίσχυση με λίθιο ή αντιψυχωσικό και στην ECT. Η σύγχρονη πρακτική αναγνωρίζει επίσης τον rTMS ως καθιερωμένη θεραπεία και την ενδορρινική εσκεταμίνη ως εξειδικευμένη επιλογή με άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ, ενώ η έννοια DTD μπορεί να είναι πιο χρήσιμη για τη μακροχρόνια διαχείριση από μια απλή δυαδική ετικέτα ανθεκτικότητας.

Πώς διαγιγνώσκετε τη διπολική διαταραχή και πώς τη διαφοροδιαγιγνώσκετε από σημαντικές εναλλακτικές διαγνώσεις;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Τεκμηρίωση επεισοδιακής μεταβολής από τη συνήθη κατάσταση του ατόμου
- 2 Αναγνώριση μανιακού/υπομανιακού συνδρόμου
- 3 Διάκριση μανίας από υπομανία βάσει βαρύτητας και συνεπειών
- 4 Διάκριση διπολικής I από διπολική II
- 5 Αναζήτηση μικτών χαρακτηριστικών
- 6 Διαφοροδιάγνωση από μονοπολική κατάθλιψη, ΔΕΠ-Υ, BPD και ψύχωση
- 7 Αποκλεισμός ουσιών, φαρμάκων και σωματικών αιτίων
- 8 Προσεκτική ερμηνεία μανίας/υπομανίας που εμφανίζεται υπό αντικαταθλιπτικό

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διπολική διαταραχή είναι κατεξοχήν **διαχρονική και επεισοδιακή διάγνωση**. Δεν τη διαγιγνώσκω από ασαφείς «μεταπτώσεις της διάθεσης». Αναζητώ διακριτές περιόδους μεταβολής της διάθεσης μαζί με αύξηση της ενέργειας ή της δραστηριότητας, που αποτελούν σαφή απόκλιση από τη συνήθη κατάσταση του ατόμου, και στη συνέχεια κρίνω αν πληρούν το κλινικό επίπεδο μανίας ή υπομανίας.

Ένα επεισόδιο του μανιακού φάσματος περιλαμβάνει συνήθως ανυψωμένη, διασταλτική ή ευερέθιστη διάθεση μαζί με αυξημένη ενέργεια ή δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά συνοδά στοιχεία είναι η μειωμένη ανάγκη για ύπνο, η αυξημένη ή πιεστική ομιλία, ο καλπασμός σκέψεων, η διασπαστικότητα, η αύξηση της στοχοκατευθυνόμενης δραστηριότητας, η άρση αναστολών ή η ανάληψη κινδύνων και οι ιδέες μεγαλείου. Στη μανία μπορεί να υπάρχουν και ψυχωσικά συμπτώματα.

Η βασική διάκριση μεταξύ **μανίας και υπομανίας αφορά κυρίως τη βαρύτητα και τις λειτουργικές συνέπειες**, όχι απλώς τον αριθμό των συμπτωμάτων. Η μανία προκαλεί σημαντική λειτουργική έκπτωση, μπορεί να απαιτήσει νοσηλεία και μπορεί να συνοδεύεται από ψύχωση. Η υπομανία αποτελεί επίσης σαφή επεισοδιακή μεταβολή, αλλά χωρίς τον ίδιο βαθμό σοβαρής έκπτωσης ή ψύχωσης.

Σε επίπεδο ταξινόμησης, η **διπολική διαταραχή τύπου I απαιτεί τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο**. Η **διπολική διαταραχή τύπου II απαιτεί τουλάχιστον ένα υπομανιακό και τουλάχιστον ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, χωρίς ιστορικό μανίας**. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα μικτά χαρακτηριστικά: μπορεί να υπάρχουν κλινικά σημαντικά μανιακά συμπτώματα κατά την κατάθλιψη ή καταθλιπτικά συμπτώματα κατά τη μανία ή την υπομανία, χωρίς να απαιτείται η παλαιότερη έννοια ενός πλήρως ταυτόχρονου «μικτού επεισοδίου». Η παρουσία τους δυσκολεύει τη διαγνωστική εικόνα και απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή με τα αντικαταθλιπτικά.

Η διαφορική διάγνωση λύνεται κυρίως με τη **χρονολογία και την**

επεισοδιακότητα. Στη μονοπολική κατάθλιψη αναζητώ ενεργά οποιοδήποτε διαβίου ιστορικό υπομανίας ή μανίας, μικτά χαρακτηριστικά, οικογενειακό ιστορικό, ετεροαναφορικές πληροφορίες και ενεργοποίηση υπό θεραπεία. Κανένας μεμονωμένος καταθλιπτικός φαινότυπος δεν αποδεικνύει διπολικότητα.

Η ΔΕΠ-Υ είναι κατά κανόνα επίμονη από την αναπτυξιακή περίοδο και εκδηλώνεται σε περισσότερα από ένα περιβάλλοντα, ενώ η υπομανία ή μανία είναι επεισοδιακή. Μια σαφής αλλαγή διάθεσης και ενέργειας, η μειωμένη ανάγκη για ύπνο, η μεγαλοϊδεατική σκέψη ή η ψύχωση συνηγορούν περισσότερο υπέρ διπολικής διαταραχής, παρότι οι δύο καταστάσεις μπορεί να συνυπάρχουν.

Στην **οριακή διαταραχή προσωπικότητας**, οι συναισθηματικές μεταβολές είναι συχνά ταχείες και αντιδραστικές σε διαπροσωπικά ή περιβαλλοντικά γεγονότα και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, διάχυτο μοτίβο δυσκολιών στην ταυτότητα, στις σχέσεις και στην παρορμητικότητα. Η διπολική διαταραχή απαιτεί σαφώς διακριτά και πιο παρατεταμένα επεισόδια που αποκλίνουν από τη συνήθη κατάσταση. Οι δύο διαταραχές μπορούν, βέβαια, να συνυπάρχουν.

Εξετάζω επίσης ουσίες, φάρμακα και σωματικά αίτια, όπως διεγερτικά, κορτικοστεροειδή, αντικαταθλιπτικά, μέθη ή στέρηση και, ανάλογα με την εικόνα, θυρεοειδικές, νευρολογικές ή άλλες παθήσεις. Διαταραχή του φάσματος της σχιζοφρένειας γίνεται πιθανότερη όταν η ψύχωση επιμένει ανεξάρτητα από τα συναισθηματικά επεισόδια, γεγονός που ξανακάνει κρίσιμη τη διαχρονική καταγραφή.

Τέλος, μανία ή υπομανία που εμφανίζεται μετά την έναρξη αντικαταθλιπτικού δεν ερμηνεύεται μηχανικά. Ένα πλήρες σύνδρομο που **επιμένει και μετά τη διακοπή του φαρμάκου και πέρα από την άμεση φυσιολογική του επίδραση** μπορεί να προσμετρηθεί υπέρ πρωτοπαθούς διπολικής διάγνωσης. Αντίθετα, μια σύντομη ενεργοποίηση που περιορίζεται στην άμεση φαρμακολογική επίδραση δεν αρκεί από μόνη της για να τεθεί διπολική διαταραχή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Διπολική Ι:** τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο.
- **Διπολική ΙΙ:** τουλάχιστον ένα υπομανιακό και ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, χωρίς ιστορικό μανίας.
- **Χρονικά όρια DSM:** μανία τουλάχιστον 7 ημέρες, ή οποιαδήποτε διάρκεια αν απαιτείται νοσηλεία· υπομανία τουλάχιστον 4 **συνεχόμενες ημέρες**. Αυτά είναι όρια του DSM και όχι καθολική διατύπωση του ICD-11.
- **Rapid cycling κατά DSM:** τουλάχιστον 4 επεισόδια διάθεσης σε 12 μήνες.
- Η διπολική διαταραχή είναι **έντονα οικογενής και πολυγονιδιακή**, αλλά συγκεκριμένα ποσοστά κληρονομησιμότητας ή κινδύνου συγγενών δεν πρέπει να μετατρέπονται σε ατομική πρόβλεψη.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση διπολικής διαταραχής από συνηθισμένες διακυμάνσεις της διάθεσης.
- Χαρακτηρισμός της χρόνιας ενεργοποίησης της ΔΕΠ-Υ ως υπομανίας.
- Χαρακτηρισμός αντιδραστικών συναισθηματικών μεταβολών της BPD ως διπολικών επεισοδίων.
- Παρουσίαση των χρονικών ορίων του DSM ως καθολικής διατύπωσης του ICD-11.
- Θεώρηση κάθε ενεργοποίησης από αντικαταθλιπτικό ως απόδειξης διπολικής διαταραχής.
- Χρήση σταθερών ποσοστών κληρονομησιμότητας ή οικογενειακού κινδύνου ως ατομικής πρόβλεψης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ταξινόμηση: το ICD-11 διακρίνει ρητά διπολική διαταραχή τύπου I και τύπου II. Οι παλαιότερες διατυπώσεις της εποχής του ICD-10 είναι πλέον παρωχημένες.

Επεισόδια υπό αντικαταθλιπτικό: πλήρες μανιακό ή υπομανιακό σύνδρομο που επιμένει πέρα από τις άμεσες φαρμακολογικές επιδράσεις μπορεί να υποστηρίξει πρωτοπαθή διπολική διάγνωση· είναι υπεραπλούστευση να χαρακτηρίζεται κάθε τέτοιο επεισόδιο ως προκαλούμενο από ουσία/φάρμακο.

Πώς αντιμετωπίζετε την οξεία μανία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Κίνδυνος, θεραπευτικό πλαίσιο και σωματική διαφορική διάγνωση
- 2 Εξέταση διακοπής αποσταθεροποιητικών αντικαταθλιπτικών
- 3 Αντιμανιακή αλληλουχία βάσει συγκεκριμένης κατευθυντήριας οδηγίας
- 4 Κλιμάκωση ανάλογα με τη βαρύτητα και την ανταπόκριση
- 5 Βραχυχρόνια προσθήκη βενζοδιαζεπίνης αν χρειάζεται
- 6 ECT για σοβαρή ή ανθεκτική μανία
- 7 Τήρηση των ισχυόντων αναπαραγωγικών περιορισμών για το βαλπροϊκό

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η οξεία μανία απαιτεί ταυτόχρονη εκτίμηση κινδύνου, αιτιολογίας και βαρύτητας, ενώ η αντιμανιακή θεραπεία αρχίζει έγκαιρα. Εκτιμώ κίνδυνο για τον ίδιο τον ασθενή ή τους άλλους, έλεγχο συμπεριφοράς, ψύχωση, σοβαρή διέγερση, στέρηση ύπνου, χρήση ουσιών, ικανότητα λήψης αποφάσεων, πιθανά σωματικά ή νευρολογικά αίτια, την τρέχουσα αγωγή και τη δυνατότητα του ασθενούς να ακολουθήσει τη θεραπεία. Η σοβαρή μανία συχνά χρειάζεται επείγουσα εξειδικευμένη ή νοσοκομειακή αντιμετώπιση, με την ασφάλεια και τη σωματική εκτίμηση να προχωρούν παράλληλα όπου είναι δυνατό.

Αν η μανία ή η υπομανία εμφανίστηκε ενώ ο ασθενής λαμβάνει αντικαταθλιπτικό, εξετάζω τη διακοπή του ως μέρος της οξείας αντιμετώπισης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αντικαταθλιπτικό πρέπει να διακόπτεται απότομα, επειδή ο κίνδυνος συμπτωμάτων διακοπής διαφέρει ανά φάρμακο. Μέθη, στέρηση ουσιών και σχετικά σωματικά αίτια πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ενεργά και όχι να θεωρείται εξ αρχής ότι το σύνδρομο είναι αμιγώς ψυχιατρικό.

Η φαρμακολογική αλληλουχία πρέπει να αναφέρεται μαζί με το πλαίσιο της κατευθυντήριας οδηγίας. Στην αλληλουχία του NICE, αν ο ασθενής δεν λαμβάνει ήδη αντιψυχωσικό ή σταθεροποιητή της διάθεσης, προσφέρεται πρώτα ένα αντιψυχωσικό. Αν είναι αναποτελεσματικό ή κακώς ανεκτό, δοκιμάζεται άλλο αντιψυχωσικό. Αν η ανταπόκριση παραμένει ανεπαρκής, προστίθεται λίθιο· αν το λίθιο είναι αναποτελεσματικό ή ακατάλληλο, εξετάζεται το βαλπροϊκό, με πλήρη τήρηση των αναπαραγωγικών περιορισμών. Άλλες διεθνείς οδηγίες χρησιμοποιούν διαφορετικές ιεραρχήσεις, επομένως δεν συγχωνεύω όλα τα συστήματα σε μία τεχνητή καθολική σειρά.

Σε σοβαρή διαταραχή συμπεριφοράς, βενζοδιαζεπίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν βραχυχρόνια ως συμπληρωματική αγωγή για διέγερση ή αϋπνία όσο αναμένεται η δράση της κύριας αντιμανιακής θεραπείας. Δεν αποτελούν, όμως, τον πυρήνα της θεραπείας της μανίας. Παράλληλα μειώνω τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, αποκαθιστώ ύπνο, ενυδάτωση και θρέψη, αντιμετωπίζω χρήση ουσιών και εμπλέκω φροντιστές όπου ενδείκνυται.

Η ECT παραμένει σημαντική επιλογή όταν η μανία είναι παρατεταμένη, σοβαρή, ανθεκτική ή απειλητική για τη ζωή. Δεν αποκλείεται επειδή το σύνδρομο είναι μανιακό και όχι καταθλιπτικό.

Όταν εξετάζεται **βαλπροϊκό**, οι σύγχρονοι κανόνες αναπαραγωγικής ασφάλειας είναι αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. Αντενδείκνυται για διπολική διαταραχή κατά την κύηση. Σε κορίτσια και γυναίκες που μπορούν να κυοφορήσουν, αντενδείκνυται εκτός εάν πληρούνται οι όροι του Προγράμματος Πρόληψης Κύησης και οι εναλλακτικές θεραπείες είναι αναποτελεσματικές ή μη ανεκτές. Για τους άνδρες, οι ισχύουσες ευρωπαϊκές προφυλάξεις απαιτούν εξειδικευμένη έναρξη ή επίβλεψη, ενημέρωση για το πιθανό νευροαναπτυξιακό σήμα κινδύνου από πατρική έκθεση, αποτελεσματική αντισύλληψη για τον άνδρα και τη γυναίκα σύντροφο κατά τη θεραπεία και για τουλάχιστον **3 μήνες μετά τη διακοπή**, αποφυγή δωρεάς σπέρματος στο ίδιο διάστημα και τακτική επανεκτίμηση.

Η συνολική προσέγγιση είναι: διασφαλίζω ασφάλεια και κατάλληλο πλαίσιο, διορθώνω αποσταθεροποιητικούς παράγοντες, χρησιμοποιώ σαφώς προσδιορισμένη κατευθυντήρια αλληλουχία, κλιμακώνω έγκαιρα όταν η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής και ενσωματώνω πλήρως την αναπαραγωγική ασφάλεια σε κάθε απόφαση για βαλπροϊκό.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **NICE οξείας μανίας:** αντιψυχωσικό → αν χρειαστεί άλλο αντιψυχωσικό → προσθήκη λιθίου αν η ανταπόκριση παραμένει ανεπαρκής → εξέταση βαλπροϊκού αν το λίθιο είναι ακατάλληλο ή αναποτελεσματικό. Άλλες οδηγίες μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετική αλληλουχία.
- **Αντικαταθλιπτικά:** το NICE λέει να **εξετάζεται η διακοπή** κατά τη μανία/υπομανία· δεν μετατρέπεται αυτό σε αυτόματο κανόνα απότομης διακοπής για κάθε φάρμακο.
- **Βαλπροϊκό στην κύηση:** αντενδείκνυται για διπολική διαταραχή.
- **Γυναίκες που μπορούν να κυοφορήσουν:** χρήση μόνο αν πληρούνται οι όροι του Pregnancy Prevention Programme και οι εναλλακτικές είναι αναποτελεσματικές ή μη ανεκτές.
- **Ρυθμιστικά στοιχεία ενημέρωσης:** περίπου **10–11%** κίνδυνος μείζονων συγγενών δυσπλασιών και αναπτυξιακά προβλήματα σε έως περίπου **30–40%** των εκτεθειμένων παιδιών. Πρόκειται για ρυθμιστικά στοιχεία συμβουλευτικής, όχι γενικούς επιδημιολογικούς κανόνες.
- **Άνδρες που λαμβάνουν βαλπροϊκό:** αποτελεσματική αντισύλληψη για τον ασθενή και τη γυναίκα σύντροφο κατά τη θεραπεία και για τουλάχιστον **3 μήνες μετά τη διακοπή**· αποφυγή δωρεάς σπέρματος για τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη διακοπή. Πρόκειται για προφύλαξη λόγω πιθανού σήματος κινδύνου.
- Δεν αποστηθίζω φόρτιση ή επίπεδα βαλπροϊκού ως καθολικό κανόνα οξείας μανίας· η δοσολογία ακολουθεί το εκάστοτε ισχύον προϊόν και πλαίσιο οδηγιών.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση μόνο της διέγερσης και παράβλεψη του μανιακού συνδρόμου ή της σωματικής διαφορικής διάγνωσης.
- Ισχυρισμός ότι τα αντικαταθλιπτικά πρέπει πάντοτε να διακόπτονται απότομα.
- Παρουσίαση λιθίου, βαλπροϊκού και αντιψυχωσικών ως μίας καθολικής ισότιμης πρώτης γραμμής χωρίς αναφορά κατευθυντήριας οδηγίας.
- Χαρακτηρισμός του βαλπροϊκού ως «πρώτης γραμμής» χωρίς τους σύγχρονους αναπαραγωγικούς περιορισμούς.
- Χρήση βενζοδιαζεπινών ως οριστικής αντιμανιακής θεραπείας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Θεραπευτική ιεράρχηση: οι μεγάλες κατευθυντήριες οδηγίες διαφέρουν ως προς τη σειρά. Η σύγχρονη προφορική απάντηση πρέπει να δηλώνει ποιο πλαίσιο χρησιμοποιεί αντί να συγχωνεύει NICE και διεθνείς αλγορίθμους.

Βαλπροϊκό: η παλαιότερη χρήση χωρίς αναπαραγωγικές επιφυλάξεις είναι παρωχημένη. Οι ισχύοντες ευρωπαϊκοί περιορισμοί πρέπει να συνοδεύουν κάθε σύσταση βαλπροϊκού στη διπολική διαταραχή.

Πώς αντιμετωπίζετε τη διπολική κατάθλιψη;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επιβεβαίωση διπολικής κατάθλιψης και εκτίμηση μικτών/μανιακών χαρακτηριστικών
- 2 Χρήση αλληλουχίας συγκεκριμένης κατευθυντήριας οδηγίας
- 3 Σύνδεση οξείας θεραπείας με τις ανάγκες συντήρησης
- 4 Προσεκτική, επικουρική χρήση αντικαταθλιπτικών
- 5 Αποφυγή μονοθεραπείας με αντικαταθλιπτικό στη διπολική I
- 6 ECT όταν απαιτείται ταχεία ανταπόκριση ή υπάρχει ανθεκτικότητα
- 7 Διάκριση διεθνούς τεκμηρίωσης από ευρωπαϊκή αδειοδότηση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διπολική κατάθλιψη δεν αντιμετωπίζεται όπως η μονοπολική κατάθλιψη. Πρώτα επιβεβαιώνω τη διπολική διάγνωση και τον υπότυπο, εξετάζω αν υπάρχουν μικτά ή μανιακά χαρακτηριστικά, εκτιμώ κίνδυνο αυτοκτονίας, ψύχωση ή κατατονία, ελέγχω τήρηση αγωγής και χρήση ουσιών και λαμβάνω υπόψη τόσο την προηγούμενη ανταπόκριση όσο και τις μελλοντικές ανάγκες θεραπείας συντήρησης.

Η θεραπευτική σειρά πρέπει να αναφέρεται μέσα σε **συγκεκριμένο κατευθυντήριο πλαίσιο** και όχι ως μία συγχωνευμένη διεθνής λίστα. Στο NICE, σημαντικές επιλογές είναι η **κουετιαπίνη** ή ο συνδυασμός **φλουοξετίνης με ολανζαπίνη**, ανάλογα με την τρέχουσα αγωγή και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς· η **λαμοτριγίνη** μπορεί να εξεταστεί σε επιλεγμένες αλληλουχίες. Αν ο ασθενής λαμβάνει ήδη λίθιο ή άλλη θεραπεία συντήρησης, πρώτα ελέγχω αν την παίρνει σωστά, αν η έκθεση είναι επαρκής και αν η υφιστάμενη στρατηγική μπορεί να βελτιστοποιηθεί πριν προσθέσω ή αλλάξω θεραπεία για το οξύ επεισόδιο.

Η επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη μακροχρόνια πορεία. Η **λαμοτριγίνη** έχει ιδιαίτερη θέση στην πρόληψη υποτροπών με καταθλιπτική πολικότητα, αλλά δεν είναι φάρμακο για την οξεία μανία. Το λίθιο μπορεί να παραμείνει σημαντικό όταν αποτελεί ήδη αποτελεσματική θεραπεία συντήρησης, ενώ η κουετιαπίνη έχει ρόλο τόσο στην οξεία διπολική κατάθλιψη όσο και στη συντήρηση. Το ζητούμενο είναι η οξεία απόφαση να εντάσσεται σε ένα λογικό μακροχρόνιο πλάνο και όχι να αντιμετωπίζεται το επεισόδιο απομονωμένα.

Η κύρια επιφύλαξη αφορά τα **αντικαταθλιπτικά**. Η μονοθεραπεία με αντικαταθλιπτικό **δεν συνιστάται στη διπολική κατάθλιψη τύπου I**. Αν χρησιμοποιηθεί αντικαταθλιπτικό, πρέπει να χορηγείται προσεκτικά μαζί με κατάλληλη αντιμανιακή ή σταθεροποιητική στρατηγική και με παρακολούθηση για αναστροφή φάσης ή αποσταθεροποίηση. Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε ιστορικό μανίας υπό αντικαταθλιπτικό, σε τρέχοντα μικτά χαρακτηριστικά ή πρόσφατη ταχεία εναλλαγή επεισοδίων, και επανεκτιμώ το αντικαταθλιπτικό αν εμφανιστεί μανία.

Η ECT παραμένει σημαντική επιλογή για ανθεκτική διπολική κατάθλιψη και πρέπει να εξετάζεται νωρίτερα όταν απαιτείται γρήγορη ανταπόκριση λόγω

σοβαρής αυτοκτονικότητας, ψύχωσης, κατατονίας ή σωματικής επιβάρυνσης από ανεπαρκή πρόσληψη τροφής ή υγρών. Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις, η ρύθμιση ύπνου και κιρκάδιου ρυθμού, η αντιμετώπιση χρήσης ουσιών και η πρόληψη υποτροπών είναι χρήσιμα συμπληρώματα, αλλά δεν υποκαθιστούν την κατάλληλη οξεία βιολογική θεραπεία όταν το επεισόδιο είναι σοβαρό.

Χρειάζεται επίσης σαφής διάκριση ανάμεσα στη **διεθνή τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας και στις ευρωπαϊκές εγκεκριμένες ενδείξεις**. Διεθνείς οδηγίες περιλαμβάνουν την καριπραζίνη και στρατηγικές με λουρασιδόνη στις επιλογές για διπολική κατάθλιψη τύπου I. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να θεωρούνται αυτομάτως συνήθεις εγκεκριμένες επιλογές για διπολική κατάθλιψη στην ΕΕ. Μπορούν να αναφέρονται ως θεραπείες με διεθνή τεκμηρίωση χωρίς να μετατρέπεται η τεκμηρίωση σε ισχυρισμό περί ευρωπαϊκής αδειοδότησης.

Η πρακτική απάντηση είναι: επιβεβαιώνω την πολικότητα και τον κίνδυνο μικτών χαρακτηριστικών, χρησιμοποιώ σαφές κατευθυντήριο πλαίσιο, συνδέω την οξεία θεραπεία με τη συντήρηση, χρησιμοποιώ αντικαταθλιπτικά με προσοχή και όχι ως μονοθεραπεία στη διπολική I, και εξετάζω ECT όταν η βαρύτητα ή η ανθεκτικότητα το απαιτούν.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **NICE:** σημαντικές οξείες επιλογές είναι η κουετιαπίνη ή η φλουοξετίνη+ολανζαπίνη· η λαμοτριγίνη μπορεί να εξεταστεί σε επιλεγμένες αλληλουχίες. Η ακριβής σειρά εξαρτάται και από την ήδη λαμβανόμενη αγωγή.
- **Διπολική I κατάθλιψη:** η μονοθεραπεία με αντικαταθλιπτικό **δεν συνιστάται**· ο όρος «αντενδείκνυται» είναι υπερβολικά απόλυτος ως καθολική ρυθμιστική διατύπωση.
- Αν χρησιμοποιηθεί αντικαταθλιπτικό, χορηγείται μαζί με κατάλληλη αντιμανιακή στρατηγική και με παρακολούθηση για **switch ή αποσταθεροποίηση της διάθεσης**.
- **Καριπραζίνη και λουρασιδόνη:** έχουν διεθνή τεκμηρίωση για διπολική κατάθλιψη, αλλά η διεθνής σύσταση αποτελεσματικότητας δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτόματα σε ισχυρισμό περί συνήθους ευρωπαϊκής αδειοδότησης για αυτή την ένδειξη.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση της διπολικής κατάθλιψης ακριβώς όπως της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής.
- Συγχώνευση NICE, διεθνών οδηγιών και ευρωπαϊκής αδειοδότησης σε μία υποτιθέμενη καθολική ιεραρχία.
- Χρήση αντικαταθλιπτικού ως μονοθεραπεία στη διπολική I.
- Παρουσίαση της μονοθεραπείας με αντικαταθλιπτικό ως καθολικά «αντενδείκνυται» αντί ως μη συνιστώμενη θεραπευτική στρατηγική.
- Παρουσίαση καριπραζίνης ή λουρασιδόνης ως συνήθων εγκεκριμένων ευρωπαϊκών θεραπειών διπολικής κατάθλιψης.
- Παράβλεψη μικτών χαρακτηριστικών και κινδύνου αναστροφής φάσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Τεκμηρίωση έναντι αδειοδότησης: οι διεθνείς συστάσεις για τη διπολική κατάθλιψη και οι ευρωπαϊκές εγκεκριμένες ενδείξεις δεν ταυτίζονται. Στην απάντηση πρέπει να δηλώνεται ποια αρχή ή ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο χρησιμοποιείται αντί να συγχέονται μεταξύ τους.

Πώς διαχειρίζεστε μακροχρόνια τη διπολική διαταραχή;

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Από κοινού σχέδιο πρόληψης υποτροπών και ανάρρωσης
- 2 Το λίθιο ως κεντρική επιλογή συντήρησης
- 3 Εναλλακτικές ανάλογα με την πολικότητα και την προηγούμενη ανταπόκριση
- 4 Ψυχοεκπαίδευση, τήρηση αγωγής, ύπνος και ουσίες
- 5 Παρακολούθηση σωματικής υγείας
- 6 Πρόληψη αυτοκτονίας και λειτουργική αποκατάσταση
- 7 Εξατομίκευση διάρκειας και σταδιακή διακοπή αν αποφασιστεί
- 8 Σύγχρονοι αναπαραγωγικοί περιορισμοί για το βαλπροϊκό

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μακροχρόνια αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής πρέπει να αποτελεί από κοινού σχέδιο πρόληψης υποτροπών και ανάρρωσης, όχι απλώς συνέχιση του φαρμάκου που έλεγξε το τελευταίο επεισόδιο. Επανεξετάζω το πρότυπο και την πολικότητα των προηγούμενων επεισοδίων, τα ατομικά πρώιμα προειδοποιητικά σημεία και τους εκλυτικούς παράγοντες, την τήρηση της αγωγής, τη σταθερότητα του ύπνου και των κιρκάδιων ρυθμών, τη χρήση ουσιών, τον κίνδυνο αυτοκτονίας, την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση και τις ανάγκες της οικογένειας ή των φροντιστών.

Η διπολική διαταραχή είναι συνήθως υποτροπιάζουσα, επομένως η θεραπεία συντήρησης είναι συχνά μακροχρόνια και μπορεί να συνεχίζεται επ' αόριστον μετά από επανειλημμένα ή σοβαρά επεισόδια. Δεν υπάρχει μία καθολική ημερομηνία διακοπής. Η επιλογή θεραπείας συντήρησης βασίζεται στην προηγούμενη ανταπόκριση, στην πολικότητα των υποτροπών, στην ανεκτικότητα, στη συννοσηρότητα και στις προτιμήσεις του ασθενούς.

Το λίθιο παραμένει κεντρική επιλογή πρώτης γραμμής και συχνά θεραπεία αναφοράς για τη μακροχρόνια διπολική διαταραχή. Έχει ιδιαίτερη αξία όταν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό και είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο ασθενή. Άλλες καθιερωμένες επιλογές περιλαμβάνουν **κουετιαπίνη, λαμοτριγίνη, βαλπροϊκό/διβαλπροϊκό και επιλεγμένα αντιψυχωσικά**, με την επιλογή να ακολουθεί το ιστορικό ανταπόκρισης και την πολικότητα των υποτροπών και όχι την υπόθεση ότι κάθε φάρμακο προλαμβάνει εξίσου αποτελεσματικά και τη μανία και την κατάθλιψη.

Η ειδικότητα ως προς την πολικότητα έχει σημασία. Η λαμοτριγίνη έχει ισχυρότερο ρόλο στην πρόληψη καταθλιπτικών υποτροπών και δεν αποτελεί θεραπεία οξείας μανίας. Η αριπιπραζόλη έχει ισχυρότερη τεκμηρίωση για την πρόληψη μανιακών υποτροπών, ενώ το λίθιο και η κουετιαπίνη έχουν ευρύτερο ρόλο συντήρησης. Πρόκειται για χρήσιμες κατευθύνσεις και όχι για άκαμπτη κατάταξη που ισχύει για κάθε ασθενή.

Η φαρμακοθεραπεία είναι μόνο ένα μέρος της συντήρησης. **Ψυχοεκπαίδευση,**

υποστήριξη της τήρησης της αγωγής, αναγνώριση των προσωπικών πρώιμων προειδοποιητικών σημείων, οικογενειακές ή CBT-informed παρεμβάσεις όπου είναι κατάλληλες, σταθερός ύπνος και καθημερινή ρουτίνα και αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών συμβάλλουν στην πρόληψη υποτροπών. Ψυχοεκπαιδευτικές, οικογενειακές ή παρεμβάσεις βασισμένες στους ρυθμούς μπορούν να μειώσουν υποτροπές και να βελτιώσουν την αυτοδιαχείριση σε επιλεγμένους πληθυσμούς, χωρίς να μετατρέπουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης σε καθολικό αποτέλεσμα.

Η σωματική υγεία χρειάζεται ενεργή παρακολούθηση, με έλεγχο βάρους, μεταβολικού και καρδιαγγειακού κινδύνου και των ειδικών ανεπιθύμητων ενεργειών της θεραπείας. Το λίθιο έχει επίσης τεκμηρίωση για μείωση του κινδύνου αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού στις διαταραχές διάθεσης, γεγονός που αποτελεί πρόσθετο λόγο να προτιμάται σε κατάλληλους ασθενείς. Το μέγεθος του οφέλους ποικίλλει μεταξύ μελετών και δεν μηδενίζει τον αυτοκτονικό κίνδυνο.

Αν εξετάζεται διακοπή θεραπείας, η απόφαση εξατομικεύεται με βάση τον αριθμό και τη βαρύτητα των προηγούμενων επεισοδίων, την ψύχωση, τις συνέπειες μιας υποτροπής, τα υπολειμματικά συμπτώματα, το προηγούμενο πρότυπο υποτροπών, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την προτίμηση του ασθενούς. Η διακοπή πρέπει να είναι **σταδιακή**, με σαφές πλάνο παρακολούθησης και έγκαιρης αναγνώρισης υποτροπής.

Όταν εξετάζεται **βαλπροϊκό** για συντήρηση, οι σύγχρονοι αναπαραγωγικοί περιορισμοί παραμένουν αναπόσπαστοι. Αντενδείκνυται για διπολική διαταραχή κατά την κύηση. Σε κορίτσια και γυναίκες που μπορούν να κυοφορήσουν, αντενδείκνυται εκτός αν πληρούνται οι όροι του Pregnancy Prevention Programme και οι εναλλακτικές θεραπείες είναι αναποτελεσματικές ή μη ανεκτές. Στους άνδρες, οι ισχύουσες ευρωπαϊκές προφυλάξεις απαιτούν εξειδικευμένη ενημέρωση για το πιθανό νευροαναπτυξιακό σήμα κινδύνου από πατρική έκθεση, αποτελεσματική αντισύλληψη για τον άνδρα και τη γυναίκα σύντροφο κατά τη θεραπεία και για τουλάχιστον **3 μήνες μετά τη διακοπή**, και αποφυγή δωρεάς σπέρματος στο ίδιο διάστημα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Στόχος λιθίου στη συντήρηση: 0,6–0,8 mmol/L** κατά NICE.
- **Επιλεγμένο υψηλότερο εύρος:** μπορεί να εξεταστεί **0,8–1,0 mmol/L** όταν έχει υπάρξει υποτροπή υπό λίθιο ή επιμένουν υποοιδικά συμπτώματα με λειτουργική επιβάρυνση.
- **Χρόνος αιμοληψίας λιθίου:** περίπου **12 ώρες μετά τη δόση**.
- **Λίθιο και αυτοκτονία:** η τεκμηρίωση υποστηρίζει μείωση του κινδύνου αυτοκτονίας/αυτοτραυματισμού, χωρίς ένα καθολικό ποσοστό μείωσης.
- **Πολικότητα συντήρησης:** λαμοτριγίνη ισχυρότερη για πρόληψη καταθλιπτικών υποτροπών· αριπιπραζόλη ισχυρότερη για μανιακές· λίθιο και κουετιαπίνη έχουν ευρύτερο ρόλο.
- **Η μακροχρόνια φροντίδα δεν είναι μόνο φάρμακα:** ψυχοεκπαίδευση, αναγνώριση ατομικών πρώιμων σημείων υποτροπής, τήρηση αγωγής, ύπνος/ρυθμοί, σωματική υγεία και λειτουργική αποκατάσταση είναι βασικά στοιχεία.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Απλή συνέχιση του οξέος φαρμάκου επ' αόριστον χωρίς συνεκτίμηση πολικότητας ή προηγούμενης ανταπόκρισης.
- Παράβλεψη ψυχοεκπαίδευσης, τήρησης αγωγής και σωματικής υγείας.
- Παράθεση ενός σταθερού ποσοστού πρόληψης αυτοκτονίας από λίθιο.
- Θεώρηση όλων των φαρμάκων συντήρησης ως εξίσου αποτελεσματικών και για τους δύο πόλους.
- Αναφορά βαλπροϊκού χωρίς τους σύγχρονους αναπαραγωγικούς περιορισμούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Λίθιο: μια συνοπτική απάντηση συντήρησης πρέπει να μπορεί να αναφέρει **0,6–0,8 mmol/L**, σε επιλεγμένες περιπτώσεις **0,8–1,0 mmol/L**, και αιμοληψία στις **12 ώρες**, χωρίς να μετατρέπεται σε πλήρη ερώτηση παρακολούθησης λιθίου.

Βαλπροϊκό: παλαιότερες απαντήσεις μπορεί να το αναφέρουν χωρίς επιφυλάξεις. Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πρακτική απαιτεί τους αναπαραγωγικούς περιορισμούς κάθε φορά που το βαλπροϊκό εξετάζεται ουσιαστικά.

Πώς αναγνωρίζετε και αντιμετωπίζετε την επιλόχεια ψύχωση;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ψυχιατρικό επείγον, συνήθως μέσα στις πρώτες 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό
- 2 Διακυμαινόμενο συναισθηματικό, ψυχωσικό και αποδιοργανωμένο σύνδρομο
- 3 Ισχυρή σχέση με το διπολικό φάσμα
- 4 Εκτίμηση ασφάλειας μητέρας και βρέφους και αποκλεισμός σωματικών αιτιών
- 5 Επείγουσα νοσηλεία· μονάδα μητέρας-βρέφους όπου είναι διαθέσιμη
- 6 Αντιψυχωσικό ± λίθιο· πρώιμη ECT όταν χρειάζεται
- 7 Θηλασμός: εκτίμηση ανά συγκεκριμένο φάρμακο
- 8 Προφύλαξη σε μελλοντικές κυήσεις

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιλόχεια ψύχωση αποτελεί **ψυχιατρικό επείγον**. Συνήθως αρχίζει αιφνίδια στην άμεση επιλόχεια περίοδο, συχνότερα μέσα στις **πρώτες 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό**, και μπορεί να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα. Το σύνδρομο είναι συχνά τόσο συναισθηματικό όσο και ψυχωσικό, γι' αυτό σκέφτομαι έντονα νόσο του διπολικού φάσματος και όχι απλώς «σχιζοφρένεια μετά τον τοκετό».

Η εικόνα μπορεί να μεταβάλλεται έντονα και να περιλαμβάνει **μανία ή μικτά χαρακτηριστικά**, σοβαρή κατάθλιψη, έντονη αϋπνία, διέγερση, παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις, σύγχυση, αποδιοργάνωση και διαταραγμένη συμπεριφορά. Επειδή η κατάσταση μπορεί να αλλάζει μέσα σε σύντομο χρόνο, οι ετεροαναφορικές πληροφορίες από οικογένεια ή φροντιστές είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η **ασφάλεια**. Εκτιμώ τον κίνδυνο αυτοκτονίας, σκέψεις ή συμπεριφορές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το βρέφος, την ικανότητα της μητέρας να παρέχει ασφαλή φροντίδα, τη σοβαρή διέγερση, την ψύχωση, την κατατονία και τυχόν σύγχυση ή ντελίριο. Παράλληλα εξετάζω **μαιευτικά, σωματικά και σχετιζόμενα με ουσίες αίτια οξείας σύγχυσης ή ψύχωσης**, χωρίς να θεωρώ ότι κάθε επιλόχεια εικόνα είναι πρωτοπαθής ψυχιατρική διαταραχή.

Χρειάζεται επείγουσα εξειδικευμένη εκτίμηση και **συνήθως απαιτείται νοσηλεία**. Όπου υπάρχει δυνατότητα, προτιμάται εξειδικευμένη **μονάδα μητέρας-βρέφους**, ώστε η θεραπεία της μητέρας, η ασφάλεια του βρέφους και η σχέση μητέρας-βρέφους να αντιμετωπίζονται μαζί. Οι μαιευτικές και περιγεννητικές υπηρεσίες εμπλέκονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Στην οξεία θεραπεία συνήθως χρειάζεται **αντιψυχωσικό**. Το **λίθιο** εξετάζεται ή προστίθεται όπου είναι κλινικά κατάλληλο, ιδίως λόγω της στενής σχέσης της επιλόχειας ψύχωσης με το διπολικό φάσμα και του ρόλου του στην πρόληψη υποτροπών. Βενζοδιαζεπίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί βραχυχρόνια όταν η σοβαρή διέγερση ή αϋπνία χρειάζεται πρόσθετο έλεγχο, χωρίς να αποτελεί την κύρια θεραπεία.

Η ECT πρέπει να εξετάζεται **έγκαιρα** όταν απαιτείται ταχεία ανταπόκριση, ιδίως σε σοβαρή ή ανθεκτική νόσο, κατατονία, ακραία διέγερση ή κίνδυνο αυτοκτονίας ή βρεφοκτονίας. Δεν είναι θεραπεία που κρατάμε υποχρεωτικά για μετά από παρατεταμένη αποτυχία όλων των άλλων επιλογών.

Οι αποφάσεις για τον θηλασμό απαιτούν εξατομικευμένη **εκτίμηση οφέλους-κινδύνου ανά συγκεκριμένο φάρμακο**, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο υποτροπής της μητέρας, την έκθεση του βρέφους και τη σωματική του ευαλωτότητα. Δεν είναι σωστό να χαρακτηρίζονται γενικά τα ψυχιατρικά φάρμακα ως «ασφαλή» ή «μη ασφαλή» στον θηλασμό. Οι ισχύουσες οδηγίες συμβουλεύουν αποφυγή θηλασμού κατά τη λήψη **λιθίου, κλοζαπίνης ή καρβαμαζεπίνης**.

Η μακροχρόνια φροντίδα πρέπει να περιλαμβάνει **πρόληψη υποτροπών**. Το λίθιο έχει την ισχυρότερη τεκμηρίωση για πρόληψη μετά από επιλόχεια ψύχωση και αποτελεί σημαντική προφυλακτική επιλογή σε γυναίκες με προηγούμενο επεισόδιο. Ιστορικό επιλόχειας ψύχωσης ή διπολικής διαταραχής τύπου I συνεπάγεται **υψηλό κίνδυνο υποτροπής μετά τον τοκετό**, αλλά το ακριβές ποσοστό μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με το ιστορικό και τη θεραπεία και δεν πρέπει να αποστηθίζεται ως ένας ενιαίος αριθμός. Οι μελλοντικές κυήσεις απαιτούν εξειδικευμένο σχεδιασμό πριν από τη σύλληψη, σαφές πλάνο πρόληψης κατά την κύηση και μετά τον τοκετό και εξέταση άμεσης προφύλαξης μετά τον τοκετό σε γυναίκες υψηλού κινδύνου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η επιλόχεια ψύχωση αρχίζει συχνά αιφνίδια μέσα στις **πρώτες 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό**.
- Συνδέεται στενά με **νόσο του διπολικού φάσματος**.
- Ευρύ επιδημιολογικό σημείο αναφοράς: περίπου **1–2 ανά 1.000 γεννήσεις** είναι κατά προσέγγιση στοιχείο και όχι διαγνωστικό όριο.
- Προηγούμενη επιλόχεια ψύχωση ή διπολική I σημαίνει **υψηλό κίνδυνο επιλόχειας υποτροπής**· δεν χρησιμοποιούμε ένα σταθερό ποσοστό για όλες τις γυναίκες.
- **Νοσηλεία σε μονάδα μητέρας-βρέφους** προτιμάται όπου είναι διαθέσιμη.
- Η ECT μπορεί να **χρησιμοποιηθεί έγκαιρα** όταν χρειάζεται ταχεία ανταπόκριση.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q27a. Πώς διαφέρει η επιλόχεια κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζεται;

Η επιλόχεια κατάθλιψη είναι **καταθλιπτικό σύνδρομο μετά τον τοκετό**, χωρίς την καθοριστική μανιακή, ψυχωσική ή αποδιοργανωμένη επείγουσα εικόνα της επιλόχειας ψύχωσης. Πρέπει επίσης να διακρίνεται από τα **maternity blues**, που είναι ήπια, βραχύχρονα και αυτοπεριοριζόμενα. Επίμονη κλινικά σημαντική κατάθλιψη, λειτουργική έκπτωση, αυτοκτονικότητα ή αδυναμία φροντίδας απαιτούν εκτίμηση για επιλόχεια κατάθλιψη.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει βαρύτητα, κίνδυνο αυτοκτονίας, ασφάλεια του βρέφους, λειτουργικότητα, σχέση και πλαίσιο φροντίδας του βρέφους, διαθέσιμη υποστήριξη, ιστορικό διπολικότητας και τυχόν ψυχωσικά συμπτώματα. Η θεραπεία ακολουθεί γενικά τις τεκμηριωμένες αρχές της κατάθλιψης, προσαρμοσμένες στην προηγούμενη ανταπόκριση, στον θηλασμό και στο μητρικό-βρεφικό πλαίσιο.

Σε ήπια ή μέτρια εικόνα μπορεί να είναι κατάλληλη καθοδηγούμενη αυτοβοήθεια ή δομημένη ψυχοθεραπεία. Σε μέτρια ή σοβαρή κατάθλιψη, μπορεί να επιλεγεί υψηλής έντασης ψυχοθεραπεία, αντικαταθλιπτικό ή συνδυασμός, ανάλογα με την προτίμηση, την προηγούμενη ανταπόκριση και τον κίνδυνο, με εξειδικευμένη περιγεννητική συμβολή όπου χρειάζεται. Σοβαρή, ψυχωσική, κατατονική ή απειλητική για τη ζωή κατάθλιψη μπορεί να απαιτήσει νοσηλεία και ECT.

Οι αποφάσεις για θηλασμό λαμβάνονται ξανά **ανά φάρμακο** και όχι με γενικές υποθέσεις για ολόκληρες κατηγορίες.

Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εξέλιξη είναι η **ζουρανολόνη**, η οποία έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ τον **Σεπτέμβριο 2025** για επιλόχεια κατάθλιψη σε ενήλικες μετά τον τοκετό. Χορηγείται ως **14ήμερη από του στόματος αγωγή** και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή να προστεθεί σε άλλο αντικαταθλιπτικό. Είναι χρήσιμο να αναγνωρίζεται ως σύγχρονη επιλογή, αλλά η ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας δεν αποδεικνύει συνήθη διαθεσιμότητα ή αποζημίωση στην Ελλάδα και δεν αντικαθιστά τις καθιερωμένες ψυχοθεραπευτικές και αντικαταθλιπτικές αλληλουχίες στη γενική απάντηση.

Άξονας ανάκλησης follow-up: κατάθλιψη vs blues vs ψύχωση → βαρύτητα/ασφάλεια/έλεγχος διπολικότητας → ψυχοθεραπεία/αντικαταθλιπτικό/συνδυασμός → προσαρμογή σε θηλασμό και περιγεννητικό πλαίσιο → ευρωπαϊκή ενημέρωση για ζουρανολόνη.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χαρακτηρισμός της επιλόχειας ψύχωσης ως «επιλόχειας σχιζοφρένειας».
- Παράβλεψη της ασφάλειας του βρέφους.
- Διαχείρισή της ως συνήθους εξωνοσοκομειακής κατάθλιψης.
- Παράβλεψη σωματικών ή μαιευτικών αιτίων σύγχυσης και ψύχωσης.
- Γενικευμένοι ισχυρισμοί περί ασφάλειας φαρμάκων στον θηλασμό.
- Παράθεση σταθερών ποσοστών επιλόχειας υποτροπής ως καθολικών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Επιλόχεια κατάθλιψη: η ζουρανολόνη δεν αποτελεί πλέον εξέλιξη μόνο των ΗΠΑ· διαθέτει ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας από τον Σεπτέμβριο 2025. Αυτό το ρυθμιστικό καθεστώς δεν πρέπει να μετατρέπεται σε ισχυρισμό περί επιβεβαιωμένης διαθεσιμότητας ή αποζημίωσης στην Ελλάδα.

Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή πανικού και την αγοραφοβία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αναγνώριση της κρίσης πανικού
- 2 Υποτροπιάζουσες απροσδόκητες κρίσεις + επίμονη ανησυχία ή μεταβολή συμπεριφοράς
- 3 Αποκλεισμός σωματικών αιτίων, ουσιών και φαρμάκων
- 4 Ανεξάρτητη εκτίμηση της αγοραφοβίας
- 5 CBT με ενδοδεκτική και καταστασιακή έκθεση
- 6 SSRI/SNRI όταν ενδείκνυται φαρμακοθεραπεία

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή πανικού χαρακτηρίζεται από **υποτροπιάζουσες απροσδόκητες κρίσεις πανικού**, οι οποίες ακολουθούνται από επίμονη ανησυχία για νέες κρίσεις ή τις συνέπειές τους και/ή από δυσλειτουργική μεταβολή της συμπεριφοράς. Η κρίση πανικού είναι διαδιαγνωστικό φαινόμενο· μία ή ακόμη και περισσότερες κρίσεις δεν αρκούν για να τεθεί διάγνωση διαταραχής πανικού. Η αγοραφοβία αξιολογείται πλέον ως ξεχωριστή διάγνωση και όχι απλώς ως προσδιοριστής της διαταραχής πανικού.

Η κρίση πανικού είναι αιφνίδια έξαρση έντονου φόβου ή δυσφορίας, με έντονα σωματικά και γνωστικά συμπτώματα. Μπορεί να περιλαμβάνει αίσθημα παλμών, θωρακική δυσφορία, δύσπνοια, ζάλη, τρόμο, εφίδρωση, παραισθησίες και φόβο απώλειας ελέγχου ή θανάτου. Στη διαταραχή πανικού διερευνώ αν οι κρίσεις είναι πραγματικά **απροσδόκητες**, πόσο συχνά επανεμφανίζονται, αν έχει αναπτυχθεί άγχος προσμονής και αν ο φόβος νέων κρίσεων έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά ή τη λειτουργικότητα.

Εξετάζω επίσης το ευρύτερο κλινικό πλαίσιο, επειδή παρόμοια συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, σε σωματικά νοσήματα ή σε καταστάσεις που σχετίζονται με ουσίες. Το ιστορικό πρέπει να περιλαμβάνει φάρμακα και ουσίες, τοξίκωση ή στέρηση όταν είναι σχετικές, καθώς και στοιχεία που υποδηλώνουν καρδιακό, αναπνευστικό, ενδοκρινολογικό ή νευρολογικό αίτιο. Ο παρακλινικός έλεγχος καθοδηγείται από την κλινική εικόνα και δεν ζητείται ως ίδιο, καθολικό πακέτο εξετάσεων για όλους.

Η **αγοραφοβία** αξιολογείται ανεξάρτητα. Το κεντρικό πρόβλημα είναι ο έντονος και επίμονος φόβος ή η αποφυγή καταστάσεων στις οποίες η διαφυγή μπορεί να φαίνεται δύσκολη ή η βοήθεια να μην είναι διαθέσιμη αν εμφανιστούν συμπτώματα που προκαλούν έντονη δυσφορία ή ανικανότητα. Συμπτώματα πανικού είναι συχνά, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Επομένως, διαταραχή πανικού και αγοραφοβία μπορούν να συνυπάρχουν όταν πληρούνται ανεξάρτητα και οι δύο διαγνώσεις, αλλά κρίσεις που εμφανίζονται μόνο μέσα στις φοβικές αγοραφοβικές καταστάσεις δεν θεμελιώνουν αυτόματα διαταραχή πανικού.

Η θεραπεία πρέπει να εξηγεί τον φαύλο κύκλο του πανικού και να αναστρέφει την

αποφυγή. Η CBT είναι κεντρική και περιλαμβάνει γνωσιακή επεξεργασία μαζί με **ενδοδεκτική έκθεση** στις φοβούμενες σωματικές αισθήσεις και **σταδιακή καταστασιακή έκθεση** όταν υπάρχει αγοραφοβική αποφυγή. Η ενδοδεκτική έκθεση προκαλεί σκόπιμα τις φοβούμενες σωματικές αισθήσεις ώστε να ελεγχθούν και να αποδυναμωθούν οι καταστροφολογικές ερμηνείες και η αποφυγή· δεν περιορίζεται σε απλή καθησύχηση ότι τα συμπτώματα είναι ακίνδυνα.

Όταν ενδείκνυται ή προτιμάται φαρμακοθεραπεία, οι **SSRIs** αποτελούν βασική μακροχρόνια επιλογή και οι **SNRIs** είναι επίσης τεκμηριωμένες επιλογές. Οι βενζοδιαζεπίνες **δεν συνιστώνται ως συνήθης μακροχρόνια θεραπεία**, λόγω ανοχής, εξάρτησης και δυσκολιών στη μακροχρόνια διαχείριση, και δεν πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα του θεραπευτικού πλάνου.

Συνοπτικά, διακρίνω την κρίση πανικού από τη διαταραχή πανικού, αποκλείω σημαντικά δευτεροπαθή αίτια, αξιολογώ την αγοραφοβία ανεξάρτητα και αντιμετωπίζω τον φαύλο κύκλο καταστροφολογικής ερμηνείας και αποφυγής με CBT βασισμένη στην έκθεση, με SSRI ή SNRI όταν είναι κατάλληλο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Οι κρίσεις πανικού είναι **διαδιαγνωστικό φαινόμενο** και δεν ταυτίζονται με τη διαταραχή πανικού.
- **Διαταραχή πανικού κατά DSM:** μετά από υποτροπιάζουσες απροσδόκητες κρίσεις, τουλάχιστον **1 μήνας** επίμονης ανησυχίας για νέες κρίσεις/συνέπειες ή δυσλειτουργικής μεταβολής της συμπεριφοράς.
- **Αγοραφοβία κατά DSM:** φόβος/άγχος σε τουλάχιστον **2 κατηγορίες καταστάσεων** που επιμένει για τουλάχιστον **6 μήνες**. Πρόκειται για σημεία αναφοράς ειδικά του DSM· δεν πρέπει να υποκαθιστούν σιωπηρά τη διατύπωση του ICD-11.
- **Στο ICD-11:** διαταραχή πανικού και αγοραφοβία είναι ανεξάρτητες διαγνώσεις.
- **Ενδοδεκτική έκθεση:** στοχεύει την καταστροφολογική ερμηνεία και την αποφυγή σωματικών αισθήσεων, προκαλώντας τες ελεγχόμενα μέσα στη θεραπεία.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ταύτιση κάθε κρίσης πανικού με διαταραχή πανικού.
- Παράβλεψη καρδιακών, ενδοκρινολογικών, ουσιολογικών ή στερητικών αιτίων.
- Αντιμετώπιση της αγοραφοβίας μόνο ως επιπλοκής ή προσδιοριστή της διαταραχής πανικού.
- Τοποθέτηση των βενζοδιαζεπινών στο κέντρο της μακροχρόνιας θεραπείας.
- Χαρακτηρισμός των μακροχρόνιων βενζοδιαζεπινών ως καθολικά «αντενδείκνυται» αντί για «δεν συνιστώνται ως συνήθης μακροχρόνια αντιμετώπιση».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ταξινομική ενημέρωση: η παλαιότερη αρχιτεκτονική «διαταραχή πανικού με/χωρίς αγοραφοβία» είναι ιστορική. Το ICD-11 αντιμετωπίζει τη διαταραχή πανικού και την αγοραφοβία ως ξεχωριστές διαγνώσεις που μπορούν να συνυπάρχουν.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επίμονη, υπερβολική ανησυχία σε πολλούς τομείς
- 2 Δυσκολία ελέγχου της ανησυχίας + τάση/αυτόνομα συμπτώματα
- 3 Διάρκεια και λειτουργική επίπτωση στο συγκεκριμένο ταξινομικό σύστημα
- 4 Αποκλεισμός άλλων ψυχιατρικών και δευτεροπαθών αιτίων
- 5 CBT ως βασική θεραπεία
- 6 SSRI πρώτης γραμμής · SNRI εναλλακτικά
- 7 Πρεγκαμπαλίνη κυρίως όταν SSRI/SNRI δεν είναι ανεκτά

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή είναι σύνδρομο **επίμονης, υπερβολικής και δύσκολα ελεγχόμενης ανησυχίας σε πολλούς τομείς της ζωής**, με κλινικά σημαντική δυσφορία ή λειτουργική έκπτωση. Είναι ευρύτερη και πιο παρατεταμένη από τις μεμονωμένες κρίσεις πανικού ή από το άγχος που περιορίζεται σε συγκεκριμένες φοβικές καταστάσεις. Η διάγνωση επομένως βασίζεται στο διάχυτο πρότυπο, τη διάρκειά του και την επίδρασή του στη λειτουργικότητα, όχι απλώς στο ότι ο ασθενής δηλώνει ότι «είναι αγχώδης».

Η ανησυχία είναι συνήθως παρούσα τις περισσότερες ημέρες και μπορεί να αφορά την υγεία, την οικογένεια, την εργασία, τα οικονομικά ή άλλους καθημερινούς τομείς. Συνοδά συμπτώματα μπορεί να είναι κινητική ανησυχία ή τάση, εκδηλώσεις αυτόνομης διέγερσης, κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα και διαταραχή ύπνου. Το κεντρικό κλινικό στοιχείο είναι ο συνδυασμός γενικευμένης ανησυχίας προσμονής και δυσκολίας αποδέσμευσης από αυτήν, όχι ένα μόνο φοβικό αντικείμενο ή κατάσταση.

Καταγράφω προσεκτικά τη **χρονική πορεία**. Στο ICD-11 το σύνδρομο πρέπει να επιμένει για τουλάχιστον **αρκετούς μήνες**. Το DSM διατηρεί απαίτηση διάρκειας τουλάχιστον **6 μηνών** και, στους ενήλικες, τουλάχιστον **3 συνοδών συμπτωμάτων**. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία είναι ειδικά για το DSM και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως καθολικοί κανόνες όλων των συστημάτων.

Η διαφορική διάγνωση είναι σημαντική, επειδή η χρόνια ανησυχία εμφανίζεται σε πολλές καταστάσεις. Ο καταθλιπτικός ιδεομνηστικός οργανώνεται γύρω από καταθλιπτικά θέματα και το καταθλιπτικό σύνδρομο· η διαταραχή πανικού γύρω από υποτροπιάζουσες κρίσεις και φόβο νέων κρίσεων· η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή γύρω από παρεισφρητικές ιδεοληψίες και καταναγκασμούς· το άγχος υγείας γύρω από επίμονη ενασχόληση με νόσο. Επίσης εξετάζω ουσίες, φάρμακα και σχετικά σωματικά αίτια όταν η εικόνα ή η χρονική αλληλουχία τα καθιστούν πιθανά.

Η θεραπεία πρέπει να είναι **συνεργατική** και να προσαρμόζεται στη βαρύτητα, τη λειτουργική έκπτωση, τις προτιμήσεις του ασθενούς και το πλαίσιο φροντίδας. Η CBT αποτελεί βασική τεκμηριωμένη θεραπεία. Στοχεύει στις διεργασίες που

συντηρούν τη χρόνια ανησυχία, όπως οι δυσλειτουργικές στρατηγικές διαχείρισης της ανησυχίας και η δυσανεξία στην αβεβαιότητα, και δεν περιορίζεται σε καθησυχασμό για κάθε επιμέρους φόβο. Η εφαρμοσμένη χαλάρωση και παρεμβάσεις CBT χαμηλότερης έντασης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τη βαρύτητα και την οργάνωση της φροντίδας.

Όταν χρησιμοποιείται φαρμακοθεραπεία, ένα **SSRI** αποτελεί την κύρια επιλογή πρώτης γραμμής. Αν το πρώτο SSRI είναι αναποτελεσματικό ή μη ανεκτό, ένα άλλο SSRI ή ένα **SNRI** είναι συνήθης επόμενη επιλογή. Η **πρεγκαμπαλίνη** τοποθετείται καλύτερα ως εναλλακτική που υποστηρίζεται από κατευθυντήριες οδηγίες όταν SSRI ή SNRI δεν είναι ανεκτά, και όχι ως συνήθης ισοδύναμη πρώτη γραμμή. Οι βενζοδιαζεπίνες περιορίζονται σε βραχυχρόνια χρήση σε κρίση και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε χρόνια θεραπεία της διαταραχής.

Συνοπτικά, αναγνωρίζω το σύνδρομο της χρόνιας διάχυτης ανησυχίας, το διακρίνω από επεισοδιακό ή ειδικό άγχος και από δευτεροπαθή αίτια, και χρησιμοποιώ CBT και/ή σεροτονινεργική φαρμακοθεραπεία ως κύριες μακροχρόνιες θεραπείες, αποφεύγοντας τη χρόνια εξάρτηση από βενζοδιαζεπίνες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR:** υπερβολική, δύσκολα ελεγχόμενη ανησυχία για τουλάχιστον 6 μήνες με τουλάχιστον 3 συνοδά συμπτώματα στους ενήλικες.
- **ICD-11:** συμπτώματα για τουλάχιστον αρκετούς μήνες, χωρίς τον σταθερό κανόνα των 6 μηνών του DSM.
- **CBT:** στοχεύει τη διεργασία της ανησυχίας και τη δυσανεξία στην αβεβαιότητα, όχι απλώς το περιεχόμενο κάθε ανησυχίας.
- **Πρεγκαμπαλίνη:** συνδέεται με την **α2δ υπομονάδα των τασεοελεγχόμενων διαύλων ασβεστίου**, μειώνοντας την απελευθέρωση διεγερτικών νευροδιαβιβαστών· η θέση της στη θεραπευτική ακολουθία εξαρτάται από τις κατευθυντήριες οδηγίες.
- **Βουσπιρόνη:** μερικός αγωνιστής **5-HT_{1A}**· χρήσιμο φαρμακολογικό follow-up, όχι καθολικό φάρμακο πρώτης γραμμής για GAD.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Παρουσίαση του κανόνα των 6 μηνών του DSM ως καθολικού.
- Ταύτιση της GAD με «αγχώδη προσωπικότητα».
- Παράβλεψη κατάθλιψης, OCD, σωματικών ή ουσιολογικών αιτιών.
- Παρουσίαση πρεγκαμπαλίνης, βουσπιρόνης ή βενζοδιαζεπινών ως ισοδύναμων συνήθων πρώτων επιλογών με CBT/SSRIs.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διάρκεια: το DSM χρησιμοποιεί όριο 6 μηνών και αριθμητικό όριο συνοδών συμπτωμάτων στους ενήλικες, ενώ το ICD-11 αναφέρεται σε τουλάχιστον αρκετούς μήνες. Δηλώνουμε το σύστημα και δεν αναμειγνύουμε τα δύο.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή κοινωνικού άγχους;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Φόβος κοινωνικής παρατήρησης και αρνητικής αξιολόγησης
- 2 Αποφυγή ή παραμονή στην κατάσταση με έντονο άγχος και λειτουργική έκπτωση
- 3 Διάκριση από φυσιολογική συστολή
- 4 Διαφοροδιάγνωση από αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας και αυτισμό
- 5 Ατομική, ειδική για τη διαταραχή CBT πρώτης επιλογής
- 6 SSRI όταν η CBT απορρίπτεται και προτιμάται φαρμακοθεραπεία

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή κοινωνικού άγχους χαρακτηρίζεται από έντονο φόβο ή άγχος σε κοινωνικές καταστάσεις λόγω της προσδοκίας ότι το άτομο θα παρατηρηθεί, θα εκτεθεί, θα ντραπεί ή θα αξιολογηθεί αρνητικά, με αποτέλεσμα αποφυγή ή παραμονή στην κατάσταση με έντονο άγχος και κλινικά σημαντική λειτουργική επιβάρυνση. Δεν αρκεί η έντονη συστολή· ο φόβος πρέπει να οργανώνει τη συμπεριφορά και να επηρεάζει ουσιαστικά τη ζωή του ατόμου.

Διευκρινίζω ποιες κοινωνικές καταστάσεις προκαλούν φόβο, τι ακριβώς προβλέπει ο ασθενής ότι θα συμβεί, πόση αποφυγή έχει αναπτυχθεί και ποιο είναι το κόστος κοινωνικά, εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά. Αναζητώ επίσης συμπεριφορές ασφάλειας και υπερβολική αυτοεστιασμένη προσοχή, επειδή μπορούν να συντηρούν τη διαταραχή ακόμη και όταν η εμφανής αποφυγή είναι περιορισμένη.

Η διαφορική διάγνωση χρειάζεται προσοχή. Η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας είναι ένα ευρύτερο και διαχρονικό πρότυπο κοινωνικής αναστολής, αισθήματος ανεπάρκειας και υπερευαισθησίας στην κριτική σε πολλά πλαίσια. Η διαταραχή κοινωνικού άγχους οργανώνεται πιο συγκεκριμένα γύρω από τον φόβο της παρατήρησης και της αρνητικής αξιολόγησης. Οι δύο καταστάσεις μπορούν να συνυπάρχουν.

Ο αυτισμός είναι νευροαναπτυξιακή κατάσταση με επίμονες διαφορές στην κοινωνική επικοινωνία μαζί με περιορισμένα ή επαναλαμβανόμενα πρότυπα και/ή αισθητηριακές ιδιαιτερότητες. Ένα αυτιστικό άτομο μπορεί να αποφεύγει κοινωνικές καταστάσεις επειδή οι επικοινωνιακές ή αισθητηριακές απαιτήσεις είναι δύσκολες, χωρίς ο πρωτεύων μηχανισμός να είναι ο φόβος αρνητικής αξιολόγησης. Αυτισμός και κοινωνικό άγχος μπορούν να συνυπάρχουν, οπότε η διάγνωση βασίζεται στον μηχανισμό της αποφυγής και όχι στην κοινωνική απόσυρση από μόνη της.

Κατά NICE, η προτιμώμενη ψυχολογική θεραπεία πρώτης γραμμής είναι η ατομική CBT ειδικά προσαρμοσμένη στη διαταραχή κοινωνικού άγχους. Στοχεύει τους μηχανισμούς που τη συντηρούν: έκθεση και συμπεριφορικά πειράματα, μείωση των συμπεριφορών ασφάλειας και της αυτοεστιασμένης προσοχής, και γνωσιακή

επεξεργασία των φοβούμενων κοινωνικών προβλέψεων. Στο μοντέλο Clark–Wells, η εγκατάλειψη των συμπεριφορών ασφάλειας και η μετατόπιση της προσοχής από την εσωτερική αυτοπαρακολούθηση είναι κεντρικές τεχνικές· μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βιντεοσκοπημένη ανατροφοδότηση για τον έλεγχο διαστρεβλωμένων αναπαραστάσεων του εαυτού. Η γενική υποστηρικτική θεραπεία δεν είναι ισοδύναμη με αυτή την ειδική προσέγγιση.

Αν το άτομο αρνηθεί την CBT και προτιμά φαρμακοθεραπεία, το NICE συνιστά **SSRI**, με σερτραλίνη ή εσιταλοπράμη ως παραδείγματα. Άλλες φαρμακευτικές στρατηγικές μπορούν να εξεταστούν μετά από ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία, αλλά όταν δίνουμε απάντηση με βάση το NICE δεν παρουσιάζουμε CBT και φάρμακο ως αυτόματα ισότιμα πρώτα βήματα.

Οι β-αναστολείς δεν αποτελούν καθιερωμένη βασική θεραπεία της διαταραχής κοινωνικού άγχους. Μπορεί να μειώσουν περιφερικά αυτόνομα συμπτώματα σε επιλεγμένες καταστάσεις επίδοσης, αλλά δεν πρέπει να μετατρέπονται σε κεντρικό θεραπευτικό κανόνα ούτε να απομνημονεύεται συγκεκριμένη δόση ως βασικό εξεταστικό δεδομένο.

Συνοπτικά, διαγιγνώσκω επίμονο φόβο κοινωνικής παρατήρησης και αρνητικής αξιολόγησης με αποφυγή και λειτουργική έκπτωση, τον διακρίνω από ευρύτερα προσωπικότητας ή νευροαναπτυξιακά πρότυπα και, όταν απαντώ με βάση το NICE, προτιμώ ατομική ειδική CBT, με SSRI όταν η CBT απορρίπτεται και το άτομο προτιμά φαρμακοθεραπεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **NICE:** προσφέρεται πρώτα **ατομική, ειδική για τη διαταραχή CBT**· αν απορριφθεί και προτιμάται φάρμακο, προσφέρεται **SSRI** όπως σερτραλίνη ή εσιταλοπράμη.
- **Μηχανισμός CBT:** μείωση αυτοεστιασμένης προσοχής και συμπεριφορών ασφάλειας, έλεγχος των φοβούμενων προβλέψεων μέσω έκθεσης/συμπεριφορικών πειραμάτων και χρήση διορθωτικής ανατροφοδότησης όπου είναι χρήσιμη.
- **DSM-5-TR:** χρησιμοποιεί προσδιοριστή **performance-only**· ο παλιός τυπικός «γενικευμένος» υπότυπος δεν ισχύει πλέον.
- **Β-αναστολείς:** μπορεί να βοηθήσουν επιλεγμένα περιφερικά αυτόνομα συμπτώματα σε καταστάσεις επίδοσης, αλλά δεν αποτελούν βασική τεκμηριωμένη θεραπεία της διαταραχής.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χαρακτηρισμός της έντονης συστολής ως διαταραχής χωρίς λειτουργική έκπτωση.
- Σύγχυση αποφευκτικής διαταραχής προσωπικότητας ή αυτισμού με κοινωνικό άγχος βάσει ενός μόνο κοινού χαρακτηριστικού.
- Παρουσίαση CBT και φαρμακοθεραπείας ως αδιαφοροποίητου ζεύγους πρώτης γραμμής όταν χρησιμοποιείται το πλαίσιο NICE.
- Σύσταση β-αναστολέων ως τυπικής θεραπείας της διαταραχής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Θεραπευτική ιεράρχηση: σε απάντηση NICE, προηγείται η ειδική ατομική CBT· φαρμακοθεραπεία προσφέρεται όταν αυτή απορρίπτεται και ο ασθενής την προτιμά.

Ταξινομική διάκριση: το DSM χρησιμοποιεί performance-only specifier· το ICD-11 δεν οργανώνεται με τον ίδιο προσδιοριστή.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ορισμός ιδεοληψιών και καταναγκασμών από τη μορφή τους
- 2 Εναισθησία και λειτουργική επιβάρυνση
- 3 Διαφορική από ψύχωση, ιδεομηρυκασμό, OCPD και επαναληπτικές συμπεριφορές
- 4 CBT με έκθεση και παρεμπόδιση της απάντησης (ERP)
- 5 SSRI με επαρκώς μακρά δοκιμή
- 6 Βελτιστοποίηση εντός εγκεκριμένου εύρους πριν από επόμενες στρατηγικές
- 7 Κλομιπραμίνη ή εξειδικευμένη ενίσχυση όταν υπάρχει ανθεκτικότητα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ/OCD) ορίζεται από **ιδεοληψίες, καταναγκασμούς ή και τα δύο**, με δυσφορία, σημαντική κατανάλωση χρόνου ή λειτουργική έκπτωση. Το βασικό διαγνωστικό έργο είναι φαινομενολογικό: οι ιδεοληψίες είναι παρεισφρητικά και ανεπιθύμητα ψυχικά γεγονότα, ενώ οι καταναγκασμοί είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή νοερές πράξεις που χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τη δυσφορία ή να αποτρέψουν μια φοβούμενη συνέπεια. Η εναισθησία ποικίλλει, επομένως η πτωχή εναισθησία δεν μετατρέπει αυτομάτως την ΙΨΔ σε ψυχωτική διαταραχή.

Οι **ιδεοληψίες** είναι υποτροπιάζουσες παρεισφρητικές σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις/ενορμήσεις που το άτομο βιώνει ως ανεπιθύμητες και δυσφορικές και συνήθως προσπαθεί σε κάποιο βαθμό να αντισταθεί, να εξουδετερώσει ή να ελέγξει. Οι **καταναγκασμοί** είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή νοερές πράξεις που εκτελούνται ως απάντηση στις ιδεοληψίες ή σύμφωνα με άκαμπτους κανόνες, συνήθως για μείωση του άγχους ή αποτροπή μιας φοβούμενης έκβασης, παρότι είναι υπερβολικοί ή δεν συνδέονται ρεαλιστικά με την έκβαση αυτή.

Συχνά θέματα είναι η μόλυνση και ο καθαρισμός, η αμφιβολία και ο έλεγχος, η συμμετρία ή τακτοποίηση, οι ταμπού ή αποκρουστικές σκέψεις και οι νοερές τελετουργίες. Η διάγνωση όμως δεν βασίζεται σε λίστα θεμάτων· αυτό που μετρά είναι η μορφή και η λειτουργία του συμπτώματος.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει ψύχωση, καταθλιπτικό ιδεομηρυκασμό, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας (OCPD), αυτιστικού τύπου επαναληπτικές συμπεριφορές και φαινόμενα τικ. Στην ΙΨΔ, ακόμη και πεποιθήσεις με πολύ ισχυρή βεβαιότητα μπορεί να παραμένουν εντός της ιδεοληπτικής δομής όταν ταιριάζουν με το συνολικό σύνδρομο και δεν υπάρχουν άλλα ψυχωτικά στοιχεία. Η **OCPD** είναι διαφορετική: αποτελεί διαχρονικό πρότυπο προσωπικότητας και όχι διαταραχή παρεισφρητικών ιδεοληψιών και εξουδετερωτικών καταναγκασμών.

Η σύγχρονη ταξινόμηση εντάσσει την ΙΨΔ στις **ιδεοψυχαναγκαστικές και συναφείς διαταραχές**, όχι στις αγχώδεις διαταραχές.

Η θεραπεία έχει δύο βασικούς πυλώνες. Η κύρια ψυχοθεραπεία είναι η **CBT με έκθεση και παρεμπόδιση της απάντησης (ERP)**. Η έκθεση ενεργοποιεί το φοβούμενο ερέθισμα ή πρόβλεψη, ενώ η παρεμπόδιση της απάντησης εμποδίζει την τελετουργία ή εξουδετερωτική πράξη που θα μείωνε βραχυπρόθεσμα το άγχος. Έτσι διακόπτεται ο **κύκλος αρνητικής ενίσχυσης** ιδεοληψίας–καταναγκασμού και επιτρέπεται νέα μάθηση ότι η απειλή δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί μέσω της τελετουργίας. Η ανασταλτική μάθηση είναι χρήσιμο σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο, όχι ένας αποκλειστικός αποδεδειγμένος νευροβιολογικός μηχανισμός.

Στη φαρμακοθεραπεία, οι **SSRIs είναι πρώτης γραμμής**. Η ΙΨΔ συχνά χρειάζεται μεγαλύτερη διάρκεια δοκιμής από την κατάθλιψη. Αν μια συνήθης δόση είναι αναποτελεσματική αλλά ανεκτή μετά από περίπου **4–6 εβδομάδες**, μπορεί να εξεταστεί σταδιακή αύξηση εντός του **εγκεκριμένου δοσολογικού εύρους της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SmPC)**. Η συνολική δοκιμή πρέπει να είναι αρκετά μακρά, συχνά έως **12 εβδομάδες**. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι χρειάζονται 12 εβδομάδες στη μέγιστη δόση ούτε ότι η συστηματική υπέρβαση των εγκεκριμένων δόσεων αποτελεί καθιερωμένη πρακτική.

Αν αποτύχουν επαρκείς θεραπευτικές διαδρομές με SSRI και ERP, η **κλομιπραμίνη** παραμένει τεκμηριωμένη επιλογή επόμενης γραμμής, με μεγαλύτερο αντιχολινεργικό και καρδιαγγειακό φορτίο και μεγαλύτερη τοξικότητα σε υπερδοσολογία. Η **ενίσχυση με αντιψυχωσικό** είναι εξειδικευμένη στρατηγική για ανθεκτική ΙΨΔ μετά από ουσιαστική αποτυχία των συνήθων προσεγγίσεων· η αντιψυχωσική μονοθεραπεία δεν αποτελεί τυπική θεραπεία της ΙΨΔ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η ΙΨΔ ανήκει στις **ιδεοψυχαναγκαστικές και συναφείς διαταραχές**.
- **ERP**: η έκθεση ενεργοποιεί τη φοβούμενη πρόβλεψη και η παρεμπόδιση της απάντησης διακόπτει την τελετουργία που αλλιώς θα ενισχυόταν αρνητικά.
- **Βελτιστοποίηση SSRI**: αν η συνήθης δόση είναι ανεπαρκής και ανεκτή μετά από περίπου **4–6 εβδομάδες**, εξετάζεται σταδιακή αύξηση σύμφωνα με την **ΠΧΠ/SmPC**. η συνολική δοκιμή μπορεί να χρειαστεί έως **12 εβδομάδες**.
- Δεν διδάσκουμε ως συνήθη κανόνα τη συστηματική χρήση SSRI πάνω από τις εγκεκριμένες δόσεις.
- **Κλομιπραμίνη** μετά από επαρκή διαδρομή SSRI/CBT· **αντιψυχωσική ενίσχυση** μόνο ως εξειδικευμένη στρατηγική σε ανθεκτική ΙΨΔ.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q31a. Πώς διακρίνετε τη διαταραχή αποθησαύρισης από την ΙΨΔ;

Η διαταραχή αποθησαύρισης είναι **ξεχωριστή σύγχρονη διάγνωση του φάσματος των ιδεοψυχαναγκαστικών και συναφών διαταραχών**, όχι απλώς υπότυπος της ΙΨΔ. Κεντρικό στοιχείο είναι η **επίμονη δυσκολία απόρριψης αντικειμένων** ανεξάρτητα από την αντικειμενική τους αξία, με συσσώρευση και ακαταστασία που περιορίζουν τη χρήση των χώρων και προκαλούν δυσφορία ή έκπτωση. Η υπερβολική απόκτηση αντικειμένων είναι συχνή αλλά όχι απαραίτητη.

Οι πεποιθήσεις και παρορμήσεις διατήρησης αντικειμένων μπορεί να βιώνονται περισσότερο ως σύμφωνες με τον εαυτό και η εναισθησία να είναι περιορισμένη ή

απούσα, αλλά η διάκριση δεν βασίζεται σε απλό δίπολο εγω-συντονίας/εγω-δυστονίας. Η διαφορική περιλαμβάνει φυσιολογική συλλεκτική συμπεριφορά, ρεαλιστική διατήρηση λόγω στέρησης ή ανάγκης και ακαταστασία δευτεροπαθή σε άλλη κατάσταση.

Αν ζητηθεί θεραπεία, η βασική απάντηση είναι **εξειδικευμένη CBT** που στοχεύει την απόρριψη, την απόκτηση, τη λήψη αποφάσεων και την αποφυγή. Δεν υποθέτουμε ότι η συνήθης φαρμακοθεραπεία της ΙΨΔ έχει ισοδύναμη τεκμηρίωση στη διαταραχή αποθησαύρισης.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ταύτιση της ΙΨΔ με αγάπη για καθαριότητα, συμμετρία ή τάξη.
- Σύγχυση ιδεοληψίας με παραληρητική ιδέα ή με χαρακτηριστικά OCPD.
- Δήλωση αποτυχίας SSRI μετά από σύντομη δοκιμή τύπου κατάθλιψης.
- Διδασκαλία αυτόματης χορήγησης «υψηλών» δόσεων πάνω από την άδεια κυκλοφορίας.
- Άμεση μετάβαση σε κλομιπραμίνη ή αντιψυχωσική ενίσχυση πριν από επαρκή διαδρομή SSRI/ERP.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή μετατραυματικού στρες;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Έκθεση σε εξαιρετικά απειλητικό ή φρικτό γεγονός/γεγονότα
- 2 Επαναβίωση στο παρόν
- 3 Αποφυγή
- 4 Επίμονη αίσθηση τρέχουσας απειλής
- 5 Λειτουργική έκπτωση και διαφορική διάγνωση
- 6 Complex PTSD όταν συνυπάρχουν διαταραχές αυτο-οργάνωσης
- 7 Trauma-focused CBT ή EMDR πρώτης γραμμής

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) ακολουθεί έκθεση σε **εξαιρετικά απειλητικό ή φρικτό γεγονός ή σειρά γεγονότων** και ορίζεται από ένα ειδικό μετατραυματικό σύνδρομο, όχι απλώς από ψυχική δυσφορία μετά από τραύμα. Στο ICD-11 η βασική αρχιτεκτονική είναι σκόπιμα συμπαγής: **επαναβίωση στο παρόν, αποφυγή και επίμονη αίσθηση τρέχουσας απειλής**, με κλινικά σημαντική λειτουργική επίπτωση. Η θεραπεία δίνει προτεραιότητα σε ψυχοθεραπείες εστιασμένες στο τραύμα, κυρίως trauma-focused CBT ή EMDR.

Η **επαναβίωση στο παρόν** δεν είναι απλή ανάμνηση. Έχει ποιότητα «εδώ και τώρα», όπως έντονη παρεισφρητική αναβίωση, flashbacks ή εφιάλτες που σχετίζονται με το τραύμα. Η **αποφυγή** αφορά τόσο εσωτερικές υπενθυμίσεις, όπως σκέψεις και συναισθήματα, όσο και εξωτερικές, όπως πρόσωπα, τόπους ή καταστάσεις. Η **επίμονη αίσθηση τρέχουσας απειλής** μπορεί να εκδηλώνεται με υπερεγρήγορη ή υπερβολική αντίδραση ξαφνιάσματος.

Στη συνέχεια εκτιμώ τη λειτουργική έκπτωση, συνυπάρχουσα κατάθλιψη ή χρήση ουσιών, διασχιστικά συμπτώματα όπου είναι σχετικά και τον άμεσο κίνδυνο. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει οξείες αντιδράσεις στο στρες, διαταραχή προσαρμογής, καταθλιπτικές και άλλες αγχώδεις διαταραχές, διασχιστικές καταστάσεις, παρουσιάσεις σχετιζόμενες με ουσίες και σωματικά ή νευρολογικά αίτια όταν η κλινική εικόνα τα υποδηλώνει.

Η **Complex PTSD** στο ICD-11 απαιτεί το πλήρες σύνδρομο PTSD και επιπλέον διαταραχές της αυτο-οργάνωσης. Οι τρεις πρόσθετοι τομείς είναι **δυσρύθμιση του συναισθήματος, επίμονη αρνητική εικόνα εαυτού και δυσκολίες στις σχέσεις**. Δεν είναι απλώς «πολύ σοβαρή PTSD» και δεν ταυτίζεται με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, παρότι μπορεί να υπάρχουν επικαλύψεις.

Η **ατομική trauma-focused CBT** αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής. Το **EMDR** είναι επίσης καθιερωμένη θεραπεία πρώτης γραμμής για ενήλικες. Ο αμφοτερόπλευρος ερεθισμός αποτελεί μέρος του πρωτοκόλλου EMDR, αλλά ο ακριβής μηχανισμός του θεραπευτικού αποτελέσματος δεν έχει τεκμηριωθεί ως μία συγκεκριμένη αιτιολογική νευροβιολογική εξήγηση.

Η φαρμακοθεραπεία δεν πρέπει να προτιμάται συστηματικά από την

trauma-focused ψυχοθεραπεία όταν μια αποτελεσματική ψυχολογική θεραπεία είναι αποδεκτή και διαθέσιμη. Αν το άτομο προτιμά φάρμακο ή υπάρχει κλινικός λόγος, SSRI ή βενλαφαξίνη αποτελούν εύλογες επιλογές.

Σημαντική αρνητική σύσταση είναι ότι **δεν προσφέρεται ρουτίνα μονοσυνεδριακής ψυχολογικής αποφόρτισης (single-session debriefing) για πρόληψη ή θεραπεία PTSD**. Η πρώιμη υποστηρικτική φροντίδα μετά από τραύμα δεν ταυτίζεται με υποχρεωτικό debriefing.

Η πρακτική απάντηση είναι επομένως: επιβεβαιώνω το ειδικό μετατραυματικό σύνδρομο, το οργανώνω στους τρεις τομείς του ICD-11, εξετάζω Complex PTSD μόνο όταν υπάρχουν και οι πρόσθετες διαταραχές αυτο-οργάνωσης και προτιμώ trauma-focused CBT ή EMDR έναντι ρουτίνας φαρμακοθεραπείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **ICD-11 PTSD:** επαναβίωση στο παρόν + αποφυγή + επίμονη αίσθηση τρέχουσας απειλής.
- **DSM-5-TR:** τα συμπτώματα επιμένουν για **περισσότερο από 1 μήνα**· αυτό είναι DSM-specific χρονικό σημείο αναφοράς.
- **ICD-11 Complex PTSD:** PTSD + δυσρύθμιση συναισθήματος + επίμονη αρνητική εικόνα εαυτού + δυσκολίες στις σχέσεις.
- **EMDR:** τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία εστιασμένη στο τραύμα· ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο ο αμφοτερόπλευρος ερεθισμός συμβάλλει στο αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιος.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q32a. Ποιος είναι ο ρόλος της πραξοσίνης στους τραυματικούς εφιάλτες;

Η πραξοσίνη μπορεί να εξεταστεί για εφιάλτες **σχετιζόμενους με τραύμα σε ορισμένα πλαίσια κατευθυντήριων οδηγιών ή πληθυσμούς**, αλλά δεν αποτελεί καθολική θεραπεία πρώτης γραμμής για την PTSD. Η κύρια θεραπευτική αρχιτεκτονική παραμένει η trauma-focused ψυχοθεραπεία. Κάθε φάρμακο αντιστοιχίζεται στο σύμπτωμα-στόχο, στον συγκεκριμένο ασθενή και στην οδηγία που χρησιμοποιούμε, αντί να παρουσιάζεται ως ρουτίνα για όλους.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χαρακτηρισμός κάθε δυσφορίας μετά από τραύμα ως PTSD.
- Μετατροπή της απάντησης σε μακρύ κατάλογο κριτηρίων DSM.
- Παρουσίαση του routine psychological debriefing ως προληπτικής θεραπείας.
- Τοποθέτηση της φαρμακοθεραπείας πριν από trauma-focused ψυχοθεραπεία ως προεπιλογή.
- Παρουσίαση του αμφοτερόπλευρου ερεθισμού ως αποδεδειγμένου μηχανισμού αποτελεσματικότητας του EMDR.
- Παρουσίαση της πραξοσίνης ως καθολικής πρώτης γραμμής φαρμακοθεραπείας PTSD.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ταξινόμηση: το ICD-11 περιλαμβάνει επίσημη διάγνωση Complex PTSD. Το DSM-5-TR δεν έχει άμεσα ισοδύναμη κατηγορία.

Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την οξεία διαταραχή στρες από τη διαταραχή προσαρμογής;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Δηλώστε το ταξινομικό σύστημα
- 2 DSM ASD μετά από τραυματικό γεγονός που πληροί το σχετικό κριτήριο
- 3 DSM ASD: 3 ημέρες έως 1 μήνα
- 4 ICD-11 Acute Stress Reaction: δεν είναι ψυχική διαταραχή
- 5 Διαταραχή προσαρμογής μετά από ευρύτερο ψυχοκοινωνικό στρεσογόνο παράγοντα
- 6 Ενασχόληση με τον στρεσογόνο παράγοντα + αδυναμία προσαρμογής + λειτουργική επίπτωση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διάκριση αρχίζει από το **ταξινομικό σύστημα**, επειδή DSM και ICD δεν χρησιμοποιούν την ίδια αρχιτεκτονική. Το DSM-5-TR διατηρεί την Acute Stress Disorder (ASD) ως ψυχική διαταραχή μετά από έκθεση σε τραυματικό γεγονός που πληροί το σχετικό κριτήριο. Το ICD-11 δεν έχει ισοδύναμη διάγνωση ASD· η **Acute Stress Reaction** ρητά **δεν ταξινομείται ως ψυχική διαταραχή**. Η διαταραχή προσαρμογής είναι διαφορετική, επειδή μπορεί να ακολουθήσει πολύ ευρύτερο φάσμα ψυχοκοινωνικών στρεσογόνων παραγόντων.

Στην **ASD κατά DSM**, προηγείται έκθεση στο αντίστοιχο τραυματικό γεγονός. Το σύνδρομο περιλαμβάνει τουλάχιστον **9 συμπτώματα** από παρείσφρηση, αρνητική διάθεση, διάσχιση, αποφυγή και διέγερση, με κλινικά σημαντική δυσφορία ή έκπτωση και τους κατάλληλους αποκλεισμούς. Το βασικό χρονικό σημείο αναφοράς είναι **3 ημέρες έως 1 μήνα μετά το τραύμα**. Αν κλινικά σημαντικά μετατραυματικά συμπτώματα συνεχίζονται πέρα από τον μήνα, γίνεται επανεκτίμηση για PTSD· η διάγνωση δεν «μετατρέπεται» αυτόματα.

Αυτό το DSM κατασκεύασμα δεν πρέπει να εισάγεται στο ICD-11. Η **Acute Stress Reaction του ICD-11** περιγράφει παροδική αντίδραση εντός του φυσιολογικού φάσματος μετά από εξαιρετικό στρες. Συνήθως αρχίζει γρήγορα και υποχωρεί σε ημέρες ή περίπου μία εβδομάδα καθώς μειώνεται η άμεση απειλή ή οι συνέπειές της. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το ICD-11 **δεν την ταξινομεί ως ψυχιατρική διαταραχή**.

Η **διαταραχή προσαρμογής** ακολουθεί αναγνωρίσιμο ψυχοκοινωνικό στρεσογόνο παράγοντα, ο οποίος δεν χρειάζεται να πληροί κριτήριο τραύματος. Χαρακτηρίζεται από **επίμονη ενασχόληση με τον στρεσογόνο παράγοντα ή τις συνέπειές του και αδυναμία προσαρμογής**, με κλινικά σημαντική λειτουργική επίπτωση. Επομένως το σύνδρομο οργανώνεται γύρω από τη δυσπροσαρμογή σε έναν στρεσογόνο παράγοντα, όχι γύρω από το ειδικό οξύ μετατραυματικό σύνδρομο της ASD κατά DSM.

Τα χρονικά στοιχεία πρέπει και εδώ να συνδέονται με το σύστημα. Στο **DSM**, τα συμπτώματα της διαταραχής προσαρμογής αναμένεται να αρχίσουν εντός **3 μηνών** από τον στρεσογόνο παράγοντα και συνήθως να υποχωρούν εντός **6 μηνών** από τη

λήξη του ή των συνεπειών του. Στο **ICD-11**, η έναρξη είναι γενικά εντός περίπου **1 μηνός** και η διαταραχή συνήθως υποχωρεί εντός περίπου 6 μηνών αφού τελειώσει ο στρεσογόνος παράγοντας ή οι συνέπειές του, εκτός αν αυτός συνεχίζεται.

Άρα, στην προφορική εξέταση: **DSM ASD = τραυματο-ειδική ψυχική διαταραχή στο παράθυρο 3 ημερών-1 μήνα· ICD-11 Acute Stress Reaction = μη παθολογικοποιημένη αντίδραση σε εξαιρετικό στρες· διαταραχή προσαρμογής = δυσπροσαρμογή σε ευρύτερο στρεσογόνο παράγοντα, με ενασχόληση και λειτουργική επίπτωση.**

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM Acute Stress Disorder: 3 ημέρες έως 1 μήνα.**
- Συμπτώματα πέρα από 1 μήνα → επανεκτίμηση για PTSD, όχι αυτόματη μετατροπή.
- **ICD-11 Acute Stress Reaction: δεν είναι ψυχική διαταραχή.**
- **DSM διαταραχή προσαρμογής: έναρξη εντός 3 μηνών· συνήθως υποχωρεί εντός 6 μηνών μετά τη λήξη του στρεσογόνου παράγοντα/συνεπειών.**
- **ICD-11 διαταραχή προσαρμογής: γενικά έναρξη εντός περίπου 1 μηνός· δεν αναμειγνύουμε τα χρονικά όρια του DSM.**

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ανάμειξη DSM ASD με ICD-11 Acute Stress Reaction.
- Χαρακτηρισμός της ICD-11 Acute Stress Reaction ως ψυχιατρικής διαταραχής.
- Ισχυρισμός ότι η ASD γίνεται αυτόματα PTSD μετά από έναν μήνα.
- Παρουσίαση των χρονικών κανόνων του DSM για διαταραχή προσαρμογής ως κανόνων του ICD-11.
- Διάγνωση διαταραχής προσαρμογής μετά από οποιοδήποτε στρες χωρίς δυσπροσαρμογή και λειτουργική επίπτωση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ταξινομική διάκριση: η Acute Stress Disorder είναι διάγνωση DSM. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως τρέχουσα κατηγορία ICD-11 και κάθε χρονικό όριο πρέπει να αποδίδεται ρητά στο σύστημα από το οποίο προέρχεται.

Ποιες είναι οι κύριες διασχιστικές διαταραχές και πώς τις αξιολογείτε;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αποπροσωποποίηση και αποπραγματοποίηση
- 2 Διασχιστική αμνησία και προσδιοριστής φυγής
- 3 Διαταραχή της ταυτότητας
- 4 Διασχιστικά νευρολογικά συμπτώματα στο ICD-11
- 5 Φαινομενολογία, πορεία και ετεροαναφορικές πληροφορίες
- 6 Αποκλεισμός νευρολογικών, ουσιολογικών και άλλων ψυχιατρικών εξηγήσεων

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διάσχιση αφορά διαταραχές της φυσιολογικής ενοποίησης της εμπειρίας: της αίσθησης του εαυτού και του περιβάλλοντος, της αυτοβιογραφικής μνήμης, της ταυτότητας και, στο ICD-11, ορισμένων συμπτωμάτων νευρολογικού τύπου. Η εκτίμηση πρέπει να είναι **φαινομενολογική και διαφοροδιαγνωστική**: περιγράφω ακριβώς ποια λειτουργία έχει διαταραχθεί, καταγράφω την έναρξη, την πορεία και το πλαίσιο και εξετάζω ενεργά νευρολογικές, σχετιζόμενες με ουσίες ή φάρμακα, διαταραχές ύπνου και άλλες ψυχιατρικές εξηγήσεις. Φυσιολογικές εξετάσεις από μόνες τους δεν θέτουν διάγνωση διασχιστικής διαταραχής.

Η **αποπροσωποποίηση** είναι αίσθηση αποστασιοποίησης ή μη πραγματικότητας σε σχέση με τον εαυτό, για παράδειγμα αίσθημα αποξένωσης από τις σκέψεις, το σώμα ή τις πράξεις. Η **αποπραγματοποίηση** αφορά την αίσθηση ότι ο εξωτερικός κόσμος ή το περιβάλλον είναι μη πραγματικό ή απομακρυσμένο. Κρίσιμη διαφορά από την ψύχωση είναι ότι **ο έλεγχος της πραγματικότητας γενικά διατηρείται**: ο ασθενής βιώνει την αλλοίωση αλλά συνήθως αναγνωρίζει ότι πρόκειται για υποκειμενική αλλαγή της εμπειρίας.

Η **διασχιστική αμνησία** είναι αδυναμία ανάκλησης σημαντικών αυτοβιογραφικών πληροφοριών που δεν εξηγείται από συνηθισμένη λήθη, αφού εξεταστούν οι σχετικές εναλλακτικές αιτίες. Η **διασχιστική φυγή** δεν αποτελεί ξεχωριστή διαταραχή στο ICD-11 αλλά προσδιοριστή της διασχιστικής αμνησίας.

Η **διαταραχή διασχιστικής ταυτότητας (DID)** εξετάζεται όταν υπάρχει κλινικά σημαντική διακοπή ή ασυνέχεια της ταυτότητας με φαινόμενα μνήμης ή αίσθησης αυτενέργειας. Το τραύμα και η κακοποίηση στην παιδική ηλικία συσχετίζονται ισχυρά με DID στην κλινική βιβλιογραφία, αλλά το τραύμα δεν αποτελεί απαραίτητο διαγνωστικό κριτήριο και η συσχέτιση δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως απλός αποδεδειγμένος αιτιολογικός κανόνας. Η διάγνωση απαιτεί διαχρονικό πρότυπο και λειτουργική επίπτωση, όχι μία μεμονωμένη ασυνήθιστη εμπειρία ούτε αποτέλεσμα υποβολής.

Το ICD-11 περιλαμβάνει επίσης τη **διαταραχή διασχιστικών νευρολογικών συμπτωμάτων** στις διασχιστικές διαταραχές. Στο DSM-5-TR η λειτουργική νευρολογική διαταραχή ταξινομείται στις Διαταραχές Σωματικών Συμπτωμάτων

και Συναφείς Διαταραχές. Η ταξινομική αυτή διαφορά δεν αλλάζει την κλινική αρχή: τα νευρολογικού τύπου συμπτώματα χρειάζονται κατάλληλη νευρολογική εκτίμηση και **θετική διαγνωστική τεκμηρίωση**, όχι διάγνωση αποκλειστικά επειδή οι συνήθεις εξετάσεις είναι φυσιολογικές.

Η εκτίμηση περιλαμβάνει ακριβή φαινομενολογία, έναρξη και πορεία, σχετικό εκλυτικό ή διαιωνιστικό πλαίσιο και λειτουργικές συνέπειες. Οι **ετεροαναφορικές πληροφορίες** είναι συχνά χρήσιμες, ιδιαίτερα όταν τίθεται θέμα συνέχειας της μνήμης ή της ταυτότητας. Διενεργώ εξέταση ψυχικής κατάστασης, ελέγχω ουσίες και φάρμακα και διερευνώ ιστορικό τραύματος όταν είναι κλινικά σχετικό, χωρίς να απαιτώ να έχει εντοπιστεί τραύμα πριν τεθεί διάγνωση.

Η διαφορική περιλαμβάνει **επιληψία ή συγκοπή, ντελίριο, διαταραχές ύπνου, PTSD και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές**, καθώς και επιδράσεις ουσιών ή φαρμάκων. Η νευρολογική εκτίμηση και ο στοχευμένος έλεγχος καθοδηγούνται από την κλινική εικόνα. Ο στόχος είναι να οριστεί θετικά το διασχιστικό φαινόμενο, να διατηρηθεί η διάκριση από την ψύχωση και να μη χρησιμοποιείται η απουσία παθολογικών ευρημάτων ως επαρκής απόδειξη διάσχισης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Αποπροσωποποίηση/αποπραγματοποίηση:** ο έλεγχος της πραγματικότητας γενικά διατηρείται.
- **Διασχιστική φυγή:** προσδιοριστής της διασχιστικής αμνησίας στο ICD-11, όχι ξεχωριστή διαταραχή.
- **DID και τραύμα:** ισχυρή κλινική συσχέτιση, αλλά όχι απαραίτητο διαγνωστικό κριτήριο ούτε απλός αιτιολογικός κανόνας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q34a. Ποια οργανικά νοσήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία όταν το κύριο σύμπτωμα είναι αμνησία ή επεισοδιακά αλλοιωμένη εμπειρία;

Δύο ιδιαίτερα σημαντικές νευρολογικές διαφορικές είναι η **παροδική ολική αμνησία (transient global amnesia, TGA)** και η **επιληψία κροταφικού λοβού**. Η TGA είναι οξύ νευρολογικό αμνησικό σύνδρομο με χαρακτηριστική διάρκεια επεισοδίου **κάτω από 24 ώρες**: αυτό είναι νευρολογικό διαγνωστικό σημείο αναφοράς, όχι κανόνας για τη διασχιστική αμνησία. Η επιληψία κροταφικού λοβού μπορεί να προκαλεί στερεότυπα βιωματικά, συναισθηματικά ή διαταραχές επίγνωσης. Επεισοδιακή αμνησία ή αλλοίωση της εμπειρίας απαιτεί επομένως νευρολογική διαφορική και δεν πρέπει να λαμβάνει διασχιστική ετικέτα επειδή οι συνήθεις εξετάσεις είναι αρνητικές.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Σύγχυση αποπροσωποποίησης με ψύχωση.
- Διάγνωση διάσχισης επειδή MRI ή EEG είναι φυσιολογικά.
- Θεώρηση ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναδειχθεί τραύμα πριν από τη διάγνωση.
- Παρουσίαση της συσχέτισης DID–τραύματος ως αναγκαίου αιτιολογικού κριτηρίου.
- Παράβλεψη TGA ή επιληψίας κροταφικού λοβού σε αμνησική/επεισοδική εικόνα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ταξινόμηση: το ICD-11 περιλαμβάνει τη διαταραχή διασχιστικών νευρολογικών συμπτωμάτων στις διασχιστικές διαταραχές· το DSM-5-TR ταξινομεί τη FND στις Διαταραχές Σωματικών Συμπτωμάτων και Συναφείς Διαταραχές.

Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε τη διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων από τη διαταραχή άγχους ασθένειας;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 SSD: έντονα σωματικά συμπτώματα + υπέρμετρη αντίδραση
- 2 IAD: ενασχόληση με σοβαρή νόσο με απόντα ή ήπια σωματικά συμπτώματα
- 3 Δεν απαιτείται «ιατρικώς ανεξήγητο» σύμπτωμα
- 4 Σωματική νόσος μπορεί να συνυπάρχει
- 5 DSM και ICD δεν αντιστοιχούν 1:1
- 6 Συνέχεια φροντίδας, αναλογικός έλεγχος, συνεργατική διατύπωση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η βασική διάκριση είναι τι κυριαρχεί στην κλινική εικόνα. Στη somatic symptom disorder (SSD) κατά DSM-5-TR, υπάρχει ένα ή περισσότερα σωματικά συμπτώματα που προκαλούν δυσφορία ή διαταράσσουν τη λειτουργικότητα, μαζί με υπερβολικές ή δυσανάλογες σκέψεις, άγχος ή συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτά. Στην illness anxiety disorder (IAD), το κεντρικό πρόβλημα είναι η επίμονη ενασχόληση με το ενδεχόμενο ύπαρξης ή εμφάνισης σοβαρής νόσου, ενώ τα σωματικά συμπτώματα είναι απόντα ή μόνο ήπια.

Κρίσιμο σύγχρονο σημείο είναι ότι η SSD δεν απαιτεί τα συμπτώματα να είναι ιατρικώς ανεξήγητα. Ο ασθενής μπορεί να έχει πραγματική σωματική νόσο. Η διάγνωση αφορά την υπέρμετρη γνωστική, συναισθηματική ή συμπεριφορική αντίδραση στα συμπτώματα και τις επιπτώσεις τους. Επομένως, αρνητικές εξετάσεις από μόνες τους δεν θέτουν τη διάγνωση και η διάγνωση SSD δεν καταργεί την υποχρέωση να διερευνώνται κατάλληλα νέα ή μεταβαλλόμενα ιατρικά σημεία συναγερμού.

Στην IAD, το άγχος υγείας και η ενασχόληση με νόσο είναι κεντρικά. Ο ασθενής μπορεί να ελέγχει επανειλημμένα το σώμα του, να αναζητά διαβεβαίωση ή επανειλημμένη ιατρική εκτίμηση, ή αντίθετα να αποφεύγει ιατρικά πλαίσια λόγω φόβου. Το φορτίο των ίδιων των σωματικών συμπτωμάτων είναι μικρό. Όταν το κέντρο της εικόνας είναι σημαντικά και δυσφορικά σωματικά συμπτώματα, η SSD είναι συνήθως καταλληλότερη DSM διατύπωση από την IAD.

Η ταξινόμηση του ICD-11 δεν αποτελεί άμεση μετάφραση των κατηγοριών του DSM. Η bodily distress disorder συνδυάζει ενοχλητικά σωματικά συμπτώματα με υπερβολική προσοχή ή ενασχόληση και σχετική λειτουργική επίπτωση, χωρίς να απαιτεί απουσία ιατρικής εξήγησης. Η υποχονδρίαση/health anxiety στο ICD-11 τοποθετείται κυρίως στις ιδεοψυχαναγκαστικές και συναφείς διαταραχές και διασταυρώνεται με τις διαταραχές άγχους ή φόβου, αντί να εντάσσεται απλώς στην ίδια ομάδα με bodily distress disorder.

Η διαχείριση πρέπει να αποφεύγει τόσο την απόρριψη όσο και τον φαύλο κύκλο ατέρμονης καθυστάσεως. Αναγνωρίζω ως πραγματικά τα συμπτώματα και την οδύνη χωρίς να ενισχύω καταστροφολογικές ερμηνείες, εξασφαλίζω συνέχεια με

σταθερό κλινικό ή ομάδα και προγραμματίζω παρακολούθηση αντί να εξαρτάται η φροντίδα αποκλειστικά από κρίσεις. Ο ιατρικός έλεγχος πρέπει να είναι αναλογικός με την κλινική εικόνα και να μην επαναλαμβάνεται μηχανικά μόνο για προσωρινή μείωση του άγχους.

Η συνεργατική βιοψυχοκοινωνική διατύπωση καλύπτει τα σωματικά συμπτώματα, τις πεποιθήσεις για νόσο, την κατανομή της προσοχής, το άγχος, τις συμπεριφορές, τις σωματικές και ψυχιατρικές συννοσηρότητες και τη λειτουργική επίπτωση. Πραγματικές σωματικές παθήσεις αντιμετωπίζονται κανονικά και νέα red flags οδηγούν σε επανεκτίμηση.

Άρα, στην SSD κυριαρχούν τα σωματικά συμπτώματα και η υπέρμετρη αντίδραση σε αυτά· στην IAD κυριαρχεί η ενασχόληση με σοβαρή νόσο με μικρό σωματικό φορτίο. Σε κανένα από τα σύγχρονα πλαίσια δεν χρειάζεται να αποδειχθεί ότι τα συμπτώματα είναι «ιατρικώς ανεξήγητα».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **SSD vs IAD:** SSD = προεξάρχοντα δυσφορικά σωματικά συμπτώματα + υπέρμετρη αντίδραση· IAD = ενασχόληση με νόσο με απόντα/ήπια σωματικά συμπτώματα.
- Το «ιατρικώς ανεξήγητο» δεν απαιτείται ούτε για DSM SSD ούτε για ICD-11 bodily distress disorder.
- **DSM-5-TR:** η υπέρμετρη κατάσταση που σχετίζεται με τα συμπτώματα ή η ενασχόληση με νόσο είναι επίμονη, με σημείο αναφοράς 6 μηνών· δεν εξάγουμε αυτό το χρονικό όριο στο ICD-11.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

HISTORICAL_EXAM_FACT: παλαιότερη DSM-IV/ICD-10 διδασκαλία χρησιμοποιούσε κατηγορίες όπως somatization disorder, hypochondriasis και pain disorder. Είναι χρήσιμες για αναγνώριση παλαιότερης ορολογίας, όχι ως τρέχουσα DSM-5-TR/ICD-11 αρχιτεκτονική.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση SSD επειδή οι εξετάσεις είναι αρνητικές.
- Παράβλεψη πραγματικής σωματικής νόσου μετά τη διάγνωση SSD.
- Επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις και εξετάσεις χωρίς οργανωμένη διαχρονική φροντίδα.
- Παρουσίαση των παλαιών κατηγοριών somatization/hypochondriasis ως άμεσων σημερινών ισοδυνάμων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ταξινομική διάκριση: DSM somatic symptom disorder/illness anxiety disorder και ICD-11 bodily distress disorder/hypochondriasis έχουν εννοιολογική επικάλυψη αλλά δεν είναι άμεσες αντιστοιχίες.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη λειτουργική νευρολογική διαταραχή;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αναγνώριση του λειτουργικού νευρολογικού φαινοτύπου
- 2 Θετική διάγνωση με λειτουργικά σημεία
- 3 Νευρολογική διαφορική και πιθανή συννοσηρότητα
- 4 Δεν απαιτούνται τραύμα ή ψυχολογικός στρεσογόνος παράγοντας
- 5 Σαφής, μη δυϊστική εξήγηση
- 6 Αποκατάσταση προσαρμοσμένη στον φαινότυπο
- 7 Κοινή θεραπευτική ευθύνη νευρολογίας και ψυχιατρικής/ψυχολογίας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η λειτουργική νευρολογική διαταραχή (FND) είναι **διάγνωση που τεκμηριώνεται θετικά από χαρακτηριστικά λειτουργικά σημεία**, όχι συμπέρασμα επειδή «οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές». Προσδιορίζω πρώτα τον νευρολογικό φαινότυπο, αναζητώ θετικά στοιχεία εσωτερικής ασυνέπειας ή ασυμβατότητας με αναγνωρισμένη νευρολογική νόσο, εξετάζω την κατάλληλη νευρολογική διαφορική και τις συννοσηρότητες και στη συνέχεια εξηγώ τη διάγνωση με τρόπο που αναγνωρίζει τα συμπτώματα ως πραγματικά και οδηγεί άμεσα στη θεραπεία. Ψυχολογικό τραύμα ή αναγνωρίσιμο στρες **δεν απαιτούνται** για τη διάγνωση.

Η FND μπορεί να εκδηλωθεί ως λειτουργική αδυναμία ή διαταραχή βάδισης, λειτουργική κινητική διαταραχή, αισθητικά συμπτώματα, διαταραχές ομιλίας/επικοινωνίας ή λειτουργικές κρίσεις. Επομένως η εξέταση είναι ειδική για τον φαινότυπο και δεν βασίζεται σε ένα γενικό σημείο.

Στη λειτουργική αδυναμία, θετικά παραδείγματα είναι το **σημείο Hoover** ή η ασυνέπεια στους απαγωγείς του ισχίου. Στον λειτουργικό τρόπο, η **απόσπαση της προσοχής, η συμπαράσυρση (entrainment) και η μεταβλητότητα** μπορούν να υποστηρίξουν τη διάγνωση. Κανένα μεμονωμένο σημείο δεν χρησιμοποιείται μηχανικά ούτε αποτελεί από μόνο του καθολική απόδειξη.

Οι **λειτουργικές κρίσεις** χρειάζονται θετική σημειολογική εκτίμηση. Όταν παραμένει αβεβαιότητα, η πιο χρήσιμη επιβεβαιωτική προσέγγιση είναι συχνά η καταγραφή σε video-EEG ενός τυπικού επεισοδίου χωρίς ικτικό επιληπτόμορφο **συσχετισμό**, ερμηνευμένου μέσα στη συνολική κλινική εικόνα. Φυσιολογικό μεσοκριτικό EEG ή φυσιολογικό EEG μετά από επεισόδιο **δεν διαγιγνώσκει** λειτουργικές κρίσεις. Η συνύπαρξη επιληψίας πρέπει να παραμένει στη διαφορική.

Σύγχρονη βασική αρχή είναι ότι **ούτε τραύμα ούτε συγκεκριμένος ψυχολογικός στρεσογόνος παράγοντας είναι προϋπόθεση**. Μπορούν να συμβάλλουν σε ορισμένους ασθενείς και να έχουν θέση στη διατύπωση ή τη θεραπεία, αλλά δεν πρέπει να επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση. Αντίστοιχα, φυσιολογική απεικόνιση ή άλλες φυσιολογικές εξετάσεις δεν αποτελούν από μόνες τους θετική ένδειξη FND.

Η θεραπεία αρχίζει με **σαφή θετική εξήγηση της διάγνωσης**. Εξηγώ ότι τα

συμπτώματα είναι πραγματικά και ακούσια, ότι η διάγνωση στηρίζεται σε αναγνωρίσιμα λειτουργικά σημεία και ότι μπορεί να υπάρχει διαταραχή στη λειτουργία ή στον έλεγχο του νευρικού συστήματος παρά τη διατήρηση ικανότητας για φυσιολογική κίνηση ή λειτουργία. Όπου είναι χρήσιμο, η επίδειξη ενός θετικού σημείου μπορεί να δείξει ότι η λειτουργία είναι δυνητικά αναστρέψιμη και ότι δεν πρόκειται κατ' ανάγκην για μόνιμη δομική βλάβη.

Η αντιμετώπιση προσαρμόζεται στον φαινότυπο. Τα κινητικά συμπτώματα συχνά ωφελούνται από **φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση ειδικά προσαρμοσμένη στην FND**, με επανεκπαίδευση της αυτόματης κίνησης, μετατόπιση της υπερβολικής αυτοεστιασμένης προσοχής, ανάδειξη διατηρημένης φυσιολογικής κίνησης και μείωση δυσπροσαρμοστικών προτύπων αποφυγής ή κίνησης. Εργοθεραπεία ή λογοθεραπεία μπορεί να χρειαστούν ανάλογα με τον φαινότυπο. Ψυχολογική θεραπεία προστίθεται όταν ενδείκνυται για τα λειτουργικά συμπτώματα ή για συννοσηρή ψυχιατρική διαταραχή· δεν είναι προϋπόθεση για να θεωρηθεί η διάγνωση έγκυρη.

Η καλή φροντίδα είναι πολυεπιστημονική. **Νευρολογία και ψυχιατρική/ψυχολογία μοιράζονται την ευθύνη της θεραπείας** αντί να μετακυλίνουν τον ασθενή από ειδικότητα σε ειδικότητα. Ο στόχος είναι συνεκτική βιοψυχοκοινωνική, μη δυϊστική διατύπωση που ενώνει τη θετική διάγνωση, την αποκατάσταση και την αντιμετώπιση σχετικών συννοσηροτήτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η FND είναι **ακούσια** και διαγιγνώσκεται με **θετικά κλινικά χαρακτηριστικά**.
- **Λειτουργική αδυναμία**: σημείο Hoover και ασυνέπεια στους απαγωγείς του ισχίου είναι χρήσιμα θετικά παραδείγματα όταν εκλύονται σωστά.
- **Λειτουργικός τρόμος**: απόσπαση προσοχής, entrainment και μεταβλητότητα είναι χρήσιμα θετικά στοιχεία.
- **Λειτουργικές κρίσεις**: φυσιολογικό μεσοκριτικό ή μετακριτικό EEG δεν είναι διαγνωστικό. Όταν χρειάζεται επιβεβαίωση, βασική εξέταση είναι η καταγραφή τυπικού επεισοδίου σε **video-EEG χωρίς ικτικό επιληπτόμορφο συσχετισμό**.
- Ψυχολογικό στρες ή τραύμα δεν απαιτούνται για τη διάγνωση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς εξηγείτε τη διάγνωση στον ασθενή;

Ονομάζω τη διάγνωση άμεσα και εξηγώ ότι τα συμπτώματα είναι **πραγματικά, ακούσια και δυνητικά σοβαρά**. Δείχνω, όπου είναι δυνατόν, τα θετικά λειτουργικά σημεία που οδήγησαν στη διάγνωση αντί να λέω «δεν βρέθηκε τίποτα» ή να βασίζομαι σε φυσιολογικές απεικονίσεις.

Μια χρήσιμη εξήγηση είναι ότι **έχει διαταραχθεί η λειτουργία ή ο έλεγχος του νευρικού συστήματος**, ενώ μέρος της φυσιολογικής ικανότητας παραμένει. Αποφεύγω να υπονοήσω ότι τα συμπτώματα είναι «μόνο ψυχολογικά», αποτέλεσμα τραύματος, φανταστικά ή εκούσια, εκτός αν συγκεκριμένος ψυχολογικός παράγοντας τεκμηριώνεται στη συγκεκριμένη διατύπωση. Η εξήγηση πρέπει να συνδέεται αμέσως με θεραπεία και αποκατάσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς διακρίνετε factitious disorder, malingering και FND;

Στην FND, τα συμπτώματα δεν παράγονται σκόπιμα. Τα θετικά λειτουργικά σημεία δείχνουν διαταραγμένη λειτουργία, όχι εξαπάτηση.

Στη **factitious disorder**, υπάρχει σκόπιμη παραποίηση ή πρόκληση συμπτωμάτων με εξαπάτηση και παρουσίαση του εαυτού ή άλλου ως ασθενούς, χωρίς εμφανές εξωτερικό όφελος. Δεν χρειάζεται να αποδειχθεί συγκεκριμένο ψυχοδυναμικό κίνητρο.

Στο **malingering**, τα συμπτώματα παράγονται ή υπερβάλλονται σκόπιμα για αναγνώριση εξωτερικό κίνητρο, και το malingering δεν αποτελεί ψυχιατρική διαταραχή.

Κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας: η **πρόθεση και το κίνητρο δεν μπορούν να συναχθούν αξιόπιστα μόνο από ασυνέπεια, ασυνήθιστα συμπτώματα, δευτερογενές όφελος ή κλινική υποψία**. Η σκόπιμη εξαπάτηση χρειάζεται τεκμηρίωση· FND δεν ισοδυναμεί με factitious disorder ή malingering.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι λένε τα σύγχρονα νευροβιολογικά μοντέλα για την FND;

Τα μοντέλα predictive processing, agency και limbic-motor networks αποτελούν ενεργά ερευνητικά πλαίσια. Μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του πώς η προσοχή, οι προσδοκίες και οι μαθημένες κινητικές προβλέψεις επηρεάζουν την αίσθηση ελέγχου, αλλά δεν είναι καθιερωμένοι μονοαιτιολογικοί μηχανισμοί ούτε διαγνωστικοί βιοδείκτες.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- «Όλες οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές, άρα FND.»
- Διάγνωση λειτουργικών κρίσεων μόνο από φυσιολογικό EEG.
- Ταύτιση FND με malingering.
- Επιβολή τραύματος ή στρες σε κάθε περίπτωση.
- Παρουσίαση αναδυόμενου δικτυακού μοντέλου ως καθιερωμένη αιτιολογία.
- Μετακύλιση του ασθενούς μεταξύ νευρολογίας και ψυχιατρικής χωρίς κοινή θεραπευτική ευθύνη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ταξινόμηση: το ICD-11 τοποθετεί την αντίστοιχη κατάσταση στις διασχιστικές νευρολογικές διαταραχές, ενώ το DSM-5-TR τοποθετεί την FND στις Διαταραχές Σωματικών Συμπτωμάτων και Συναφείς Διαταραχές. Η κλινική διάγνωση παραμένει θετική και δεν βασίζεται στη θέση της ταξινόμησης ή σε αρνητικές εξετάσεις.

Πώς αξιολογείτε και πώς διατυπώνετε μια διαταραχή χρήσης ουσιών;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Καταγραφή όλων των ουσιών και του προτύπου χρήσης
- 2 Τοξίκωση, στέρηση και χαρακτηριστικά εξάρτησης
- 3 Ψυχιατρικές, σωματικές και κοινωνικές συνέπειες
- 4 Άμεσος και μακροπρόθεσμος κίνδυνος
- 5 Προηγούμενη θεραπεία, κίνητρο και στόχοι
- 6 Συννοσηρότητα, διαιωνιστικοί παράγοντες και μείωση βλάβης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εκτίμηση μιας διαταραχής χρήσης ουσιών πρέπει να αποσαφηνίσει τι χρησιμοποιείται, με ποιο πρότυπο, ποιο σύνδρομο και ποιες συνέπειες και κινδύνους προκαλεί, καθώς και τι συντηρεί τη χρήση, και να μετατρέψει αυτά τα δεδομένα σε θεραπευτική διατύπωση. Δεν εστιάζω μόνο στην ποσότητα· εξετάζω τοξίκωση, στέρηση, απώλεια ελέγχου, συννοσηρότητα, λειτουργικές συνέπειες, άμεση ασφάλεια και τους στόχους του ίδιου του ασθενούς.

Ξεκινώ χαρτογραφώντας όλες τις ουσίες: αλκοόλ, παράνομες ουσίες, συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τυχόν χρήση πολλαπλών ουσιών. Για καθεμία καταγράφω ποσότητα και συχνότητα, οδό χορήγησης, διάρκεια, πρόσφατες μεταβολές, πλαίσιο χρήσης και συνδυασμούς. Το χρονικό πρότυπο έχει σημασία, επειδή επεισοδιακή βαριά χρήση (binge), συνεχής χρήση και χρήση συνδεδεμένη με συγκεκριμένες καταστάσεις μπορεί να έχουν διαφορετικούς κινδύνους.

Στη συνέχεια καθορίζω το σύνδρομο που σχετίζεται με την ουσία: επεισόδια τοξίκωσης και στέρησης, craving, μειωμένο έλεγχο, αυξανόμενη προτεραιότητα της χρήσης, ανοχή ή στέρηση όπου υπάρχουν και συνέχιση παρά τη βλάβη. Η σύγχρονη ταξινόμηση είναι ευρύτερη από την παλαιά σύντομη διάκριση «επιβλαβής χρήση ή εξάρτηση» και περιλαμβάνει επίσης επιβλαβή επεισόδια ή πρότυπα, καταστάσεις στέρησης και ψυχιατρικά σύνδρομα επαγόμενα από ουσίες όπου είναι σχετικά.

Έπειτα αποσαφηνίζω τις συνέπειες. Οι ψυχιατρικές μπορεί να είναι επιδείνωση διάθεσης, άγχους, ψύχωσης ή άλλων συμπτωμάτων, ενώ οι σωματικές εξαρτώνται από την ουσία και την οδό χρήσης. Πρωτί για επαγγελματική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, οικονομικές ή νομικές συνέπειες, παραμέληση υποχρεώσεων, στέγαση και κοινωνική σταθερότητα.

Η εκτίμηση κινδύνου είναι ενσωματωμένη στην αξιολόγηση. Πρωτί ειδικά για υπερδοσολογία, σπασμούς κατά τη στέρηση, αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονικότητα, βία, παραμέληση ή ζητήματα προστασίας ευάλωτων προσώπων, καθώς και κινδύνους στην οδήγηση ή στην εργασία. Αν το ιστορικό είναι αβέβαιο ή ο κίνδυνος δεν αποσαφηνίζεται, οι ετεροαναφορικές πληροφορίες μπορεί να είναι κρίσιμες. Η σωματική εξέταση και ο εργαστηριακός

έλεγχος στοχεύουν στις ουσίες, τις πιθανές επιπλοκές και τη σχεδιαζόμενη θεραπεία, όχι σε ένα ίδιο μη επιλεκτικό πακέτο για όλους.

Ανασκοπώ επίσης προηγούμενες θεραπευτικές προσπάθειες και περιόδους αποχής ή μειωμένης χρήσης: τι βοήθησε, τι προηγήθηκε της υποτροπής και αν υπήρξε στο παρελθόν σοβαρή στέρηση ή άλλη επιπλοκή. Το κίνητρο δεν αντιμετωπίζεται ως σταθερό γνώρισμα. Διευκρινίζω τον τρέχοντα στόχο και την ετοιμότητα για αλλαγή: αποχή, μείωση, ασφαλέστερη χρήση ή απλώς διατήρηση επαφής με θεραπεία μπορεί να είναι διαφορετικές άμεσες προτεραιότητες.

Τέλος, συνθέτω το σύνδρομο χρήσης με την ψυχιατρική και ιατρική συννοσηρότητα, το κοινωνικό πλαίσιο, τους εκλυτικούς και ενισχυτικούς παράγοντες, όσα έχουν βοηθήσει στο παρελθόν και τους τρέχοντες κινδύνους. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τόσο **θεραπεία όσο και μείωση βλάβης**, με ρεαλιστικούς στόχους και παρακολούθηση, αντί να υποθέτουμε ότι η διαγνωστική ετικέτα υπαγορεύει από μόνη της το επόμενο βήμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR SUD: 2–3 κριτήρια = ήπια, 4–5 = μέτρια, ≥6 = σοβαρή**, από 11 κριτήρια. Αυτό είναι DSM-specific σύστημα βαρύτητας, όχι αρχιτεκτονική ICD-11.
- Η εξάρτηση αναγνωρίζεται κλινικά από μειωμένο έλεγχο, craving, προτεραιοποίηση της χρήσης, ανοχή ή στέρηση και συνέχιση παρά τη βλάβη.
- Το ICD-11 έχει ευρύτερη substance-specific ταξινόμηση από το παλαιό δίπολο ICD-10 επιβλαβούς χρήσης/εξάρτησης.
- Η τοξικολογική εξέταση ούρων είναι **βοηθητικό στοιχείο έκθεσης**, όχι διάγνωση ούτε ακριβές εργαλείο χρονολόγησης. Δεν απομνημονεύουμε ένα καθολικό «παράθυρο ανίχνευσης» για όλες τις ουσίες και μεθόδους.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q37a. Πώς προσεγγίζετε τη διακοπή καπνίσματος στη σχιζοφρένεια, ιδίως ως προς τις αλληλεπιδράσεις με ψυχοτρόπα;

Η διακοπή καπνίσματος πρέπει να **προσφέρεται ενεργά**, αλλά χρειάζεται πρόβλεψη των φαρμακοκινητικών αλλαγών. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι **πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες του καπνού — όχι η νικοτίνη — επάγουν το CYP1A2**.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την **κλοζαπίνη** και επηρεάζει επίσης την ολανζαπίνη. Απότομη μείωση ή διακοπή καπνίσματος αίρει την επαγωγή του CYP1A2 και μπορεί να αυξήσει την έκθεση στο φάρμακο μέσα σε ημέρες. Άρα μια νοσηλεία σε άκαπνο περιβάλλον μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κλοζαπίνης ακόμη και αν χορηγείται υποκατάσταση νικοτίνης.

Η **υποκατάσταση νικοτίνης και το άτμισμα νικοτίνης δεν διατηρούν την επαγωγή CYP1A2 από τον καπνό**. Χρειάζεται επομένως επανεκτίμηση της αγωγής, παρακολούθηση για τοξικότητα και TDM όπου ενδείκνυται, όχι μηχανική καθολική ποσοστιαία μείωση δόσης. Αν ο ασθενής ξαναρχίσει να καπνίζει, η έκθεση σε κλοζαπίνη ή ολανζαπίνη μπορεί να μειωθεί και να χαθεί αποτελεσματικότητα, άρα η δόση χρειάζεται επανεκτίμηση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Για διακοπή καπνίσματος, **βαρενικλίνη και υποκατάσταση νικοτίνης** είναι **θεμιτές επιλογές** στη σχιζοφρένεια· η βουπροπιόνη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μετά από εξατομικευμένο έλεγχο αντενδείξεων. Η παλαιότερη γενικευμένη ανησυχία ότι η βαρενικλίνη αντενδείκνυται ψυχιατρικά δεν πρέπει να αναπαράγεται ως καθολικός κανόνας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Εστίαση μόνο στην ποσότητα χωρίς συνέπειες, κίνδυνο και συννοσηρότητα.
- Παράβλεψη συνταγογραφούμενων κατασταλτικών, οπιοειδών ή χρήσης πολλών ουσιών.
- Αντιμετώπιση του κινήτρου ως σταθερού χαρακτηριστικού.
- Θεώρηση τοξικολογικού αποτελέσματος ή detection window ως απόδειξης διάγνωσης ή ακριβούς χρόνου χρήσης.
- Ισχυρισμός ότι η νικοτίνη επάγει το CYP1A2.
- Υπόθεση ότι η υποκατάσταση νικοτίνης προλαμβάνει την αλληλεπίδραση με κλοζαπίνη.
- Απομνημόνευση μιας καθολικής ποσοστιαίας μείωσης δόσης κλοζαπίνης μετά τη διακοπή καπνίσματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ταξινόμηση ουσιών: η παλαιότερη εξεταστική συντόμευση βασιζόταν στην επιβλαβή χρήση και το σύνδρομο εξάρτησης του ICD-10. Το ICD-11 χρησιμοποιεί ευρύτερη ουσιο-ειδική αρχιτεκτονική με επιβλαβή επεισόδια/πρότυπα, τοξίκωση, στέρηση και επαγόμενες διαταραχές.

Διακοπή καπνίσματος στη σχιζοφρένεια: η βαρενικλίνη δεν απορρίπτεται λόγω παλαιάς καθολικής προειδοποίησης. Το κύριο πρακτικό ζήτημα ασφάλειας είναι η μεταβολή του CYP1A2 από τον καπνό, ιδίως με κλοζαπίνη.

Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη στέρηση αλκοόλ;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αναγνώριση του συνδρόμου στέρησης
- 2 Παράγοντες κινδύνου σοβαρής στέρησης
- 3 Ασφαλής επιλογή θεραπευτικού πλαισίου
- 4 Κατάλληλο σχήμα βενζοδιαζεπινών
- 5 Θειαμίνη και ιατρική υποστήριξη
- 6 Παρακολούθηση για σπασμούς, ντελίριο και αυτόνομη αστάθεια

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η στέρηση αλκοόλ κυμαίνεται από ανεπίπλεκτο σύνδρομο άγχους και αυτόνομης υπερδραστηριότητας έως **σπασμούς και delirium tremens**, επομένως η αντιμετώπιση αρχίζει με εκτίμηση της βαρύτητας και επιλογή ασφαλούς θεραπευτικού πλαισίου. Αξιολογώ τα τρέχοντα συμπτώματα, το ιστορικό προηγούμενης σοβαρής στέρησης, τη συννοσηρότητα και την κοινωνική υποστήριξη και χρησιμοποιώ σχήμα βενζοδιαζεπινών μαζί με θειαμίνη και ιατρική παρακολούθηση, με άμεση κλιμάκωση αν εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές.

Η ανεπίπλεκτη στέρηση περιλαμβάνει συνήθως **τρόμο, εφίδρωση και άλλη αυτόνομη υπερδραστηριότητα, άγχος, αϋπνία, ναυτία και αντιληπτικές διαταραχές**. Οι δύο σημαντικότερες επιπλοκές είναι οι **σπασμοί στέρησης** και το **delirium tremens**. Ντελίριο, έντονη αυτόνομη αστάθεια, σπασμοί ή αδυναμία αξιόπιστης κλινικής εκτίμησης απομακρύνουν αμέσως τον ασθενή από ένα απλό χαμηλού κινδύνου εξωνοσοκομειακό σχήμα.

Η χρονική εξέλιξη είναι χρήσιμη ως αδρός κλασικός προσανατολισμός, όχι ως διαγνωστικό χρονόμετρο. Αυτόνομα συμπτώματα εμφανίζονται συχνά στις πρώτες **6–12 ώρες**, αντιληπτικά συμπτώματα περίπου στις **12–24 ώρες**, σπασμοί συχνά στις **24–48 ώρες** και **delirium tremens** συνήθως αργότερα, συχνά περίπου στις **48–72 ώρες**. Τα χρονικά αυτά παράθυρα αλληλεπικαλύπτονται και διαφέρουν σημαντικά μεταξύ ασθενών, οπότε η βαρύτητα, το ιστορικό και η τρέχουσα φυσιολογία έχουν μεγαλύτερη αξία από την ακριβή ώρα.

Το ιστορικό προηγούμενης στέρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Προηγούμενο **delirium tremens ή σπασμοί στέρησης**, σημαντική σωματική ή ψυχιατρική συννοσηρότητα, γηριατρική ή άλλη ευπάθεια, φτωχό υποστηρικτικό περιβάλλον και ταυτόχρονη στέρηση από κατασταλτικά φάρμακα μειώνουν το όριο για νοσοκομειακή ή άλλη εποπτευόμενη αντιμετώπιση. Το πλαίσιο καθορίζεται από τον κίνδυνο, όχι μόνο από την αναφερόμενη ποσότητα κατανάλωσης.

Τα **σχήματα βενζοδιαζεπινών με σταδιακή μείωση είναι καθιερωμένη θεραπεία**. Οι μακράς δράσης βενζοδιαζεπίνες είναι συχνά χρήσιμες επειδή παρέχουν ομαλότερη κάλυψη, ενώ **λοραζεπάμη ή οξαζεπάμη συχνά προτιμώνται όταν ο ηπατικός οξειδωτικός μεταβολισμός είναι διαταραγμένος**. Πρόκειται για κλινική προτίμηση, όχι απόλυτο κανόνα. Σταθερά δοσολογικά σχήματα μπορούν να

χρησιμοποιηθούν στην κοινότητα, ενώ η symptom-triggered χορήγηση προϋποθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και συχνή, αξιόπιστη εκτίμηση και ταιριάζει κυρίως σε νοσοκομειακά ή εποπτευόμενα πλαίσια.

Η CIWA-Ar μπορεί να βοηθήσει στη δομημένη παρακολούθηση, αλλά είναι βοήθημα της κλινικής κρίσης και όχι διαγνωστικό τεστ ή αυτόνομος αλγόριθμος φαρμακοθεραπείας. Τα cut-offs δεν εφαρμόζονται μηχανικά, ιδίως σε ντελίριο, ιατρική αστάθεια ή όταν ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει αξιόπιστα.

Η ιατρική φροντίδα προχωρά παράλληλα. Χορηγώ **θειαμίνη**, αξιολογώ ενυδάτωση και θρέψη, ελέγχω για σωματικές επιπλοκές και αναζητώ σημεία εγκεφαλοπάθειας Wernicke. Σπασμοί, ντελίριο, σοβαρή αυτόνομη αστάθεια ή υποψία Wernicke απαιτούν επείγουσα κλιμάκωση και νοσοκομειακή αντιμετώπιση, όχι απλώς αύξηση ενός εξωνοσοκομειακού σχήματος.

Η πρακτική ακολουθία είναι: αναγνωρίζω το σύνδρομο, εντοπίζω ποιος κινδυνεύει από βαριά στέρηση, επιλέγω το σωστό πλαίσιο, χρησιμοποιώ εποπτευόμενο σχήμα βενζοδιαζεπινών, χορηγώ θειαμίνη και υποστηρικτική φροντίδα και κλιμακώνω νωρίς όταν εμφανίζονται επιπλοκές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Κλασική χρονική εικόνα μόνο **κατά προσέγγιση**: αυτόνομα συμπτώματα ~6–12 h, αντιληπτικά ~12–24 h, σπασμοί ~24–48 h, delirium tremens συχνά ~48–72 h.
- **Μακράς δράσης βενζοδιαζεπίνες** συχνά χρήσιμες· **λοραζεπάμη/οξαζεπάμη** συχνά προτιμώνται όταν υπάρχει διαταραχή ηπατικού οξειδωτικού μεταβολισμού, χωρίς αυτό να είναι απόλυτος κανόνας.
- **CIWA-Ar = βοήθημα**, όχι διαγνωστικό τεστ ούτε ασφαλής μοναδικός οδηγός σε επιπλεγμένη στέρηση.
- Η symptom-triggered θεραπεία **δεν είναι αυτόματα ανώτερη** σε κάθε πλαίσιο· απαιτεί αξιόπιστη εκτίμηση και κατάλληλη στελέχωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q38a. Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε την εγκεφαλοπάθεια Wernicke;

Η εγκεφαλοπάθεια Wernicke είναι **ιατρικό επείγον**. Τη σκέφτομαι νωρίς σε άτομο με κατάχρηση αλκοόλ ή υποθρεψία που εμφανίζει σύγχυση ή άλλη μεταβολή της νοητικής κατάστασης, οφθαλμοκινητικές διαταραχές, αταξία ή διαταραχή βάδισης ή άλλη συμβατή εικόνα. Η πλήρης κλασική τριάδα συχνά απουσιάζει, επομένως δεν περιμένω να συνυπάρξουν και τα τρία στοιχεία.

Η θεραπεία αρχίζει αμέσως, χωρίς αναμονή για απεικόνιση ή διαγνωστική επιβεβαίωση. Το εξεταστικό σχήμα είναι **θειαμίνη IV 300–500 mg τρεις φορές ημερησίως για 3–5 ημέρες**. Αν ο ασθενής παραμένει συμπτωματικός, συνεχίζεται **300–500 mg IV ημερησίως για ακόμη 3–5 ημέρες ή όσο συνεχίζεται η κλινική βελτίωση**, και στη συνέχεια χορηγείται από του στόματος θειαμίνη.

Η θειαμίνη δίνεται **πριν ή μαζί με υδατάνθρακες** όπου είναι εφικτό, αλλά σε υπογλυκαιμία η επείγουσα γλυκόζη δεν καθυστερεί. Ελέγχω και διορθώνω επίσης **υπομαγνησισαιμία**, ιδιαίτερα όταν η ανταπόκριση στη θειαμίνη είναι ανεπαρκής. Η μη θεραπευμένη Wernicke μπορεί να εξελιχθεί σε **σύνδρομο Korsakoff**, γι' αυτό η

θεραπεία είναι εμπειρική και επείγουσα όταν η υποψία είναι ουσιαστική.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χαμηλού κινδύνου εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση σε ιστορικό delirium tremens ή σπασμών στέρησης.
- Αντιμετώπιση των κλασικών χρονικών παραθύρων ως άκαμπτων κριτηρίων.
- Τυφλή εφαρμογή CIWA-Ar σε ντελίριο ή αναξιόπιστη επικοινωνία.
- Παρουσίαση λοραζεπάμης/οξαζεπάμης ως καθολικά υποχρεωτικών σε ηπατική νόσο.
- Απαίτηση της πλήρους τριάδας Wernicke πριν από θεραπεία.
- Χρήση μόνο από του στόματος θειαμίνης σε ύποπτη Wernicke.
- Καθυστέρηση γλυκόζης σε υπογλυκαιμία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Χρονισμός στέρησης: τα κλασικά χρονικά παράθυρα είναι χρήσιμα για προσανατολισμό, αλλά η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως στη βαρύτητα και στο ιστορικό.

Wernicke: η παλαιότερη διδασκαλία υπερτόνιζε την πλήρη τριάδα. Η σύγχρονη επείγουσα πρακτική απαιτεί χαμηλό κατώφλι υποψίας και άμεση παρεντερική θειαμίνη.

Πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης αλκοόλ μετά τη στέρηση;

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Καθορισμός θεραπευτικού στόχου
- 2 Δομημένη ψυχοκοινωνική πρόληψη υποτροπής
- 3 Ακαμπροσάτη ή ναλτρεξόνη όταν είναι κατάλληλες
- 4 Δισουλφιράμη και ναλμεφαίνη σε επιλεγμένες περιπτώσεις
- 5 Παρακολούθηση ανάρρωσης, συμμόρφωσης και σωματικής υγείας
- 6 Αρκετά μακρά θεραπεία για σταθεροποίηση της αλλαγής

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αποτοξίνωση είναι μόνο η αρχή της θεραπείας της διαταραχής χρήσης αλκοόλ. Μετά τη στέρηση συμφωνώ με τον ασθενή έναν σαφή στόχο — συνήθως αποχή ή μείωση — και συνδυάζω δομημένη ψυχοκοινωνική πρόληψη υποτροπής με φαρμακοθεραπεία όταν είναι κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη τη σωματική υγεία, τη χρήση οπιοειδών, τη δυνατότητα σταθερής λήψης της αγωγής και την προηγούμενη ανταπόκριση.

Το ψυχοκοινωνικό σχέδιο πρέπει να είναι συγκεκριμένο και όχι απλώς η συμβουλή «να μην πίνει». Χρήσιμες προσεγγίσεις είναι η **κινητοποιητική εργασία, η CBT και άλλες συμπεριφορικές στρατηγικές**, με συμμετοχή οικογένειας ή κοινωνικού δικτύου όταν ταιριάζει. Ομάδες αλληλοβοήθειας μπορεί επίσης να βοηθήσουν ορισμένους ασθενείς. Ο στόχος είναι να αναγνωριστούν οι εκλυτικοί παράγοντες, να ενισχυθούν στρατηγικές αντιμετώπισης, να σχεδιαστούν οι καταστάσεις υψηλού κινδύνου και να βελτιωθούν οι κοινωνικές συνθήκες που στηρίζουν την ανάρρωση.

Η φαρμακοθεραπεία εξαρτάται από τον στόχο και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ασθενούς. **Η ακαμπροσάτη και η από του στόματος ναλτρεξόνη είναι τα κύρια φάρμακα πρόληψης υποτροπής μετά τη στέρηση.** Η ακαμπροσάτη τροποποιεί γλουταματεργική και GABAεργική σηματοδότηση, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ένας μοναδικός μηχανισμός. Η ναλτρεξόνη είναι ανταγωνιστής οπιοειδών υποδοχέων, κλινικά κυρίως του μ-υποδοχέα, και μειώνει την οπιοειδο-μεσολαβούμενη σηματοδότηση ανταμοιβής. Η επιλογή λαμβάνει υπόψη ηπατική και νεφρική λειτουργία, τρέχουσα ή προβλέψιμη χρήση οπιοειδών, πιθανότητα συνεπούς λήψης, προηγούμενο όφελος και προτίμηση.

Η ναλτρεξόνη **δεν πρέπει να αρχίζει σε τρέχουσα χρήση ή εξάρτηση από οπιοειδή**, επειδή ο ανταγωνισμός των οπιοειδών μπορεί να προκαλέσει **αιφνίδια οξεία στέρηση** και παράλληλα αποκλείει την οπιοειδή αναλγησία. Οι ηπατικές αντενδείξεις και η παρακολούθηση ακολουθούν την τρέχουσα **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SmPC)**· δεν αρκεί ο γενικός χαρακτηρισμός «ηπατοτοξική».

Η **δισουλφιράμη** έχει πιο επιλεγμένο ρόλο. Αναστέλλει την **αφυδρογονάση της ακεταλδεϋδης**, οπότε η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί συσσώρευση ακεταλδεϋδης

και αποτρεπτική δυσάρεστη αντίδραση. Μπορεί να εξεταστεί όταν η αποχή είναι ο συμφωνημένος στόχος και οι πρώτες επιλογές είναι ακατάλληλες, μη ανεκτές ή αναποτελεσματικές ή όταν ο ασθενής την προτιμά. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται πολύ από τη λήψη της αγωγής, γι' αυτό η επιτηρούμενη χορήγηση μπορεί να είναι χρήσιμη. Πρέπει επίσης να συζητούνται οι αντενδείξεις και οι κίνδυνοι της κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη λήψη της.

Η **ναλμεφαίνη** είναι διαφορετική: προσανατολίζεται στη μείωση της κατανάλωσης και όχι πρωτίστως στην αποχή. Είναι επιλογή που εξαρτάται από την άδεια κυκλοφορίας και το συγκεκριμένο σύστημα υγείας για επιλεγμένους ενήλικες με υψηλό επίπεδο κινδύνου κατανάλωσης οι οποίοι δεν χρειάζονται άμεση αποτοξίνωση. Δεν αποτελεί καθολικό βήμα μετά τη στέρηση.

Η διάρκεια χρειάζεται πρακτική ευελιξία. Περίπου 6 μήνες είναι χρήσιμο θεραπευτικό σημείο αναφοράς για ακαμπροσάτη ή ναλτρεξόνη στο υφιστάμενο πλαίσιο, όχι αυτόματη ημερομηνία διακοπής. Η συνέχιση εξατομικεύεται ανάλογα με το όφελος, τον κίνδυνο υποτροπής, τη λήψη της αγωγής, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την πρόοδο.

Στη μακροχρόνια παρακολούθηση δεν μετρώ μόνο πόσο πίνει ο ασθενής. Παρακολουθώ **craving, lapses** ή υποτροπές, **ψυχιατρική συννοσηρότητα, σωματικές επιπλοκές, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση, συμμόρφωση και προσωπικούς στόχους**. Αν υπάρξει υποτροπή, επανεκτιμώ τι συντηρεί τη διαταραχή και ενισχύω τη θεραπεία· δεν τη θεωρώ αυτόματα απόδειξη αποτυχίας.

Η κεντρική αρχή είναι ότι η αντιμετώπιση της στέρησης αφαιρεί τον άμεσο φυσιολογικό κίνδυνο, ενώ η ανάρρωση από AUD απαιτεί μακροχρόνιο σχέδιο πρόληψης υποτροπής με ψυχοκοινωνική θεραπεία, κατάλληλα επιλεγμένη φαρμακοθεραπεία και διαχρονική παρακολούθηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Η θεραπεία της στέρησης δεν ισοδυναμεί με θεραπεία της AUD.**
- **Ακαμπροσάτη:** τροποποιεί γλουταματεργική/GABAεργική σηματοδότηση· ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι πλήρως καθορισμένος.
- **Ναλτρεξόνη:** ανταγωνιστής οπιοειδών υποδοχέων, κυρίως μ κλινικά. Δεν αρχίζει σε τρέχουσα χρήση/εξάρτηση από οπιοειδή, λόγω πρόκλησης οξείας στέρησης και αποκλεισμού αναλγησίας.
- **Δισουλφιράμη:** αναστολή αφυδρογονάσης ακεταλδεϋδης → συσσώρευση ακεταλδεϋδης με αλκοόλ· είναι αποτρεπτική θεραπεία, όχι θεραπεία της στέρησης.
- **Ναλμεφαίνη:** επιλεγμένη στρατηγική μείωσης κατανάλωσης, με θέση που εξαρτάται από άδεια και δικαιοδοσία· όχι καθολικό μετα-αποτοξινωτικό βήμα.
- Η φαρμακοθεραπεία πρόληψης υποτροπής συνδυάζεται συνήθως με δομημένη ψυχοκοινωνική φροντίδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q39a. Πώς επιλέγετε μεταξύ ακαμπροσάτης, ναλτρεξόνης και δισουλφιράμης;

Ξεκινώ από τον θεραπευτικό στόχο και το προφίλ αντενδείξεων. Η ακαμπροσάτη

είναι επιλογή διατήρησης της αποχής και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν δεν επιθυμούμε ανταγωνισμό οπιοειδών. Η ναλτρεξόνη είναι χρήσιμη όταν στόχος είναι η μείωση της ανταμοιβής από το αλκοόλ ή της βαριάς κατανάλωσης, αλλά τρέχουσα χρήση/εξάρτηση από οπιοειδή αποτελεί σημαντικό αποκλεισμό. Η δισουλφιράμη είναι επιλεγμένη αποτρεπτική θεραπεία με στόχο την αποχή, της οποίας η αποτελεσματικότητα εξαρτάται έντονα από τη λήψη της αγωγής και συχνά ωφελείται από επίβλεψη. Η επιλογή γίνεται με βάση στόχο, σωματική υγεία, έκθεση σε οπιοειδή, πιθανότητα συνεπούς λήψης, προηγούμενη ανταπόκριση και προτίμηση, όχι με απλή κατάταξη αποτελεσματικότητας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Κατάλογος φαρμάκων χωρίς σύνδεση με στόχο και αντενδείξεις.
- Παρουσίαση της ακαμπροσάτης απλώς ως NMDA ανταγωνιστή.
- Γενικός χαρακτηρισμός της ναλτρεξόνης ως «ηπατοτοξικής» και παράβλεψη του άμεσου κινδύνου με οπιοειδή.
- Έναρξη ναλτρεξόνης σε τρέχουσα εξάρτηση από οπιοειδή.
- Παρουσίαση δισουλφιράμης ως routine first-line.
- Παρουσίαση ναλμεφαίνης ως καθολικού θεραπευτικού βήματος.
- Θεώρηση ενός lapse ως αυτόματης αποτυχίας θεραπείας.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης οπιοειδών;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Υπερδοσολογία: αποκατάσταση αερισμού
- 2 Εκτίμηση στέρησης και εξάρτησης
- 3 Θεραπεία συντήρησης αντί αποτοξίνωσης ως μοναδικού στόχου
- 4 Ασφαλής μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη
- 5 Ναλοξόνη για το σπίτι και εκπαίδευση στην υπερδοσολογία
- 6 Ισχύον ελληνικό πλαίσιο πρόσβασης στη ναλοξόνη
- 7 Μείωση βλάβης από ενέσιμη χρήση και λοιμώξεις

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή χρήσης οπιοειδών αντιμετωπίζεται ως χρόνια υποτροπιάζουσα διαταραχή με πρόληψη υπερδοσολογίας, θεραπεία με οπιοειδείς αγωνιστές και μείωση βλάβης, όχι με την αποτοξίνωση ως προεπιλεγμένο τελικό στόχο. Αναγνωρίζω πρώτα τυχόν οξεία υπερδοσολογία, στη συνέχεια αξιολογώ εξάρτηση και στέρηση, προσφέρω θεραπεία συντήρησης με μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη όπου είναι κατάλληλη και αντιμετωπίζω λοιμώξεις, ενέσιμες και ψυχοκοινωνικές επιπλοκές.

Στην υπερδοσολογία οπιοειδών, η κλασική εικόνα είναι καταστολή του επιπέδου συνείδησης με αναπνευστική καταστολή, συχνά με μύση. Η αντιμετώπιση δίνει προτεραιότητα στον αεραγωγό και στον επαρκή αερισμό μαζί με ναλοξόνη, ανταγωνιστή των οπιοειδών υποδοχέων. Η ναλοξόνη τιτλοποιείται με κλινικό στόχο την αποκατάσταση επαρκούς αερισμού και όχι σύμφωνα με έναν καθολικό δοσολογικό πίνακα για όλα τα προϊόντα και τις οδούς χορήγησης. Επειδή η δράση της μπορεί να τελειώσει πριν υποχωρήσει η επίδραση του οπιοειδούς, μπορεί να χρειαστούν επαναλαμβανόμενες δόσεις και συνεχιζόμενη παρακολούθηση.

Η στέρηση αναγνωρίζεται κλινικά, αλλά η αποτοξίνωση από μόνη της δεν αποτελεί την προτιμώμενη θεραπεία. Η μείωση ή διακοπή οπιοειδών μειώνει την ανοχή και έτσι η επάνοδος στη χρήση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερδοσολογίας. Για πολλούς ασθενείς, η θεραπεία με οπιοειδείς αγωνιστές με μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη είναι καθιερωμένη μακροχρόνια φροντίδα, όχι απλώς γέφυρα προς αποτοξίνωση.

Και τα δύο φάρμακα απαιτούν ασφαλή έναρξη. Η μεθαδόνη έχει μακρό και ιδιαίτερα μεταβλητό χρόνο ημιζωής αποβολής, επομένως μπορεί να συσσωρευτεί κατά την εισαγωγή. Οι αυξήσεις της δόσης γίνονται προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη αναπνευστικό κίνδυνο, αλληλεπιδράσεις και QT, και όχι έναν υποτιθέμενο μοναδικό κανόνα ημιζωής.

Η βουπρενορφίνη είναι μερικός αγωνιστής του μ-οπιοειδούς υποδοχέα με υψηλή συγγένεια. Η υψηλή συγγένεια της επιτρέπει να εκτοπίζει πλήρεις αγωνιστές αλλά με χαμηλότερη ενδογενή μ-αγωνιστική δραστηριότητα. Αν αρχίσει ενώ εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική δράση πλήρους αγωνιστή, μπορεί να

προκαλέσει **αιφνίδια οξεία στέρηση (precipitated withdrawal)**. Γι' αυτό η έναρξη βασίζεται στην εγκατάσταση αντικειμενικής, κλινικά σημαντικής στέρησης. Δεν υπάρχει ένα καθολικό όριο COWS ή συγκεκριμένος αριθμός ωρών για όλα τα οπιοειδή, επειδή ο χρόνος εξαρτάται από το οπιοειδές, το σκεύασμα και το πρότυπο έκθεσης.

Στους συνδυασμούς **βουπρενορφίνης/ναλοξόνης**, η ναλοξόνη λειτουργεί κυρίως ως αποτρεπτικό στοιχείο για **παράνομη διάθεση ή μη προβλεπόμενη παρεντερική χρήση**: έχει σχετικά χαμηλή υπογλώσσια βιοδιαθεσιμότητα αλλά μπορεί να ανταγωνιστεί τα οπιοειδή αν χορηγηθεί παρεντερικά. Αυτό δεν μετατρέπεται σε ένα σταθερό ποσοστό βιοδιαθεσιμότητας ούτε σε απόλυτο ισχυρισμό ότι η ένεση έχει πάντοτε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα.

Η πρόληψη υπερδοσολογίας πρέπει να είναι ρουτίνα. Οι ασθενείς και, όπου είναι κατάλληλο, οι οικείοι τους λαμβάνουν **εκπαίδευση για υπερδοσολογία και take-home/community naloxone**. Στην Ελλάδα, από τον **Ιούλιο 2025**, η ενδορρινική και η προγεμισμένη ενέσιμη ναλοξόνη μπορούν να συνταγογραφούνται από ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας, να διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία και να χορηγούνται από οποιονδήποτε σε επείγον περιστατικό υπερδοσολογίας. Δεν προσθέτουμε μη επαληθευμένες απαιτήσεις διάθεσης ή επίβλεψης.

Στο ελληνικό σύστημα, τα **προγράμματα του OKANA** χρησιμοποιούν **μεθαδόνη και βουπρενορφίνη στο πλαίσιο ολοκληρωμένης θεραπείας**. Το εξεταστικά χρήσιμο σημείο είναι η διαθεσιμότητα τεκμηριωμένης θεραπείας με οπιοειδείς αγωνιστές· δεν εισάγουμε κανόνες επιτήρησης ή φαρμακείου από άλλες χώρες χωρίς επαλήθευση.

Αξιολογώ επίσης τις βλάβες από ενέσιμη χρήση και χρόνια χρήση οπιοειδών: **κίνδυνο HBV, HCV και HIV, ανάγκη εμβολιασμού και ελέγχου, λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων, ενδοκαρδίτιδα και πρόσβαση σε υπηρεσίες βελονών/συρίγγων** όπου είναι σχετικά. Ψυχιατρική συννοσηρότητα, αυτοκτονικός κίνδυνος, στέγαση, κοινωνική σταθερότητα και ταυτόχρονη χρήση αλκοόλ ή κατασταλτικών επηρεάζουν επίσης τον κίνδυνο υπερδοσολογίας και το θεραπευτικό σχέδιο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Βουπρενορφίνη**: υψηλής συγγένειας μερικός **μ-αγωνιστής**· έναρξη πριν εγκατασταθεί επαρκής στέρηση από πλήρη αγωνιστή μπορεί να προκαλέσει precipitated withdrawal μέσω εκτόπισης.
- **Μεθαδόνη**: μακρός και μεταβλητός χρόνος ημιζωής με κίνδυνο συσσώρευσης κατά την έναρξη· δεν χρησιμοποιούμε ένα μοναδικό εύρος ημιζωής ως δοσολογικό κανόνα.
- **Ναλοξόνη**: ανταγωνιστής οπιοειδών υποδοχέων· η επείγουσα δόση εξαρτάται από προϊόν, οδό και κλινικό στόχο, με επανάληψη όταν χρειάζεται.
- **Η αποτοξίνωση μειώνει την ανοχή** και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερδοσολογίας αν επαναληφθεί η χρήση.
- **Η θεραπεία με οπιοειδείς αγωνιστές είναι θεραπεία συντήρησης**, όχι απλώς γέφυρα αποτοξίνωσης.
- **Ελλάδα, Ιούλιος 2025**: ενδορρινική/προγεμισμένη ενέσιμη ναλοξόνη μπορεί να συνταγογραφείται από ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας, να διατίθεται από

ιδιωτικά φαρμακεία και να χορηγείται από οποιονδήποτε σε επείγον υπερδοσολογίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q40a. Γιατί η βουπρενορφίνη μπορεί να προκαλέσει οξεία στέρηση;

Επειδή έχει πολύ υψηλή συγγένεια για τον μ-υποδοχέα αλλά μόνο μερική αγωνιστική αποτελεσματικότητα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ουσιαστική δράση πλήρους αγωνιστή, η βουπρενορφίνη τον εκτοπίζει από τον υποδοχέα αλλά παρέχει μικρότερη ενδογενή μ-ενεργοποίηση. Η απότομη καθαρή μείωση του αποτελέσματος στον υποδοχέα προκαλεί precipitated withdrawal. Γι' αυτό η εισαγωγή βασίζεται σε εγκατεστημένη στέρηση και όχι σε ένα καθολικό χρονικό όριο ή βαθμολογία COWS.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Παρουσίαση της αποτοξίνωσης ως προεπιλεγμένης θεραπείας.
- Ένας σταθερός κανόνας ωρών ή COWS για όλες τις μορφές οπιοειδών.
- Ένας μοναδικός χρόνος ημιζωής μεθαδόνης ως κανόνας δοσολογίας.
- Εστίαση μόνο στη ναλοξόνη και παράβλεψη αεραγωγού/αερισμού.
- Μία καθολική δόση ναλοξόνης για όλα τα προϊόντα και τις οδούς.
- Επινοημένοι ελληνικοί κανόνες διάθεσης/επίβλεψης μεθαδόνης ή βουπρενορφίνης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Θεραπευτικό μοντέλο: η παλαιότερη αποτοξινωσιοκεντρική προσέγγιση είναι ανεπαρκής για πολλούς ασθενείς. Η σύγχρονη φροντίδα δίνει έμφαση στη θεραπεία συντήρησης με οπιοειδείς αγωνιστές, την πρόληψη υπερδοσολογίας και τη μείωση βλάβης.

Ελληνική πρόσβαση στη ναλοξόνη: η αλλαγή του Ιουλίου 2025 διέυρνε ουσιαστικά τη συνταγογράφηση, τη διάθεση από ιδιωτικά φαρμακεία και την επείγουσα χορήγηση.

Ποια ψυχιατρικά σύνδρομα σχετιζόμενα με την κάνναβη πρέπει να αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή χρήσης κάνναβης;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Τοξίκωση και στέρηση
- 2 Προσεκτική διάγνωση ψύχωσης επαγόμενης από κάνναβη
- 3 Διαχρονική διάκριση από πρωτοπαθή ψύχωση
- 4 Σύνδρομο υπερέμεσης από κανναβινοειδή
- 5 Κάνναβη ως τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου, όχι ντετερμινιστική αιτία
- 6 Ψυχοκοινωνική θεραπεία της διαταραχής χρήσης κάνναβης
- 7 Συνθετικά κανναβινοειδή: συχνά βαρύτερη και απρόβλεπτη εικόνα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κάνναβη μπορεί να προκαλέσει **τοξίκωση, στέρηση και ψυχιατρικά σύνδρομα επαγόμενα από ουσίες**, μεταξύ αυτών και ψυχωσικές εικόνες. Το κρίσιμο διαγνωστικό έργο είναι να αποσαφηνιστεί η χρονική σχέση και να μην θεωρηθεί ότι κάθε ψύχωση σε χρήστη κάνναβης είναι κατ' ανάγκην επαγόμενη από την ουσία. Η έκθεση στην κάνναβη συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ψύχωσης και δυσμενέστερη πορεία όταν υπάρχει ήδη ψυχωσική διαταραχή, ιδίως με συχνή χρήση ή προϊόντα υψηλής δραστηριότητας, αλλά αυτό είναι τροποποιήσιμη συσχέτιση κινδύνου και όχι ντετερμινιστική αιτιότητα.

Κατά την **τοξίκωση**, μπορεί να εμφανιστούν άγχος ή πανικός, αντιληπτικές διαταραχές και μερικές φορές ψυχωσικά συμπτώματα. Η **THC είναι μερικός αγωνιστής CB1/CB2** και αποτελεί το κύριο κανναβινοειδές που ευθύνεται για την τοξίκωση και τις ψυχωσιμομιμητικές επιδράσεις. Η CBD έχει σύνθετη φαρμακολογία πολλαπλών στόχων και δεν πρέπει να αναχθεί σε έναν μόνο μηχανισμό CB1 ούτε να παρουσιάζεται ως καθιερωμένη routine αντιψυχωσική θεραπεία.

Η στέρηση κάνναβης είναι αναγνωρισμένο σύνδρομο και εξετάζεται όταν συμπτώματα εμφανίζονται μετά από μείωση ή διακοπή σε εξαρτημένο χρήστη. Συνήθως αρχίζουν μέσα στις **πρώτες ημέρες**, αλλά ο χρονισμός ποικίλλει και δεν αποτελεί άκαμπτο διαγνωστικό κανόνα.

Στην **ψύχωση επαγόμενη από κάνναβη**, αναζητώ εύλογη χρονική σχέση με τοξίκωση ή στέρηση και συμπτώματα που υπερβαίνουν τις αναμενόμενες παροδικές επιδράσεις μιας απλής τοξίκωσης. Η διάγνωση γίνεται λιγότερο πειστική όταν η ψύχωση προϋπήρχε σαφώς της έκθεσης, όταν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ανεξάρτητης ψυχωσικής διαταραχής ή όταν το ψυχωσικό σύνδρομο επιμένει πολύ πέρα από την αναμενόμενη ουσιο-σχετιζόμενη περίοδο.

Δεν υπάρχει ένα μοναδικό χρονικό όριο αποχής που να αποδεικνύει αν η ψύχωση είναι επαγόμενη από κάνναβη ή πρωτοπαθή. Η διάκριση είναι διαχρονική και βασίζεται στη χρονολογία, προηγούμενα επεισόδια, **ετεροαναφορικό ιστορικό**, την επιμονή των συμπτωμάτων και το ευρύτερο σχιζοφρενικό ή συναισθηματικό

σύνδρομο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, όπου πρόωρη αιτιολογική απόδοση στην κάνναβη μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση μιας εξελισσόμενης πρωτοπαθούς διαταραχής.

Πρέπει επίσης να αναγνωρίζεται το **σύνδρομο υπερέμεσης από κανναβινοειδή**, με υποτροπιάζουσα ναυτία και εμέτους στο πλαίσιο χρόνιας χρήσης. Τα θερμά μπάνια ή ντους είναι χαρακτηριστικά σε πολλούς ασθενείς αλλά **δεν απαιτούνται** για τη διάγνωση. Η **σταθερή αποχή από την κάνναβη** είναι η οριστική προληπτική παρέμβαση, παρότι ο χρόνος υποχώρησης και το πρότυπο υποτροπών ποικίλλουν.

Η χρήση κάνναβης παραμένει κλινικά σημαντική ακόμη και όταν δεν αποτελεί τη μοναδική αιτία της ψύχωσης. Συχνότερη και υψηλότερης δραστηριότητας χρήση συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο ψύχωσης, ενώ η συνεχιζόμενη χρήση σε εγκατεστημένη ψύχωση συνδέεται με χειρότερη πορεία και περισσότερες υποτροπές. Επομένως η μείωση ή διακοπή είναι σημαντικός τροποποιήσιμος θεραπευτικός στόχος χωρίς να λέμε ότι η κάνναβη «προκαλεί αναπόφευκτα σχιζοφρένεια».

Η θεραπεία της **διαταραχής χρήσης κάνναβης** είναι κυρίως ψυχοκοινωνική: σύντομες παρεμβάσεις, motivational enhancement, CBT και οικογενειακές προσεγγίσεις ανάλογα με τον ασθενή και το πλαίσιο. Δεν υπάρχει φαρμακοθεραπεία με routine άδεια κυκλοφορίας που να πρέπει να παρουσιάζεται ως καθιερωμένη θεραπεία της διαταραχής χρήσης κάνναβης.

Πρωτό επίσης ειδικά για **συνθετικά κανναβινοειδή**, τα οποία αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία στη σύγχρονη ταξινόμηση και μπορούν να προκαλέσουν βαρύτερη και λιγότερο προβλέψιμη διέγερση, ψύχωση και σωματική τοξικότητα από την κλασική κάνναβη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **THC:** μερικός **CB1/CB2 αγωνιστής**, κύριος παράγοντας τοξίκωσης και ψυχωσιμομιμητικών επιδράσεων.
- **CBD:** σύνθετη φαρμακολογία πολλαπλών στόχων· όχι ένα απλό CB1 φάρμακο ούτε καθιερωμένη routine αντιψυχωσική θεραπεία.
- **Στέρηση κάνναβης:** συχνά αρχίζει στις πρώτες ημέρες μετά τη διακοπή, αλλά ο χρονισμός ποικίλλει.
- **Cannabinoid hyperemesis:** υποτροπιάζουσα ναυτία/έμετοι σε χρόνια έκθεση· τα θερμά μπάνια είναι χαρακτηριστικά αλλά όχι απαραίτητα· η σταθερή αποχή είναι η οριστική προληπτική παρέμβαση.
- Τα **συνθετικά κανναβινοειδή** αναγνωρίζονται χωριστά στο ICD-11.
- Δεν υπάρχει ένα μοναδικό διάστημα αποχής που να αποδεικνύει αιτιότητα κάνναβης έναντι πρωτοπαθούς ψύχωσης.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ντετερμινιστικός ισχυρισμός ότι η κάνναβη «προκαλεί σχιζοφρένεια».
- Αυτόματη διάγνωση substance-induced psychosis επειδή ο ασθενής χρησιμοποιεί κάνναβη.
- Απαίτηση θερμών μπάνιων για cannabinoid hyperemesis.
- Παρουσίαση CBD ως αποδεδειγμένη routine αντιψυχωσική θεραπεία.
- Χρήση άκαμπτου χρονικού κανόνα στέρησης.
- Παράβλεψη της συνεχιζόμενης κάνναβης ως τροποποιήσιμου παράγοντα υποτροπής σε πρωτοπαθή ψύχωση.

Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τις διαταραχές που σχετίζονται με διεγερτικά;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Συμπαθητικομιμητικό τοξίδρομο
- 2 Άμεσος έλεγχος καρδιαγγειακών, νευρολογικών και υπερθερμικών επειγόντων
- 3 Βενζοδιαζεπίνες και υποστηρικτική φροντίδα στην οξεία φάση
- 4 Αντιμετώπιση της ψύχωσης χωρίς να χαθεί η ιατρική τοξικότητα
- 5 Withdrawal/crash και αυτοκτονικός κίνδυνος
- 6 Contingency management στη μακροχρόνια θεραπεία

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η τοξίκωση από διεγερτικά αντιμετωπίζεται ως συμπαθητικομιμητικό επείγον μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Η κοκαΐνη και οι αμφεταμίνες μπορούν να προκαλέσουν διέγερση, αυτόνομη ενεργοποίηση, παράνοια ή ψύχωση, υπερθερμία, σπασμούς και σοβαρές καρδιαγγειακές ή εγκεφαλοαγγειακές επιπλοκές. Επομένως το πρώτο βήμα είναι ταυτόχρονη ψυχιατρική και ιατρική εκτίμηση και όχι απλώς καταστολή της διέγερσης.

Η τυπική εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει έντονη διέγερση, άγχος, ταχυκαρδία ή υπέρταση, καχυποψία ή έκδηλη ψύχωση. Αναζητώ αμέσως θωρακικό άλγος ή ισχαιμία μυοκαρδίου, σοβαρή υπέρταση, αρρυθμία, υπερθερμία, σπασμούς, εστιακά νευρολογικά σημεία, διαταραχή συνείδησης, ραβδομυόλυση ή νεφρική βλάβη, σοβαρή ψύχωση και αυτοκτονικότητα.

Οι μηχανισμοί είναι εξεταστικά χρήσιμοι. Η κοκαΐνη αναστέλλει τους μεταφορείς επαναπρόσληψης μονοαμινών, ιδιαίτερα DAT, NET και SERT. Οι αμφεταμίνες αυξάνουν την απελευθέρωση μονοαμινών, αντιστρέφουν τη μεταφορά τους και επηρεάζουν επίσης τον VMAT2. Πρόκειται για υψηλού επιπέδου μηχανισμούς, όχι για ιστορίες ενός μοναδικού μοριακού στόχου.

Για την οξεία διέγερση και την υπεραδρενεργική κατάσταση, οι βενζοδιαζεπίνες είναι η βασική θεραπεία πρώτης γραμμής, μαζί με περιβαλλοντική αποκλιμάκωση και υποστηρικτική ιατρική φροντίδα. Η υπερθερμία απαιτεί ενεργή ψύξη. Η ενυδάτωση και τα λοιπά μέτρα καθοδηγούνται από την κλινική κατάσταση, ενώ ισχαιμία, σπασμοί ή νευρολογικά συμβάματα χρειάζονται ειδική επείγουσα αντιμετώπιση.

Σημαντική σύγχρονη διόρθωση αφορά τους β-αναστολείς μετά από κοκαΐνη ή άλλα διεγερτικά. Ο παλαιός απόλυτος κανόνας «κανένας β-αναστολέας ποτέ» είναι υπερβολικός. Στην οξεία τοξίκωση προτιμώνται βενζοδιαζεπίνες και αγγειοδιασταλτικές στρατηγικές, αλλά αν χρειάζεται κλινικά β-αποκλεισμός, η επιλογή του παράγοντα και το πλαίσιο έχουν σημασία και συχνά προτιμάται συνδυασμένος α/β αποκλεισμός αντί γενικής απαγόρευσης.

Η ψύχωση αξιολογείται παράλληλα με το σωματικό σύνδρομο. Παράνοια, ψευδαισθήσεις ή απτική αίσθηση/ψευδαίσθηση ότι έντομα έρπουν πάνω ή κάτω

από το δέρμα (formication) δεν πρέπει να αποσπών από την αναζήτηση υπερθερμίας, εμφράγματος, ΑΕΕ ή σπασμών. Η χρονική σχέση με τη χρήση, η επιμονή μετά την υποχώρηση της τοξίκωσης και το ευρύτερο ψυχιατρικό ιστορικό βοηθούν στη διάκριση επαγόμενης από ουσίες έναντι ανεξάρτητης ψύχωσης.

Μετά από βαριά χρήση μπορεί να ακολουθήσει **φάση στέρησης ή crash** με κόπωση, διαταραχή ύπνου, δυσφορία ή κατάθλιψη, ανηδονία και craving. Ο αυτοκτονικός κίνδυνος χρειάζεται ειδική εκτίμηση, επειδή τα καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να είναι κλινικά σημαντικά ακόμη και μετά το τέλος της οξείας τοξίκωσης.

Η μακροχρόνια θεραπεία είναι κυρίως συμπεριφορική. Το **contingency management** έχει την **ισχυρότερη και πιο συνεπή τεκμηρίωση μεταξύ των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων για stimulant-use disorder**, και μπορεί να συνδυαστεί με CBT ή άλλες δομημένες συμπεριφορικές προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει μία καθολικά εγκεκριμένη φαρμακοθεραπεία που να πρέπει να παρουσιάζεται ως standard medication treatment.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Κοκαΐνη:** αναστέλλει κυρίως **DAT/NET/SERT**.
- **Αμφεταμίνη/δεξαμφεταμίνη:** αυξάνει απελευθέρωση/αντίστροφη μεταφορά μονοαμινών και επηρεάζει **VMAT2**.
- Ο απόλυτος κανόνας «**ποτέ β-αναστολέας μετά από κοκαΐνη**» είναι **ξεπερασμένος**. Βενζοδιαζεπίνες παραμένουν πρώτης γραμμής για συμπαθητικομιμητική διέγερση/υπέρταση· όταν χρειάζεται β-αποκλεισμός μπορεί να εξεταστεί συνδυασμένος α/β παράγοντας.
- Η stimulant psychosis μπορεί να περιλαμβάνει παράνοια, ψευδαισθήσεις και **formication**.
- **Contingency management** έχει το ισχυρότερο τρέχον ψυχοκοινωνικό treatment signal.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση της ψύχωσης ή διέγερσης ενώ χάνεται υπερθερμία, ισχαιμία μυοκαρδίου, ΑΕΕ ή σπασμοί.
- Αναπαραγωγή της παλαιάς απόλυτης απαγόρευσης β-αναστολέων.
- Μετατροπή ενός μηχανισμού διεγερτικού σε μονοστόχο αφήγηση.
- Παράβλεψη αυτοκτονικού κινδύνου στη φάση crash.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Β-αναστολείς: η παλαιότερη διδασκαλία συχνά επέβαλλε καθολική απαγόρευση μετά από κοκαΐνη. Η σύγχρονη προσέγγιση είναι πιο υπό όρους: βενζοδιαζεπίνες και αγγειοδιασταλτικά προτιμώνται οξέως, αλλά συνδυασμένος α/β αποκλεισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι κλινικά απαραίτητος.

Πώς αντιμετωπίζετε την εξάρτηση και τη στέρηση από βενζοδιαζεπίνες;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Όχι απότομη διακοπή
- 2 Κίνδυνος στέρησης και επιπλοκών
- 3 Αργή, εξατομικευμένη σταδιακή μείωση
- 4 Παύση ή επιβράδυνση όταν τα συμπτώματα γίνονται προβληματικά
- 5 Επιλεκτική μετάβαση σε βενζοδιαζεπίνη μακράς δράσης
- 6 Παράλληλη θεραπεία άγχους/αϋπνίας
- 7 Φλουμαζενίλη: κίνδυνος σε εξάρτηση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εξάρτηση από βενζοδιαζεπίνες αντιμετωπίζεται συνήθως με **συνεργατική, σταδιακή και εξατομικευμένη μείωση**, επειδή η απότομη διακοπή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή στέρηση, ακόμη και σπασμούς ή ντελίριο. Αρχικά εκτιμώ την τρέχουσα δόση και διάρκεια χρήσης, προηγούμενες εμπειρίες στέρησης, συννοσηρότητα και παράγοντες που αυξάνουν τον ιατρικό ή ψυχιατρικό κίνδυνο, και στη συνέχεια συμφωνώ ένα πλάνο που προσαρμόζεται στα συμπτώματα αντί να επιβάλλεται ένα σταθερό ημερολόγιο.

Η πρώτη αρχή είναι να μην διακόπτεται απότομα η βενζοδιαζεπίνη όταν είναι πιθανή φυσιολογική εξάρτηση, ακόμη κι αν η δόση φαίνεται σχετικά μικρή. Η βαρύτητα της στέρησης επηρεάζεται από το ατομικό πρότυπο χρήσης και την ευαλωτότητα. Πρωτό για προηγούμενες δύσκολες μειώσεις, σπασμούς ή ντελίριο, ταυτόχρονη χρήση αλκοόλ ή άλλων κατασταλτικών, σοβαρά σωματικά νοσήματα και ψυχιατρική αστάθεια. Επιπλεγμένη στέρηση ή υψηλός ιατρικός/ψυχιατρικός κίνδυνος μπορεί να απαιτεί νοσοκομειακό ή άλλο εποπτευόμενο πλαίσιο.

Μια χρήσιμη σύγχρονη αφετηρία είναι μείωση περίπου 5–10% **κάθε 2–4 εβδομάδες**, γενικά χωρίς μειώσεις μεγαλύτερες από 25% **κάθε 2 εβδομάδες**. Αυτές είναι αρχές εκκίνησης τύπου ASAM και όχι υποχρεωτικό πρόγραμμα για όλους. Χρόνια χρήση, υψηλότερες δόσεις ή μεγάλη ευαισθησία στη στέρηση μπορεί να απαιτούν πολύ βραδύτερη πορεία.

Η μείωση πρέπει να είναι **προσαρμοσμένη στην κλινική ανταπόκριση**. Αν η στέρηση γίνει ουσιαστικά προβληματική, παγώνω προσωρινά τη μείωση ή κάνω τις επόμενες μειώσεις μικρότερες και πιο αραιές. Η εμφάνιση συμπτωμάτων δεν σημαίνει «αποτυχία» του ασθενούς. Στόχος είναι ασφαλής προοδευτική μείωση με διατήρηση της θεραπευτικής συνεργασίας και της λειτουργικότητας.

Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να βοηθήσει μετάβαση σε **διαζεπάμη ή άλλη βενζοδιαζεπίνη μακράς δράσης**, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Η απόφαση εξαρτάται από το αρχικό φάρμακο, το δοσολογικό πρότυπο, την προτίμηση και ιατρικούς παράγοντες. Σε ηπατική δυσλειτουργία η μετατροπή σε μακράς δράσης φάρμακο μπορεί να είναι λιγότερο ελκυστική· λοραζεπάμη, οξαζεπάμη ή παραμονή στο αρχικό βραχύτερης δράσης φάρμακο μπορεί να είναι καταλληλότερα. Οι

πίνακες ισοδυναμίας βοηθούν, αλλά δεν είναι ακριβείς βιολογικές μετατροπές.

Παράλληλα αντιμετωπίζω τον λόγο για τον οποίο χορηγείται η βενζοδιαζεπίνη. Άγχος, αϋπνία και άλλα συμπτώματα χρειάζονται ενεργή τεκμηριωμένη θεραπεία, ώστε η μείωση να μη βιώνεται ως αφαίρεση της μοναδικής στρατηγικής αντιμετώπισης. CBT, CBT-I και άλλες κατάλληλες συμπεριφορικές παρεμβάσεις μπορούν να στηρίξουν το πλάνο σταδιακής μείωσης και διακοπής της αγωγής.

Σημαντικό τοξικολογικό σημείο είναι η φλουμαζενίλη. Δρα ανταγωνιστικά στη θέση πρόσδεσης των βενζοδιαζεπινών, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή στέρηση και σπασμούς σε χρόνιο εξαρτημένο ασθενή και να είναι επικίνδυνη σε μικτές υπερδοσολογίες με σπασμογόνες ουσίες ή φάρμακα. Επομένως δεν αποτελεί routine στρατηγική αναστροφής της καταστολής σε εξαρτημένους ασθενείς και χρησιμοποιείται μόνο σε επιλεγμένη εξειδικευμένη ένδειξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **ASAM 2025:** αρχικό πλάνο περίπου 5–10% κάθε 2–4 εβδομάδες, γενικά όχι πάνω από 25% κάθε 2 εβδομάδες, με επιβράδυνση ή παύση όπου χρειάζεται.
- Η σύγχρονη μείωση είναι **symptom-responsive**, όχι άκαμπτη εφαρμογή ημερολογίου.
- **Μετάβαση σε διαζεπάμη** = προαιρετική, όχι υποχρεωτική για όλους.
- Η στέρηση μπορεί να προκαλέσει **σπασμούς και ντελίριο**.
- **Φλουμαζενίλη:** μπορεί να προκαλέσει σοβαρή στέρηση/σπασμούς σε χρόνια εξάρτηση ή μικτή σπασμογόνο υπερδοσολογία· δεν χρησιμοποιείται routine σε αυτό το πλαίσιο.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Απότομη διακοπή επειδή η δόση φαίνεται «χαμηλή».
- Μετατροπή του ποσοστού μείωσης σε υποχρεωτικό σταθερό πρόγραμμα.
- Αντιμετώπιση των πινάκων ισοδυναμίας ως ακριβών βιολογικών μετατροπών.
- Υπόθεση ότι κάθε ασθενής πρέπει να μεταβεί σε διαζεπάμη.
- Συνέχιση άκαμπτου taper παρά κλινικά σημαντική στέρηση.
- Αδιάκριτη χορήγηση φλουμαζενίλης σε χρόνιο εξαρτημένο ασθενή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Σχήματα μείωσης: τα κλασικά Ashton-style ή άλλα σταθερά κλασματικά σχήματα είναι χρήσιμα ιστορικά πρότυπα, όχι καθολικά σύγχρονα standards. Η τρέχουσα προσέγγιση εξατομικεύεται και προσαρμόζεται σε συμπτώματα και κίνδυνο.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη διαταραχή τυχερών παιχνιδιών;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Μειωμένος έλεγχος, αυξανόμενη προτεραιότητα, συνέχιση παρά τη βλάβη
- 2 Οικονομικές, κοινωνικές και αυτοκτονικές συνέπειες
- 3 Διάκριση από τζόγο μόνο κατά μανία/υπομανία
- 4 CBT ειδικά για gambling ως πρώτη γραμμή
- 5 Πρακτική μείωση οικονομικής βλάβης
- 6 Ναλτρεξόνη μόνο σε επιλεγμένη εξειδικευμένη δεύτερη γραμμή

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή τυχερών παιχνιδιών είναι **συμπεριφορικός εθισμός**, όχι απλώς συχνός τζόγος ούτε απλώς διαταραχή ελέγχου παρορμήσεων. Το κεντρικό πρότυπο είναι μειωμένος έλεγχος της συμπεριφοράς, αυξανόμενη προτεραιότητα του τζόγου έναντι άλλων δραστηριοτήτων και συνέχιση ή κλιμάκωση παρά τις ουσιαστικές αρνητικές συνέπειες. Η εκτίμηση πρέπει να καλύπτει οικονομική βλάβη, προστασία εξαρτώμενων ή ευάλωτων προσώπων, αυτοκτονικό κίνδυνο και το ενδεχόμενο η συμπεριφορά να εμφανίζεται αποκλειστικά σε μανιακό ή υπομανιακό επεισόδιο.

Αρχικά καταγράφω το **πρότυπο τζόγου και την απώλεια ελέγχου**: συχνότητα, αποτυχημένες προσπάθειες περιορισμού, χρόνο και νοητική ενασχόληση, και αν ο τζόγος έχει εκτοπίσει εργασία, σχέσεις ή άλλες υποχρεώσεις. Κλασικές γνωστικές διαστρεβλώσεις, όπως το **κυνήγι απωλειών**, η **πλάνη του παίκτη** και το **φαινόμενο σχεδόν επιτυχίας (near-miss)**, είναι κλινικά χρήσιμες αλλά δεν αποτελούν από μόνες τους τη διάγνωση.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές και τις διερευνώ άμεσα: **χρέη, πρόσβαση σε χρήματα, δανεισμό, επαγγελματικές συνέπειες, διάλυση σχέσεων, νομικά προβλήματα, κινδύνους για εξαρτώμενα μέλη και ζητήματα προστασίας**. Ο αυτοκτονικός κίνδυνος χρειάζεται ρητή εκτίμηση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει οξεία οικονομική ή διαπροσωπική κρίση.

Η διπολική διαφορική είναι σημαντική. Τζόγος που εμφανίζεται μόνο μέσα σε σαφές **μανιακό ή υπομανιακό επεισόδιο** οδηγεί σε αξιολόγηση και θεραπεία του επεισοδίου, όχι αυτόματα σε διάγνωση gambling disorder. Αν όμως το παθολογικό πρότυπο επιμένει εκτός επεισοδίων διάθεσης, οι δύο διαγνώσεις μπορούν να συνυπάρχουν.

Η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι **CBT ειδικά προσαρμοσμένη στη διαταραχή τυχερών παιχνιδιών**. Ομαδική CBT είναι βασική επιλογή όταν είναι αποδεκτή και εφικτή· ατομική CBT όταν η ομαδική δεν ταιριάζει ή απορρίπτεται. Motivational work και πρόληψη υποτροπής μπορούν να υποστηρίξουν τη συμμετοχή, ιδίως όταν υπάρχει αμφιθυμία ή επαναλαμβανόμενη υποτροπή.

Η θεραπεία περιλαμβάνει και άμεση **μείωση της πρόσβασης στη βλάβη**: αυτοαποκλεισμό, όρια, περιορισμό πρόσβασης σε χρήματα και, όπου χρειάζεται,

οικονομική, κοινωνική ή νομική υποστήριξη. Αυτά δεν είναι απλώς διοικητικά μέτρα· περιορίζουν τις περιβαλλοντικές ευκαιρίες που συντηρούν τη συμπεριφορά και προστατεύουν τον ασθενή και τα εξαρτώμενα πρόσωπα από περαιτέρω απώλειες.

Η φαρμακοθεραπεία δεν είναι routine first-line. **Off-label ναλτρεξόνη μπορεί να εξεταστεί σε εξειδικευμένη φροντίδα** μετά από αποτυχία επαρκούς ψυχολογικής θεραπείας ή όταν επιμένουν επαναλαμβανόμενες υποτροπές. Πρόκειται για επιλεγμένη δεύτερη γραμμή και όχι για τυπική αγωγή όλων των ασθενών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **ICD-11:** gambling disorder ανήκει στις διαταραχές λόγω εθιστικών συμπεριφορών.
- **DSM-5-TR:** τουλάχιστον 4 από 9 κριτήρια σε 12 μήνες. Αυτό είναι DSM-specific scaffold, όχι αρχιτεκτονική ICD-11.
- **Gambler's fallacy και near-miss effects** είναι σχετικές γνωστικές διαστρεβλώσεις, όχι αυτοτελή διαγνωστικά κριτήρια.
- **Ναλτρεξόνη:** επιλεγμένη specialist second-line off-label επιλογή μετά από επαρκή αποτυχία ψυχολογικής θεραπείας ή επαναλαμβανόμενη υποτροπή· όχι routine first-line.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση gambling disorder όταν ο τζόγος συμβαίνει μόνο στη μανία/υπομανία.
- Παράβλεψη αυτοκτονικού κινδύνου, κρίσης χρέους και προστασίας εξαρτώμενων προσώπων.
- Παρουσίαση της διαταραχής απλώς ως impulse-control disorder.
- Ταύτιση μιας γνωστικής διαστρέβλωσης με τη διάγνωση.
- Παρουσίαση ναλτρεξόνης ως routine πρώτη γραμμή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ταξινόμηση: παλαιότερη διδασκαλία τοποθετούσε τον παθολογικό τζόγο κυρίως στις διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων. Το ICD-11 τον τοποθετεί στις διαταραχές λόγω εθιστικών συμπεριφορών.

Φαρμακοθεραπεία: παλαιότερες απαντήσεις μπορεί να έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένας ρόλος φαρμάκου. Η σύγχρονη προσέγγιση επιτρέπει επιλεγμένη specialist off-label ναλτρεξόνη μετά από αποτυχία ψυχολογικής θεραπείας ή επαναλαμβανόμενη υποτροπή, με την CBT να παραμένει πρώτη γραμμή.

Πώς αναγνωρίζετε, πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε το ντελίριο;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Οξεία και διακυμαινόμενη πορεία
- 2 Διαταραχή προσοχής και επίγνωσης
- 3 Υπερδραστήρια, υποδραστήρια και μικτή μορφή
- 4 Εντοπισμός και θεραπεία του αιτίου
- 5 4AT σε γενικό νοσοκομείο/μακροχρόνια φροντίδα
- 6 Μη φαρμακευτικά μέτρα πρώτα
- 7 Αντιψυχωσικό μόνο για σοβαρή δυσφορία ή κίνδυνο

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ντελίριο είναι οξεία ή υποξεία, διακυμαινόμενη διαταραχή της προσοχής και της επίγνωσης με συνοδή γνωστική μεταβολή, συνήθως λόγω ενός ή περισσότερων σωματικών, φαρμακευτικών, τοξικών ή στερητικών παραγόντων. Οι προτεραιότητες είναι η έγκαιρη αναγνώριση, η ανεύρεση και θεραπεία του αιτίου και η ασφαλής υποστηρικτική διαχείριση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το **υποδραστήριο ντελίριο**, που μπορεί να εμφανίζεται ως μειωμένη δραστηριότητα και ήσυχη απόσυρση αντί για διέγερση.

Η έναρξη είναι συνήθως μέσα σε ώρες έως ημέρες και η εικόνα μεταβάλλεται στη διάρκεια του 24ώρου. Η διαταραχή της προσοχής είναι κεντρική: ο ασθενής αποσπάται εύκολα, δεν διατηρεί ή δεν μετατοπίζει σωστά την προσοχή του και μπορεί να έχει μεταβαλλόμενη επίγνωση του περιβάλλοντος. Συνοδά γνωστικά ή αντιληπτικά φαινόμενα είναι συχνά. Το ντελίριο μπορεί να είναι υπερδραστήριο, υποδραστήριο ή μικτό, άρα η διέγερση ούτε απαιτείται ούτε αρκεί για τη διάγνωση.

Η αξιολόγηση εστιάζει άμεσα στην αιτιολογία. Λαμβάνω ετεροαναφορικές πληροφορίες για το συνήθες γνωστικό και λειτουργικό επίπεδο και για τη χρονική εξέλιξη, ανασκοπώ όλα τα συνταγογραφούμενα και μη φάρμακα και την έκθεση σε ουσίες και κάνω σωματική και νευρολογική εξέταση. Συχνές αιτίες ή συνεισφέροντες παράγοντες είναι λοίμωξη, υποξία, αφυδάτωση ή μεταβολικές διαταραχές, πόνος, δυσκοιλιότητα ή επίσχεση ούρων, φαρμακευτικές επιδράσεις, τοξίκωση ή στέρηση, αισθητηριακή έκπτωση και μεταβολές του περιβάλλοντος. Οι εξετάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και όχι το ίδιο μη επιλεκτικό πακέτο για όλους.

Για **ανίχνευση ντελίου** σε γενικό νοσοκομείο ή δομή μακροχρόνιας φροντίδας, το πρακτικό σημείο αναφοράς είναι το 4AT. Βαθμολογία ≥ 4 υποδηλώνει πιθανό ντελίριο και/ή γνωστική έκπτωση και πρέπει να οδηγεί σε κλινική αξιολόγηση· δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση. Σε ΜΕΘ ή στην ανάνηψη μετά από αναισθησία / μεταναίσθητική ανάνηψη, τα CAM-ICU ή ICDSC μπορεί να είναι καταλληλότερα. Το κλασικό CAM παραμένει έγκυρο σε άλλα πλαίσια, αλλά η τρέχουσα γενική νοσοκομειακή πρακτική NICE επικεντρώνεται στο 4AT.

Η αντιμετώπιση βασίζεται στη **θεραπεία των εκλυτικών παραγόντων και την υποστηρικτική φροντίδα**. Βελτιστοποιώ ενυδάτωση και θρέψη, κινητοποιώ όπου είναι δυνατόν, εξασφαλίζω γυαλιά και ακουστικά βοηθήματα, διατηρώ φυσιολογικά ερεθίσματα ημέρας-νύχτας και ύπνου-εγρήγορσης, επαναπροσανατολίζω τακτικά, εμπλέκω οικεία πρόσωπα, αποφεύγω περιττές μετακινήσεις και περιορισμούς όπου είναι εφικτό και διατηρώ ήρεμο, ασφαλές περιβάλλον χωρίς υπερδιέγερση ή αισθητηριακή αποστέρηση.

Τα αντιψυχωσικά δεν θεραπεύουν το υποκείμενο ντελίριο. Εξετάζονται μόνο όταν υπάρχει έντονη δυσφορία ή σημαντικός κίνδυνος και η αποκλιμάκωση ή άλλα μη φαρμακευτικά μέτρα έχουν αποτύχει ή δεν είναι κατάλληλα. Αν χρειαστεί αλοπεριδόλη, χρησιμοποιείται χαμηλή δόση για το συντομότερο δυνατό διάστημα, συνήθως όχι περισσότερο από περίπου μία εβδομάδα στο πλαίσιο NICE. Η νόσος Parkinson και η άνοια με σωμάτια Lewy αποτελούν βασικές αντενδείξεις στην τρέχουσα καθοδήγηση ασφάλειας της αλοπεριδόλης.

Οι βενζοδιαζεπίνες δεν αποτελούν routine θεραπεία του ντελίου, αλλά μπορεί να είναι κατάλληλες όταν η υποκείμενη κατάσταση είναι **στέρηση αλκοόλ/κατασταλτικών ή κατατονία**. Αυτό αναδεικνύει γιατί πρέπει να θεραπεύουμε την αιτία και όχι γενικά «τη διέγερση».

Οι κύριες διαφορικές είναι άνοια, κατάθλιψη, πρωτοπαθής ψύχωση και μερικές φορές κατατονία. Η άνοια είναι συνήθως πιο ύπουλη και προοδευτική, η κατάθλιψη δεν προκαλεί τυπικά οξύ διακυμαινόμενο σύνδρομο απροσεξίας, και στην πρωτοπαθή ψύχωση η προσοχή και η συνείδηση είναι συνήθως σαφέστερες. Οξεία έναρξη + διακύμανση + διαταραχή προσοχής πρέπει να ανεβάζουν άμεσα το ντελίριο στη διαφορική.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **4AT ≥ 4 :** πιθανό ντελίριο και/ή γνωστική έκπτωση· ενεργοποιεί κλινική αξιολόγηση αλλά **δεν αποτελεί διάγνωση**.
- **NICE γενικό νοσοκομείο/μακροχρόνια φροντίδα:** 4AT ως βασικό εργαλείο ανίχνευσης όταν υπάρχουν ενδείξεις ντελίου.
- **ΜΕΘ/μεταναισθητική ανάνηψη:** CAM-ICU ή ICDSC.
- Τα αντιψυχωσικά **δεν θεραπεύουν το υποκείμενο ντελίριο**· χαμηλή, βραχύχρονη αλοπεριδόλη μόνο για σοβαρή δυσφορία/κίνδυνο όταν αποτύχει ή δεν ενδείκνυται η αποκλιμάκωση.
- **Νόσος Parkinson και DLB:** σημαντικές αντενδείξεις για αλοπεριδόλη στην τρέχουσα καθοδήγηση ασφάλειας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διαφυγή υποδραστήριου ντελίου.
- Διάγνωση ντελίου σε κάθε διεγερμένο ηλικιωμένο χωρίς οξεία διακυμαινόμενη απροσεξία.
- Θεώρηση του 4AT ≥ 4 ως διάγνωσης.
- Χρήση αντιψυχωσικού σαν να θεραπεύει ή να συντομεύει το ντελίριο.
- Χρήση του «sundowning» ως διαγνωστικού κριτηρίου.
- Routine βενζοδιαζεπίνες εκτός ειδικών ενδείξεων όπως στέρηση ή κατατονία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ενημέρωση ανίχνευσης: παλαιότερη διδασκαλία συχνά επικεντρωνόταν στο CAM. Στην τρέχουσα NICE πρακτική γενικού νοσοκομείου και μακροχρόνιας φροντίδας, το **4AT** είναι το κύριο σημείο αναφοράς όταν υπάρχουν ενδείξεις ντελίριου.

Πώς αξιολογείτε έναν ασθενή με υποψία μείζονος νευρογνωστικής διαταραχής / άνοιας;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ιστορικό και ετεροαναφορικές πληροφορίες
- 2 Έναρξη, πορεία και γνωστικό πρότυπο
- 3 Λειτουργική απώλεια στις ADLs/IADLs
- 4 Αποκλεισμός ντελίριου, κατάθλιψης και δευτεροπαθών αιτίων
- 5 Κλινική εξέταση και στοχευμένος έλεγχος
- 6 Δομική απεικόνιση για αιτιολογία/υπότυπο
- 7 Εξειδικευμένοι βιοδείκτες μόνο όταν αλλάζουν τη διαχείριση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αξιολόγηση άνοιας πρέπει να απαντά σε τέσσερα ερωτήματα: υπάρχει επίκτητη γνωστική έκπτωση, έχει περιορίσει την ανεξάρτητη λειτουργικότητα, τι υποδηλώνει η πορεία για την αιτιολογία και υπάρχουν αναστρέψιμοι ή επιβαρυντικοί παράγοντες; Η διάγνωση δεν τίθεται από μια βαθμολογία γνωστικής δοκιμασίας. Συνδυάζω ιστορικό του ασθενούς, ετεροαναφορικό ιστορικό, λειτουργική εκτίμηση, εξέταση ψυχικής κατάστασης και νευρολογική εξέταση, στοχευμένες εξετάσεις και δομική απεικόνιση.

Αρχικά διευκρινίζω την **έναρξη και την πορεία**: ύπουλη ή απότομη, προοδευτική ή διακυμαινόμενη, με τυχόν κλιμακωτές μεταβολές ή αλλαγές μετά από αγγειακό επεισόδιο. Οι **ετεροαναφορικές πληροφορίες** είναι συχνά απαραίτητες, επειδή η εναισθησία μπορεί να είναι περιορισμένη και ο ασθενής να υποεκτιμά τη λειτουργική έκπτωση. Οργανώνω τη γνωστική εικόνα σε προσοχή, εκτελεστικές λειτουργίες, μάθηση και μνήμη, γλώσσα, αντιληπτικοκινητική/οπτικοχωρική λειτουργία και κοινωνική γνώση, ενώ διερευνώ και συμπεριφορικά ή νευροψυχιατρικά συμπτώματα.

Το κρίσιμο διαγνωστικό βήμα είναι η **λειτουργική επίπτωση**. Αξιολογώ βασικές δραστηριότητες καθημερινής ζωής και ιδιαίτερα σύνθετες δραστηριότητες όπως διαχείριση φαρμάκων, οικονομικών, μαγείρεμα, μετακινήσεις και άλλα σύνθετα καθήκοντα. Η **έκπτωση που περιορίζει την ανεξάρτητη καθημερινή λειτουργικότητα** είναι το βασικό διαχωριστικό σημείο ανάμεσα στην άνοια/major neurocognitive disorder και σε ηπιότερη γνωστική διαταραχή.

Αναζητώ ενεργά **εναλλακτικές ή συνεισφέρουσες αιτίες**. Το ντελίριο πρέπει να αποκλείεται όταν υπάρχει οξεία διακύμανση ή απροσεξία, και ένα μείζον καταθλιπτικό σύνδρομο μπορεί να μιμηθεί ή να επιβαρύνει τη γνωστική εικόνα. Ελέγχω φαρμακευτική επιβάρυνση, ιδίως αντιχολινεργικά, αλκοόλ και άλλες ουσίες, καθώς και σωματικά ή νευρολογικά νοσήματα. Η σωματική και νευρολογική εξέταση μπορεί να αναδείξει εστιακά σημεία, παρκινσονισμό, διαταραχή βάδισης ή άλλα στοιχεία που κατευθύνουν τον υπότυπο ή δευτεροπαθή αιτία.

Μια σταθμισμένη σύντομη γνωστική δοκιμασία είναι χρήσιμη, αλλά **φυσιολογική**

σύντομη βαθμολογία δεν αποκλείει άνοια όταν το ιστορικό και η λειτουργικότητα είναι ύποπτα. MoCA, MMSE, ACE-III και παρόμοια εργαλεία είναι **εργαλεία ανίχνευσης ή σύντομης γνωστικής αξιολόγησης**, με επίδοση που εξαρτάται από ηλικία, εκπαίδευση, γλώσσα, πολιτισμικό πλαίσιο και setting. Δεν διαγιγνώσκω ή αποκλείω major NCD με ένα μόνο cut-off όπως MoCA <26 ή MMSE <24. Επίσημη νευροψυχολογική αξιολόγηση βοηθά όταν η διάγνωση ή ο υπότυπος παραμένουν αβέβαιοι, τα ελλείμματα είναι λεπτά ή χρειάζεται ακριβέστερο γνωστικό προφίλ.

Ο παρακλινικός έλεγχος είναι στοχευμένος και όχι ένα υποχρεωτικό ενιαίο panel. Ζητώ εξετάσεις αίματος ή ούρων για εύλογες αναστρέψιμες ή συνεισφέρουσες αιτίες ανάλογα με το κλινικό πλαίσιο και συνήθως οργανώνω **δομική απεικόνιση εγκεφάλου**, εκτός αν η διάγνωση και ο υπότυπος είναι ήδη σαφείς. MRI προτιμάται όταν έχει σημασία το αγγειακό φορτίο ή η λεπτομέρεια του υποτύπου· CT είναι αποδεκτή όταν η MRI δεν είναι διαθέσιμη ή αντενδείκνυται.

Οι εξειδικευμένοι βιοδείκτες έχουν αυξημένο ρόλο σε επιλεγμένα περιστατικά, ιδίως όταν η νόσος Alzheimer παραμένει αβέβαιη ή εξετάζεται disease-modifying anti-amyloid θεραπεία. CSF amyloid/tau και επικυρωμένοι **βιοδείκτες πλάσματος** μπορούν να ενισχύσουν την αιτιολογική βεβαιότητα στο κατάλληλο σύνδρομο, αλλά **συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν** την ολοκληρωμένη κλινική εκτίμηση και τη δομική απεικόνιση.

Η αξιολόγηση κλείνει με πρακτικό σχεδιασμό κινδύνου και φροντίδας: οδήγηση, ασφάλεια φαρμάκων και οικονομικών, ικανότητα λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων, safeguarding και υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών ανάλογα με το άτομο και τη δικαιοδοσία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η λειτουργική απώλεια έχει μεγαλύτερη σημασία από μία βαθμολογία: ο περιορισμός της ανεξάρτητης λειτουργικότητας διαχωρίζει dementia/major NCD από ηπιότερη γνωστική έκπτωση.
- MoCA, MMSE και ACE-III cut-offs δεν είναι διαγνωστικά όρια.
- Φυσιολογικό σύντομο γνωστικό test δεν αποκλείει άνοια.
- Δεν διδάσκουμε ένα ενιαίο «reversible dementia panel»· ο έλεγχος στοχεύει εύλογες αναστρέψιμες/συνεισφέρουσες αιτίες.
- Οι plasma Alzheimer biomarkers εισέρχονται στην εξειδικευμένη πρακτική αλλά δεν υποκαθιστούν καθολικά την κλινική εκτίμηση ή τη δομική απεικόνιση.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση άνοιας από screening score μόνο.
- MoCA <26 ή MMSE <24 ως διαγνωστικά κριτήρια.
- Παράλειψη ετεροαναφορικού ιστορικού ή λειτουργικής έκπτωσης.
- Ένα σταθερό εργαστηριακό panel ανεξάρτητα από το κλινικό πλαίσιο.
- Βιοδείκτες πριν από ολοκληρωμένη κλινική εκτίμηση.
- Παρουσίαση του όρου «major neurocognitive disorder» ως μοναδικής τρέχουσας ορολογίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ορολογία: «major neurocognitive disorder» είναι όρος DSM. Η άνοια παραμένει τρέχουσα κλινική ορολογία και το ICD-11 διατηρεί διαγνώσεις άνοιας οργανωμένες κατά αιτιολογία.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε τη νόσο Alzheimer;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Υπουλο, προοδευτικό αμνησικό σύνδρομο
- 2 Λειτουργική έκπτωση και αποκλεισμός μιμητών
- 3 Βιοδείκτες όταν χρειάζονται για διαγνωστική βεβαιότητα ή επιλογή θεραπείας
- 4 Αναστολέας AChE ± μεμαντίνη για συμπτωματική θεραπεία
- 5 Υποστήριξη λειτουργικότητας, ασφάλειας και φροντιστών
- 6 Αντι-αμυλοειδική θεραπεία μόνο σε επιλεγμένη πρώιμη νόσο με επιβεβαιωμένο αμυλοειδές
- 7 ARIA και MRI ως βασικά ζητήματα ασφάλειας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η νόσος Alzheimer είναι τυπικά ένα ύπουλο και προοδευτικό νευρογνωστικό σύνδρομο, που συχνά αρχίζει με διαταραχή της νέας μάθησης και της επεισοδιακής μνήμης και στη συνέχεια επεκτείνεται σε άλλες φλοιώδεις λειτουργίες. Η διάγνωση παραμένει κλινική και λειτουργική, με υποστήριξη από ετεροαναφορικό ιστορικό, εξέταση, απεικόνιση και βιοδείκτες όταν χρειάζονται. Η θεραπεία συνδυάζει συμπτωματική γνωστική αγωγή, υποστήριξη της ασφάλειας και των φροντιστών και, πλέον, αντι-αμυλοειδική θεραπεία μόνο σε προσεκτικά επιλεγμένη πρώιμη νόσο.

Η τυπική εικόνα είναι σταδιακή έκπτωση της πρόσφατης μνήμης και της ικανότητας απόκτησης νέων πληροφοριών. Με την εξέλιξη μπορεί να επηρεαστούν η γλώσσα, η πράξη, η αναγνώριση, οι οπτικοχωρικές λειτουργίες και οι εκτελεστικές ικανότητες. Για διάγνωση σε επίπεδο άνοιας είναι ουσιώδης η λειτουργική έκπτωση, γι' αυτό διερευνώ πώς η γνωστική διαταραχή επηρεάζει τη διαχείριση φαρμάκων και οικονομικών, τις οικιακές εργασίες και άλλες καθημερινές δραστηριότητες, όχι μόνο το αποτέλεσμα γνωστικών δοκιμασιών.

Η διαφορική περιλαμβάνει άνοια με σωματίδια Lewy, μετωποκροταφική άνοια, αγγειακή γνωστική διαταραχή, κατάθλιψη και ντελίριο. Το ντελίριο χαρακτηρίζεται περισσότερο από οξεία διακύμανση και διαταραχή της προσοχής παρά από σταθερά προοδευτική πορεία. Η αιτιολογική εκτίμηση συνθέτει επομένως το πρότυπο έκπτωσης, τη νευρολογική εξέταση και τη δομική απεικόνιση.

Κλασικά, η παθολογία της νόσου Alzheimer περιλαμβάνει αμυλοειδικές πλάκες και παθολογία tau. Οι βιοδείκτες μπορούν να τεκμηριώσουν αμυλοειδική και tau παθολογία και να αυξήσουν την αιτιολογική βεβαιότητα όταν ο φαινότυπος είναι άτυπος ή αβέβαιος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικοί όταν εξετάζεται αντι-αμυλοειδική θεραπεία. Θετικός βιοδείκτης όμως δεν ισοδυναμεί από μόνος του με κλινική άνοια· ερμηνεύεται μέσα στο κλινικό σύνδρομο και τη λειτουργική αξιολόγηση.

Για συμπτωματική θεραπεία, **donepezil, rivastigmine και galantamine** είναι καθιερωμένες επιλογές για ήπια έως μέτρια νόσο Alzheimer. **Donepezil και**

galantamine είναι αναστρέψιμοι αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης, ενώ η **rivastigmine** αναστέλλει τόσο την ακετυλοχολινεστεράση όσο και τη βουτυρυλοχολινεστεράση. Ενισχύουν τη χολινεργική σηματοδότηση αλλά δεν αναστρέφουν τη νευροεκφυλιστική διεργασία.

Η μεμαντίνη είναι μη συναγωνιστικός ως προς τη θέση σύνδεσης (**uncompetitive**) ανταγωνιστής NMDA υποδοχέων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέτρια νόσο όταν οι αναστολείς AChE αντενδείκνυνται ή δεν είναι ανεκτοί και σε σοβαρή νόσο· σε μέτρια ή σοβαρή νόσο μπορεί επίσης να συνδυαστεί με αναστολέα AChE σύμφωνα με την τρέχουσα καθοδήγηση. Η φροντίδα περιλαμβάνει επίσης καθημερινή λειτουργικότητα, ρουτίνες, συννοσηρότητα, ασφάλεια, οδήγηση ή οικονομικά όπου είναι σχετικά και εκπαίδευση/υποστήριξη φροντιστών.

Σημαντική σύγχρονη εξέλιξη είναι τα **lecanemab** και **donanemab**. Στην ΕΕ έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς με πρώιμη συμπτωματική νόσο Alzheimer — ήπια γνωστική διαταραχή ή ήπια άνοια λόγω Alzheimer — με επιβεβαιωμένη παθολογία αμυλοειδούς, και η τρέχουσα ευρωπαϊκή ένδειξη εξαιρεί τους **ομοζυγώτες APOE ε4**. Οι θεραπείες αυτές **επιβραδύνουν σε μέτριο βαθμό την έκπτωση**· δεν αναστρέφουν εγκατεστημένη άνοια ούτε αποκαθιστούν χαμένη λειτουργία.

Η χρήση τους είναι εξειδικευμένη και απαιτεί εντατική παρακολούθηση ασφάλειας. Τα **ARIA-E** και **ARIA-H** είναι βασικές ανεπιθύμητες ενέργειες και απαιτούν παρακολούθηση με MRI. Η συχνότητα ARIA διαφέρει ανά προϊόν, μελέτη και γονότυπο, επομένως δεν υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό που να αποτελεί καθολικό κίνδυνο της κατηγορίας. Η ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας επίσης δεν σημαίνει αυτόματα routine πρόσβαση, αποζημίωση ή διαθεσιμότητα στην Ελλάδα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Donepezil/galantamine**: αναστρέψιμοι αναστολείς AChE.
- **Rivastigmine**: αναστολή AChE και BuChE.
- **Memantine**: **uncompetitive** ανταγωνιστής NMDA υποδοχέων.
- Οι βιοδείκτες Alzheimer αυξάνουν την **αιτιολογική βεβαιότητα**, αλλά δεν αντικαθιστούν την κλινική/λειτουργική διάγνωση.
- **Lecanemab** και **donanemab**: ευρωπαϊκή άδεια για επιλεγμένη πρώιμη νόσο Alzheimer με επιβεβαιωμένο αμυλοειδές· η τρέχουσα ευρωπαϊκή χρήση εξαιρεί τους **APOE ε4 ομοζυγώτες**.
- **ARIA-E/ARIA-H**: καθοριστικά ζητήματα ασφάλειας με ανάγκη MRI· δεν απομνημονεύουμε ένα καθολικό ποσοστό επίπτωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q47a. Τι κάνουν στην πράξη οι αναστολείς χολινεστεράσης και η μεμαντίνη;

Οι αναστολείς χολινεστεράσης αυξάνουν τη **συναπτική ακετυλοχολίνη μειώνοντας την ενζυμική διάσπασή της**· η **rivastigmine** αναστέλλει επιπλέον και τη βουτυρυλοχολινεστεράση. Η μεμαντίνη είναι **uncompetitive** ανταγωνιστής NMDA υποδοχέων και τροποποιεί παθολογική γλουταματεργική σηματοδότηση. Είναι συμπτωματικές γνωστικές θεραπείες· καμία δεν πρέπει να περιγράφεται ως

θεραπεία που σταματά ή αναστρέφει την παθολογία Alzheimer.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει καθόλου disease-modifying θεραπεία.
- Παρουσίαση των anti-amyloid θεραπειών ως routine για κάθε Alzheimer ή για μέτρια/σοβαρή άνοια.
- Ταύτιση ευρωπαϊκής άδειας κυκλοφορίας με routine ελληνική διαθεσιμότητα ή αποζημίωση.
- Θεώρηση θετικού βιοδείκτη ως ολόκληρης της διάγνωσης.
- Παρουσίαση AChE inhibitors ή memantine ως disease-modifying.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Τροποποίηση νόσου: η παλαιότερη διδασκαλία ότι δεν υπάρχει καμία disease-modifying θεραπεία δεν είναι πλέον κυριολεκτικά τρέχουσα. Anti-amyloid θεραπεία είναι διαθέσιμη για **περιορισμένο πληθυσμό πρώιμης νόσου**, με μέτριο disease-slowing όφελος και σημαντικές απαιτήσεις ασφάλειας· δεν είναι ιάσιμη θεραπεία.

Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την άνοια με σωμάτια Lewy από την άνοια στη νόσο Parkinson;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Διακυμαινόμενη γνωστική λειτουργία
- 2 Υποτροπιάζουσες, καλοσχηματισμένες οπτικές ψευδαισθήσεις
- 3 Αυτόματα εμφανιζόμενος παρκινσονισμός
- 4 Διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM (RBD)
- 5 Σοβαρή ευαισθησία στα αντιψυχωσικά
- 6 Κανόνας του 1 έτους ως ταξινομική σύμβαση
- 7 Αναστολείς χολινεστεράσης όπου ενδείκνυνται

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η άνοια με σωμάτια Lewy (DLB) και η άνοια στη νόσο Parkinson (PDD) είναι στενά συγγενείς διαταραχές του φάσματος των Lewy bodies και διακρίνονται κυρίως από τη χρονική σχέση της άνοιας με τον παρκινσονισμό. Η DLB αναγνωρίζεται από χαρακτηριστικό γνωστικό προφίλ και τέσσερα πυρηνικά κλινικά χαρακτηριστικά, ενώ ο κανόνας του ενός έτους χρησιμοποιείται πρακτικά για ταξινόμηση και όχι ως βιολογικό όριο. Η ευαισθησία στα αντιψυχωσικά αποτελεί σημαντικό ζήτημα ασφάλειας, ιδιαίτερα στην DLB.

Το γνωστικό προφίλ της DLB μπορεί να είναι λιγότερο αμιγώς αμνησικό από της νόσου Alzheimer, με σημαντικές δυσκολίες στην προσοχή, τις εκτελεστικές λειτουργίες και την οπτικοαντιληπτική επεξεργασία. Τα τέσσερα πυρηνικά χαρακτηριστικά είναι **διακυμαινόμενη γνωστική λειτουργία, υποτροπιάζουσες καλοσχηματισμένες οπτικές ψευδαισθήσεις, παρκινσονισμός που εμφανίζεται αυθόρμητα και διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM**. Η RBD έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή μπορεί να προηγείται της γνωστικής έκπτωσης κατά χρόνια και αποτελεί πλέον πυρηνικό χαρακτηριστικό και όχι απλώς υποστηρικτικό στοιχείο.

Πρόσθετα στοιχεία μπορεί να είναι πτώσεις, συγκοπτικά ή ορθοστατικά επεισόδια και άλλη δυσλειτουργία του αυτονόμου. Όταν η διάγνωση παραμένει αβέβαιη, ορισμένοι **ενδεικτικοί βιοδείκτες** μπορούν να την υποστηρίξουν: μειωμένη πρόσληψη στον μεταφορέα ντοπαμίνης του ραβδωτού σώματος, χαμηλή καρδιακή πρόσληψη MIBG και πολυυπνογραφική τεκμηρίωση ύπνου REM χωρίς ατονία. Οι εξετάσεις αυτές έχουν περιορισμούς και **υποστηρίζουν αλλά δεν αντικαθιστούν** το κλινικό σύνδρομο.

Η πρακτική διάκριση από την PDD χρησιμοποιεί τη σύμβαση του ενός έτους. Αν η άνοια εμφανιστεί πριν, ταυτόχρονα ή εντός ενός έτους από τον παρκινσονισμό, ταξινομείται ως DLB. Αν εμφανιστεί μετά από ήδη εγκατεστημένη νόσο Parkinson και πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα, ταξινομείται ως PDD. Ο κανόνας βοηθά στην επικοινωνία και ταξινόμηση, αλλά **δεν αποτελεί βιολογικά επικυρωμένο διαχωριστικό όριο**· οι δύο καταστάσεις ανήκουν σε φάσμα Lewy-body disease.

Η θεραπεία στοχεύει τη γνωστική και νευροψυχιατρική επιβάρυνση,

αποφεύγοντας παράλληλα φάρμακα που επιδεινώνουν κίνηση ή γνωστική λειτουργία. **Donepezil ή rivastigmine** είναι καθιερωμένες επιλογές για ήπια έως μέτρια DLB, ενώ η μεμαντίνη μπορεί να εξεταστεί όταν οι αναστολείς AChE δεν είναι ανεκτοί ή αντενδείκνυνται. Αναστολή χολινεστεράσης χρησιμοποιείται και στην PDD, ιδιαίτερα με rivastigmine.

Μείζον σημείο ασφάλειας είναι η **σοβαρή ευαισθησία στα αντιψυχωσικά**. Ισχυρός αποκλεισμός D2 μπορεί να προκαλέσει σημαντική επιδείνωση, επομένως αντιψυχωσικά δεν χορηγούνται αδιάκριτα στην DLB. Ο κίνδυνος νοσηρότητας και θνησιμότητας είναι κλινικά σημαντικός, αλλά δεν απομνημονεύουμε έναν παλαιό σταθερό πολλαπλασιαστή ως καθολική αλήθεια. Αν υπάρχουν ψυχωσικά συμπτώματα, προηγείται έλεγχος για ντελίριο, σωματικά εκλυτικά αίτια και φαρμακευτικούς παράγοντες και, μόνο αν τα συμπτώματα είναι δυσφορικά ή επικίνδυνα, εξετάζεται εξειδικευμένη θεραπεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Τέσσερα πυρηνικά χαρακτηριστικά DLB: **διακυμαινόμενη γνωστική λειτουργία, υποτροπιάζουσες οπτικές ψευδαισθήσεις, αυθόρμητος παρκινσονισμός, RBD.**
- Ο κανόνας του 1 έτους είναι λειτουργική ταξινομική σύμβαση, όχι βιολογικό όριο.
- Ενδεικτικοί βιοδείκτες: μειωμένη πρόσληψη DAT στο ραβδωτό, χαμηλή καρδιακή πρόσληψη MIBG, PSG-τεκμηριωμένος REM ύπνος χωρίς ατονία.
- Η **σοβαρή ευαισθησία στα αντιψυχωσικά** είναι κρίσιμο safety point· δεν χρησιμοποιούμε καθολικό mortality multiplier.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς προσεγγίζετε τις οπτικές ψευδαισθήσεις στη νόσο Parkinson;

Πρώτα αποκλείω ντελίριο, λοίμωξη, μεταβολική διαταραχή, φαρμακευτική τοξικότητα και οπτική ή άλλη αισθητηριακή έκπτωση. Αν οι ψευδαισθήσεις είναι ανεκτές και δεν προκαλούν δυσφορία ή κίνδυνο, δεν απαιτείται αυτόματα φαρμακοθεραπεία.

Επανεξετάζω πιθανά επιβαρυντικά αντιπαρκινσονικά φάρμακα με ειδικό Parkinson, σταθμίζοντας πιθανή βελτίωση της ψύχωσης έναντι κινητικής επιδείνωσης και κινδύνου στέρησης. Αν χρειαστεί αντιψυχωσικό, **quetiapine** μπορεί να εξεταστεί σε επιλεγμένους ασθενείς χωρίς γνωστική έκπτωση, αν και η τεκμηρίωσή της είναι ασθενέστερη από της clozapine. **Clozapine** είναι η τεκμηριωμένη specialist επιλογή όταν αποτυγχάνει η συνήθης θεραπεία και απαιτεί υποχρεωτική αιματολογική παρακολούθηση· οι δόσεις είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες της σχιζοφρένειας.

Αποφεύγω olanzapine και έντονο D2 αποκλεισμό λόγω κινητικής επιδείνωσης. Η **primavanserin** δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως routine ευρωπαϊκή ή ελληνική φροντίδα· είναι κυρίως αμερικανική επιλογή και δεν υπάρχει καθιερωμένη κεντρική ευρωπαϊκή άδεια για Parkinson psychosis.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων από αγωνιστές ντοπαμίνης;

Τυπικές συμπεριφορές είναι τζόγος, υπερσεξουαλικότητα, καταναγκαστικές αγορές/δαπάνες και binge eating. Punding και dopamine dysregulation syndrome είναι συγγενή καταναγκαστικά ή reward-related φαινόμενα αλλά δεν απαιτούνται για τον ορισμό.

Οι αγωνιστές ντοπαμίνης είναι σημαντικός φαρμακευτικός παράγοντας κινδύνου. Η μεσομεταιχμιακή και D3-related φαρμακολογία είναι σχετική, αλλά δεν αποτελεί πλήρη μονοϋποδοχειακή αιτιολογική εξήγηση. Ρωτώ ενεργά και αναζητώ ετεροαναφορικές πληροφορίες, επειδή ο ασθενής μπορεί να αποκρύπτει ή να υποβαθμίζει τις συμπεριφορές λόγω ντροπής. Πρώτη θεραπευτική κίνηση είναι **σταδιακή μείωση του αγωνιστή ντοπαμίνης υπό ειδική καθοδήγηση**, όπου είναι εφικτό. Δεν διακόπτεται απότομα λόγω κινδύνου dopamine agonist withdrawal syndrome. Αν η φαρμακευτική προσαρμογή δεν επαρκεί, μπορεί να εξεταστεί specialist CBT στοχευμένη στη συγκεκριμένη διαταραχή ελέγχου παρορμήσεων.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διδασκαλία μόνο της παλαιάς τριάδας DLB και παράλειψη της RBD.
- Αντιμετώπιση του 1-year rule ως βιολογικά αποδεδειγμένου.
- Βιοδείκτης ως υποκατάστατο του κλινικού συνδρόμου.
- Καθολικός mortality multiplier για neuroleptic sensitivity.
- Αδιάκριτη χρήση ισχυρών D2 blockers στην DLB.
- Άμεσο αντιψυχωσικό σε Parkinson hallucinations πριν από έλεγχο ντελίριου/φαρμάκων.
- Απότομη διακοπή αγωνιστή ντοπαμίνης ή ηθικοποίηση συμπεριφοράς που εμφανίστηκε κατά τη θεραπεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

DLB: η παλαιότερη διδασκαλία συχνά παρουσίαζε πυρηνική τριάδα και RBD ως υποστηρικτικό στοιχείο. Η σύγχρονη συναίνεση περιλαμβάνει την **RBD ως ένα από τα τέσσερα πυρηνικά κλινικά χαρακτηριστικά**.

Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τη μετωποκροταφική άνοια;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Πρώιμη μεταβολή συμπεριφοράς/προσωπικότητας
- 2 Άρση αναστολών, απάθεια, μειωμένη ενσυναίσθηση
- 3 Στερεοτυπίες, καταναγκαστικότητα, υπερστοματικότητα
- 4 Εκτελεστική δυσλειτουργία και γλωσσικές παραλλαγές
- 5 Απεικόνιση ως υποστήριξη της κλινικής διάγνωσης
- 6 Όχι routine φάρμακα Alzheimer
- 7 Συμπτωματική και υποστηρικτική αντιμετώπιση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μετωποκροταφική άνοια, ιδιαίτερα η συμπεριφορική παραλλαγή (bvFTD), συχνά αρχίζει με **επίκτητη αλλαγή προσωπικότητας, συμπεριφοράς και εκτελεστικής λειτουργίας και όχι με κυρίαρχο αμνησικό σύνδρομο**. Το κλειδί είναι η αναγνώριση ενός προοδευτικού συμπεριφορικού-εκτελεστικού προτύπου, η διάκρισή του από πρωτοπαθή ψυχιατρική νόσο και Alzheimer και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και της ασφάλειας χωρίς αυτόματη μεταφορά των συνήθων φαρμάκων της Alzheimer.

Πρώιμα χαρακτηριστικά είναι η **άρση αναστολών**, κοινωνικά απρόσφορη συμπεριφορά ή απώλεια κοινωνικών φραγμών, **απάθεια ή αδράνεια**, μειωμένη ενσυναίσθηση, εμμένουσες/στερεότυπες/καταναγκαστικές συμπεριφορές και **υπερστοματικότητα ή αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες**. Η εκτελεστική δυσλειτουργία είναι συχνή. Μπορούν επίσης να εμφανιστούν γλωσσικές παραλλαγές· στην προφορική εξέταση είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η FTD μπορεί να ξεκινήσει ως συμπεριφορικό ή γλωσσικό σύνδρομο.

Η σχετική διατήρηση επεισοδιακής μνήμης και οπτικοχωρικής λειτουργίας είναι συχνό πρώιμο πρότυπο αλλά **όχι απόλυτος κανόνας**. Διαταραχή μνήμης δεν αποκλείει bvFTD.

Η ψυχιατρική διαφορική είναι κρίσιμη. Μανία μπορεί να προκαλέσει άρση αναστολών, κατάθλιψη απάθεια και μακροχρόνια χαρακτηριστικά προσωπικότητας να μοιάζουν με το σύνδρομο. Η διάκριση βασίζεται σε **προοδευτική επίκτητη αλλαγή από την προηγούμενη προσωπικότητα και λειτουργικότητα**, με ετεροαναφορικό ιστορικό και συνολική νευρολογική/γνωστική πορεία. Η Alzheimer παραμένει σημαντική διαφορική όταν προεξάρχει η μνήμη ή η οπτικοχωρική έκπτωση.

Η MRI μπορεί να δείξει **μετωπιαία ή πρόσθια κροταφική ατροφία**. FDG-PET ή SPECT αιμάτωσης μπορεί να υποστηρίξουν τη διάγνωση όταν υπάρχει αβεβαιότητα. Φυσιολογική απεικόνιση από μόνη της δεν αποκλείει FTD όταν το κλινικό σύνδρομο είναι πειστικό.

Το οικογενειακό ιστορικό έχει σημασία, επειδή η γενετική FTD είναι σημαντική. Εξεταστικά χρήσιμα γονίδια είναι **C9orf72, MAPT και GRN**, χωρίς να

απομνημονεύουμε ένα καθολικό ποσοστό αυτοσωμικής επικρατούς νόσου ή ένα «πιο συχνό» γονίδιο για όλους τους πληθυσμούς. Γενετική συμβουλευτική και έλεγχος ανήκουν σε εξειδικευμένο πλαίσιο.

Δεν υπάρχει καθιερωμένη disease-modifying ή γνωστικοενισχυτική φαρμακοθεραπεία. Αναστολείς ακετυλοχολινεστεράσης και μεμαντίνη δεν χορηγούνται **routine** απλώς επειδή υπάρχει άνοια. Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. **SSRIs** ή **trazodone** μπορούν off-label να χρησιμοποιηθούν σε επιλεγμένα συμπεριφορικά συμπτώματα όπως άρση αναστολών, καταναγκαστικότητα, ευερεθιστότητα ή υπερστοματικότητα, αλλά η τεκμηρίωση είναι περιορισμένη και δεν αποτελούν θεραπεία της νόσου.

Κεντρικές είναι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις: εκπαίδευση φροντιστών, περιβαλλοντικές και συμπεριφορικές στρατηγικές, σχεδιασμός ασφάλειας και πολυεπιστημονική υποστήριξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η πρώιμη διατήρηση επεισοδιακής μνήμης είναι **συχνή αλλά όχι απαραίτητη**.
- **C9orf72, MAPT, GRN**: βασικά γονίδια οικογενούς FTD.
- **AChE inhibitors** και **memantine** δεν προσφέρονται **routine** στην FTD.
- **SSRIs/trazodone**: off-label για επιλεγμένα συμπεριφορικά συμπτώματα, όχι disease-modifying θεραπεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q49a. Πότε μπαίνει η γενετική στην εκτίμηση;

Εξετάζω specialist genetic counselling/testing ιδιαίτερα σε **ισχυρό οικογενειακό ιστορικό**, πρώιμη έναρξη προοδευτικής νόσου ή **φαινότυπο που υποδηλώνει γενετικό φάσμα FTD**. Για νίνα, τα βασικά γονίδια είναι C9orf72, MAPT και GRN. Η συμβουλευτική πρέπει να εξηγεί ότι διεισδυτικότητα και φαινότυπος ποικίλλουν και ότι το αποτέλεσμα έχει συνέπειες για συγγενείς· δεν πρόκειται για πληθυσμιακό screening κάθε συμπεριφορικής εικόνας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Απόρριψη FTD επειδή υπάρχει διαταραχή μνήμης.
- Διάγνωση διπολικής/προσωπικότητας χωρίς να εξεταστεί προοδευτική επίκτητη αλλαγή.
- Αυτόματη χρήση φαρμάκων Alzheimer.
- Παρουσίαση SSRIs/trazodone ως καθιερωμένη θεραπεία της νόσου.
- Καθολικό ποσοστό κληρονομικότητας ή «πιο συχνό γονίδιο».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Θεραπεία: η γενική χορήγηση «αντιανοϊκών» φαρμάκων δεν είναι κατάλληλη στην FTD. Η σύγχρονη προσέγγιση είναι υποστηρικτική και συμπτωματοκεντρική, χωρίς routine AChE inhibitors ή memantine.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε την αγγειακή γνωστική διαταραχή / αγγειακή άνοια;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Σκεφτείτε το φάσμα VCI
- 2 Τεκμηριώστε κλινικά εύλογη αγγειακή σχέση
- 3 Εκτελεστική επιβράδυνση, εστιακά και βαδιστικά σημεία
- 4 Δομική απεικόνιση, αλλά όχι διάγνωση από την απεικόνιση μόνο
- 5 Η stepwise πορεία δεν είναι απαραίτητη
- 6 Συχνή μικτή Alzheimer/αγγειακή παθολογία
- 7 Αγγειακή πρόληψη όταν ενδείκνυται, αποκατάσταση και λειτουργικότητα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αγγειακή γνωστική διαταραχή (VCI) είναι **φάσμα γνωστικών διαταραχών που σχετίζονται με εγκεφαλοαγγειακή νόσο**, με την αγγειακή άνοια στο άκρο όπου έχει χαθεί η ανεξάρτητη λειτουργικότητα. Η διάγνωση απαιτεί πειστική σχέση μεταξύ του γνωστικού συνδρόμου και της αγγειακής εγκεφαλικής βλάβης· ούτε η κλιμακωτή πορεία ούτε οι αλλοιώσεις λευκής ουσίας επαρκούν μόνες τους. Η αντιμετώπιση εστιάζει στην ενδεδειγμένη αγγειακή πρόληψη, την αποκατάσταση, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια.

Η πορεία είναι μεταβλητή. Μπορεί να υπάρξει επιδείνωση μετά από γνωστό ΑΕΕ, κλασική **κλιμακωτή (stepwise) πορεία**, ή πιο σταδιακή εξέλιξη, ιδιαίτερα στη νόσο μικρών αγγείων. Άρα το stepwise pattern είναι χρήσιμο κλασικό στοιχείο αλλά όχι διαγνωστική προϋπόθεση.

Το γνωστικό προφίλ συχνά διαφέρει από το καθαρά αμνησικό πρότυπο Alzheimer. **Εκτελεστική δυσλειτουργία και επιβράδυνση επεξεργασίας πληροφοριών** μπορεί να είναι έντονες, ιδίως σε υποφλοιώδη ή μικροαγγειακή νόσο. Εστιακά νευρολογικά σημεία, διαταραχή βάδισης και αγγειακοί παράγοντες κινδύνου υποστηρίζουν τη διάγνωση όπου υπάρχουν, αλλά κανένα δεν είναι υποχρεωτικό.

Τεκμηριώνω τη χρονική σχέση αγγειακών συμβαμάτων και γνωστικής έκπτωσης, λαμβάνω **ετεροαναφορικό ιστορικό** και αξιολογώ τη λειτουργική επίπτωση. Η δομική απεικόνιση πρέπει να δείχνει **εγκεφαλοαγγειακό φορτίο συμβατό με το κλινικό σύνδρομο**. Ωστόσο, τα απεικονιστικά ευρήματα δεν αρκούν από μόνα τους, επειδή μπορεί να συνυπάρχουν με άλλη παθολογία ή να μην εξηγούν την έκταση και το πρότυπο της γνωστικής διαταραχής.

Στην πράξη η **μικτή παθολογία είναι συχνή**. Alzheimer και αγγειακή νόσος δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Όταν ο φαινότυπος υποστηρίζει και τις δύο, η διατύπωση πρέπει να το αναγνωρίζει αντί να επιβάλλει τεχνητό «είτε-είτε».

Η θεραπεία περιλαμβάνει **βελτιστοποίηση αγγειακών παραγόντων κινδύνου και δευτερογενή πρόληψη ΑΕΕ σύμφωνα με τις συνήθειες καρδιαγγειακές/εγκεφαλοαγγειακές ενδείξεις**, μαζί με αντιμετώπιση σχετικής συννοσηρότητας. Αντιαιμοπεταλιακά ή στατίνες δεν χορηγούνται απλώς επειδή η γνωστική διαταραχή χαρακτηρίστηκε «αγγειακή»· χρειάζεται η κανονική αγγειακή

ένδειξή τους. Η αποκατάσταση στοχεύει κινητικότητα, επικοινωνία, γνωστικές λειτουργίες, καθημερινή λειτουργικότητα και ασφάλεια ανάλογα με τα ελλείμματα.

Αναστολείς AChE και μεμαντίνη δεν αποτελούν routine θεραπεία της αμιγούς αγγειακής άνοιας. Μπορεί να είναι κατάλληλοι όταν υπάρχει συνυπάρχουσα ή μικτή νευροεκφυλιστική ένδειξη, όπως Alzheimer, PDD ή DLB. Ο θεραπευτικός κορμός της VCI παραμένει η πρόληψη περαιτέρω αγγειακής βλάβης όπου υπάρχει ένδειξη και η μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Stepwise decline:** κλασικό αλλά **όχι απαραίτητο**.
- **VCI** είναι ευρύτερη έννοια από vascular dementia.
- Αγγειακά απεικονιστικά ευρήματα **δεν αρκούν από μόνα τους** για διάγνωση.
- Αντιαιμοπεταλιακά, στατίνες και αντιυπερτασική θεραπεία ακολουθούν τις **συνήθειες αγγειακές ενδείξεις**.
- AChE inhibitors/memantine **όχι routine για αμιγή vascular dementia**· εξετάζονται όταν υπάρχει μικτή Alzheimer/PDD/DLB ένδειξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q50a. Τι είναι το CADASIL και ποιο απεικονιστικό πρότυπο το υποδηλώνει;

Το CADASIL είναι κληρονομική νόσος μικρών αγγείων που σχετίζεται με παθογόνες παραλλαγές του NOTCH3. Στο κατάλληλο κλινικό και οικογενειακό πλαίσιο, η προσβολή των **πρόσθιων κροταφικών πόλων και των έξω καψών** στη MRI είναι χαρακτηριστική και ενισχύει σημαντικά την υποψία, αλλά **δεν είναι παθογνωμονική**. Η διάγνωση συνδυάζει φαινότυπο, οικογενειακό ιστορικό και κατάλληλο γενετικό έλεγχο.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση vascular dementia μόνο από αλλοιώσεις λευκής ουσίας.
- Θεώρηση ότι σταδιακή πορεία αποκλείει VCI.
- Αντιμετώπιση Alzheimer και αγγειακής νόσου ως αμοιβαία αποκλειόμενων.
- Αντιαιμοπεταλιακά/στατίνες μόνο επειδή η άνοια λέγεται «αγγειακή».
- Routine AChE inhibitors/memantine στην αμιγή vascular dementia.
- Χαρακτηρισμός των πρόσθιων κροταφικών/έξω καψικών αλλοιώσεων CADASIL ως παθογνωμονικών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Εννοιολογική ενημέρωση: η παλαιότερη διδασκαλία υπερτόνιζε την κλιμακωτή πορεία. Η σύγχρονη VCI περιλαμβάνει post-stroke, stepwise, σταδιακές και μικτές πορείες.

Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα της άνοιας (BPSD);

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ορίστε τη συμπεριφορά και το πλαίσιο
- 2 Αναζητήστε πρώτα αναστρέψιμους παράγοντες
- 3 Εκτιμήστε κίνδυνο και επιβάρυνση φροντιστών
- 4 Προσωποκεντρικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις πρώτης γραμμής
- 5 Θεραπεία του συγκεκριμένου συνδρόμου, όχι γενική καταστολή
- 6 Αντιψυχωσικά μόνο για σοβαρή δυσφορία ή κίνδυνο βλάβης
- 7 Τακτική επανεκτίμηση και μείωση/διακοπή όπου είναι εφικτό

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα BPSD είναι συχνά, αλλά δεν αποτελούν μία ενιαία ένδειξη για καταστολή. Πρώτα ορίζω ακριβώς τη συμπεριφορά, αναζητώ αναστρέψιμους ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, εκτιμώ κίνδυνο και επιβάρυνση φροντιστών και εφαρμόζω προσωποκεντρικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Αντιψυχωσικά διατηρούνται για σοβαρή δυσφορία ή σημαντικό κίνδυνο βλάβης όταν το πιθανό όφελος υπερτερεί των αγγειακών εγκεφαλικών και θνησιμότητας κινδύνων.

Τα BPSD μπορεί να περιλαμβάνουν διέγερση ή επιθετικότητα, ψύχωση, κατάθλιψη ή άγχος, απάθεια, διαταραχή ύπνου, περιπλάνηση και άρση αναστολών. Περιγράφω συγκεκριμένα τι συμβαίνει, πότε, σε ποιο περιβάλλον, με ποιον, τι προηγείται και τι μειώνει τη συμπεριφορά. Συχνά έτσι αναδεικνύεται ένας αντιμετωπίσιμος εκλυτικός παράγοντας.

Πριν αποδώσω τη συμπεριφορά στην άνοια, αναζητώ ντελίριο, πόνο, λοίμωξη, δυσκοιλιότητα, επίσχεση ούρων, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, αισθητηριακή έκπτωση, διαταραχή ύπνου, περιβαλλοντικό στρες και ανεκπλήρωτες ανάγκες. Αιφνίδια επιθετικότητα λόγω πόνου ή ντελیریου απαιτεί θεραπεία του αιτίου, όχι απλώς ψυχοτρόπο.

Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει βλάβη προς τον ασθενή, φροντιστές ή τρίτους, μη ασφαλή περιπλάνηση και την επίπτωση των συμπτωμάτων στην αυτοχρησία και ικανότητα των φροντιστών. Λαμβάνω επίσης υπόψη συνήθειες ρουτίνες, τρόπο επικοινωνίας και προηγούμενες πηγές ανακούφισης ή ουσιαστικής δραστηριότητας.

Πρώτη γραμμή είναι **προσωποκεντρική μη φαρμακευτική αντιμετώπιση**: τροποποίηση περιβάλλοντος, μείωση εκλυτικών παραγόντων, οικείες ρουτίνες, ουσιαστική δραστηριότητα, καλύτερη επικοινωνία, διόρθωση αισθητηριακών ελλειμμάτων, βελτίωση ύπνου και άνεσης και υποστήριξη φροντιστών. Συννοσηρά σύνδρομα όπως κατάθλιψη, άγχος, πόνος ή διαταραχή ύπνου θεραπεύονται ειδικά και όχι με ένα κατασταλτικό φάρμακο για κάθε συμπεριφορά.

Τα αντιψυχωσικά δεν είναι **routine** θεραπεία των **BPSD**. Εξετάζονται μόνο όταν υπάρχει σοβαρή δυσφορία ή ουσιαστικός κίνδυνος βλάβης και τα μη φαρμακευτικά μέτρα έχουν αποτύχει ή δεν επαρκούν. Οι αγγειακοί εγκεφαλικοί και mortality κίνδυνοι συζητούνται ποιοτικά, όχι με έναν παλαιό καθολικό πολλαπλασιαστή. Αν χορηγηθεί αντιψυχωσικό, χρησιμοποιείται η **χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για τη συντομότερη δυνατή έκθεση**, με συχνή επανεκτίμηση και προσπάθεια μείωσης ή διακοπής όταν είναι κλινικά κατάλληλο.

Ειδικό licensing fact: η **ρισπεριδόνη** έχει βραχυχρόνια ένδειξη έως **6 εβδομάδες** για επίμονη επιθετικότητα σε μέτρια έως σοβαρή άνοια Alzheimer, αφού έχουν αποτύχει μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις και υπάρχει κίνδυνος βλάβης. Η δόση ακολουθεί την τρέχουσα **ΠΧΠ/SmPC**. Το όριο αυτό **δεν είναι καθολικός κανόνας 6 ή 6-12 εβδομάδων** για κάθε αντιψυχωσικό ή κάθε BPSD.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Αντιψυχωσικά στην άνοια αυξάνουν **κίνδυνο αγγειακών εγκεφαλικών συμβαμάτων και θνησιμότητας**: κρατάμε την προειδοποίηση χωρίς καθολικό fixed multiplier.
- **Ρισπεριδόνη**: έως **6 εβδομάδες** για επίμονη επιθετικότητα σε **μέτρια-σοβαρή Alzheimer dementia** μετά αποτυχία μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων και όταν υπάρχει κίνδυνος βλάβης: δόση σύμφωνα με ΠΧΠ/SmPC.
- Το licensing των 6 εβδομάδων **δεν είναι καθολικός κανόνας διάρκειας**.
- Χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, συντομότερη έκθεση, συχνή επανεκτίμηση και προσπάθεια διακοπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q51a. Πότε θα συνεχίζατε αντιψυχωσικό πέρα από την άμεση κρίση;

Μόνο αν η αρχική σοβαρή δυσφορία ή ο κίνδυνος βλάβης παραμένουν κλινικά σημαντικά και οι επανεκτιμήσεις δείχνουν ότι **το όφελος εξακολουθεί να υπερτερεί των αγγειακών εγκεφαλικών, mortality και λοιπών κινδύνων**. Πρέπει να υπάρχει σαφές σύμπτωμα-στόχος και πλάνο επανεκτίμησης. Δεν συνεχίζω επειδή «κάποτε βοήθησε» ούτε χρησιμοποιώ το licensing 6 εβδομάδων της ρισπεριδόνης ως προεπιλεγμένη διάρκεια άλλου φαρμάκου ή ένδειξης.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιψυχωσικό πριν από έλεγχο πόνου, ντελίριου, λοίμωξης, δυσκοιλιότητας ή επίσχεσης.
- Χρήση για ευκολία προσωπικού ή routine wandering.
- Καθολικοί σταθεροί πολλαπλασιαστές stroke/mortality.
- Αόριστη συνέχιση επειδή υπήρξε παλαιότερα βελτίωση.
- Μετατροπή της άδειας 6 εβδομάδων της ρισπεριδόνης σε universal duration rule.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διάρκεια αντιψυχωσικού: παλαιότερη διδασκαλία μπορεί να δίνει γενικό course

6–12 εβδομάδων. Η σύγχρονη πρακτική είναι **συντομότερη δυνατή έκθεση με τακτική επανεκτίμηση**· οι έως 6 εβδομάδες αφορούν συγκεκριμένο licensing της ρισπεριδόνης για επίμονη επιθετικότητα σε μέτρια–σοβαρή Alzheimer dementia.

Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε τη σοβαρή παραμέληση εαυτού ή τις συνθήκες ρυπαρότητας όταν ο ασθενής αρνείται βοήθεια;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Άμεσος σωματικός και περιβαλλοντικός κίνδυνος
- 2 Υποκείμενη αιτία
- 3 Ετεροαναφορικό ιστορικό και εκτίμηση του περιβάλλοντος
- 4 Ικανότητα λήψης της συγκεκριμένης απόφασης και εγκυρότητα της άρνησης
- 5 Το λιγότερο περιοριστικό πολυεπιστημονικό πλάνο
- 6 Ελληνικά κριτήρια ακούσιας νοσηλείας — όχι self-neglect από μόνο του

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η σοβαρή παραμέληση εαυτού δεν είναι διάγνωση και δεν αποτελεί από μόνη της λόγο ακούσιας ψυχιατρικής νοσηλείας. Πρέπει να εκτιμήσω τους άμεσους κινδύνους, να καταλάβω αν πρόκειται για αυτόνομη αλλά μη συνετή επιλογή ή για διαταραγμένη λήψη αποφάσεων λόγω ψυχικής ή νευρολογικής διαταραχής και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσω το λιγότερο περιοριστικό μέτρο που είναι συμβατό με την ασφάλεια και το ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Ξεκινώ από τον **άμεσο σωματικό και περιβαλλοντικό κίνδυνο**: θρέψη και ενυδάτωση, λοίμωξη ή μη θεραπευμένο σωματικό νόσημα, πτώσεις, παραμέληση φαρμακευτικής αγωγής και κινδύνους όπως πυρκαγιά, διαρροή αερίου, παράσιτα ή μη ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Εξετάζω επίσης αν κινδυνεύουν εξαρτώμενα ή άλλα πρόσωπα.

Στη συνέχεια διερευνώ τι προκαλεί ή συντηρεί την παραμέληση. Πιθανότητες είναι άνοια ή άλλη νευρογνωστική διαταραχή, ντελίριο, σοβαρή κατάθλιψη, ψύχωση, χρήση ουσιών, διαταραχή αποθησαύρισης και μετωπιαία/εκτελεστική δυσλειτουργία. Ο ιστορικός όρος «**σύνδρομο Διογένη**» μπορεί να περιγράψει ορισμένες εικόνες σοβαρής παραμέλησης και ρυπαρότητας, αλλά είναι ετερογενής και δεν αποτελεί ενιαία αιτιολογική διάγνωση.

Οι **ετεροαναφορικές πληροφορίες** είναι συχνά απαραίτητες, επειδή ο ασθενής μπορεί να μην αποτυπώνει τον βαθμό λειτουργικής έκπτωσης ή τον πραγματικό περιβαλλοντικό κίνδυνο. Όπου είναι εφικτό, άμεση εκτίμηση της κατοικίας μαζί με κοινοτικές ή κοινωνικές υπηρεσίες μπορεί να αποσαφηνίσει τις συνθήκες, τους κινδύνους και τις ανάγκες υποστήριξης.

Η άρνηση βοήθειας αξιολογείται ως προς τη **συγκεκριμένη απόφαση**. Η ικανότητα λήψης αποφάσεων δεν είναι καθολική ετικέτα «ικανός/ανίκανος». Τεκμηριώνω λειτουργικά αν ο ασθενής μπορεί να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση για θεραπεία, νοσηλεία, κατ' οίκον υποστήριξη ή άλλη παρέμβαση. Στην Ελλάδα **δεν παρουσιάζω τον τετραμερή έλεγχο του UK Mental Capacity Act ως ελληνικό νόμο**.

Αν ο ασθενής έχει την ικανότητα να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση και η άρνηση

είναι νομικά έγκυρη, ένας τρόπος ζωής που οι κλινικοί θεωρούν επικίνδυνο, εκκεντρικό ή μη συνετό **δεν εξουσιοδοτεί αυτόματα καταναγκαστική παρέμβαση**. Συνεχίζω τη θεραπευτική συνεργασία, τη μείωση βλάβης, την πρακτική υποστήριξη και την επανεκτίμηση, προσπαθώντας να μειώσω τον κίνδυνο χωρίς περιττό εξαναγκασμό.

Αν η λήψη της απόφασης είναι διαταραγμένη, η διαχείριση ακολουθεί το **ελληνικό πλαίσιο συναίνεσης και επειγουσών καταστάσεων**, με συμμετοχή οικογένειας και κατάλληλων υγειονομικών, κοινωνικών ή νομικών μηχανισμών όπου χρειάζεται. Η δικαστική συμπαράσταση και η συναίνεση είναι ξεχωριστά νομικά ζητήματα από τη self-neglect. Η επείγουσα θεραπεία χωρίς συναίνεση είναι στενή εξαίρεση και όχι γενική λύση για χρόνια παραμέληση.

Για ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία, η **σοβαρή παραμέληση από μόνη της δεν επαρκεί**. Πρέπει να υπάρχει ψυχική διαταραχή και να πληρούται μία από τις νομοθετικές οδούς της ελληνικής ακούσιας νοσηλείας. Επίσης δεν υπάρχει επαληθευμένη γενική ελληνική νομοθετική εξουσία που να επιτρέπει αναγκαστικό μη επείγον «καθάρισμα» ή άλλη κοινωνική παρέμβαση σε ενήλικα με έγκυρη ικανότητα λήψης της σχετικής απόφασης. Η πρακτική αντιμετώπιση μπορεί επομένως να απαιτεί συντονισμό υγειονομικών, κοινωνικών, δημοτικών και δικαστικών φορέων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Self-neglect από μόνο του δεν δικαιολογεί ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία στην Ελλάδα.
- Η εγκυρότητα της άρνησης εξαρτάται από τη συγκεκριμένη απόφαση και το ελληνικό πλαίσιο συναίνεσης, όχι από το αν η επιλογή φαίνεται συνετή στον γιατρό.
- Η severe self-neglect δεν δημιουργεί από μόνη της γενική εξουσία αναγκαστικής μη επείγουσας κοινωνικής παρέμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

HISTORICAL_EXAM_FACT: «σύνδρομο Διογένη» είναι ιστορική περιγραφική ετικέτα για ορισμένες εικόνες σοβαρής παραμέλησης/ρυπαρότητας. Δεν αποτελεί ενιαία σύγχρονη διάγνωση ούτε αιτιολογική εξήγηση.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- «Σύνδρομο Διογένη» ως αιτιολογική διάγνωση.
- Ταύτιση της άρνησης βοήθειας με ανικανότητα.
- Εισαγωγή του UK Mental Capacity Act ως ελληνικού δικαίου.
- Υπόθεση ότι δικαστική συμπαράσταση ή self-neglect αυτομάτως επιτρέπουν εξαναγκασμό.
- Επινοημένη γενική ελληνική εξουσία για υποχρεωτικό καθαρισμό κατοικίας/κοινωνική παρέμβαση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Νομικό πλαίσιο: κλινικές έννοιες από το UK capacity framework μπορεί να είναι χρήσιμες ως heuristic, αλλά δεν είναι ελληνικό νομοθετικό κείμενο. Η ελληνική απάντηση πρέπει να χρησιμοποιεί το ελληνικό δίκαιο συναίνεσης και ακούσιας νοσηλείας και να μην αντιμετωπίζει τη self-neglect ως αυτόνομο κριτήριο υποχρεωτικής εισαγωγής.

Πότε πρέπει να υποψιαστείτε αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα σε μια ψυχιατρική εικόνα και τι κάνετε;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ταχεία/υποξεία εξέλιξη
- 2 Σπασμοί, κατατονία, γνωστική έκπτωση
- 3 Κινητικές, γλωσσικές και συνειδησιακές μεταβολές
- 4 Αυτόνομη αστάθεια ή εστιακά νευρολογικά σημεία
- 5 EEG + MRI + ENY + αντισώματα ορού/ENY
- 6 Έγκαιρη ανοσοθεραπεία και έλεγχος νεοπλασματος

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα πρέπει να υποψιαστώ όταν ένα νέο ψυχιατρικό σύνδρομο εξελίσσεται **γρήγορα, μέσα σε ημέρες έως εβδομάδες**, και συνοδεύεται από νευρολογικά ή εγκεφαλοπαθητικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν θεωρώ την εικόνα πρωτοπαθή ψύχωση ή μανία πριν εξεταστεί ενεργά η πιθανότητα εγκεφαλίτιδας. Χρειάζεται επείγουσα νευρολογική εκτίμηση, EEG, MRI, μελέτη ENY με νευρωνικά αντισώματα, έλεγχος ορού και έγκαιρη ανοσοθεραπεία όταν η λοίμωξη έχει αποκλειστεί σε εύλογο βαθμό.

Τα σημαντικότερα στοιχεία είναι τα **red flags στην πορεία και στην εξέταση**: νέα επιληπτικά επεισόδια, κατατονία, ταχέως εξελισσόμενη γνωστική έκπτωση, μειωμένο ή διακυμαινόμενο επίπεδο συνείδησης, ανώμαλες κινήσεις ή στοματοπροσωπικές δυσκινησίες, αυτόνομη αστάθεια, γλωσσική δυσλειτουργία και εστιακά νευρολογικά σημεία. Έντονη συμπεριφορική ή ψυχιατρική αλλαγή δυσανάλογη με την αναμενόμενη πορεία μιας πρωτοπαθούς ψυχιατρικής νόσου επίσης μειώνει το κατώφλι διερεύνησης.

Η **anti-NMDA receptor encephalitis** είναι το πρωτότυπο παράδειγμα επειδή τα ψυχιατρικά συμπτώματα μπορεί να κυριαρχούν αρχικά. Άλλα αντισώματα, όπως **LG11 ή CASPR2**, μπορεί να είναι σχετικά ανάλογα με τον φαινότυπο, χωρίς η απάντηση να μετατρέπεται σε κατάλογο. Στην LG11, οι **faciobrachial dystonic seizures** είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές και η υπονατριαιμία συχνή, αλλά κανένα εύρημα δεν είναι υποχρεωτικό ή παθογνωμονικό.

Η διερεύνηση περιλαμβάνει νευρολογική εξέταση και **EEG, MRI εγκεφάλου και ENY**. Τα νευρωνικά αντισώματα εξετάζονται συνήθως τόσο σε ορό όσο και σε ENY, επειδή η διαγνωστική απόδοση εξαρτάται από το αντίσωμα. Το ENY είναι ιδιαίτερα σημαντικό για anti-NMDAR, ενώ ορισμένα αντισώματα όπως LG11 μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στον ορό. Άρα ένα **μεμονωμένο αποτέλεσμα ορού μπορεί να παραπλανήσει** σε ορισμένα σύνδρομα· δεν υπάρχει καθολικός κανόνας ότι ένα δείγμα υπερέχει για όλα τα αντισώματα.

Το EEG μπορεί να δείξει εγκεφαλοπάθεια ή επιληπτική δραστηριότητα και η MRI να υποστηρίξει τη διάγνωση ή να αναδείξει εναλλακτική παθολογία. Το **extreme delta brush** είναι χαρακτηριστικό εύρημα που σχετίζεται με anti-NMDAR

encephalitis αλλά είναι ασυνήθιστο και δεν απαιτείται για τη διάγνωση. Φυσιολογικό ή μη ειδικό αποτέλεσμα μίας εξέτασης δεν τερματίζει τη διερεύνηση όταν τα red flags παραμένουν ισχυρά.

Αναζητώ επίσης συνδεδεμένο νεόπλασμα όταν το υποδεικνύουν το σύνδρομο ή το προφίλ αντισωμάτων.

Η θεραπεία δεν καθυστερεί άσκοπα έως ότου επιστρέψει κάθε αποτέλεσμα. Όταν η λοίμωξη έχει αποκλειστεί σε εύλογο βαθμό, πρώτης γραμμής ανοσοθεραπεία είναι υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, **IVIG και/ή plasma exchange**. Αν υπάρχει σχετιζόμενος όγκος, η αντιμετώπισή του αποτελεί μέρος της θεραπείας. Η δεύτερη γραμμή ανοσοθεραπείας ανήκει στην εξειδικευμένη νευρολογική φροντίδα.

Αντιψυχωσικά μπορεί να χρειαστούν για σοβαρή διέγερση ή επικίνδυνη συμπεριφορά, αλλά είναι συμπτωματικά· δεν θεραπεύουν την εγκεφαλίτιδα και δεν πρέπει να καθυστερούν τη νευρολογική διερεύνηση ή την ανοσοθεραπεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ταχεία ψυχιατρική επιδείνωση + σπασμοί, κατατονία, γνωστική έκπτωση, κινητική διαταραχή, διαταραχή συνείδησης ή αυτόνομη αστάθεια → autoimmune encephalitis pathway.
- Έλεγχος ορού και ENY ανάλογα με το αντίσωμα· ENY ιδιαίτερα σημαντικό για NMDAR, serum sensitivity μπορεί να είναι υψηλότερη για LGI1.
- **Extreme delta brush**: χαρακτηριστικό αλλά σπάνιο και όχι απαραίτητο.
- **LGI1**: faciobrachial dystonic seizures ιδιαίτερα χαρακτηριστικές, υπονατριαιμία συχνή· όχι απόλυτα κριτήρια.
- Πρώτη γραμμή ανοσοθεραπείας: **κορτικοστεροειδή, IVIG και/ή plasma exchange**, με θεραπεία όγκου όπου χρειάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q53a. Γιατί είναι επικίνδυνο να βασιστείτε μόνο σε αντισώματα ορού;

Επειδή η διαγνωστική απόδοση εξαρτάται από το αντίσωμα και το βιολογικό υλικό. Στην **anti-NMDAR encephalitis**, το ENY είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ένα μεμονωμένο serum result μπορεί να παραπλανήσει. Αντίθετα, αντισώματα όπως **LGI1** μπορεί να ανιχνεύονται πιο ευαίσθητα στον ορό. Η ασφαλής προσέγγιση είναι syndrome-led ερμηνεία με τον κατάλληλο συνδυασμό ορού/ENY, όχι καθολική υπεροχή του ενός δείγματος.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση σχιζοφρένειας ή μανίας παρά τα νευρολογικά red flags.
- Αναμονή για «πλήρες κλασικό σύνδρομο».
- Αδιάκριτη εξάρτηση από serum-only testing.
- Extreme delta brush ως απαιτούμενο εύρημα.
- Faciobrachial dystonic seizures ως παθογνωμονικές.
- Εξαντλητικός κατάλογος αντισωμάτων αντί για κλινικό αλγόριθμο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Σύγχρονη προσέγγιση: όχι απλώς «anti-NMDA». Αναγνώριση red flags → EEG/MRI → κατάλληλος έλεγχος ENY + ορού → έγκαιρη ανοσοθεραπεία όταν η λοίμωξη έχει αποκλειστεί εύλογα.

Ποια ψυχιατρικά προβλήματα συνδέονται με την επιληψία και πώς τα προσεγγίζετε;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ικτική, περιϊκτική/μετακριτική και μεσοκριτική χρονική σχέση
- 2 Κατάθλιψη, άγχος και αυτοκτονικός κίνδυνος
- 3 Μετακριτική ψύχωση με διαυγές μεσοδιάστημα
- 4 Μεσοκριτική ψύχωση
- 5 Ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες αντιεπιληπτικών
- 6 Ψυχοτρόπα: ουδός σπασμών και αλληλεπιδράσεις
- 7 Λειτουργικές/διασχιστικές κρίσεις στη διαφορική

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα ψυχιατρικά φαινόμενα στην επιληψία οργανώνονται καλύτερα από τη **χρονική τους σχέση με τις κρίσεις**: ικτικά, περιϊκτικά ή μετακριτικά και μεσοκριτικά. Παράλληλα αξιολογώ τη συχνή ψυχιατρική συννοσηρότητα, τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιεπιληπτικών και τις αλληλεπιδράσεις των ψυχοτρόπων, ενώ όταν η φύση των επεισοδίων είναι αβέβαιη διατηρώ τις λειτουργικές/διασχιστικές κρίσεις στη διαφορική.

Τα **ικτικά ψυχιατρικά φαινόμενα** μπορεί να περιλαμβάνουν αιφνίδιο φόβο, βιωματικά ή αυτόνομα συμπτώματα και εμπειρίες που μοιάζουν με ψευδαισθήσεις, ιδιαίτερα σε κρίσεις κροταφικού λοβού. Το κύριο διαγνωστικό στοιχείο είναι η στερεότυπη σχέση με επιληπτική δραστηριότητα και όχι μια μεμονωμένη ασυνήθιστη εμπειρία.

Στη **μετακριτική περίοδο**, σύγχυση και διέγερση είναι συχνές, ενώ η μετακριτική ψύχωση αποτελεί ειδικό σύνδρομο. Χαρακτηριστικό είναι ένα **διαυγές μεσοδιάστημα (lucid interval)** μετά τις κρίσεις, αλλά δεν το μετατρέπω σε άκαμπτο κανόνα 12–72 ή 24–48 ωρών. Οι σύγχρονες περιγραφές επιτρέπουν διάστημα από ώρες έως αρκετές ημέρες, με την ψύχωση γενικά να αρχίζει εντός μίας εβδομάδας μετά από συρροή κρίσεων.

Μεσοκριτικά μπορεί να εμφανιστούν **κατάθλιψη, άγχος ή χρόνιο ψυχωσικό σύνδρομο**. Η κατάθλιψη και ο αυτοκτονικός κίνδυνος χρειάζονται ενεργή αξιολόγηση και δεν αντιμετωπίζονται ως απλώς «κατανοητές συνέπειες» της επιληψίας. Η θεραπεία του ψυχιατρικού συνδρόμου γίνεται με ταυτόχρονη συνεκτίμηση του ελέγχου των κρίσεων και των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων.

Η ανασκόπηση της φαρμακευτικής αγωγής είναι κρίσιμη. **Levetiracetam** μπορεί να προκαλέσει σημαντική ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, κατάθλιψη, διέγερση και ψυχωσικά συμπτώματα. **Topiramate** μπορεί να προκαλέσει γνωστική επιβράδυνση και δυσκολία εύρεσης λέξεων. Αντίστροφα, τα ψυχοτρόπα επηρεάζουν τον ουδό σπασμών: η **κλοζαπίνη** τον μειώνει με τρόπο που **σχετίζεται με τη δόση/έκθεση**, ενώ η **βουπροπιόνη** αντενδείκνυται σε άτομα με **παρούσα ή παρελθούσα διαταραχή επιληπτικών κρίσεων**. Οι SSRIs συγκαταλέγονται γενικά στις προτιμώμενες αντικαταθλιπτικές επιλογές όταν

χρειάζεται αγωγή. Αντιεπιληπτικά με ενζυμική επαγωγή μπορούν επίσης να μειώσουν την έκθεση σε ψυχοτρόπα.

Όταν η φύση των επεισοδίων είναι αβέβαιη, εξετάζω λειτουργικές ή διασχιστικές κρίσεις. Δεν παράγονται εκούσια. Η διάγνωση είναι κλινική και, όταν χρειάζεται, μπορεί να υποστηριχθεί από video-EEG τυπικού επεισοδίου. Φυσιολογικό μεσοκριτικό EEG δεν διαγιγνώσκει λειτουργικές κρίσεις.

Η διαχείριση είναι συνεργατική μεταξύ νευρολογίας και ψυχιατρικής: βελτιστοποίηση ελέγχου κρίσεων, θεραπεία ψυχιατρικής συννοσηρότητας, ανασκόπηση ανεπιθύμητων ενεργειών αντιεπιληπτικών, επιλογή ψυχοτρόπων με βάση ουδό σπασμών και αλληλεπιδράσεις και αντιμετώπιση λειτουργικών και ψυχοκοινωνικών συνεπειών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Μετακριτική ψύχωση:** χαρακτηριστικό lucid interval από ώρες έως αρκετές ημέρες, με έναρξη ψύχωσης γενικά εντός μίας εβδομάδας μετά από cluster κρίσεων· όχι άκαμπος κανόνας 24–48 h.
- **Levetiracetam:** ευερεθιστότητα/επιθετικότητα, κατάθλιψη, διέγερση, ψυχωσικά συμπτώματα.
- **Topiramate:** γνωστική επιβράδυνση και word-finding difficulty.
- **Clozapine:** μειώνει τον ουδό σπασμών με dose/exposure-related τρόπο.
Bupropion: αντενδείκνυται σε seizure disorder.
- Λειτουργικές/διασχιστικές κρίσεις δεν είναι εκούσιες και φυσιολογικό EEG μόνο του δεν τις διαγιγνώσκει.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

HISTORICAL_EXAM_FACT: το σύνδρομο Gastaut–Geschwind/Geschwind είναι ιστορική και αμφισβητούμενη περιγραφή χαρακτηριστικών προσωπικότητας/συμπεριφοράς που συνδέθηκαν με επιληψία κροταφικού λοβού. Δεν παρουσιάζεται ως καθιερωμένο σύγχρονο σύνδρομο ή διάγνωση προσωπικότητας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Άκαμπος κανόνας 12–72 ή 24–48 h για το lucid interval.
- Θεώρηση των λειτουργικών κρίσεων ως εκούσιων.
- Διάγνωση λειτουργικών κρίσεων επειδή το EEG είναι φυσιολογικό.
- Geschwind ως καθιερωμένο σύγχρονο σύνδρομο.
- Παράβλεψη ψυχιατρικών/γνωστικών ανεπιθύμητων ενεργειών αντιεπιληπτικών.
- Παράβλεψη κατάθλιψης και αυτοκτονικού κινδύνου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Χρονισμός και ιστορικό υλικό: η παλαιότερη διδασκαλία μπορεί να δίνει άκαμpto lucid interval και να παρουσιάζει το Geschwind syndrome ως εγκατεστημένο. Η σύγχρονη πρακτική θεωρεί το lucid interval μεταβλητό και το Geschwind

ιστορικό/αμφισβητούμενο.

Ποιες ψυχιατρικές και συμπεριφορικές συνέπειες μπορεί να ακολουθήσουν μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Οξύ ντελίριο και μετατραυματική αμνησία (PTA)
- 2 Επίμονη γνωστική και εκτελεστική δυσλειτουργία
- 3 Κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, συναισθηματική αστάθεια
- 4 Απάθεια, άρση αναστολών και επίκτητη αλλαγή συμπεριφοράς
- 5 Αυτοκτονικός κίνδυνος και χρήση ουσιών
- 6 Αποκατάσταση, περιβάλλον και οικογένεια
- 7 Προσεκτική συμπτωματοκεντρική φαρμακοθεραπεία

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση μπορεί να προκαλέσει οξεία συγχυτική κατάσταση και μετατραυματική αμνησία και στη συνέχεια ευρύ φάσμα επίμονων γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων. Η ψυχιατρική εκτίμηση συνδέει τα συμπτώματα με την κάκωση, τη νευρολογική ανάρρωση, τη μετωπιαία-εκτελεστική λειτουργία και τις προϋπάρχουσες ευαλωτότητες, ενώ η αντιμετώπιση παραμένει πρωτίστως προσανατολισμένη στην αποκατάσταση και όχι σε έναν καθολικό φαρμακευτικό αλγόριθμο.

Στην πρώιμη φάση, **ντελίριο και μετατραυματική αμνησία (PTA)** είναι κεντρικά. Η PTA είναι σημαντική για την εκτίμηση βαρύτητας, την πρόγνωση και τον σχεδιασμό αποκατάστασης, αλλά οι παλαιές ακριβείς κατηγορίες διάρκειας, όπως «ήπια <24 ώρες, μέτρια 1–7 ημέρες, σοβαρή >7 ημέρες», δεν αποτελούν έναν καθολικό σύγχρονο κανόνα. Η βαρύτητα της TBI εκτιμάται συνδυάζοντας PTA με άλλα στοιχεία, όπως **GCS, απώλεια συνείδησης και απεικόνιση**, και τα όρια διαφέρουν ανά σύστημα.

Μακροχρόνια μπορεί να εμφανιστούν **γνωστική και εκτελεστική δυσλειτουργία, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα και επιθετικότητα, συναισθηματική αστάθεια, απάθεια ή αδράνεια, άρση αναστολών και επίκτητη αλλαγή προσωπικότητας ή συμπεριφοράς**. Η χρήση ουσιών μπορεί να δυσχεράνει την ανάρρωση και ο αυτοκτονικός κίνδυνος πρέπει να αξιολογείται ρητά.

Οι μετωπιαίες-εκτελεστικές συσχετίσεις βοηθούν κλινικά: **κογχομετωπιαία δυσλειτουργία → παρορμητικότητα/άρση αναστολών, ραχιοπλάγια προμετωπιαία δυσλειτουργία → εκτελεστικά προβλήματα, πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου/έσω μετωπιαίο σύστημα → απάθεια και μειωμένη έναρξη δραστηριότητας**. Αυτές είναι χρήσιμες δικτυακές συσχετίσεις και όχι άκαμπτοι κανόνες «μία βλάβη-ένα σύμπτωμα».

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει το αρχικό τραύμα και την πορεία της PTA, τρέχουσα νευρολογική και σωματική κατάσταση, γνωστικές/εκτελεστικές λειτουργίες, διάθεση, επιθετικότητα ή παρορμητικότητα, χρήση ουσιών, αυτοκτονικό κίνδυνο, φαρμακευτικές επιδράσεις, επιβάρυνση οικογένειας ή φροντιστών και

λειτουργικούς στόχους. Επίκτητη συμπεριφορική αλλαγή δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως προϋπάρχουσα διαταραχή προσωπικότητας χωρίς να συνεκτιμηθεί η εγκεφαλική κάκωση.

Κατά την **PTA ή οξεία διέγερση**, δίνω έμφαση σε περιβάλλον χαμηλών ερεθισμάτων, προσανατολισμό, ρύθμιση ύπνου και αρχές νευροαποκατάστασης. Η μακροχρόνια φροντίδα είναι πολυτροπική: νευροαποκατάσταση, εργοθεραπεία και γνωστικές παρεμβάσεις, συμπεριφορικές στρατηγικές, εκπαίδευση οικογένειας και πρακτική υποστήριξη σύμφωνα με τα ελλείμματα και τους στόχους.

Η φαρμακοθεραπεία, όταν χρειάζεται, είναι **στοχευμένη στο σύμπτωμα**. Η τεκμηρίωση για συγκεκριμένα φάρμακα στη μετα-TBI διέγερση είναι ετερογενής, άρα δεν υπάρχει ένας καθολικός αλγόριθμος. Ψυχοτρόπα χρησιμοποιούνται με προσοχή επειδή καταστολή, αντιχολινεργική επιβάρυνση, γνωστικές ανεπιθύμητες ενέργειες και επιδράσεις στον ουδό σπασμών μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Η απάθεια απαιτεί ειδική διάκριση, επειδή η μειωμένη έναρξη δραστηριότητας μετά από TBI μπορεί να αντανakλά μετωποϋποφλοιώδη δυσλειτουργία και όχι κατάθλιψη. Αντίστοιχα, επιθετικότητα, παρορμητικότητα ή συναισθηματική αστάθεια ερμηνεύονται μέσα στο νευρολογικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **PTA:** σημαντικός δείκτης βαρύτητας/πρόγνωσης, αλλά όχι καθολικός πίνακας exact duration bins ούτε ο μοναδικός predictor.
- Η σύγχρονη εκτίμηση βαρύτητας συνδυάζει **PTA, GCS, απώλεια συνείδησης και απεικόνιση**.
- **Κογχομετωπιαίος → disinhibition/impulsivity; DLPFC → executive dysfunction; πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου/έσω μετωπιαίος → apathy/poor initiation:** χρήσιμες συσχετίσεις, όχι deterministic lesion rules.
- Η οξεία διέγερση κατά PTA αντιμετωπίζεται κυρίως με περιβαλλοντικές και αποκαταστασιακές στρατηγικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q55a. Πώς διακρίνετε την απάθεια μετά TBI από την κατάθλιψη;

Η απάθεια είναι κυρίως μείωση της **στοχοκατευθυνόμενης έναρξης και κινητοποίησης**, συχνά χωρίς έντονη υποκειμενική θλίψη, ενοχή ή απελπισία. Η κατάθλιψη υποστηρίζεται από ευρύτερο συναισθηματικό-γνωστικό σύνδρομο με επίμονη χαμηλή διάθεση, αρνητική αυτοαξιολόγηση, ενοχή, απελπισία και αυτοκτονικότητα. Μπορούν να συνυπάρχουν και η ανηδονία από μόνη της δεν τις διαχωρίζει αξιόπιστα.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Πρωτοπαθής διαταραχή προσωπικότητας χωρίς να εξεταστεί επίκτητη μετα-TBI αλλαγή.
- Ταύτιση κάθε μειωμένου κινήτρου με κατάθλιψη.
- Ακαμπτα PTA duration bins ως καθολική σύγχρονη ταξινόμηση.
- PTA ως μοναδικός απόλυτος predictor.
- Μετωπιαίες συσχετίσεις ως exact one-lesion/one-symptom maps.
- Ακαμπτος καθολικός φαρμακευτικός αλγόριθμος για διέγερση.

Πώς προσεγγίζετε μια εκτίμηση διασυνδετικής ψυχιατρικής σε νοσηλευόμενο σωματικά πάσχοντα ασθενή;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αποσαφήνιση του ερωτήματος παραπομπής
- 2 Ντελίριο, λήψη αποφάσεων, αυτοκτονικότητα, στέρηση
- 3 Ψυχιατρικά σύνδρομα από νόσο ή φάρμακα
- 4 Λειτουργικές ή σωματικές εκδηλώσεις
- 5 Βιοψυχοκοινωνική διατύπωση μέσα στο ιατρικό πλαίσιο
- 6 Σαφείς, εφαρμόσιμες συστάσεις προς τη θεράπουσα ομάδα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διασυνδετική εκτίμηση αρχίζει με ένα σαφές ερώτημα: **τι ακριβώς χρειάζεται να αποφασίσει τώρα η ιατρική ή χειρουργική ομάδα;** Ο ρόλος του ψυχιάτρου δεν είναι να επαναλάβει ένα γενικό ψυχιατρικό ιστορικό, αλλά να εντοπίσει το σχετικό σύνδρομο, τον κίνδυνο ή το πρόβλημα λήψης απόφασης μέσα στο σωματικό πλαίσιο και να δώσει συνοπτικές συστάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.

Συχνά ερωτήματα είναι **ντελίριο, ικανότητα λήψης συγκεκριμένης απόφασης και συναίνεση ή άρνηση, αυτοτραυματισμός/αυτοκτονικός κίνδυνος, στέρηση ουσιών, κατάθλιψη ή άγχος, φαρμακογενή ψυχιατρικά συμπτώματα και λειτουργικές ή σωματικές εκδηλώσεις**. Κάθε ερώτημα απαιτεί διαφορετικό βάθος και επείγοντα χαρακτήρα.

Στη συνέχεια εξετάζω προσεκτικά το **ιατρικό πλαίσιο**: υποκείμενη νόσο, τρέχουσα φυσιολογική διαταραχή, πρόσφατες επεμβάσεις ή παραμονή σε ΜΕΘ, πόνο, ύπνο, φάρμακα και αλληλεπιδράσεις, αλκοόλ και άλλες ουσίες. Νέο ψυχιατρικό σύμπτωμα σε σωματικά πάσχοντα ασθενή μπορεί να προκαλείται ή να επιβαρύνεται από τη νόσο ή τη θεραπεία της, επομένως ο ιατρικός και φαρμακευτικός έλεγχος είναι κεντρικός.

Το προϋπάρχον ψυχιατρικό ιστορικό ενσωματώνεται στην τρέχουσα σωματική κατάσταση. Συχνά χρειάζονται **ετεροαναφορικές πληροφορίες** για το προηγούμενο γνωστικό ή λειτουργικό επίπεδο, τη συμπεριφορά, τη λήψη της αγωγής ή τον κίνδυνο. Η διατύπωση συνδέει τη σωματική νόσο, το θεραπευτικό φορτίο, το ψυχιατρικό ιστορικό, τον τρόπο αντιμετώπισης, την τρέχουσα συμπεριφορά και το κοινωνικό πλαίσιο.

Συχνό ερώτημα είναι η **ικανότητα λήψης απόφασης ή η άρνηση θεραπείας**. Η εκτίμηση είναι ειδική για τη συγκεκριμένη απόφαση. Στην Ελλάδα δεν παρουσιάζω τον τετραμερή statutory έλεγχο του UK Mental Capacity Act ως ελληνικό νόμο. Διακρίνω την κλινική εκτίμηση της δυνατότητας του ασθενούς να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση από τη νομική εγκυρότητα της συναίνεσης ή της άρνησης στο ελληνικό πλαίσιο.

Η εκτίμηση κινδύνου είναι επίσης εστιασμένη. Αν η παραπομπή αφορά self-harm,

αυτοκτονικότητα, διέγερση ή άρνηση θεραπείας, πρέπει να απαντήσω ποιος είναι ο άμεσος κίνδυνος, τι τον τροφοδοτεί και τι πρέπει να κάνει τώρα η ομάδα. Αν υποπτεύομαι ντελίριο ή στέρηση, αυτό αλλάζει άμεσα τόσο τη διερεύνηση όσο και τη θεραπεία και δεν αποτελεί παρεμπόμπουσα ψυχιατρική ετικέτα.

Η αξία της διασυνδεδετικής ψυχιατρικής βρίσκεται στις **συστάσεις**: ποιο σύνδρομο θεωρώ πιθανό, ποιες διαφορικές παραμένουν, ποιοι κίνδυνοι είναι άμεσοι, ποιες εξετάσεις ή φαρμακευτικές αλλαγές χρειάζονται, πώς πρέπει το προσωπικό να επικοινωνεί ή να διαχειρίζεται τη συμπεριφορά και ποιος αναλαμβάνει την παρακολούθηση. Οι συστάσεις πρέπει να είναι σαφείς, πρακτικές και συνδεδεμένες με το αρχικό ερώτημα.

Η διασυνδεδετική ψυχιατρική **δεν αφαιρεί την ευθύνη από την κύρια ιατρική ομάδα**. Προσθέτει ψυχιατρική συλλογιστική στην ιατρική διατύπωση και διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ ειδικοτήτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η αποσαφήνιση του **ερωτήματος παραπομπής** αποτελεί μέρος της ίδιας της consultation.
- Η ικανότητα λήψης αποφάσεων είναι **decision-specific** και **jurisdiction-sensitive**.
- Η ουσιαστική liaison formulation ενώνει **σωματική νόσο, θεραπευτικές επιδράσεις, ψυχιατρικό ιστορικό, συμπεριφορά και κοινωνικό πλαίσιο**.
- Τα proactive/integrated liaison models **μπορεί να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και ορισμένες εκβάσεις**, αλλά η επίδραση σε length of stay ή readmission εξαρτάται από μοντέλο υπηρεσίας και πληθυσμό και δεν αποτελεί καθολικό αποτέλεσμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q56a. Τι κάνει μια σύσταση διασυνδεδετικής ψυχιατρικής χρήσιμη για την ιατρική ομάδα;

Απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα παραπομπής και μετατρέπει την ψυχιατρική συλλογιστική σε ενέργειες: πιθανό σύνδρομο και διαφορική, άμεσος κίνδυνος, τι χρειάζεται διερεύνηση ή φαρμακευτική ανασκόπηση, πώς πρέπει να επικοινωνεί το προσωπικό ή να διαχειρίζεται τη συμπεριφορά, αν η λήψη αποφάσεων επηρεάζει την προτεινόμενη παρέμβαση και ποιος αναλαμβάνει το follow-up. Ένα γενικό ψυχιατρικό ιστορικό χωρίς εφαρμόσιμες συστάσεις έχει μικρή αξία.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Μετατροπή της liaison assessment σε γενική λήψη ψυχιατρικού ιστορικού.
- «Adjustment disorder» για κάθε δυσφορία σωματικά πάσχοντος.
- Παράβλεψη ντελίου, φαρμακευτικών επιδράσεων ή στέρησης.
- Εισαγωγή UK capacity law στην ελληνική πρακτική.
- Παρουσίαση proactive liaison ως εγγυημένη μείωση νοσηλείας/readmission.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ελληνικό νομικό πλαίσιο: UK-derived capacity frameworks δεν παρουσιάζονται ως ελληνικός νόμος. Στην ελληνική προφορική απάντηση διακρίνουμε την κλινική

εκτίμηση της δυνατότητας λήψης απόφασης από τη νομική εγκυρότητα συναίνεσης ή άρνησης.

Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την απάθεια από την κατάθλιψη;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Απάθεια = μειωμένη στοχοκατευθυνόμενη δραστηριότητα
- 2 Συμπεριφορική/γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική διάσταση
- 3 Κατάθλιψη = αρνητικό συναίσθημα και καταθλιπτικές γνωσίες
- 4 Η ανηδονία επικαλύπτεται
- 5 Μετωποϋποφλοιώδη νοσήματα και φαρμακευτικές επιδράσεις
- 6 Απάθεια και κατάθλιψη μπορούν να συνυπάρχουν

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάθεια είναι κυρίως διαταραχή της στοχοκατευθυνόμενης κινητοποίησης και δραστηριότητας, ενώ η κατάθλιψη είναι σύνδρομο διάθεσης με αρνητικό συναίσθημα και καταθλιπτικές γνωσίες. Και οι δύο μπορεί να προκαλούν μειωμένη δραστηριότητα και κοινωνική απόσυρση, αλλά η διάκριση βασίζεται στην ποιότητα της εσωτερικής εμπειρίας και στο συνολικό σύνδρομο. Μπορούν επίσης να συνυπάρχουν.

Στην απάθεια, το κεντρικό χαρακτηριστικό είναι η μειωμένη έναρξη ή η μειωμένη αυθόρμητη στοχοκατευθυνόμενη συμπεριφορά. Ο ασθενής μπορεί να έχει λιγότερη αυθόρμητη δραστηριότητα, σκέψη ή σχεδιασμό, συναισθηματική άμβλυνση και κοινωνική αποδέσμευση. Τα σύγχρονα μοντέλα τη θεωρούν πολυδιάστατη, με συμπεριφορική/γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική διάσταση.

Στη σχετικά αμιγή απάθεια συχνά λείπει το χαρακτηριστικό καταθλιπτικό γνωστικό-συναισθηματικό σύνδρομο. Ο ασθενής μπορεί να είναι ανενεργός ή συναισθηματικά επίπεδος χωρίς επίμονη θλίψη, ενοχή, απελπισία, αυτομομφή ή αυτοκτονική σκέψη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε νευρολογικές και νευροεκφυλιστικές διαταραχές, όπου η μειωμένη έναρξη μπορεί να αντανακλά μετωποϋποφλοιώδη δυσλειτουργία και όχι πρωτοπαθή διαταραχή διάθεσης.

Η κατάθλιψη υποστηρίζεται από επίμονη χαμηλή διάθεση, αρνητική αυτοαξιολόγηση, ενοχή, απελπισία, καταθλιπτικές γνωσίες, βιολογικά συμπτώματα και αυτοκτονικότητα. Χαμηλή δραστηριότητα ή μειωμένη έναρξη από μόνες τους δεν αρκούν.

Η ανηδονία δεν αποτελεί αξιόπιστο μοναδικό διαχωριστικό σημείο. Μειωμένο ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση μπορεί να εμφανίζεται και στις δύο καταστάσεις. Ομοίως, περιορισμένη υποκειμενική δυσφορία μπορεί να υποδηλώνει απάθεια αλλά δεν την αποδεικνύει.

Το νευρολογικό πλαίσιο βοηθά. Μετωποϋποφλοιώδη δίκτυα, μεταξύ αυτών ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου και το κοιλιακό ραβδωτό, έχουν συσχετιστεί με απάθεια, αλλά το σύνδρομο δεν αναγάζεται σε μία ντοπαμινεργική οδό ή μία εντόπιση βλάβης. Απάθεια εμφανίζεται στη νόσο Parkinson, στο ΑΕΕ, μετά TBI και σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Φάρμακα, ντελίριο και γνωστικές διαταραχές

επίσης επανεξετάζονται όταν το κίνητρο μεταβάλλεται.

Ρωτώ ξεχωριστά για έναρξη, προσπάθεια, στοχοκατευθυνόμενη δραστηριότητα, συναισθηματική ανταπόκριση, κοινωνική συμμετοχή, θλίψη, ενοχή, απελπισία και αυτοκτονικό κίνδυνο. Οι **ετεροαναφορικές πληροφορίες** είναι συχνά πολύτιμες, επειδή οι οικείοι μπορεί να παρατηρούν μεγάλη μείωση αυθόρμητης δραστηριότητας ακόμη και όταν ο ασθενής αναφέρει μικρή υποκειμενική δυσφορία.

Η θεραπεία είναι **αιτιολογική και συνδρομική**. Θεραπεύω κατάθλιψη όταν υπάρχει, επανεξετάζω φάρμακα και νευρολογικούς παράγοντες και υποστηρίζω λειτουργικότητα και περιβαλλοντική δομή. Δεν υπάρχει καθολικός κανόνας ότι η απάθεια θεραπεύεται με «προ-ντοπαμινεργικό» φάρμακο ή αναστολέα χολινεστεράσης, ούτε χορηγώ SSRI απλώς επειδή ο ασθενής είναι ανενεργός.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Απάθεια** = μειωμένη στοχοκατευθυνόμενη δραστηριότητα, όχι «κατάθλιψη χωρίς θλίψη».
- Θλίψη, ενοχή, απελπισία και αυτοκτονικότητα ενισχύουν σαφώς τη διάγνωση κατάθλιψης.
- Μετωποϋποφλοιώδη και ACC/ventral-striatal δίκτυα εμπλέκονται, αλλά η απάθεια δεν αναγάζεται σε ένα κύκλωμα ή νευροδιαβιβαστή.
- Η θεραπεία είναι **αιτιολογική και syndrome-specific**: δεν υπάρχει καθολική dopaminergic ή cholinesterase-inhibitor θεραπεία.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- **Ανηδονία** ως μοναδικός discriminator.
- Χαμηλή υποκειμενική δυσφορία ως απόδειξη απάθειας.
- Διάγνωση κατάθλιψης από την αδράνεια μόνο.
- Απάθεια ως ένα single ACC/dopamine lesion model.
- Υπόθεση ότι dopaminergic drugs είναι καθολικά προτιμητέα ή ότι SSRIs δεν μπορούν να συνεισφέρουν σε emotional blunting.
- Παράβλεψη της συνύπαρξης απάθειας και κατάθλιψης.

Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε το σύνδρομο Charles Bonnet από την ψύχωση, το ντελίριο και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα;

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Σημαντική οπτική έκπτωση
- 2 Υποτροπιάζουσες οπτικές ψευδαισθήσεις
- 3 Εναισθησία συνήθως διατηρημένη ή αναπτυσσόμενη
- 4 Αποκλεισμός ντελίου και πρωτοπαθούς ψύχωσης
- 5 DLB/PD, επιληψία, φάρμακα και εστιακά νευρολογικά αίτια
- 6 Εξήγηση, καθησυχασμός και βελτιστοποίηση όρασης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το σύνδρομο Charles Bonnet χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες οπτικές ψευδαισθήσεις σε άτομο με σημαντική οπτική έκπτωση, χωρίς πρωτοπαθή ψυχωσική διαταραχή ή ντελίριο που να εξηγεί το φαινόμενο. Οι ψευδαισθήσεις είναι συχνά ζωηρές και σχηματισμένες και η εναισθησία συνήθως διατηρείται ή αναπτύσσεται μετά από εξήγηση, αλλά η απόλυτα ακέραιη εναισθησία δεν είναι υποχρεωτική κάθε στιγμή. Το βασικό έργο είναι να αναγνωριστεί ένα visual-release phenomenon και να αποκλειστούν γνωστικά, νευρολογικά, φαρμακευτικά και delirium-related αίτια.

Οι ψευδαισθήσεις είναι συχνά σύνθετες ή σχηματισμένες, όπως πρόσωπα, άνθρωποι, ζώα ή σκηνές, αλλά η ακριβής μορφή τους είναι υποστηρικτική και όχι διαγνωστική. Είναι κατά κανόνα οπτικές και όχι μέρος ενός ευρύτερου ψυχωσικού συνδρόμου, ενώ η σημαντική οπτική βλάβη είναι κεντρική στο πλαίσιο.

Η εναισθησία βοηθά στη διάκριση, αλλά χρειάζεται αποχρώσεις. Πολλοί ασθενείς αναγνωρίζουν ότι οι εικόνες δεν είναι πραγματικές, όμως αρχική αβεβαιότητα ή μερική/διακυμαινόμενη εναισθησία μπορεί να εμφανιστεί. Επίμονη πλήρης απουσία εναισθησίας πρέπει να οδηγεί σε επανεξέταση για άλλη αιτία και όχι να αποκλείει αυτομάτως το Charles Bonnet από την πρώτη στιγμή.

Πρώτη σημαντική διαφορική είναι το ντελίριο, με οξεία διακυμαινόμενη διαταραχή προσοχής και επίγνωσης στο πλαίσιο σωματικής νόσου, φαρμάκων, τοξίκωσης ή στέρησης. Οπτικές ψευδαισθήσεις με διακυμαινόμενη απροσεξία ή μειωμένη επίγνωση δεν πρέπει να αποδίδονται σε uncomplicated Charles Bonnet.

Εξετάζω επίσης νευροεκφυλιστικά και νευρολογικά σύνδρομα. DLB ή PDD μπορεί να έχουν οπτικές ψευδαισθήσεις αλλά συνοδεύονται από γνωστική έκπτωση και ενδέχεται να εμφανίζουν γνωστικές διακυμάνσεις, παρκινσονισμό και RBD. Επιληψία, ημικρανία, εστιακή νευρολογική νόσος, φάρμακα ή ουσίες μπορεί επίσης να προκαλέσουν οπτικά φαινόμενα.

Πρωτοπαθής ψύχωση είναι λιγότερο πιθανή όταν οι ψευδαισθήσεις περιορίζονται στην οπτική τροπικότητα σε άτομο με μειωμένη όραση και χωρίς ευρύτερο ψυχωσικό σύνδρομο, αλλά εξακολουθώ να εξετάζω παραληρητικές ιδέες,

διαταραχή σκέψης και άλλα ψυχωσικά συμπτώματα.

Η αντιμετώπιση uncomplicated Charles Bonnet είναι κυρίως **εξήγηση και καθησυχασμός**. Εξηγώ ότι το φαινόμενο μπορεί να συνοδεύει την οπτική βλάβη και δεν σημαίνει από μόνο του σχιζοφρένεια ή άνοια. Βελτιστοποιώ την όραση όπου είναι δυνατόν, αντιμετωπίζω την οφθαλμολογική νόσο, επανεξετάζω φάρμακα και παρεμπόδιτες οξείες νόσους και χρησιμοποιώ περιβαλλοντικές ή συμπεριφορικές στρατηγικές όπου βοηθούν.

Routine αντιψυχωσική θεραπεία δεν αποτελεί standard care για uncomplicated Charles Bonnet. Η φαρμακολογική τεκμηρίωση είναι περιορισμένη και φάρμακα επιφυλάσσονται για εξαιρετικές specialist περιπτώσεις, όχι αντανakλαστικά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η διατηρημένη εναισθησία είναι **χαρακτηριστική** αλλά **όχι απόλυτα απαραίτητη** κάθε στιγμή.
- Οι ψευδαισθήσεις είναι συχνά **σύνθετες/σχηματισμένες**, αλλά κανένας συγκεκριμένος οπτικός φαινότυπος δεν είναι διαγνωστικός.
- Routine αντιψυχωσικό στην uncomplicated Charles Bonnet **δεν είναι standard care**.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Σχιζοφρένεια από isolated visual hallucinations σε άτομο με οπτική βλάβη.
- Απαίτηση τέλει εναισθησίας ως απόλυτου κανόνα.
- Συγκεκριμένο hallucination phenotype ως υποχρεωτικό.
- Παράβλεψη DLB ή ντελίριου όταν είναι διαταραγμένες γνωστικές λειτουργίες/προσοχή.
- Routine αντιψυχωσική αγωγή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Εναισθησία: παλαιότερες διατυπώσεις μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι πρέπει να είναι πάντα πλήρως ακέραιη. Η σύγχρονη απάντηση επιτρέπει αρχική αβεβαιότητα ή μερική/διακυμαινόμενη εναισθησία, με την επίμονη απουσία να αποτελεί red flag για άλλη διάγνωση.

Πώς διαγιγνώσκετε τη ΔΕΠ-Υ ενηλίκων και πώς τη διαφοροδιαγιγνώσκετε από συχνές μιμητικές καταστάσεις;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όχι απλή καταμέτρηση συμπτωμάτων
- 2 Ορισμένα συμπτώματα πριν από τα 12 έτη
- 3 Συμπτώματα σε περισσότερα από ένα πλαίσια με τρέχουσα λειτουργική έκπτωση
- 4 Ανασύνθεση αναπτυξιακού ιστορικού και ετεροαναφορικές πληροφορίες όπου υπάρχουν
- 5 Διαφορική διάγνωση και συννοσηρότητα
- 6 Οι κλίμακες υποστηρίζουν — δεν διαγιγνώσκουν
- 7 Θεραπεία μετά από ολοκληρωμένη διαγνωστική διατύπωση και εκτίμηση ασφάλειας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ΔΕΠ-Υ ενηλίκων είναι **νευροαναπτυξιακή διαταραχή**, άρα η διάγνωση απαιτεί περισσότερα από τρέχοντα παράπονα διάσπασης προσοχής ή κακής οργάνωσης. Πρέπει να τεκμηριώσω επίμονο πρότυπο απροσεξίας και/ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας με εκτελεστικές δυσκολίες, να επιβεβαιώσω ότι ορισμένα συμπτώματα υπήρχαν **πριν από τα 12 έτη**, να δείξω ουσιαστική τρέχουσα έκπτωση σε σημαντικούς τομείς της ζωής και να αξιολογήσω ενεργά εναλλακτικές εξηγήσεις και συννοσηρότητα.

Αρχικά χαρακτηρίζω το σημερινό σύνδρομο: **περισπασιμότητα**, αποδιοργάνωση, λησμοσύνη, δυσκολία ολοκλήρωσης έργων, παρορμητικότητα, ανησυχία και δυσκολίες στον σχεδιασμό ή τη διατήρηση προσπάθειας, ανάλογα με την εικόνα. Το κλειδί είναι η **λειτουργική επίπτωση**: εργασία ή σπουδές, διαχείριση νοικοκυριού και οικονομικών, πρακτικές υποχρεώσεις, σχέσεις και κοινωνική λειτουργικότητα.

Το αναπτυξιακό ιστορικό είναι κεντρικό. Η σύγχρονη ταξινόμηση απαιτεί **ορισμένα συμπτώματα πριν από την ηλικία των 12 ετών**, όχι όμως επίσημη παιδική διάγνωση, σχολικά έγγραφα ή υποχρεωτική επιβεβαίωση από γονέα. Ανασυνθέτω προσεκτικά την παιδική και εφηβική λειτουργικότητα χρησιμοποιώντας την αφήγηση του ασθενούς και, όταν είναι διαθέσιμα, ετεροαναφορικές πληροφορίες ή αρχεία. Η απουσία collateral αυξάνει την αβεβαιότητα αλλά δεν αποκλείει αυτόματα τη διάγνωση.

Τα συμπτώματα πρέπει να εμφανίζονται **σε περισσότερα από ένα περιβάλλοντα ή πλαίσια** και όχι μόνο σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Ρωτώ πώς εκδηλώνονται σε εργασία, σπίτι, σχέσεις και άλλες σταθερές υποχρεώσεις. Οι κλίμακες μπορούν να οργανώσουν την εκτίμηση και να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες, αλλά **δεν θέτουν από μόνες τους διάγνωση ΔΕΠ-Υ**.

Η διαφορική είναι ευρεία επειδή τα προβλήματα προσοχής και εκτελεστικών

λειτουργιών είναι μη ειδικά. Εξετάζω άγχος, κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, διαταραχές ύπνου, χρήση ουσιών, αυτισμό, παθολογία προσωπικότητας, TBI και άλλες γνωστικές αιτίες, καθώς και καφεΐνη, άλλα διεγερτικά, φάρμακα και το πρότυπο ύπνου. Η συννοσηρότητα δεν αποκλείει τη ΔΕΠ-Υ· στόχος είναι να ξεχωρίσω τα αναπτυξιακά επίμονα συμπτώματα από εκείνα που εξηγούνται καλύτερα από άλλη κατάσταση.

Χρήσιμη διάκριση από τη διπολική διαταραχή είναι η **αναπτυξιακή, σχετικά σταθερή παρουσία έναντι επεισοδιακής μεταβολής από το σύνηθες επίπεδο λειτουργικότητας**. Τα συμπτώματα ΔΕΠ-Υ μπορεί να μεταβάλλονται με τη δομή, τις απαιτήσεις και το περιβάλλον, αλλά το σύνδρομο παραμένει αναπτυξιακό· η μανία/υπομανία είναι επεισοδιακή και συνοδεύεται από ευρύτερη βιολογική και συμπεριφορική μεταβολή.

Μετά την τεκμηρίωση της διάγνωσης, η θεραπεία εξατομικεύεται. Σε γενικές γραμμές, **lisdexamfetamine ή methylphenidate** αποτελούν πρώτες φαρμακολογικές επιλογές στους ενήλικες, με **atomoxetine** ως κύρια μη διεγερτική επιλογή μετά από δυσανεξία ή ανεπαρκή ανταπόκριση και στα δύο διεγερτικά. Πριν από φάρμακο ελέγχω καρδιαγγειακό ιστορικό, σφυγμό και αρτηριακή πίεση, βάρος, ψυχιατρική και σωματική συννοσηρότητα, αλληλεπιδράσεις και κίνδυνο κατάχρησης ή **παράνομης διάθεσης της συνταγογραφούμενης αγωγής σε τρίτους (diversion)**. Routine ECG δεν απαιτείται για κάθε ασθενή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR ενηλίκων:** τουλάχιστον 5 συμπτώματα στον inattentive ή hyperactive-impulsive τομέα, μαζί με τις λοιπές απαιτήσεις. Είναι DSM-specific αριθμητικό scaffold, όχι αυτόνομη διάγνωση.
- Αναπτυξιακό σημείο αναφοράς: **ορισμένα συμπτώματα πριν από τα 12 έτη**.
- Παιδική επίσημη διάγνωση, σχολικά αρχεία ή γονεϊκό collateral δεν είναι υποχρεωτικά· χρειάζεται όμως αξιόπιστο αναπτυξιακό ιστορικό.
- Η διάγνωση είναι αναπτυξιακή, αφορά περισσότερα από ένα πλαίσια και βασίζεται σε λειτουργική έκπτωση· **οι κλίμακες δεν επαρκούν**.
- **ADHD vs bipolar:** developmental/trait-like pattern έναντι episodic shift from baseline.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q59a. Τι κάνετε αν δεν υπάρχει σαφής τεκμηρίωση παιδικής έκπτωσης;

Διαχωρίζω την απουσία τεκμηρίων από την τεκμηριωμένη απουσία συμπτωμάτων. Υψηλή ικανότητα, έντονη εξωτερική δομή ή οικογενειακή υποστήριξη μπορεί να είχαν αντιρροπήσει τις δυσκολίες, ενώ τα παιδικά αρχεία μπορεί απλώς να μην υπάρχουν πλέον.

Ανασυνθέτω όσο γίνεται καλύτερα την παιδική λειτουργικότητα και αναζητώ επίμονα πρώιμα συμπτώματα χωρίς να απαιτώ προηγούμενη διάγνωση. Ωστόσο, **γνήσια de novo adult-onset ADHD δεν αποτελεί καθιερωμένη διάγνωση DSM-5-TR ή ICD-11**. Αν τα συμπτώματα φαίνονται πραγματικά νέα στην ενήλικη ζωή, επανεξετάζω τόσο ένα παραγνωρισμένο αναπτυξιακό ιστορικό όσο και εναλλακτικές εξηγήσεις, όπως διάθεση, άγχος, ύπνος, ουσίες ή γνωστική

διαταραχή.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Απαίτηση επίσημης παιδικής διάγνωσης ή σωζόμενων σχολικών εγγράφων.
- Διάγνωση από adult rating scale μόνο.
- Κάθε πρόβλημα συγκέντρωσης = ADHD.
- Χρόνια αναπτυξιακά συμπτώματα ως bipolar activation.
- Κάθε ιστορικό άγχους, tic ή SUD ως απόλυτη stimulant contraindication.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η παλαιότερη ICD-10 διδασκαλία χρησιμοποιούσε onset-before-7. Τα τρέχοντα DSM-5-TR και ICD-11 χρησιμοποιούν **συμπτώματα πριν από τα 12 έτη** ως αναπτυξιακό σημείο αναφοράς.

Πώς αξιολογείτε τον αυτισμό σε έναν ενήλικα;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Διά βίου αναπτυξιακό πρότυπο
- 2 Κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση
- 3 Περιορισμένα/επαναλαμβανόμενα και αισθητηριακά χαρακτηριστικά
- 4 Ανασύνθεση αναπτυξιακού ιστορικού
- 5 Λειτουργικότητα και προσαρμογή
- 6 Διαφορική διάγνωση και συννοσηρότητα
- 7 Masking/camouflaging χωρίς να γίνεται διαγνωστικό κριτήριο

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αξιολόγηση αυτισμού στον ενήλικα είναι **αναπτυξιακή εκτίμηση**, όχι διάγνωση ενός νέου συνδρόμου που ξεκίνησε στην ενήλικη ζωή. Πρέπει να τεκμηριώσω διά βίου πρότυπο που συνδυάζει διαφορές στην κοινωνική επικοινωνία/αλληλεπίδραση με περιορισμένα ή επαναλαμβανόμενα πρότυπα, επιμονή στην ομοιομορφία, εστιασμένα ενδιαφέροντα και/ή αισθητηριακές ιδιαιτερότητες, και να δείξω πώς επηρεάζει τη σημερινή λειτουργικότητα.

Ξεκινώ από την τρέχουσα εικόνα με αναπτυξιακό πλαίσιο. Στον κοινωνικό τομέα εξετάζω αμοιβαιότητα, κατανόηση και πλοήγηση κοινωνικών συμβάσεων, σχέσεις και τρόπο επικοινωνίας. Στον δεύτερο τομέα ρωτώ για ρουτίνες, δυσκολία στις αλλαγές, περιορισμένα ή ιδιαίτερα εστιασμένα ενδιαφέροντα, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και αισθητηριακές ευαισθησίες ή αναζήτηση αισθητηριακών ερεθισμάτων. **Και οι δύο τομείς έχουν σημασία**: κοινωνική δυσκολία μόνη της δεν αρκεί.

Στη συνέχεια ανασυνθέτω **παιδική και εφηβική ανάπτυξη**: σχέσεις με συνομηλίκους, τρόπο επικοινωνίας, παιχνίδι και ενδιαφέροντα, αντιδράσεις στις αλλαγές, αισθητηριακές εμπειρίες, σχολική πορεία και προσαρμογή. Ετεροαναφορικές πληροφορίες και παλαιά αρχεία βοηθούν όταν υπάρχουν, αλλά η απουσία τους δεν αποκλείει αυτόματα τη διάγνωση.

Η σημερινή λειτουργικότητα είναι εξίσου σημαντική: εκπαίδευση και εργασία, σχέσεις, ανεξάρτητη διαβίωση, καθημερινή οργάνωση και επίδραση αισθητηριακών ή περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Κάποιος μπορεί να λειτουργεί καλά σε πολύ δομημένο πλαίσιο αλλά να δυσκολεύεται έντονα όταν αυξάνονται οι κοινωνικές ή εκτελεστικές απαιτήσεις, γι' αυτό η εξωτερική επίδοση δεν αντικαθιστά την αξιολόγηση της προσπάθειας και της υποστήριξης που απαιτείται.

Η διαφορική και η συννοσηρότητα περιλαμβάνουν **κοινωνικό άγχος, ΔΕΠ-Υ, OCD, σχιζοειδή ή σχιζότυπα χαρακτηριστικά, ψύχωση και διαταραχή διανοητικής ανάπτυξης**, καθώς και διαταραχές διάθεσης/άγχους και άλλες συνυπάρχουσες καταστάσεις. Δεν προσπαθώ να εξηγήσω κάθε δυσκολία με μία μόνο διάγνωση. Ο αυτισμός μπορεί να συνυπάρχει με αυτές, αλλά το αυτιστικό πρότυπο πρέπει να παραμένει αναπτυξιακά συνεκτικό.

Δομημένα εργαλεία και ερωτηματολόγια μπορούν να υποστηρίξουν την

αξιολόγηση, αλλά κανένα AQ, ADOS, ADI-R, CAT-Q ή άλλο μεμονωμένο εργαλείο δεν διαγιγνώσκει ή αποκλείει αυτόνομα τον αυτισμό. Ερμηνεύονται μαζί με το αναπτυξιακό ιστορικό, την άμεση κλινική αξιολόγηση και τη λειτουργικότητα.

Στους ενήλικες εξετάζω επίσης **masking/camouflaging**. Ορισμένα άτομα καταστέλλουν ή αντισταθμίζουν ορατά αυτιστικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα μια σύντομη δομημένη συνάντηση να υποεκτιμά την εικόνα. Αυτό μπορεί να συμβάλει σε καθυστερημένη αναγνώριση, αλλά συμβαίνει σε όλα τα φύλα και **δεν αποτελεί διάγνωση ή διαγνωστικό κριτήριο**. Ομοίως, το «autistic burnout» είναι χρήσιμη βιωματική/ερευνητική έννοια και όχι τυπική διαγνωστική απαίτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q60a. Τι είναι masking ή camouflaging;

Είναι η καταστολή, απόκρυψη ή αντιστάθμιση παρατηρήσιμων αυτιστικών χαρακτηριστικών. Παραδείγματα είναι προετοιμασμένα conversational scripts, μίμηση συνομηλίκων, συνειδητή εκμάθηση κοινωνικών κανόνων, εξαναγκασμένη βλεμματική επαφή ή καταστολή stimming.

Μπορεί να μειώσει τα ορατά σημεία σε μια σύντομη δομημένη αξιολόγηση και να καθυστερήσει την αναγνώριση. Ωστόσο **δεν αποτελεί από μόνο του διάγνωση ή κριτήριο**, ούτε δικαιολογεί το στερεότυπο ότι «ο αυτισμός στις γυναίκες ορίζεται από masking». Είναι μέρος της διατύπωσης που πρέπει να υποστηρίζεται από το ευρύτερο αναπτυξιακό πρότυπο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ο αυτισμός είναι **διά βίου νευροαναπτυξιακή κατάσταση** με αναπτυξιακή έναρξη.
- Μετρούν και οι δύο τομείς: **κοινωνική επικοινωνία/αλληλεπίδραση** και **περιορισμένα/επαναλαμβανόμενα/αισθητηριακά χαρακτηριστικά**.
- Τα δομημένα εργαλεία υποστηρίζουν αλλά **δεν διαγιγνώσκουν ή αποκλείουν αυτόνομα**.
- Το masking μπορεί να αποκρύψει την εικόνα αλλά **δεν αντικαθιστά τη διαγνωστική τεκμηρίωση**.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση από CAT-Q, ADOS, ADI-R ή άλλο εργαλείο μόνο.
- Masking ως απόδειξη αυτισμού.
- Υπόθεση ότι camouflaging αφορά αποκλειστικά γυναίκες.
- «Autistic burnout» ως formal diagnostic criterion.
- Παράβλεψη αναπτυξιακού ιστορικού επειδή ο ασθενής είναι ενήλικας.

Πώς αξιολογείτε νέα ψυχιατρικά ή συμπεριφορικά συμπτώματα σε ενήλικα με διαταραχή διανοητικής ανάπτυξης;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Καθορισμός του αναπτυξιακού και προσαρμοστικού επιπέδου αναφοράς
- 2 Σαφής προσδιορισμός του τι έχει αλλάξει
- 3 Ετεροαναφορικές πληροφορίες και υποστήριξη της επικοινωνίας
- 4 Πρώτα αναζήτηση σωματικών αιτίων
- 5 Εκτίμηση ψυχιατρικών και περιβαλλοντικών παραγόντων
- 6 Έλεγχος φαρμακευτικών επιδράσεων
- 7 Διατύπωση κινδύνου και λιγότερο περιοριστική αντιμετώπιση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όταν ένας ενήλικας με διαταραχή διανοητικής ανάπτυξης εμφανίζει νέα ψυχιατρικά ή συμπεριφορικά συμπτώματα, ξεκινώ προσδιορίζοντας το **συνήθες επίπεδο λειτουργίας του και ακριβώς τι έχει αλλάξει**, αντί να θεωρήσω ότι η νέα συμπεριφορά αποτελεί απλώς μέρος της διαταραχής διανοητικής ανάπτυξης. Η διαγνωστική επισκίαση είναι σημαντικός κίνδυνος. Νέα επιθετικότητα, απόσυρση, διαταραχές ύπνου ή φαινομενικά ψυχιατρικά συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε πόνο, σωματική νόσο, φαρμακευτικές ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλαγές στο περιβάλλον ή σε πραγματική ψυχιατρική διαταραχή.

Η διαταραχή διανοητικής ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς στη **νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική συμπεριφορά**, με έναρξη κατά την αναπτυξιακή περίοδο. Η βαρύτητα, επομένως, δεν πρέπει να ανάγεται σε μία μόνο ζώνη IQ. Στην τρέχουσα εκτίμηση διευκρινίζω το συνήθες επίπεδο επικοινωνίας, προσαρμοστικής λειτουργικότητας, συμπεριφοράς, ύπνου, ανεξαρτησίας και αναγκών υποστήριξης και λαμβάνω ετεροαναφορικές πληροφορίες από φροντιστές ή συγγενείς που γνωρίζουν καλά το άτομο.

Το επόμενο ερώτημα είναι **τι άλλαξε, πότε και σε ποιο πλαίσιο**. Σε άτομα με περιορισμένη λεκτική επικοινωνία, η αλλαγή της συμπεριφοράς μπορεί να είναι η κύρια έκφραση δυσφορίας. Αναζητώ ενεργά πόνο και συχνά σωματικά αίτια, όπως οδοντιατρικά προβλήματα, δυσκοιλιότητα, επίσχεση ούρων ή ουρολοίμωξη, άλλη λοίμωξη, τραυματισμό, επιληπτικές κρίσεις, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και διαταραχή ύπνου. Φαρμακευτική τοξικότητα, στερητικά φαινόμενα και άλλα σωματικά αίτια πρέπει επίσης να εξετάζονται πριν αποδοθεί η εικόνα σε πρωτοπαθή ψυχιατρική διαταραχή.

Ο έλεγχος της φαρμακευτικής αγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή η πολυφαρμακία μπορεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά ή τη γνωστική λειτουργία. Εξετάζω πρόσφατες αλλαγές φαρμάκων, αντιχολινεργική επιβάρυνση, ακαθησία ή άλλες εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες και, όπου σχετίζεται, συμπεριφορικές ανεπιθύμητες ενέργειες αντιεπιληπτικών.

Αφού εκτιμηθούν τα σωματικά αίτια, εξετάζω ψυχιατρικά σύνδρομα με βάση το

συνήθες επίπεδο λειτουργίας και τον τρόπο επικοινωνίας του ατόμου, χωρίς να απαιτώ μια «τυπική» λεκτική περιγραφή. Συμπτώματα διάθεσης, ψύχωσης, άγχους ή άλλων διαταραχών μπορεί να χρειαστεί να συναχθούν εν μέρει από τη συμπεριφορά και τις ετεροαναφορικές πληροφορίες, αλλά το διαγνωστικό κατώφλι δεν πρέπει να χαμηλώνει επειδή το άτομο έχει διαταραχή διανοητικής ανάπτυξης. Παράλληλα, εξετάζω αλλαγές ρουτίνας, υπερβολικές απαιτήσεις, αισθητηριακό στρες, διαπροσωπικές συγκρούσεις και μη καλυπτόμενες ανάγκες που μπορεί να συντηρούν τη συμπεριφορά.

Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει κίνδυνο βλάβης προς τον εαυτό ή άλλους, ευλωτότητα, παραμέληση και ζητήματα προστασίας. Η διατύπωση του περιστατικού πρέπει να συνθέτει το αναπτυξιακό επίπεδο, την επικοινωνία, τους σωματικούς και ψυχιατρικούς παράγοντες, τη φαρμακευτική αγωγή, το περιβάλλον και τη λειτουργία της συμπεριφοράς.

Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι **η λιγότερο περιοριστική και να κατευθύνεται στο αίτιο**. Αντιμετωπίζω τη σωματική νόσο, βελτιστοποιώ την επικοινωνία και το περιβάλλον και χρησιμοποιώ ψυχολογικές ή συμπεριφορικές παρεμβάσεις όπου είναι εφικτό. Τα αντιψυχωσικά **δεν αποτελούν θεραπεία ρουτίνας για συμπεριφορά που προκαλεί σοβαρά προβλήματα**. Επιφυλάσσονται για σοβαρό κίνδυνο ή για περιπτώσεις στις οποίες κατάλληλες σωματικές, ψυχιατρικές, ψυχολογικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις έχουν αποτύχει ή δεν επαρκούν, με σαφώς καθορισμένο σύμπτωμα-στόχο, την ελάχιστη αποτελεσματική δόση και πρόωπη επανεκτίμηση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς θα προσεγγίζατε έναν ενήλικα με ελάχιστη λεκτική επικοινωνία που εμφανίζει νέα επιθετικότητα και αϋπνία;

Μια αιφνίδια αλλαγή σε επιθετικότητα και ύπνο την αντιμετωπίζω αρχικά ως πιθανή έκφραση πόνου ή σωματικής νόσου μέχρι να αποκλειστούν. Δίνω προτεραιότητα σε οδοντικό πόνο, δυσκοιλιότητα, ουρολογικά προβλήματα ή ουρολοίμωξη, άλλες λοιμώξεις, τραυματισμό, επιληπτικές κρίσεις, φαρμακευτικές επιδράσεις ή στέρηση, διαταραχή ύπνου και πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα ή κακοποίηση, αξιοποιώντας τη γνώση των φροντιστών για τη συνήθη συμπεριφορά του ατόμου.

Το βασικό λάθος θα ήταν να προχωρήσω άμεσα σε καταστολή ή αντιψυχωσική αγωγή χωρίς να έχω διερευνήσει γιατί άλλαξε η συμπεριφορά.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Ποια είναι η σημασία του συνδρόμου Down για τον κίνδυνο άνοιας;

Το σύνδρομο Down συνδέεται με πολύ υψηλό, αυξανόμενο με την ηλικία κίνδυνο παθολογίας Alzheimer και κλινικής άνοιας, που βιολογικά σχετίζεται εν μέρει με την τρισωμία του γονιδίου APP στο χρωμόσωμα 21. Δεν θα δίδασκα μία σταθερή ηλικία στην οποία η παθολογία Alzheimer γίνεται καθολική, επειδή ο χρόνος εμφάνισης και η κλινική έκφραση ποικίλλουν.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η σύγχρονη διάγνωση διαταραχής διανοητικής ανάπτυξης απαιτεί έκπτωση στη νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική λειτουργικότητα με αναπτυξιακή έναρξη· η βαρύτητα δεν ταξινομείται μόνο με άκαμπτες ζώνες IQ.
- Αποφύγετε τη **διαγνωστική επισκίαση**.
- Σε νέα αλλαγή συμπεριφοράς, σκεφτείτε **πρώτα σωματικό αίτιο**.
- Στο σύνδρομο Down, η παθολογία και ο κίνδυνος Alzheimer αυξάνονται έντονα με την ηλικία· μην χρησιμοποιείτε έναν καθολικό κανόνα «έως τα 40».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Παλαιότερα μοντέλα βαρύτητας βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε ζώνες IQ. Η σύγχρονη εκτίμηση συνδυάζει τη νοητική λειτουργία με την προσαρμοστική λειτουργικότητα και τις ανάγκες υποστήριξης.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε την ψυχογενή ανορεξία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Περιορισμός της πρόσληψης με σημαντικά χαμηλό σωματικό βάρος
- 2 Επίμονες συμπεριφορές που εμποδίζουν την αποκατάσταση του βάρους / φόβος αύξησης βάρους
- 3 Χαρακτηριστική ψυχοπαθολογία γύρω από το βάρος και το σχήμα σώματος
- 4 Εκτίμηση σωματικού και ψυχιατρικού κινδύνου
- 5 Διατροφική αποκατάσταση και επανάκτηση βάρους
- 6 Εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία για διαταραχές πρόσληψης τροφής
- 7 Περιορισμένος επικουρικός ρόλος της φαρμακοθεραπείας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ψυχογενής ανορεξία διαγιγνώσκεται από τον συνδυασμό σημαντικά χαμηλού σωματικού βάρους, επίμονου περιορισμού της πρόσληψης ή συμπεριφορών που εμποδίζουν την αποκατάσταση του βάρους, και χαρακτηριστικής ψυχοπαθολογίας σχετικά με το βάρος και το σχήμα σώματος. Δεν χρησιμοποιώ BMI κάτω από 17,5 ούτε την αμηνόρροια ως καθολικές σύγχρονες διαγνωστικές προϋποθέσεις. Η αντιμετώπιση συνδυάζει εκτίμηση του σωματικού κινδύνου, διατροφική αποκατάσταση και επανάκτηση βάρους, εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία και συνεχή σωματική παρακολούθηση.

Διερευνώ άμεσα το σύνδρομο της διαταραχής πρόσληψης τροφής: την έκταση και τη διάρκεια του διατροφικού περιορισμού, τις συμπεριφορές που εμποδίζουν την πρόσληψη βάρους, τον φόβο αύξησης του βάρους, καθώς και τη διαταραχή ή υπεραξιολόγηση του βάρους και του σχήματος σώματος. Το βάρος πρέπει να ερμηνεύεται μέσα στο συνολικό κλινικό πλαίσιο και όχι να ανάγεται σε ένα μόνο αριθμητικό όριο.

Στη συνέχεια εκτιμώ την πορεία και τη βαρύτητα. Πρωτί για τον ρυθμό απώλειας βάρους, την τρέχουσα πρόσληψη, τη σωματική άσκηση, επεισόδια υπερφαγίας ή καθαρτικές/αντιρροπιστικές συμπεριφορές, εμέτους και άλλες πρακτικές που αποσκοπούν στην αποτροπή αύξησης βάρους, καθώς και για την ικανότητα διατήρησης επαρκούς ενυδάτωσης και θρέψης. Ο σωματικός και ο ψυχιατρικός κίνδυνος αξιολογούνται παράλληλα, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργικής έκπτωσης, του αυτοτραυματισμού, του κινδύνου αυτοκτονίας και της σχετικής συννοσηρότητας.

Η σωματική εκτίμηση πρέπει να είναι ανάλογη της βαρύτητας και να περιλαμβάνει ζωτικά σημεία, κατάσταση ενυδάτωσης και στοχευμένο παρακλινικό έλεγχο, όπως ΗΚΓ και ηλεκτρολύτες όταν ενδείκνυται. Ένας ασθενής μπορεί να βρίσκεται σε υψηλό ιατρικό κίνδυνο λόγω ταχείας απώλειας βάρους, φυσιολογικής αστάθειας ή βιοχημικών διαταραχών, ακόμη και όταν μία μεμονωμένη μέτρηση βάρους δεν φαίνεται ακραία.

Η θεραπεία έχει τρεις αλληλένδετους άξονες. Πρώτον, **διατροφική αποκατάσταση**

και επανάκτηση βάρους, με ιατρική παρακολούθηση ανάλογη του κινδύνου. Δεύτερον, εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία για τη διαταραχή πρόσληψης τροφής. Στους ενήλικες, τεκμηριωμένες επιλογές περιλαμβάνουν **CBT-ED**, **MANTRA** και **SSCM**. Τρίτον, αντιμετώπιση των συννοσηρών ψυχιατρικών και σωματικών προβλημάτων και των κοινωνικών ή λειτουργικών συνεπειών της νόσου.

Η φαρμακοθεραπεία δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως αυτόνομη θεραπεία του πυρήνα της διαταραχής. Μπορεί να χρησιμοποιείται για σαφώς διαγνωσμένη συννοσηρότητα όταν ενδείκνυται, αλλά δεν υποκαθιστά τη διατροφική αποκατάσταση ή την εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία. Φάρμακα εκτός εγκεκριμένης ένδειξης, όπως η ολανζαπίνη, μπορεί να εξετάζονται σε επιλεγμένες περιπτώσεις και σε εξειδικευμένο πλαίσιο, αλλά δεν αποτελούν καθιερωμένη θεραπεία του πυρήνα της ψυχογενούς ανορεξίας.

Συνολικά, αναγνωρίζω τη σύγχρονη διαγνωστική αρχιτεκτονική χωρίς παρωχημένες απαιτήσεις αμηνόρροιας ή σταθερού BMI, εκτιμώ προσεκτικά τον σωματικό και ψυχιατρικό κίνδυνο και οργανώνω συντονισμένη διατροφική, ψυχοθεραπευτική και ιατρική φροντίδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q62a. Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την ARFID από την ψυχογενή ανορεξία;

Στη διαταραχή αποφευκτικής/περιοριστικής πρόσληψης τροφής (ARFID), ο περιορισμός μπορεί να οφείλεται σε αισθητηριακή ευαισθησία, φόβο δυσάρεστων συνεπειών ή χαμηλό ενδιαφέρον ή όρεξη για φαγητό. Οι συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλό βάρος ή απώλεια βάρους, διατροφικές ανεπάρκειες, εξάρτηση από συμπληρώματα ή εντερική σίτιση ή σημαντική ψυχοκοινωνική επιβάρυνση.

Η κρίσιμη διάκριση είναι ότι η ARFID δεν καθοδηγείται από υπεραξιολόγηση του βάρους ή του σχήματος σώματος ούτε από φόβο πάχυνσης. Τα δεδομένα θεραπείας στους ενήλικες είναι λιγότερο ώριμα, επομένως η αντιμετώπιση πρέπει να είναι πολυεπιστημονική, να διορθώνει τις ιατρικές και διατροφικές συνέπειες και να χρησιμοποιεί συμπεριφορικές ή CBT-βασισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στον συγκεκριμένο μηχανισμό που συντηρεί τον περιορισμό, αντί να θεωρεί ότι υπάρχει μία καθολική επώνυμη ψυχοθεραπεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η αμηνόρροια δεν απαιτείται για τη διάγνωση της ψυχογενούς ανορεξίας.
- Δεν υπάρχει καθολικό σταθερό διαγνωστικό όριο BMI.
- Οι κατηγορίες BMI του DSM, όπου χρησιμοποιούνται, είναι προσδιοριστές βαρύτητας και όχι διαγνωστικά όρια· η κλινική βαρύτητα μπορεί να αποκλίνει από το BMI.
- Η ARFID διακρίνεται από την απουσία ψυχοπαθολογίας βάρους/σχήματος σώματος ως κινητήριου παράγοντα του περιορισμού.
- Η φαρμακοθεραπεία δεν αποτελεί πρωταρχική θεραπεία του πυρήνα της ψυχογενούς ανορεξίας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση ψυχογενούς ανορεξίας μόνο από το BMI.
- Αντιμετώπιση ενός προσδιοριστή βαρύτητας BMI του DSM ως διαγνωστικού ορίου.
- Απαίτηση αμηνόρροιας.
- Υπόθεση ότι η φαρμακοθεραπεία υποκαθιστά τη διατροφική αποκατάσταση και την εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η παλαιότερη διδασκαλία του ICD-10 έδινε ιδιαίτερη έμφαση σε όρια BMI και στην αμηνόρροια. Η σύγχρονη διάγνωση δεν πρέπει να εξαρτάται καθολικά από κανένα από τα δύο.

Πώς αντιμετωπίζετε την ψυχογενή ανορεξία με σοβαρή σωματική επιβάρυνση;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Η φυσιολογική αστάθεια αντιμετωπίζεται ως ιατρικό επείγον
- 2 Πολυδιάστατη εκτίμηση κινδύνου με το MEED
- 3 Ζωτικά σημεία, ΗΚΓ, βιοχημικός έλεγχος και γλυκόζη
- 4 Κλιμάκωση της φροντίδας ή εισαγωγή όταν ο ασθενής δεν είναι ιατρικά ασφαλής
- 5 Αναγνώριση του κινδύνου συνδρόμου επανασίτισης
- 6 Θειαμίνη και διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών
- 7 Παρακολουθούμενη επανασίτιση ανάλογα με τον κίνδυνο

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ψυχογενής ανορεξία με σοβαρή σωματική επιβάρυνση αποτελεί **ιατρικό επείγον** όταν υπάρχει φυσιολογική αστάθεια ή δυσλειτουργία οργάνων, και η αντιμετώπιση απαιτεί στενό συντονισμό ιατρικής και ψυχιατρικής ομάδας. Η σύγχρονη εκτίμηση κινδύνου είναι πολυδιάστατη και δεν βασίζεται μόνο στο BMI. Αναγνωρίζω άμεσα την αστάθεια, διενεργώ επείγουσα φυσιολογική και βιοχημική εκτίμηση, καθορίζω το κατάλληλο επίπεδο ιατρικής φροντίδας και αρχίζω παρακολουθούμενη διατροφική αποκατάσταση με ενεργή πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών της επανασίτισης.

Το σύγχρονο πλαίσιο είναι το **MEED**, το οποίο έχει αντικαταστήσει το παλαιότερο MARSIPAN και συνδυάζει πολλαπλούς τομείς κινδύνου. Εκτιμώ τον ρυθμό και την έκταση της απώλειας βάρους, την πρόσφατη πρόσληψη και τον περιορισμό, την ενυδάτωση, την αδυναμία και τη λειτουργική έκπτωση, μαζί με τον σφυγμό, την αρτηριακή πίεση και τις ορθοστατικές μεταβολές, τη θερμοκρασία, τη γλυκόζη, το ΗΚΓ και τις σχετικές βιοχημικές παραμέτρους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν η έντονη βραδυκαρδία, η υπόταση ή ορθοστατική αστάθεια, η υποθερμία, η αφυδάτωση, η συγκοπή, οι ηλεκτροκαρδιογραφικές ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές, η υπογλυκαιμία, η ταχεία απώλεια βάρους, ο σοβαρός περιορισμός της πρόσληψης, η λοίμωξη, η έντονη αδυναμία και ενδείξεις δυσλειτουργίας οργάνων. Χρήσιμα παραδείγματα **κόκκινης ζώνης κινδύνου** στους ενήλικες είναι BMI κάτω από 13 kg/m², σφυγμός κατά την αφύπνιση κάτω από 40/min, θερμοκρασία κάτω από 35,5°C και γλυκόζη κάτω από 3,0 mmol/L. Πρόκειται για αξιομνημόνευτους δείκτες κινδύνου μέσα σε ένα πολυδιάστατο πλαίσιο και όχι για μεμονωμένα κριτήρια εισαγωγής.

Επείγουσα ιατρική εισαγωγή ή κλιμάκωση της φροντίδας απαιτείται όταν υπάρχει φυσιολογική αστάθεια, σοβαρή βιοχημική ή ηλεκτροκαρδιογραφική επιβάρυνση, αδυναμία διατήρησης ασφαλούς ενυδάτωσης ή θρέψης, σοβαρός κίνδυνος επανασίτισης ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που καθιστά τον ασθενή ιατρικά μη ασφαλής. Ένας ιατρικά ασταθής ασθενής δεν πρέπει να παραμένει σε ακατάλληλο αμιγώς ψυχιατρικό πλαίσιο μόνο επειδή η υποκείμενη νόσος είναι διαταραχή πρόσληψης τροφής.

Κύριος θεραπευτικός κίνδυνος είναι το **σύνδρομο επανασίτισης**. Η επανασίτιση μπορεί να προκαλέσει μεταβολές φωσφόρου, καλίου και μαγνησίου, διαταραχές υγρών και έλλειψη θειαμίνης, με δυνητικές αρρυθμίες, νευρολογική επιδείνωση και ανεπάρκεια οργάνων. Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου χρειάζονται θειαμίνη και πολυβιταμινούχο σκεύασμα πριν ή μαζί με την έναρξη σίτισης, στενή παρακολούθηση φωσφόρου, καλίου, μαγνησίου, γλυκόζης και ισοζυγίου υγρών και ενεργή διόρθωση τυχόν διαταραχών.

Η σύγχρονη αρχή είναι η **επανασίτιση ανάλογα με τον κίνδυνο, με ενεργή παρακολούθηση**, και όχι η παρατεταμένη ακραία υποσίτιση ως καθολική στρατηγική ασφάλειας. Οι ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου εξακολουθούν να χρειάζονται προσεκτική έναρξη από εξειδικευμένη ομάδα, αλλά δεν υπάρχει ένα ενιαίο θερμιδικό σχήμα ή εργαστηριακό χρονοδιάγραμμα που πρέπει να απομνημονεύεται ως καθολικό. Το πλάνο εξαρτάται από τη βαρύτητα, το θεραπευτικό πλαίσιο και το τοπικό πρωτόκολλο.

Η πρακτική απάντηση είναι επομένως: έγκαιρη αναγνώριση της ιατρικής αστάθειας, πολυδιάστατη εκτίμηση κατά MEED, κλιμάκωση στο κατάλληλο ιατρικό επίπεδο φροντίδας, πρόληψη των επιπλοκών επανασίτισης με θειαμίνη και παρακολούθηση ηλεκτρολυτών και αποκατάσταση της θρέψης υπό εξειδικευμένη παρακολούθηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Το **MEED αντικαθιστά το MARSIPAN** ως το σύγχρονο πλαίσιο εκτίμησης κινδύνου.
- Χρήσιμα παραδείγματα κόκκινης ζώνης κινδύνου στους ενήλικες: **BMI <13 kg/m²**, **σφυγμός κατά την αφύπνιση <40/min**, **θερμοκρασία <35,5°C**, **γλυκόζη <3,0 mmol/L**.
- Πρόκειται για **δείκτες κινδύνου και όχι αυτοτελή κριτήρια εισαγωγής**.
- Ο κίνδυνος επανασίτισης αφορά διαταραχές φωσφόρου, καλίου, μαγνησίου, υγρών και θειαμίνης.
- Θειαμίνη και στενή παρακολούθηση φωσφόρου/K/Mg/γλυκόζης/υγρών είναι βασικές αρχές στην επανασίτιση υψηλού κινδύνου· τα ακριβή σχήματα αναπλήρωσης και σίτισης εξαρτώνται από τον κίνδυνο και το πλαίσιο.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Χρήση του BMI ως μοναδικού κριτηρίου ιατρικής ασφάλειας.
- Αντιμετώπιση ενός μόνο κόκκινου δείκτη MEED ως αυτόματου κριτηρίου εισαγωγής χωρίς το συνολικό κλινικό πλαίσιο.
- Χρήση ενός άκαμπτου ορίου QTc ως ολόκληρης της εκτίμησης κινδύνου.
- Απομνημόνευση ενός καθολικού θερμιδικού σχήματος επανασίτισης.
- Παράλειψη γλυκόζης, φωσφόρου, μαγνησίου ή θειαμίνης.
- Παραμονή ιατρικά ασταθούς ασθενούς σε αμιγώς ψυχιατρικό πλαίσιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το παλαιότερο MARSIPAN και οι πολύ αργές καθολικές στρατηγικές σίτισης έχουν αντικατασταθεί από **πολυδιάστατη εκτίμηση κινδύνου κατά MEED και**

παρακολουθούμενη επανασίτιση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο.

Πώς διαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε την ψυχογενή βουλιμία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας με απώλεια ελέγχου
- 2 Επαναλαμβανόμενες αντιρροπιστικές συμπεριφορές
- 3 Υπεραξιολόγηση βάρους και σχήματος σώματος
- 4 Εκτίμηση του σωματικού κινδύνου από καθαρτικές συμπεριφορές
- 5 CBT προσαρμοσμένη στις διαταραχές πρόσληψης τροφής
- 6 Φλουοξετίνη 60 mg/ημέρα μόνο επικουρικά

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ψυχογενής βουλιμία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας με απώλεια ελέγχου, επαναλαμβανόμενες αντιρροπιστικές συμπεριφορές και υπερβολική επίδραση του βάρους ή του σχήματος σώματος στην αυτοαξιολόγηση. Η βασική διαγνωστική διάκριση από την ψυχογενή ανορεξία είναι ότι, εάν το άτομο πληροί τη διαγνωστική αρχιτεκτονική της ψυχογενούς ανορεξίας με σημαντικά χαμηλό βάρος, η διάγνωση παραμένει ψυχογενής ανορεξία και όχι ψυχογενής βουλιμία. Η αντιμετώπιση συνδυάζει εκτίμηση του σωματικού κινδύνου με CBT για διαταραχές πρόσληψης τροφής, ενώ η φαρμακοθεραπεία έχει επικουρικό ρόλο όπου ενδείκνυται.

Αρχικά διευκρινίζω το πρότυπο της υπερφαγίας: εάν τα επεισόδια συνοδεύονται από υποκειμενική ή αντικειμενική αίσθηση υπερβολικής πρόσληψης και, κυρίως, από απώλεια ελέγχου, καθώς και πώς συνδέονται με τον περιορισμό της πρόσληψης, τις συναισθηματικές καταστάσεις και τις αντιρροπιστικές συμπεριφορές. Στη συνέχεια ρωτώ για αυτοπροκαλούμενους εμέτους, κατάχρηση καθαρτικών ή διουρητικών, νηστεία και υπερβολική άσκηση και εκτιμώ πόσο το βάρος και το σχήμα σώματος κυριαρχούν στην αυτοαξιολόγηση.

Δεν χρησιμοποιώ ένα άκαμπτο όριο BMI για να διαχωρίσω τη βουλιμία από την ανορεξία. Το διαγνωστικό ερώτημα είναι εάν το συνολικό σύνδρομο αντιστοιχεί σε ψυχογενή ανορεξία με σημαντικά χαμηλό βάρος και την αντίστοιχη αρχιτεκτονική περιορισμού/αποτροπής αύξησης βάρους, ή σε ψυχογενή βουλιμία χωρίς αυτό το πλαίσιο.

Η σωματική εκτίμηση εστιάζει ιδιαίτερα στις συνέπειες των καθαρτικών συμπεριφορών. Οι επαναλαμβανόμενοι έμετοι ή άλλες αντιρροπιστικές συμπεριφορές μπορεί να προκαλέσουν υποκαλιαιμία και άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αφυδάτωση και κίνδυνο αρρυθμιών ή προβλημάτων σχετιζόμενων με το QT. Ρωτώ για οδοντιατρικές και γαστρεντερικές επιπλοκές και ζητώ ηλεκτρολύτες και ΗΚΓ όταν ενδείκνυται κλινικά.

Η ψυχιατρική εκτίμηση περιλαμβάνει κατάθλιψη, άγχος, αυτοτραυματισμό ή κίνδυνο αυτοκτονίας, χρήση ουσιών και άλλες συννοσηρότητες. Η ντροπή συχνά είναι έντονη, επομένως χρειάζεται άμεση και μη επικριτική διερεύνηση.

Ο θεραπευτικός κορμός είναι CBT προσαρμοσμένη στις διαταραχές πρόσληψης

τροφής. Μια κλιμακωτή προσέγγιση μπορεί να αρχίζει με καθοδηγούμενη αυτοβοήθεια εστιασμένη στη βουλιμία και να προχωρά σε ατομική CBT-ED όταν χρειάζεται. Η θεραπεία στοχεύει στην τακτική λήψη γευμάτων, στον κύκλο υπερφαγίας–περιορισμού–αντιρρόπησης, στην υπεραξιολόγηση του βάρους και του σχήματος σώματος και στην πρόληψη υποτροπής, και όχι μόνο στη διακοπή των εμέτων.

Η φαρμακοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία. Στους ενήλικες, η **φλουοξετίνη 60 mg/ημέρα** είναι έγκυρο εξεταστικό δεδομένο ως **επικουρική θεραπεία στην ψυχοθεραπεία** για τη μείωση της υπερφαγίας και των καθαρτικών συμπεριφορών. Η βουπροπιόνη αντενδείκνυται σε άτομα με τρέχουσα ή προηγούμενη ψυχογενή ανορεξία ή βουλιμία, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες προϊόντος, λόγω κινδύνου επιληπτικών κρίσεων. Πρόκειται για ζήτημα συνταγογραφικής ασφάλειας και όχι για θεραπευτική επιλογή της διαταραχής.

Η πρακτική προσέγγιση είναι επομένως ο ακριβής προσδιορισμός του συνδρόμου υπερφαγίας–αντιρρόπησης, η εκτίμηση των σωματικών συνεπειών των καθαρτικών συμπεριφορών, η διαφοροδιάγνωση από την ψυχογενή ανορεξία χωρίς άκαμπτο όριο BMI και η εφαρμογή CBT με φλουοξετίνη μόνο επικουρικά όπου ενδείκνυται.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DSM-5-TR:** υπερφαγία και αντιρροπιστικές συμπεριφορές τουλάχιστον **μία φορά την εβδομάδα για 3 μήνες**. Πρόκειται για αριθμητικό πλαίσιο ειδικό για το DSM.
- **Φλουοξετίνη 60 mg/ημέρα:** τεκμηριωμένη **επικουρική** θεραπεία στην ψυχογενή βουλιμία ενηλίκων· δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία.
- **Βουπροπιόνη:** αντενδείκνυται σε τρέχουσα ή προηγούμενη ψυχογενή ανορεξία ή βουλιμία στις σχετικές πληροφορίες προϊόντος λόγω κινδύνου επιληπτικών κρίσεων.
- Η διάκριση AN–BN βασίζεται στο εάν πληρούνται η **αρχιτεκτονική της ψυχογενούς ανορεξίας με χαμηλό βάρος**, όχι σε ένα μόνο όριο BMI.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση βουλιμίας μόνο από την υπερφαγία, χωρίς αντιρροπιστικές συμπεριφορές και ψυχοπαθολογία βάρους/σχήματος.
- Χρήση ενός αριθμού BMI ως ορίου μεταξύ ανορεξίας και βουλιμίας.
- Χρήση της φλουοξετίνης ως μοναδικής θεραπείας.
- Χορήγηση βουπροπιόνης σε ασθενή με τρέχουσα ή προηγούμενη ψυχογενή ανορεξία/βουλιμία χωρίς αναγνώριση της αντένδειξης λόγω κινδύνου επιληπτικών κρίσεων.

Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε τη χρόνια αϋπνία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επιβεβαίωση αϋπνίας παρά την επαρκή δυνατότητα για ύπνο
- 2 Τεκμηρίωση επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας
- 3 Διερεύνηση ωραρίου, ουσιών, φαρμάκων και συννοσηρότητας
- 4 Αποκλεισμός άλλων διαταραχών ύπνου
- 5 CBT-I ως βασική θεραπεία
- 6 Επιλεκτική χρήση φαρμακοθεραπείας
- 7 Επανεκτίμηση της επιμονής και των διαιωνιστικών παραγόντων

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η χρόνια αϋπνία είναι επίμονη δυσκολία στην επέλευση ή τη διατήρηση του ύπνου ή υπερβολικά πρώιμη αφύπνιση **παρά την επαρκή δυνατότητα για ύπνο**, με ουσιαστικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αρχικά καθορίζω το πρότυπο ύπνου και αποκλείω άλλη διαταραχή ύπνου, σωματική ή ψυχιατρική νόσο, καθώς και αιτίες σχετιζόμενες με ουσίες ή φάρμακα. **Η CBT-I είναι η προτιμώμενη μακροχρόνια θεραπεία πρώτης γραμμής· η υγιεινή ύπνου από μόνη της δεν αποτελεί επαρκές θεραπευτικό πρόγραμμα.**

Διευκρινίζω την έναρξη και τη διάρκεια, τη συνήθη ώρα κατάκλισης και αφύπνισης, τον χρόνο που ο ασθενής παραμένει ξύπνιος στο κρεβάτι, τις νυχτερινές αφύπνισεις, τους ημερήσιους ύπνους και τις διαφορές μεταξύ εργάσιμων και ελεύθερων ημερών. Ένα **ημερολόγιο ύπνου** μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση της αϋπνίας από ένα ακανόνιστο πρόγραμμα ή μια κιρκάδια διαταραχή. Ρωτώ επίσης για καφεΐνη, αλκοόλ και άλλες ουσίες, συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πόνο, συμπτώματα διάθεσης και άγχους και περιβαλλοντικούς ή συμπεριφορικούς παράγοντες που συντηρούν το πρόβλημα.

Η διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνει ανεπαρκή ευκαιρία για ύπνο, αποφρακτική υπνική άπνοια, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, διαταραχές κιρκάδιου ρυθμού και διαταραχή ύπνου δευτεροπαθή σε σωματική ή ψυχιατρική νόσο. Το ζητούμενο είναι να διαγνωστεί η διαταραχή ύπνου και όχι απλώς να αντιμετωπιστεί το παράπονο «δεν κοιμάμαι».

Η κύρια θεραπεία είναι η **γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία (CBT-I)**. Περιλαμβάνει έλεγχο ερεθισμάτων, **περιορισμό ή συμπίεση του χρόνου στο κρεβάτι**, γνωσιακή δουλειά πάνω σε δυσλειτουργικές πεποιθήσεις για τον ύπνο και στρατηγικές πρόληψης υποτροπής. Ο περιορισμός του χρόνου στο κρεβάτι τον φέρνει πιο κοντά στον πραγματικό χρόνο ύπνου και αυξάνει την **ομοιοστατική πίεση για ύπνο**, ενώ ο έλεγχος ερεθισμάτων επανασυνδέει το κρεβάτι και το υπνοδωμάτιο με τον ύπνο και όχι με παρατεταμένη εγρήγορση. Η υγιεινή ύπνου αποτελεί χρήσιμο υποστηρικτικό στοιχείο, αλλά από μόνη της συνήθως δεν αντιμετωπίζει τη μαθημένη υπερδιέγερση και τους συμπεριφορικούς κύκλους που συντηρούν τη χρόνια αϋπνία.

Η φαρμακοθεραπεία έχει πιο επιλεκτικό ρόλο. Υπνωτικά μπορεί να εξεταστούν όταν η CBT-I δεν είναι διαθέσιμη, δεν είναι κατάλληλη, απορρίπτεται ή αποδεικνύεται ανεπαρκής, αλλά η χρόνια χορήγηση βενζοδιαζεπινών ή Z-drugs δεν πρέπει να αποτελεί τη συνήθη προεπιλογή. Η επιλογή φαρμάκου εξατομικεύεται στο κλινικό πλαίσιο και δεν υποκαθιστά την αξιολόγηση της υποκείμενης διαταραχής ύπνου.

Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή επιλογή είναι η **daridorexant**, διπλός **ανταγωνιστής των υποδοχέων ορεξίνης OX1/OX2**, που μειώνει την ώθηση προς εγρήγορση. Έχει εγκριθεί για αϋπνία ενηλίκων διάρκειας τουλάχιστον **3 μηνών** με επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών και εξάρτησης διαφέρει από εκείνο των βενζοδιαζεπινών, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως φάρμακο χωρίς δυνατότητα έκπτωσης ή προβλημάτων που σχετίζονται με εξάρτηση. Αντενδείκνυται στη ναρκοληψία.

Η συνολική προσέγγιση είναι επομένως να ορίσω με ακρίβεια το σύνδρομο της αϋπνίας, να το διακρίνω από την ανεπαρκή δυνατότητα για ύπνο και άλλες διαταραχές ύπνου, να χρησιμοποιήσω την CBT-I ως κεντρική μακροχρόνια θεραπεία και να προσθέσω επιλεγμένη φαρμακοθεραπεία μόνο όταν δικαιολογείται κλινικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q65a. Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε τη διαταραχή καθυστερημένης φάσης ύπνου-εγρήγορσης από την αϋπνία;

Η διαταραχή καθυστερημένης φάσης ύπνου-εγρήγορσης είναι μια **κιρκάδια καθυστέρηση**: το άτομο δυσκολεύεται να αποκοιμηθεί και να ξυπνήσει στις συμβατικές ώρες, αλλά μπορεί να έχει φυσιολογική ποιότητα και διάρκεια ύπνου όταν του επιτρέπεται να ακολουθεί το προτιμώμενο, πιο όψιμο ωράριό του. Στην αϋπνία, η δυσκολία ύπνου επιμένει παρά την κατάλληλη χρονική τοποθέτηση και την επαρκή ευκαιρία για ύπνο.

Η αντιμετώπιση βασίζεται στη σταθεροποίηση του ωραρίου και σε κατάλληλα χρονισμένες κιρκάδιες παρεμβάσεις, όπως μελατονίνη και φως, σε γενικό επίπεδο. Δεν θα έδινα ένα άκαμπτο καθολικό πρωτόκολλο χρονισμού χωρίς εξατομικευμένη εκτίμηση της φάσης ύπνου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Χρόνια αϋπνία: δυσκολία ύπνου τουλάχιστον **3 νύχτες την εβδομάδα για τουλάχιστον 3 μήνες**, παρά επαρκή δυνατότητα για ύπνο, με επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Η CBT-I είναι η προτιμώμενη μακροχρόνια θεραπεία πρώτης γραμμής· η υγιεινή ύπνου από μόνη της δεν επαρκεί.
- Ο περιορισμός του χρόνου στο κρεβάτι αυξάνει την **ομοιοστατική πίεση για ύπνο**· ο έλεγχος ερεθισμάτων επανασυνδέει το κρεβάτι με τον ύπνο αντί με την εγρήγορση.
- **Daridorexant**: διπλός ανταγωνιστής των υποδοχέων ορεξίνης OX1/OX2, εγκεκριμένος στην ΕΕ για επιλεγμένους ενήλικες με χρόνια αϋπνία και ημερήσιες επιπτώσεις.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση αϋπνίας χωρίς να έχει τεκμηριωθεί επαρκής δυνατότητα για ύπνο.
- Αντιμετώπιση της υγιεινής ύπνου ως πλήρους προγράμματος CBT-I.
- Προεπιλογή χρόνιας αγωγής με βενζοδιαζεπίνη ή Z-drug.
- Ισχυρισμός ότι οι διπλοί ανταγωνιστές ορεξίνης έχουν μηδενική πιθανότητα ανοχής, εξάρτησης ή έκπτωσης την επόμενη ημέρα.
- Παρουσίαση της lemborexant ως συνήθους ευρωπαϊκής επιλογής χωρίς τρέχουσα επαλήθευση της έγκρισης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η CBT-I παραμένει η προτιμώμενη μακροχρόνια θεραπεία πρώτης γραμμής. Σύγχρονη εξέλιξη είναι ότι η **daridorexant αποτελεί πραγματική ευρωπαϊκή φαρμακολογική επιλογή** για επιλεγμένες περιπτώσεις χρόνιας αϋπνίας, πέρα από το παλαιότερο πλαίσιο που περιοριζόταν στην CBT-I και στα παραδοσιακά υπνωτικά.

Πώς αξιολογείτε την υπερβολική ημερήσια υπνηλία και πώς αναγνωρίζετε τη ναρκοληψία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επιβεβαίωση πραγματικής ημερήσιας υπνηλίας
- 2 Αποκλεισμός ανεπαρκούς ύπνου, OSA, φαρμάκων και κιρκάδιων αιτίων
- 3 Διερεύνηση καταπληξίας και φαινομένων REM
- 4 Διάκριση ναρκοληψίας τύπου 1 από τύπο 2
- 5 Ολονύκτια PSG και στη συνέχεια MSLT
- 6 Αντιμετώπιση σε εξειδικευμένο πλαίσιο ιατρικής ύπνου

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η υπερβολική ημερήσια υπνηλία είναι σύμπτωμα, επομένως πρώτα πρέπει να επιβεβαιώσω ότι ο ασθενής είναι πράγματι υπνηλικός και να αναζητήσω συχνές εναλλακτικές αιτίες πριν διαγνώσω ναρκοληψία. Αποκλείω ανεπαρκή ύπνο, αποφρακτική υπνική άπνοια, κατασταλτικά φάρμακα, κιρκάδια διαταραχή, κατάθλιψη ή σωματική νόσο και στη συνέχεια αναζητώ ειδικά χαρακτηριστικά ναρκοληψίας. **Η καταπληξία είναι το ισχυρότερο κλινικό διακριτικό στοιχείο για τη ναρκοληψία τύπου 1.**

Ξεκινώ από το ιστορικό ύπνου: συνολική δυνατότητα για ύπνο, συνήθες ωράριο, ημερήσιους ύπνους, εργασία σε βάρδιες, ροχαλητό ή μαρτυρούμενες άπνοιες, κατασταλτικά και άλλα φάρμακα, αλκοόλ και άλλες ουσίες. Διευκρινίζω επίσης αν το κύριο ενόχλημα είναι υπνηλία και όχι κόπωση ή μειωμένο κίνητρο. Η κιρκάδια καθυστέρηση και η χρόνια ανεπαρκής διάρκεια ύπνου είναι συχνοί μιμητές και πρέπει να διακρίνονται από μια ενδογενή διαταραχή υπερυπνίας.

Η ναρκοληψία χαρακτηρίζεται από επίμονη υπερβολική υπνηλία με ακατανίκητα επεισόδια ύπνου. Ρωτώ ειδικά για **καταπληξία** — σύντομα επεισόδια απώλειας μυϊκού τόνου που εκλύονται από συναίσθημα, συνήθως με διατηρημένη συνείδηση — καθώς και για υπνική παράλυση και υπναγωγικές ή υπνοπομπικές ψευδαισθήσεις. Αυτά τα φαινόμενα REM υποστηρίζουν τη διάγνωση, αλλά η παλαιά «κλασική τετράδα» δεν απαιτείται σε κάθε ασθενή.

Η σύγχρονη ταξινόμηση διακρίνει δύο κύριες μορφές. Η **ναρκοληψία τύπου 1** συνδέεται με καταπληξία και/ή ανεπάρκεια υποκρετίνης/ορεξίνης μέσα στο κατάλληλο διαγνωστικό πλαίσιο. Η **ναρκοληψία τύπου 2** δεν συνοδεύεται από καταπληξία ούτε από επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια υποκρετίνης. Το HLA-DQB1*06:02 σχετίζεται ισχυρά με τη ναρκοληψία τύπου 1, αλλά δεν είναι αρκετά ειδικό ώστε να χρησιμοποιείται μόνο του ως διαγνωστική εξέταση.

Η αντικειμενική διερεύνηση, όταν ενδείκνυται, περιλαμβάνει **ολονύκτια πολυυπνογραφία και στη συνέχεια δοκιμασία πολλαπλών λανθανόντων χρόνων ύπνου (MSLT)**. Το βασικό εξεταστικό ορόσημο στο MSLT είναι **μέσος λανθάνων χρόνος ύπνου ≤ 8 λεπτά με τουλάχιστον 2 SOREMPs**, ερμηνευόμενο μετά από κατάλληλη ολονύκτια PSG και σωστή προετοιμασία. Προηγούμενος ανεπαρκής ύπνος, κιρκάδια ασυμφωνία και φαρμακευτικές επιδράσεις μπορούν να

αλλοιώσουν ή να ακυρώσουν το αποτέλεσμα, επομένως το MSLT δεν ερμηνεύεται απομονωμένα.

Η αντιμετώπιση γίνεται σε εξειδικευμένο πλαίσιο και συνδυάζει συμπεριφορικά μέτρα, σταθερό και προγραμματισμένο ύπνο και φαρμακοθεραπεία που στοχεύει την ημερήσια υπνηλία και, όπου χρειάζεται, την καταπληξία. Σε μια γενική προφορική απάντηση δεν χρειάζεται να απαριθμήσω όλους τους διαθέσιμους παράγοντες· σημασία έχουν η σωστή διάγνωση, ο αποκλεισμός συχνών αιτιών και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Η πρακτική αλληλουχία είναι: επιβεβαίωση υπερβολικής υπνηλίας, αποκλεισμός συχνών δευτεροπαθών αιτιών, αναζήτηση καταπληξίας και άλλων φαινομένων REM, PSG/MSLT όπου ενδείκνυται και εξειδικευμένη αντιμετώπιση επιβεβαιωμένης ναρκοληψίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q66a. Τι είναι η διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο REM και γιατί έχει σημασία στην ψυχιατρική;

Η διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο REM (RBD) χαρακτηρίζεται από εκδραμάτιση των ονείρων λόγω απώλειας της φυσιολογικής μυϊκής ατονίας του REM. Η διάγνωση υποστηρίζεται ή επιβεβαιώνεται με πολυυπνογραφική τεκμηρίωση ύπνου REM χωρίς ατονία.

Η αντιμετώπιση ξεκινά με πρόληψη τραυματισμών, έλεγχο φαρμάκων που μπορεί να την προκαλούν ή να την επιδεινώνουν και διερεύνηση άλλων διαταραχών ύπνου. Μελατονίνη άμεσης αποδέσμευσης ή κλοναζεπάμη παραμένουν συμπτωματικές επιλογές με υπό όρους υποστήριξη σε κατάλληλους ασθενείς.

Η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη πτυχή είναι η ισχυρή συσχέτισή της με α-συνουκλείνοπάθειες, όπως η νόσος Parkinson και η άνοια με σωματίδια Lewy. Η συσχέτιση αυτή έχει προγνωστική σημασία, αλλά δεν υπάρχει καθιερωμένη νευροπροστατευτική θεραπεία που να μπορεί να υποσχεθεί πρόληψη μελλοντικής νευροεκφύλισης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η καταπληξία κατευθύνει έντονα προς ναρκοληψία τύπου 1.
- Η κλασική τετράδα δεν απαιτείται σε κάθε ασθενή· η υπερβολική ημερήσια υπνηλία είναι κεντρική, με καταπληξία και/ή ανεπάρκεια υποκρετίνης να ορίζουν τον τύπο 1 στο σύγχρονο ταξινομικό πλαίσιο.
- MSLT: μέσος λανθάνων χρόνος ύπνου ≤ 8 λεπτά και ≥ 2 SOREMPs, μετά από κατάλληλη ολονύκτια PSG και προετοιμασία.
- Το HLA-DQB1*06:02 σχετίζεται με NT1 αλλά δεν τη διαγιγνώσκει.
- RBD = εκδραμάτιση ονείρων + ύπνος REM χωρίς ατονία· πρώτα πρόληψη τραυματισμών.
- Η RBD συνδέεται ισχυρά με α-συνουκλείνοπάθειες, αλλά δεν υπάρχει καθιερωμένη νευροπροστατευτική θεραπεία.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση ναρκοληψίας μόνο από υπνική παράλυση ή υπναγωγικές ψευδαισθήσεις.
- Απαίτηση της κλασικής τετράδας σε κάθε ασθενή.
- Χρήση HLA ως αυτόνομης διαγνωστικής εξέτασης.
- Ερμηνεία του MSLT χωρίς έλεγχο του προηγούμενου ύπνου, του κιρκάδιου ρυθμισμού ή φαρμακευτικών συγχυτικών παραγόντων.

Ποια είναι τα κύρια στάδια του ύπνου και ποια τα χαρακτηριστικά τους στο ΗΕΓ;

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- | | |
|---|--|
| 1 | N1 — δραστηριότητα θήτα / μετάβαση στον ύπνο |
| 2 | N2 — υπνικές άτρακτοι + συμπλέγματα K |
| 3 | N3 — ύπνος βραδέων κυμάτων υψηλού δυναμικού |
| 4 | REM — χαμηλού δυναμικού μικτή συχνότητα + ατονία |
| 5 | Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι NREM-REM μέσα στη νύχτα |
| 6 | Περισσότερος ύπνος βραδέων κυμάτων νωρίς, περισσότερο REM αργότερα |

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο φυσιολογικός ύπνος οργανώνεται σε **στάδια NREM N1, N2 και N3, τα οποία εναλλάσσονται με τον ύπνο REM** σε επαναλαμβανόμενους κύκλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τις εξετάσεις, το βασικό είναι να αναγνωρίζει κανείς κάθε στάδιο από το ηλεκτροεγκεφαλογραφικό και φυσιολογικό του πρότυπο και όχι να απομνημονεύει μία άκαμπτη ποσοστιαία κατανομή.

Το **N1** είναι ελαφρύς μεταβατικός ύπνος. Ο ρυθμός άλφα της εγρήγορσης εξασθενεί και στο ΗΕΓ επικρατεί **δραστηριότητα συχνότητας θήτα**· μπορεί να εμφανιστούν και αιχμηρά κύματα κορυφής. Είναι το ελαφρύτερο στάδιο NREM και αντιστοιχεί στη μετάβαση από την εγρήγορση στον εγκατεστημένο ύπνο.

Το **N2** αναγνωρίζεται από τις **υπνικές ατράκτους και τα συμπλέγματα K** σε υπόστρωμα μικτής δραστηριότητας χαμηλότερου δυναμικού. Οι άτρακτοι παράγονται από θαλαμοφλοιώδη κυκλώματα και αποτελούν ένα από τα καθοριστικά ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά του σταδίου. Το N2 καταλαμβάνει συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του ύπνου των ενηλίκων.

Το **N3** είναι ο ύπνος βραδέων κυμάτων και χαρακτηρίζεται από υψηλού δυναμικού **βραδεία δραστηριότητα δέλτα**. Αποτελεί τον βαθύτερο NREM ύπνο, συγκεντρώνεται περισσότερο στο πρώτο μέρος της νύχτας και συνδέεται με το υψηλότερο κατώφλι αφύπνισης. Οι ακριβείς συμβάσεις συχνότητας και δυναμικού που χρησιμοποιούνται για τη σταδιοποίηση είναι τεχνικά κριτήρια εργαστηρίων ύπνου και όχι αναγκαίοι γενικοί διαγνωστικοί κανόνες για μια ψυχιατρική προφορική εξέταση.

Ο **ύπνος REM** χαρακτηρίζεται από σχετικά **χαμηλού δυναμικού, μικτής συχνότητας, αποσυγχρονισμένο ΗΕΓ**, ταχείες οφθαλμικές κινήσεις και έντονη ατονία των σκελετικών μυών, με αναμενόμενες εξαιρέσεις όπως το διάφραγμα και σύντομες μυϊκές συσπάσεις. Όνειρα μπορούν να εμφανιστούν και σε άλλα στάδια, αλλά η ζωνή ανάκληση ονείρων συνδέεται κλασικά με το REM. Οι περίοδοι REM γίνονται μεγαλύτερες και πιο έντονες προς το τελευταίο μέρος της νύχτας.

Μέσα στη νύχτα, NREM και REM επανέρχονται κυκλικά. Η κλασική διδασκαλία αναφέρει κύκλους περίπου **90–110 λεπτών**, με αρκετούς κύκλους ανά νύχτα, αλλά η διάρκεια των κύκλων και οι αναλογίες των σταδίων μεταβάλλονται με την ηλικία, το άτομο, τη συγκεκριμένη νύχτα και τον τρόπο σταδιοποίησης. Το

σταθερό ποιοτικό μοτίβο είναι ότι ο ύπνος βραδέων κυμάτων συγκεντρώνεται κυρίως στο πρώτο τρίτο της νύχτας, ενώ το REM στο τελευταίο τρίτο.

Η πρακτική προφορική απάντηση είναι επομένως: N1 με θήτα, N2 με υπνικές ατράκτους και συμπλέγματα K, N3 με βραδέα κύματα υψηλού δυναμικού, REM με χαμηλού δυναμικού μικτή συχνότητα, ταχείες οφθαλμικές κινήσεις και ατονία, όλα οργανωμένα σε επαναλαμβανόμενους κύκλους NREM-REM.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **N1:** κυρίως δραστηριότητα θήτα· μπορεί να εμφανίζονται αιχμηρά κύματα κορυφής.
- **N2:** υπνικές άτράκτοι + συμπλέγματα K.
- **N3:** υψηλού δυναμικού βραδεία δραστηριότητα δέλτα.
- **REM:** χαμηλού δυναμικού μικτή συχνότητα/αποσυγχρονισμένο HEG + ταχείες οφθαλμικές κινήσεις + ατονία σκελετικών μυών.
- Ο ύπνος βραδέων κυμάτων συγκεντρώνεται νωρίτερα μέσα στη νύχτα· το REM γίνεται εντονότερο αργότερα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Η κλασική διδασκαλία για τον ύπνο ενηλίκων αναφέρει κατά προσέγγιση N1 ~5%, N2 ~45–50%, N3 ~15–20%, REM ~20–25%, με κύκλους περίπου 90–110 λεπτών και περίπου 4–6 κύκλους ανά νύχτα. Πρόκειται για χρήσιμα μεγέθη προσανατολισμού και όχι για αμετάβλητες φυσιολογικές ή διαγνωστικές αλήθειες· η ηλικία και η διακύμανση από νύχτα σε νύχτα έχουν σημασία.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q67a. Ποιες μεταβολές στην αρχιτεκτονική του ύπνου συνδέονται κλασικά με την κατάθλιψη;

Κλασικά ευρήματα σε επίπεδο ομάδων είναι **βραχύτερος λανθάνων χρόνος REM, αυξημένη πυκνότητα REM και μειωμένος ύπνος βραδέων κυμάτων**. Πρόκειται για χρήσιμες συσχετίσεις της βιολογικής ψυχιατρικής και της παραδοσιακής εξεταστικής ύλης, αλλά **δεν αποτελούν διαγνωστικές εξετάσεις για την κατάθλιψη**, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ακριβές όριο λανθάνοντος χρόνου REM ως καθολικός κλινικός κανόνας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Σύγχυση των ατράκτων και συμπλεγμάτων K του N2 με τα βραδέα κύματα του N3.
- Παράλειψη της μυϊκής ατονίας του REM.
- Αντιμετώπιση των κλασικών ποσοστών των σταδίων ύπνου ως αμετάβλητων φυσιολογικών τιμών.
- Χρήση του βραχύτερου λανθάνοντος χρόνου REM ως διαγνωστικής εξέτασης για κατάθλιψη.

Πώς ταξινομείτε και πώς διατυπώνετε μια διαταραχή προσωπικότητας;

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αναγνώριση επίμονης δυσλειτουργίας της προσωπικότητας
- 2 Εκτίμηση της βαρύτητας
- 3 Περιγραφή των διαστάσεων χαρακτηριστικών του ICD-11
- 4 Χρήση του προσδιοριστή οριακού προτύπου όπου ενδείκνυται
- 5 Αναπτυξιακή και διαπροσωπική διατύπωση
- 6 Εκτίμηση συννοσηρότητας, δυνατών σημείων και κινδύνου
- 7 Σαφής διάκριση ICD-11 και DSM

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαταραχή προσωπικότητας είναι ένα επίμονο και διάχυτο δυσπροσαρμοστικό πρότυπο που επηρεάζει τη λειτουργία του εαυτού και τις διαπροσωπικές σχέσεις, αναδύεται έως την εφηβεία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή και προκαλεί κλινικά σημαντική δυσλειτουργία. Στο σύγχρονο ICD-11 το βασικό πλαίσιο είναι **διαστασιακό και όχι κατηγορικό**: πρώτα τεκμηριώνεται η διαταραχή προσωπικότητας, έπειτα εκτιμάται η βαρύτητα και στη συνέχεια περιγράφονται οι κυρίαρχες διαστάσεις χαρακτηριστικών. Παράλληλα χρειάζεται διατύπωση του περιστατικού, επειδή η διάγνωση από μόνη της δεν εξηγεί πώς αναπτύχθηκαν ούτε πώς συντηρούνται οι δυσκολίες του ατόμου.

Πρώτα διαπιστώνω ότι το πρότυπο είναι επίμονο, εμφανίζεται **σε διαφορετικά πλαίσια της ζωής** και δεν αποτελεί απλώς επίδραση μιας οξείας κατάστασης, όπως επεισόδιο διάθεσης, ψύχωση, χρήση ουσιών ή άλλη διαταραχή. Εξετάζω την ταυτότητα, την αυτοκατεύθυνση, τις σχέσεις, τη ρύθμιση του συναισθήματος, τη συμπεριφορά και τις συνέπειες στην εργασία, τη συντροφικότητα και την ευρύτερη κοινωνική λειτουργικότητα.

Στη συνέχεια, το ICD-11 διαβαθμίζει τη βαρύτητα ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Η βαρύτητα αποτελεί την κεντρική οργανωτική μεταβλητή της διάγνωσης, επειδή αποτυπώνει καλύτερα την έκταση της δυσλειτουργίας και του κινδύνου από ό,τι η απλή απόδοση μιας παραδοσιακής κατηγορικής ετικέτας.

Το προφίλ προσωπικότητας μπορεί κατόπιν να περιγραφεί με πέντε διαστάσεις χαρακτηριστικών: **Αρνητική Συναισθηματικότητα, Απόσπαση, Αντικοινωνικότητα, Άρση Αναστολών και Αναγκαστικότητα**. Μπορεί επίσης να προστεθεί προαιρετικά ο **προσδιοριστής Οριακού Προτύπου (Borderline Pattern)**. Οι διαστάσεις χρησιμοποιούνται περιγραφικά και ανάλογα με το προφίλ και δεν πρέπει να μετατρέπουν την απάντηση σε έναν νέο κατάλογο παλαιών κατηγορικών διαγνώσεων.

Αυτό διαφέρει από το σύστημα της Ενότητας II του DSM-5-TR, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί τις παραδοσιακές ονομαστικές διαταραχές προσωπικότητας και την ομαδοποίηση σε Cluster A, B και C. Σε μια προφορική εξέταση δηλώνω ποιο ταξινομικό σύστημα χρησιμοποιώ και δεν αναμειγνύω τη

διαστασιακή διάγνωση του ICD-11 με τα κατηγορικά κριτήρια του DSM σαν να αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα.

Η διάγνωση πρέπει στη συνέχεια να ενταχθεί σε μια **βιοψυχοκοινωνική και αναπτυξιακή διατύπωση**. Εξετάζω ιδιοσυγκρασία, ιστορικό δεσμών και σχέσεων, αντιξοότητες ή τραύμα όπου σχετίζονται, μαθημένα σχήματα και στρατηγικές αντιμετώπισης, επαναλαμβανόμενα διαπροσωπικά πρότυπα, δυνατά σημεία και προστατευτικούς παράγοντες. Επίσης αξιολογώ συννοσηρές διαταραχές διάθεσης, άγχους, χρήσης ουσιών, νευροαναπτυξιακές και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές και ενσωματώνω στη διατύπωση κινδύνου, όπου χρειάζεται, τον αυτοτραυματισμό, την αυτοκτονικότητα, την επιθετικότητα, την ευαλωτότητα και ζητήματα προστασίας.

Η πρακτική αξία του διαστασιακού συστήματος είναι ότι δύο άνθρωποι με παρόμοια παραδοσιακή διαγνωστική ετικέτα μπορεί να διαφέρουν πολύ ως προς τη βαρύτητα και τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών τους. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός πρέπει επομένως να ακολουθεί το πραγματικό πρότυπο δυσλειτουργίας, τον κίνδυνο, τη συννοσηρότητα και τους στόχους του ασθενούς και όχι μόνο τη διαγνωστική ετικέτα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας από τη διαταραχή κοινωνικού άγχους;

Ένα αποφευκτικό πρότυπο προσωπικότητας είναι **διάχυτο και αφορά την αυτοεικόνα, τις σχέσεις και τη συνολική διαπροσωπική λειτουργία**, ενώ η διαταραχή κοινωνικού άγχους οργάνωνεται γύρω από τον φόβο παρατήρησης και αρνητικής αξιολόγησης σε κοινωνικές καταστάσεις. Υπάρχει σημαντική επικάλυψη και οι δύο μπορούν να συνυπάρχουν.

Η «αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας» παραμένει ορολογία του DSM και παλαιότερων συστημάτων. Στο ICD-11, αντίστοιχος φαινότυπος περιγράφεται διαστασιακά, συχνά μέσω **Αρνητικής Συναισθηματικότητας και Απόσπασης**, και όχι ως ξεχωριστή αποφευκτική κατηγορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς διακρίνετε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας από την ΙΨΔ;

Το αναγκαστικό/OCPD πρότυπο είναι ένας διάχυτος τρόπος προσωπικής λειτουργίας που χαρακτηρίζεται από **τελειοθηρία, ακαμψία, τάξη, έλεγχο και υπερβολική ευσυνειδησία**. Η ΙΨΔ είναι ξεχωριστή ιδεοψυχαναγκαστική και συναφής διαταραχή, που ορίζεται από ιδεοληψίες και/ή καταναγκασμούς.

Η συνηθισμένη συντόμευση ότι η OCPD είναι εγωσυντονική ενώ η ΙΨΔ εγωδυστονική είναι **χρήσιμη τάση και όχι απόλυτο διαγνωστικό κριτήριο**. Στο ICD-11 δεν υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία OCPD/αναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας· η **Αναγκαστικότητα είναι προσδιοριστής χαρακτηριστικών**, ενώ η ΙΨΔ παραμένει ξεχωριστή διαταραχή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Διαταραχή προσωπικότητας κατά ICD-11: ήπια / μέτρια / σοβαρή.
- Πέντε διαστάσεις χαρακτηριστικών: Αρνητική Συναισθηματικότητα, Απόσπαση, Αντικοινωνικότητα, Άρση Αναστολών, Αναγκαστικότητα.
- Μπορεί να προστεθεί προαιρετικά ο προσδιοριστής Οριακού Προτύπου.
- Το αποφευκτικό πρότυπο αφορά διάχυτη λειτουργία προσωπικότητας/εαυτού και σχέσεων· το κοινωνικό άγχος επικεντρώνεται στον φόβο παρατήρησης και αρνητικής αξιολόγησης.
- OCPD/αναγκαστικό πρότυπο έναντι ΙΨΔ: διάχυτη τελειοθηρία/έλεγχος έναντι ιδεοληψιών και/ή καταναγκασμών· το εγωσυντονικό/εγωδυστονικό αποτελεί μόνο τάση.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ανάμειξη της διαστασιακής βαρύτητας και των χαρακτηριστικών του ICD-11 με κατηγορικά κριτήρια DSM σαν να αποτελούν ένα σύστημα.
- Παρουσίαση των παλαιών Cluster A/B/C ως σύγχρονης δομής του ICD-11.
- Χρήση του εγωσυντονικού έναντι εγωδυστονικού ως μοναδικού κριτηρίου διάκρισης ΙΨΔ/OCPD.
- Διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας από συμπεριφορά που εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια οξείας διαταραχής διάθεσης, ψύχωσης ή κατάστασης σχετιζόμενης με ουσίες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η παλαιότερη διδασκαλία κατά ICD-10 και DSM ήταν κυρίως κατηγορική. Το ICD-11 οργανώνεται γύρω από διαστασιακή βαρύτητα και προσδιοριστές χαρακτηριστικών, ενώ η Ενότητα II του DSM-5-TR εξακολουθεί να διατηρεί τις ονομαστικές κατηγορικές διαγνώσεις.

Πώς αντιμετωπίζετε την οριακή διαταραχή προσωπικότητας (BPD);

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Εκτίμηση κινδύνου και σαφές θεραπευτικό πλαίσιο
- 2 Συνεργατική διατύπωση του περιστατικού
- 3 Δομημένη ψυχοθεραπεία ως κύρια θεραπεία
- 4 Πλάνο κρίσης και σαφή όρια
- 5 Θεραπεία πραγματικής συννοσηρότητας
- 6 Αποφυγή φαρμακοθεραπείας για τον πυρήνα της BPD και χρόνιας πολυφαρμακίας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας αντιμετωπίζεται πρωτίστως με **δομημένη θεραπευτική σχέση και τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία**, και όχι με φαρμακοθεραπεία που στοχεύει την ίδια τη διαταραχή προσωπικότητας. Ξεκινώ με εκτίμηση κινδύνου, συνεργατική διατύπωση του περιστατικού, σαφή όρια και πλάνο κρίσης, και στη συνέχεια προσφέρω μια συνεκτική εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία, αντιμετωπίζοντας χωριστά τις συννοσηρές διαταραχές και επανεξετάζοντας περιττή φαρμακευτική αγωγή.

Το κλινικό πρότυπο περιλαμβάνει συνήθως αστάθεια στις σχέσεις, την αυτοεικόνα και το συναίσθημα, παρορμητικότητα, επαναλαμβανόμενο αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονικότητα, ευαισθησία στην εγκατάλειψη, θυμό και, ορισμένες φορές, παροδικό παρανοειδή ιδεασμό ή **διασχιστικά φαινόμενα που σχετίζονται με στρες**. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να κατανοούνται διαχρονικά και όχι ως σειρά ασύνδετων κρίσεων.

Η εκτίμηση κινδύνου είναι επομένως κεντρική. Διερευνώ τρέχοντα και προηγούμενο αυτοτραυματισμό, αυτοκτονική πρόθεση, παρορμητικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, χρήση ουσιών, διαπροσωπική βία ή ευαλωτότητα και τις συνθήκες που προηγούνται των κρίσεων. Παράλληλα, αποφεύγω κάθε επαφή να μετατρέπεται σε άμορφη επείγουσα παρέμβαση. Ένα **σαφές θεραπευτικό πλαίσιο**, μια κοινή διατύπωση και ένα συμφωνημένο πλάνο κρίσης βοηθούν στη συνέπεια και μειώνουν την αντιδραστική φροντίδα.

Η κύρια θεραπεία είναι η **δομημένη εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία**. Η DBT, η MBT, η **θεραπεία σχημάτων** και η **ψυχοθεραπεία εστιασμένη στη μεταβίβαση** είναι καθιερωμένες εξειδικευμένες προσεγγίσεις· δεν χρειάζεται να παρουσιάζεται μία από αυτές ως υποχρεωτική για κάθε ασθενή. Η DBT συνδυάζει ρητά **αποδοχή και αλλαγή** με συμπεριφορικές δεξιότητες που στοχεύουν στη ρύθμιση του συναισθήματος, την ανοχή στη δυσφορία και τον αυτοτραυματισμό. Η MBT στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας κατανόησης των ψυχικών καταστάσεων του εαυτού και των άλλων, ιδιαίτερα υπό διαπροσωπικό στρες. Η γενικότερη αρχή είναι μια σταθερή, οργανωμένη θεραπεία που δουλεύει με τη συναισθηματική απορρύθμιση, τα διαπροσωπικά πρότυπα, τον αυτοτραυματισμό και τους στόχους του ασθενούς μέσα σε συνεπή θεραπευτική σχέση.

Η φαρμακοθεραπεία δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως θεραπεία για τον πυρήνα της BPD, τη συναισθηματική αστάθεια ή τον επαναλαμβανόμενο αυτοτραυματισμό. Η χρόνια αντιψυχωσική θεραπεία και η μακροχρόνια πολυφαρμακία για την ίδια τη διαταραχή προσωπικότητας πρέπει να αποφεύγονται. Εάν υπάρχει σαφώς διαγνωσμένη συννοσηρή καταθλιπτική, αγχώδης, διπολική, ψυχωτική ή άλλη διαταραχή, αυτή αντιμετωπίζεται με βάση τις δικές της ενδείξεις και η υπάρχουσα αγωγή ελέγχεται για αναποτελεσματικές ή περιττές συνταγογραφήσεις.

Πολύ βραχυχρόνια φαρμακευτική αγωγή σε κρίση μπορεί περιστασιακά να εξεταστεί για συγκεκριμένο σύμπτωμα-στόχο, αλλά μόνο με προσοχή στον κίνδυνο υπερδοσολογίας και κατάχρησης, κατά προτίμηση με ένα φάρμακο και με σαφές πλάνο διακοπής ή επανεκτίμησης. Πρέπει να παραμένει περιφερειακή στη θεραπευτική στρατηγική και όχι να γίνεται η αυτόματη απάντηση στη δυσφορία.

Η μακροχρόνια πορεία πρέπει να συζητείται χωρίς θεραπευτικό μηδενισμό. Η συμπτωματική ύφεση είναι συχνή με την πάροδο του χρόνου, αλλά η λειτουργική αποκατάσταση μπορεί να υστερεί σε σχέση με τη συμπτωματική βελτίωση, ενώ ο κίνδυνος αυτοκτονίας παραμένει κλινικά σημαντικός. Δεν θα παρέθετα σταθερά ποσοστά ύφεσης ή δια βίου θανάτου από αυτοκτονία σαν να αποτελούν καθολικά προγνωστικά μεγέθη.

Συνολικά, η καλή αντιμετώπιση συνδυάζει σταθερό θεραπευτικό πλαίσιο, ενεργή διαχείριση κινδύνου, δομημένη ψυχοθεραπεία, σχεδιασμό κρίσεων, θεραπεία πραγματικής συννοσηρότητας και συνειδητή αποφυγή φαρμακοκεντρικής φροντίδας για τον πυρήνα της διαταραχής προσωπικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q69a. Πώς διακρίνετε τη συναισθηματική αστάθεια της BPD από τη διπολική διαταραχή;

Στην BPD, οι μεταβολές του συναισθήματος είναι συχνά ταχείες και αντιδραστικές σε διαπροσωπικά ή περιβαλλοντικά γεγονότα, μέσα σε ένα χρόνιο πρότυπο δυσλειτουργίας ταυτότητας και σχέσεων. Η διπολική διαταραχή απαιτεί διακριτά, παρατεταμένα επεισόδια που αντιπροσωπεύουν σαφή απόκλιση από το συνήθες επίπεδο λειτουργίας.

Αναζητώ επεισοδικότητα, μειωμένη ανάγκη για ύπνο, ιδέες μεγαλείου, αυξημένη στοχοκατευθυνόμενη δραστηριότητα και αναγνωρίσιμο μεσοεπεισοδιακό επίπεδο λειτουργίας. Η διάρκεια βοηθά αλλά δεν αρκεί μόνη της· η διάκριση πρέπει να συνδυάζει τη βιολογική ενεργοποίηση, τη μεταβολή από το συνήθες επίπεδο, τη διαπροσωπική αντιδραστικότητα και το διαχρονικό πρότυπο προσωπικότητας. Οι δύο διαταραχές μπορούν επίσης να συνυπάρχουν.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η δομημένη ψυχοθεραπεία είναι η κύρια θεραπεία· η φαρμακοθεραπεία δεν θεραπεύει τον πυρήνα της BPD.
- Τεκμηριωμένες εξειδικευμένες θεραπείες περιλαμβάνουν DBT, MBT, θεραπεία σχημάτων και ψυχοθεραπεία εστιασμένη στη μεταβίβαση.
- DBT: διαλεκτικός συνδυασμός αποδοχής + αλλαγής και συμπεριφορικές δεξιότητες για ρύθμιση συναισθήματος, ανοχή στη δυσφορία και

αυτοτραυματισμό.

- **MBT:** ενισχύει τη νοητικοποίηση, ιδιαίτερα υπό διαπροσωπικό στρες.
- Η μακροχρόνια συμπτωματική ύφεση είναι συχνή, αλλά η λειτουργική αποκατάσταση μπορεί να καθυστερεί· αποφεύγετε σταθερά καθολικά ποσοστά ύφεσης ή θανάτου από αυτοκτονία.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων κρίσεων με διαρκώς αυξανόμενη χρόνια πολυφαρμακία.
- Χορήγηση αντιψυχωσικού ή σταθεροποιητή διάθεσης σαν να αποτελεί τροποποιητική θεραπεία της BPD.
- Διάγνωση διπολικής διαταραχής μόνο επειδή οι μεταβολές διάθεσης είναι έντονες.
- Διάκριση BPD και διπολικής διαταραχής αποκλειστικά βάσει ενός κανόνα διάρκειας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η φαρμακοκεντρική προσέγγιση ή η χρόνια πολυφαρμακία είναι παρωχημένες. Η δομημένη ψυχοθεραπεία είναι η κύρια θεραπεία και η φαρμακοθεραπεία δεν αποτελεί θεραπεία του πυρήνα της BPD.

Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας από την ψυχοπάθεια;

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Διάκριση επίσημης διάγνωσης από ιατροδικαστικό κατασκευάσμα
- 2 Η ASPD δίνει μεγαλύτερο βάρος στη συμπεριφορά
- 3 Η ψυχοπάθεια προσθέτει συναισθηματικά και διαπροσωπικά χαρακτηριστικά
- 4 Αναπτυξιακό ιστορικό και ιστορικό χρήσης ουσιών
- 5 Εκτίμηση βίας, εκμετάλλευσης και ευρύτερου κινδύνου
- 6 Η εγκληματικότητα δεν ταυτίζεται με την ψυχοπάθεια

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και η ψυχοπάθεια αλληλεπικαλύπτονται, αλλά **δεν είναι συνώνυμες έννοιες**. Η ASPD είναι επίσημη διάγνωση του DSM με σημαντική έμφαση στην επίμονη αντικοινωνική συμπεριφορά και στην αδιαφορία για τα δικαιώματα των άλλων και τους κοινωνικούς κανόνες. **Η ψυχοπάθεια δεν αποτελεί ανεξάρτητη διάγνωση στο DSM-5-TR ή στο ICD-11**· είναι ένα κατασκευάσμα της προσωπικότητας και της ιατροδικαστικής ψυχιατρικής που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε συναισθηματικά και διαπροσωπικά χαρακτηριστικά, επιπλέον της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Στην ASPD αναμένω ένα επίμονο πρότυπο που μπορεί να περιλαμβάνει εξαπάτηση, παρορμητικότητα, επιθετικότητα, ανευθυνότητα και αδιαφορία για τα δικαιώματα ή την ασφάλεια των άλλων, στο πλαίσιο σχετικού αναπτυξιακού αντικοινωνικού ιστορικού. Η διάγνωση δεν πρέπει να ανάγεται στην απλή παρουσία εγκληματικής συμπεριφοράς, επειδή η παραβατικότητα μπορεί να προκύπτει από πολλές άλλες οδούς, όπως χρήση ουσιών, κοινωνικό πλαίσιο, παρορμητικότητα ή άλλες ψυχιατρικές διαταραχές.

Η ψυχοπάθεια είναι εννοιολογικά στενότερη και εστιάζει περισσότερο σε χαρακτηριστικά. Πέρα από έναν αντικοινωνικό τρόπο ζωής, δίνει έμφαση σε στοιχεία όπως **επιφανειακή γοητεία, χειριστικότητα, αναλγησία ή σκληρότητα, ρηχό συναίσθημα και έλλειψη ενσυναίσθησης ή μεταμέλειας**. Ένα άτομο μπορεί επομένως να πληροί κριτήρια ASPD χωρίς να παρουσιάζει ολόκληρο το συναισθηματικό-διαπροσωπικό προφίλ της ψυχοπάθειας.

Το σύγχρονο ICD-11 δεν δημιουργεί ξεχωριστή διάγνωση ψυχοπάθειας. Οι αντικοινωνικοί ή δυσκοινωνικοί φαινότυποι περιγράφονται διαστασιακά μέσα στη διαταραχή προσωπικότητας, με βάση τη βαρύτητα και το σχετικό προφίλ χαρακτηριστικών. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να μην χρησιμοποιείται η «ψυχοπάθεια» ως συνήθης διαγνωστική ετικέτα στη γενική ψυχιατρική.

Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει αναπτυξιακό ιστορικό, σχέσεις, εκπαίδευση και εργασία, χρήση ουσιών, προηγούμενη επιθετικότητα και παραβατικότητα, παρορμητικότητα, ικανότητα ενσυναίσθησης και μεταμέλειας, πρότυπα εκμετάλλευσης και τρέχοντα κίνδυνο. Η διατύπωση κινδύνου πρέπει να είναι

συγκεκριμένη: εξετάζω βία, εξαναγκασμό, εκμετάλλευση, παράγοντες σχετιζόμενους με υποτροπή παραβατικότητας, άρση αναστολών λόγω ουσιών και προστατευτικούς παράγοντες, αντί να θεωρώ ότι η διάγνωση προβλέπει αυτόματα τη συμπεριφορά.

Το **PCL-R** μπορεί να αναφερθεί ως εξειδικευμένο ιατροδικαστικό εργαλείο για την εκτίμηση ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών, αλλά δεν αποτελεί διαγνωστική εξέταση ρουτίνας στη γενική ψυχιατρική. Τα όρια βαθμολογίας διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία και το ερευνητικό πλαίσιο και το εργαλείο δεν αποτελεί από μόνο του καθολικό προγνωστικό δείκτη βίαιης υποτροπής.

Η πρακτική διάκριση είναι επομένως ότι η ASPD αποτελεί επίσημη διάγνωση με ισχυρό συμπεριφορικό στοιχείο, ενώ η ψυχοπάθεια είναι ιατροδικαστικό και προσωπολογικό κατασκεύασμα που προσθέτει χαρακτηριστικό συναισθηματικό και διαπροσωπικό ύφος. Κανένας από τους δύο όρους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της εγκληματικότητας και και οι δύο απαιτούν προσεκτική αναπτυξιακή, ουσιολογική και εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η ψυχοπάθεια δεν αποτελεί επίσημη διάγνωση του DSM-5-TR ή του ICD-11.
- Η ψυχοπάθεια προσθέτει διαπροσωπικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά σκληρότητας/χειριστικότητας πέρα από την αντικοινωνική συμπεριφορά.
- Το **PCL-R** είναι εξειδικευμένο ιατροδικαστικό μέτρο· δεν χρησιμοποιούμε ένα καθολικό cut-off ούτε το αντιμετωπίζουμε ως αυτόνομο τεστ πρόβλεψης βίας ή υποτροπής.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ταύτιση της εγκληματικότητας με την ASPD ή την ψυχοπάθεια.
- Υπόθεση ότι όλοι οι ασθενείς με ASPD είναι ψυχοπαθείς.
- Αντιμετώπιση μιας βαθμολογίας PCL-R ως γενικής ψυχιατρικής διάγνωσης.
- Παρουσίαση ενός συγκεκριμένου cut-off PCL-R ως καθολικού ορίου που ορίζει την ψυχοπάθεια.
- Παρουσίαση της ψυχοπάθειας ως του μοναδικού ισχυρότερου προγνωστικού παράγοντα μελλοντικής βίας.

Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε τη σεξουαλική δυσλειτουργία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Προσδιορισμός του τομέα της σεξουαλικής λειτουργίας που έχει επηρεαστεί
- 2 Έναρξη, πλαίσιο και βαθμός δυσφορίας
- 3 Σωματικά, ψυχιατρικά, σχεσιακά και φαρμακευτικά αίτια
- 4 Στοχευμένη διερεύνηση
- 5 Αντιμετώπιση αναστρέψιμων αιτιών
- 6 Ψυχοσεξουαλικές/σχεσιακές παρεμβάσεις και θεραπεία ανάλογα με τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η σεξουαλική δυσλειτουργία πρέπει να αξιολογείται **βιοψυχοκοινωνικά**, αρχίζοντας από το εάν η κύρια δυσκολία αφορά την επιθυμία, τη διέγερση, τον οργασμό ή τον πόνο/τη διείσδυση, με την αναγνώριση ότι οι τομείς αυτοί μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται. Διευκρινίζω την έναρξη, το πλαίσιο και τη σχετιζόμενη δυσφορία και στη συνέχεια διερευνώ συστηματικά σχεσιακά, ψυχιατρικά, σωματικά, φαρμακευτικά και σχετιζόμενα με ουσίες αίτια πριν επιλέξω θεραπεία.

Ξεκινώ από τη φαινομενολογία. Είναι το πρόβλημα δια βίου ή επίκτητο, γενικευμένο ή περιστασιακό, σταθερό ή διακυμαινόμενο; Ρωτώ για τη σεξουαλική επιθυμία, τη σωματική και υποκειμενική διέγερση, τον οργασμό, τον πόνο ή τη δυσκολία στη διείσδυση και για το αν το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλα τα πλαίσια ή μόνο με συγκεκριμένο σύντροφο ή κατάσταση. Η δυσφορία και η λειτουργική επίπτωση έχουν σημασία, επειδή δεν είναι παθολογική κάθε διαφοροποίηση της σεξουαλικής ανταπόκρισης.

Το σχεσιακό και ψυχολογικό πλαίσιο είναι σημαντικό. Διερευνώ την επικοινωνία, τις συγκρούσεις, το άγχος επίδοσης, συμπτώματα διάθεσης και άγχους, τραύμα όπου σχετίζεται, την εικόνα σώματος και σημαντικές αλλαγές ζωής. Παράλληλα, δεν υποθέτω ότι ένα σεξουαλικό πρόβλημα είναι ψυχογενές μόνο και μόνο επειδή ο ασθενής έχει ψυχιατρικό ιστορικό.

Η σωματική εκτίμηση εξαρτάται από την εκάστοτε εικόνα. Πιθανοί παράγοντες είναι ενδοκρινικές, νευρολογικές και άλλες σωματικές παθήσεις, καθώς και χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Ο έλεγχος της φαρμακευτικής αγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην ψυχιατρική. Τα SSRI's μπορούν να προκαλέσουν μειωμένη επιθυμία, διαταραχές διέγερσης και οργασμική δυσλειτουργία, αλλά ο μηχανισμός είναι πολυπαραγοντικός και διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο φάρμακο· δεν πρέπει να αποδίδεται σε μία καθολική εξήγηση μέσω του 5-HT_{2A}. Τα αντιψυχωσικά που αυξάνουν την προλακτίνη μπορούν να προκαλέσουν υπογοναδισμό και σεξουαλικές ή αναπαραγωγικές διαταραχές.

Η κλινική εξέταση και οι περαιτέρω εξετάσεις πρέπει επομένως να καθοδηγούνται από το συγκεκριμένο σύμπτωμα και την πιθανολογούμενη αιτία. Προλακτίνη ή άλλος ενδοκρινολογικός έλεγχος ζητείται όταν υπάρχει κλινική ένδειξη και όχι ως

καθολικό εργαστηριακό πακέτο.

Η θεραπεία αρχίζει από τη διόρθωση αναστρέψιμων παραγόντων όπου είναι δυνατόν. Αυτό μπορεί να σημαίνει θεραπεία σωματικής νόσου, τροποποίηση ενός υπεύθυνου φαρμάκου, αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών ή επανεξέταση ψυχιατρικής αγωγής που προκαλεί μη αποδεκτές σεξουαλικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι αλλαγές φαρμάκων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ψυχιατρική σταθερότητα και τις τοπικές εγκεκριμένες ενδείξεις, αντί να θεωρείται ότι μια συχνά αναφερόμενη εναλλακτική, όπως η βουπροπιόνη, αποτελεί συνήθη αντικαταθλιπτική επιλογή σε κάθε ευρωπαϊκή δικαιοδοσία.

Ψυχοσεξουαλικές ή σχεσιακές παρεμβάσεις μπορεί να είναι χρήσιμες όταν το άγχος, η αποφυγή, η επικοινωνία ή οι σχέσεις συντηρούν το πρόβλημα. Παράλληλα, μπορεί να ενδείκνυται θεραπεία ειδικά για τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία — για παράδειγμα, **αναστολέας PDE5** σε κατάλληλη περίπτωση στυτικής δυσλειτουργίας. Οι αναστολείς PDE5 ενισχύουν την οδό μονοξειδίου του αζώτου-cGMP στον στυτικό ιστό· δεν αποτελούν γενική θεραπεία για κάθε είδος σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Η συνολική προσέγγιση είναι επομένως να ορίσω με ακρίβεια το σεξουαλικό πρόβλημα, να το αξιολογήσω μέσα στο σωματικό, ψυχιατρικό και σχεσιακό πλαίσιο, να εντοπίσω αναστρέψιμα αίτια και να χρησιμοποιήσω στοχευμένη ψυχοσεξουαλική, φαρμακευτική ή άλλη ιατρική παρέμβαση ανάλογα με τον μηχανισμό.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η σεξουαλική δυσλειτουργία από SSRIs είναι **πολυπαραγοντική**· δεν πρέπει να αναχθεί σε έναν μόνο μηχανισμό υποδοχέα.
- Τα αντιψυχωσικά που αυξάνουν την προλακτίνη μπορούν να προκαλέσουν **υπογοναδισμό και σεξουαλική δυσλειτουργία**.
- Οι **αναστολείς PDE5** αναστέλλουν τη φωσφοδιεστεράση-5 και ενισχύουν τη σηματοδότηση NO-cGMP· αποτελούν θεραπεία ειδικά για τη στυτική δυσλειτουργία και όχι γενικό φάρμακο για κάθε σεξουαλική δυσλειτουργία.
- Οι στρατηγικές αλλαγής φαρμάκου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη **τη δικαιοδοσία και την εγκεκριμένη ένδειξη**· η βουπροπιόνη δεν αποτελεί συνήθη αντικαταθλιπτική επιλογή σε κάθε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Υπόθεση ότι κάθε σεξουαλικό πρόβλημα είναι ψυχογενές.
- Παραγγελία καθολικού ενδοκρινολογικού ελέγχου ανεξάρτητα από τον φαινότυπο.
- Απόδοση όλης της σεξουαλικής δυσλειτουργίας από SSRI σε έναν υποδοχέα.
- Χρήση αναστολέα PDE5 σαν να θεραπεύει χαμηλή επιθυμία, οργασμική δυσλειτουργία ή πόνο.
- Μεταφορά μιας αμερικανικής στρατηγικής αλλαγής αντικαταθλιπτικού στην ευρωπαϊκή πρακτική χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έγκριση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η παλαιότερη ταξινόμηση του ICD-10 τοποθετούσε συχνά τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες σε ψυχιατρικές ή «μη οργανικές» κατηγορίες. **Το ICD-11 τις τοποθετεί στις Καταστάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία,** υποστηρίζοντας ένα ευρύτερο βιοψυχοκοινωνικό και όχι αμιγώς ψυχιατρικό πλαίσιο.

Πώς αξιολογείτε και πώς αντιμετωπίζετε μια παραφιλική διαταραχή και τον σχετιζόμενο κίνδυνο;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Το άτυπο σεξουαλικό ενδιαφέρον δεν αποτελεί αυτομάτως διαταραχή
- 2 Συναίνεση, βλάβη, δυσφορία και άμεσος κίνδυνος
- 3 Σεξουαλικό και ιατροδικαστικό ιστορικό
- 4 Δυνητικά θύματα, πρόσβαση και κλιμάκωση
- 5 Συννοσηρότητα, άρση αναστολών και προστατευτικοί παράγοντες
- 6 Εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία και διαχείριση κινδύνου
- 7 Φαρμακοθεραπεία μόνο σε επιλεγμένες ενδείξεις

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ένα άτυπο σεξουαλικό ενδιαφέρον ή μια παραφιλία δεν αποτελεί αυτομάτως ψυχιατρική διαταραχή. Πρώτα πρέπει να καθοριστεί εάν το πρότυπο αφορά άτομα που δεν συναινούν, εάν προκαλεί κλινικά σημαντική δυσφορία που δεν οφείλεται απλώς στο στίγμα ή την κοινωνική απόρριψη, ή εάν συνεπάγεται ουσιαστικό άμεσο κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου, ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι μια προσεκτική σεξουαλική, ψυχιατρική και ιατροδικαστική διατύπωση κινδύνου και όχι μια ηθική κρίση πάνω στη συναινετική σεξουαλικότητα.

Διευκρινίζω τη φύση, τη συχνότητα και την επιμονή των φαντασιώσεων, ενορμήσεων και συμπεριφορών, εάν έχουν γίνει πράξη και σε ποιο βαθμό το άτομο μπορεί να τις ελέγξει εκούσια. Η συναίνεση είναι κεντρική. Ρωτώ εάν οποιαδήποτε συμπεριφορά αφορά ή στοχεύει άτομα που δεν συναινούν και εάν υπάρχουν αναγνωρίσιμα δυνητικά θύματα ή καταστάσεις που αυξάνουν την πρόσβαση και την ευκαιρία.

Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να είναι συγκεκριμένη και συμπεριφορική. Διερευνώ τυχόν κλιμάκωση με τον χρόνο, προηγούμενη σεξουαλική και μη σεξουαλική παραβατικότητα, σχεδιασμό ή πρόβα συμπεριφοράς, πρόσβαση σε πιθανά θύματα, χρήση ουσιών ή άλλους παράγοντες άρσης αναστολών, τρέχουσα ψυχική διαταραχή, έλεγχο παρορμήσεων, προστατευτικές σχέσεις, συνεργασία με τη θεραπεία και προθυμία χρήσης στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου. Οι ενέργειες προστασίας ευάλωτων ατόμων ή δημόσιας ασφάλειας εξαρτώνται από το πραγματικό επίπεδο και τη φύση του κινδύνου και από τη σχετική δικαιοδοσία· ίδια η διάγνωση δεν υπαγορεύει μία αυτόματη αντίδραση.

Η συννοσηρότητα έχει σημασία, επειδή κατάθλιψη, άγχος, ιδεοληπτικά ή καταναγκαστικά χαρακτηριστικά, χρήση ουσιών και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές μπορεί να επηρεάζουν τόσο τη δυσφορία όσο και τον κίνδυνο. Διακρίνω τη δυσφορία που είναι εγγενής στο σεξουαλικό πρότυπο από τη δυσφορία που προκύπτει αποκλειστικά από ντροπή, στίγμα ή φόβο κοινωνικής απόρριψης, επειδή η σύγχρονη ταξινόμηση αποφεύγει συνειδητά την

παθολογικοποίηση συναινετικών άτυπων σεξουαλικών ενδιαφερόντων μόνο για αυτούς τους λόγους.

Η θεραπεία είναι εξειδικευμένη και συνήθως συνδυάζει **ψυχοθεραπεία, πρόληψη υποτροπής και ρητές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου**. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στους εκλυτικούς παράγοντες, στα γνωστικά και συμπεριφορικά πρότυπα, στην αυτορρύθμιση, στην πρόσβαση σε καταστάσεις κινδύνου και στους προστατευτικούς παράγοντες.

Η φαρμακοθεραπεία μπορεί να εξετάζεται επιλεκτικά. Τα **SSRIs** μπορεί να έχουν ρόλο σε ορισμένες περιπτώσεις χαμηλότερου ή μέτριου κινδύνου με καταναγκαστική ή παραισθητική σεξουαλική ενασχόληση ή σχετική συννοσηρότητα. Η **αντιανδρογονική θεραπεία ή τα ανάλογα GnRH** αποτελούν εξειδικευμένες παρεμβάσεις για επιλεγμένες σοβαρές ή υψηλού κινδύνου περιπτώσεις. Τα ανάλογα GnRH καταστέλλουν σημαντικά τη γοναδική τεστοστερόνη και τη σεξουαλική ενόρμηση, αλλά δεν πρέπει να περιγράφονται σαν να εξαλείφουν τη σεξουαλική διέγερση ή τον κίνδυνο. Η χρήση τους εξαρτάται από τον κίνδυνο, τη συναίνεση και το νομικό πλαίσιο και απαιτεί ενδοκρινολογική, μεταβολική, οστική και καρδιαγγειακή παρακολούθηση.

Η βασική αρχή για την προφορική εξέταση είναι επομένως να διαχωρίζω το ενδιαφέρον από τη διαταραχή, να οργανώνω την αξιολόγηση γύρω από τη συναίνεση και τη βλάβη, να διατυπώνω τον κίνδυνο συγκεκριμένα και να χρησιμοποιώ αναλογική εξειδικευμένη θεραπεία χωρίς παθολογικοποίηση της σεξουαλικής ποικιλομορφίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η **παραφιλία δεν είναι συνώνυμη με την παραφιλική διαταραχή**.
- Στο σύγχρονο ICD-11, τα συναινετικά άτυπα ενδιαφέροντα δεν αποτελούν διαταραχές απλώς επειδή είναι ασυνήθιστα ή κοινωνικά απορριπτέα.
- Ανάλογα με την κατηγορία, η διαταραχή μπορεί να αφορά άτομα που δεν συναινούν, έντονη εγγενή δυσφορία ή σημαντικό άμεσο κίνδυνο τραυματισμού/θανάτου.
- Τα SSRIs και οι αντιανδρογονικές/GnRH στρατηγικές είναι επιλεγμένες εξειδικευμένες επιλογές, όχι συνήθους θεραπείας για συναινετική άτυπη σεξουαλικότητα.
- Τα ανάλογα GnRH καταστέλλουν σημαντικά τη γοναδική τεστοστερόνη/σεξουαλική ενόρμηση· δεν εγγυώνται εξάλειψη της διέγερσης, της παραβατικής συμπεριφοράς ή του κινδύνου.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ταύτιση άτυπου ενδιαφέροντος με ψυχιατρική διαταραχή.
- Αντιμετώπιση της δυσφορίας που οφείλεται μόνο στο στίγμα ως επαρκούς απόδειξης διαταραχής.
- Χρήση της διαγνωστικής ετικέτας αντί για συμπεριφορική εκτίμηση κινδύνου.
- Παρουσίαση της ορμονικής θεραπείας ως συνήθους παρέμβασης ή ως θεραπείας που εξαλείφει τον κίνδυνο.
- Παράλειψη της συναίνεσης και του νομικού πλαισίου στις εξειδικευμένες φαρμακολογικές παρεμβάσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η παλαιότερη κατηγορική διδασκαλία μπορούσε να παθολογικοποιεί υπερβολικά εύκολα άτυπα σεξουαλικά ενδιαφέροντα. Το σύγχρονο ICD-11 αποφεύγει ρητά την ταξινόμηση συναινετικών άτυπων ενδιαφερόντων ως διαταραχών χωρίς σχετική βλάβη, μη συναίνεση, κλινικά σημαντική δυσφορία ή άμεσο κίνδυνο.

Πώς προσεγγίζετε τη δυσφορία φύλου ή την ασυμβατότητα φύλου σε έναν ενήλικα;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Η ποικιλομορφία φύλου δεν αποτελεί ψυχοπαθολογία
- 2 Διευκρίνιση του βιώματος, της δυσφορίας και των στόχων του ατόμου
- 3 Βιοψυχοκοινωνικό ιστορικό με σεβασμό
- 4 Εκτίμηση συννοσηρότητας και κινδύνου με τους δικούς τους όρους
- 5 Ικανότητα λήψης απόφασης για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
- 6 Υποστήριξη της αυτονομίας και κατάλληλη εξειδικευμένη παραπομπή

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ποικιλομορφία φύλου αυτή καθαυτή δεν αποτελεί ψυχιατρική διαταραχή. Ο ρόλος μου δεν είναι να διαγνώσω ψυχική νόσο με βάση την ταυτότητα, την έκφραση ή τη μη συμμόρφωση προς κοινωνικά πρότυπα φύλου, αλλά να κατανοήσω το βίωμα ασυμβατότητας ή δυσφορίας φύλου, να αξιολογήσω τη δυσφορία, την ασφάλεια και τη συννοσηρότητα όπου χρειάζεται, να υποστηρίξω την ενημερωμένη αυτόνομη λήψη αποφάσεων και να διευκολύνω την πρόσβαση σε κατάλληλη εξειδικευμένη φροντίδα υγείας φύλου όταν αυτό ζητείται.

Ξεκινώ με ιστορικό που λαμβάνεται με σεβασμό, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα, τις αντωνυμίες και τους όρους που επιλέγει το ίδιο το άτομο για την ταυτότητα και τους στόχους του. Διερευνώ τη φύση και τη διάρκεια της ασυμβατότητας ή της δυσφορίας φύλου, ποιες πτυχές του σώματος ή του κοινωνικού ρόλου προκαλούν δυσφορία, ποιες αλλαγές ή μορφές υποστήριξης επιθυμεί το άτομο και πώς το βίωμα επηρεάζει τις σχέσεις, την εργασία, την καθημερινή λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής.

Το κοινωνικό πλαίσιο έχει σημασία. Πρωτό για υποστήριξη από οικογένεια και σχέσεις, διακρίσεις, στρες μειονότητας, στεγαστικές ή επαγγελματικές δυσκολίες και άλλα εμπόδια στην πρόσβαση στη φροντίδα. Η δυσφορία που προκύπτει από απόρριψη ή στίγμα δεν πρέπει να παρερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η ίδια η ποικιλομορφία φύλου είναι παθολογική.

Η ψυχιατρική εκτίμηση παραμένει σημαντική, αλλά γίνεται με βάση την ίδια την ψυχιατρική εικόνα. Κατάθλιψη, άγχος, νευροαναπτυξιακές καταστάσεις, συμπτώματα σχετιζόμενα με τραύμα, χρήση ουσιών και κίνδυνος αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας πρέπει να αναγνωρίζονται και να θεραπεύονται όταν υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει αυτομάτως να χρησιμοποιούνται για να ακυρώσουν ή να ερμηνεύσουν ως ψυχοπαθολογική την ταυτότητα φύλου του ατόμου. Αντίστροφα, μια κλινικά σημαντική ψυχική διαταραχή δεν πρέπει να αγνοείται επειδή η συνάντηση αφορά ζητήματα φύλου.

Για κάθε προτεινόμενη παρέμβαση, αξιολογώ την ικανότητα λήψης της συγκεκριμένης απόφασης με τον συνήθη κλινικό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι το άτομο κατανοεί τη φύση, τα πιθανά οφέλη, τους περιορισμούς και τους κινδύνους της απόφασης και μπορεί να συμμετάσχει ουσιαστικά στην ενημερωμένη

συναίνεση. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η αυτόνομη λήψη αποφάσεων και όχι να μετατραπεί ο ψυχίατρος σε «θυρωρό» που οφείλει να αποδείξει την ταυτότητα του ατόμου.

Η εκτίμηση και η φροντίδα πρέπει να είναι **εξατομικευμένες και όχι να επιβάλλονται μέσα από μία ενιαία υποχρεωτική διαδικασία**. Δεν χρειάζεται κάθε ενήλικας τις ίδιες πολυεπιστημονικές εκτιμήσεις, τα ίδια βήματα κοινωνικής μετάβασης ή τις ίδιες ιατρικές παρεμβάσεις. Η συμβουλευτική για τη γονιμότητα είναι σχετική πριν από θεραπείες που μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα, αλλά συνδέεται με τη συγκεκριμένη προτεινόμενη παρέμβαση και δεν αποτελεί υποχρεωτικό βήμα για κάθε ενήλικα με ποικιλομορφία φύλου.

Οι παράγοντες σωματικής υγείας που σχετίζονται με τους στόχους του ατόμου εντάσσονται στη φροντίδα με κατάλληλη εξειδικευμένη συνεργασία. Όταν ζητείται εκτίμηση ή παρέμβαση υγείας φύλου, διευκολύνω την παραπομπή ή υποστήριξη μέσω κατάλληλης εξειδικευμένης υπηρεσίας, αποφεύγοντας ατεκμηρίωτες υποθέσεις για συγκεκριμένες ελληνικές υπηρεσίες, αποζημίωση ή διαδικασίες παραπομπής.

Η συνολική προσέγγιση είναι επομένως σεβαστική, μη παθολογικοποιητική και κλινικά αυστηρή: κατανοώ τους στόχους και τη δυσφορία του ατόμου, εκτιμώ την ασφάλεια και τη συννοσηρότητα χωρίς αιτιολογικές υποθέσεις, υποστηρίζω την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων και συνδέω το άτομο με την κατάλληλη φροντίδα υγείας φύλου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Το ICD-11 μετέφερε την Ασυμβατότητα Φύλου στην Εφηβεία και την Ενήλικη Ζωή εκτός των ψυχικών διαταραχών, στις Καταστάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία.
- Η ποικιλομορφία φύλου αυτή καθαυτή δεν αποτελεί ψυχοπαθολογία.
- Η ψυχιατρική συννοσηρότητα αξιολογείται και θεραπεύεται με τους δικούς της όρους· δεν ακυρώνει αυτομάτως την ταυτότητα φύλου ή τους θεραπευτικούς στόχους.
- Η συμβουλευτική για τη γονιμότητα είναι σχετική πριν από παρεμβάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα και δεν αποτελεί καθολική απαίτηση για κάθε ενήλικα.
- Δεν υπάρχει επαληθευμένη ενιαία ελληνική εθνική διαδικασία παραπομπής/αποζημίωσης που πρέπει να επινοηθεί στην προφορική εξέταση.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Παθολογικοποίηση της τρανς ή άλλης ποικιλόμορφης ταυτότητας φύλου.
- Υπόθεση ότι η ψυχιατρική συννοσηρότητα ακυρώνει την ταυτότητα φύλου.
- Μετατροπή του ψυχιάτρου σε «θυρωρό» που πρέπει να αποδείξει την ταυτότητα.
- Παρουσίαση μίας ενιαίας πολυεπιστημονικής διαδικασίας ή κοινωνικής μετάβασης ως υποχρεωτικής για κάθε ενήλικα.
- Επινόηση μη επαληθευμένων ελληνικών κανόνων υπηρεσιών ή παραπομπής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το ICD-10 τοποθετούσε τις διαγνώσεις που σχετίζονται με το φύλο στις ψυχικές διαταραχές. Το ICD-11 μετέφερε την Ασυμβατότητα Φύλου στην Εφηβεία και την Ενήλικη Ζωή στις Καταστάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία, αντανακλώντας την αρχή ότι η ποικιλομορφία φύλου δεν αποτελεί από μόνη της ψυχική νόσο.

Ποιες βασικές φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές αρχές έχουν σημασία στην ψυχοφαρμακολογία;

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα
- 2 Κατανομή, πρωτεϊνική σύνδεση και όγκος κατανομής
- 3 Μεταβολισμός: Φάση I/II και αλληλεπιδράσεις CYP
- 4 Νεφρική απέκκριση, χρόνος ημιζωής και σταθερή κατάσταση
- 5 Αγωνισμός, ανταγωνισμός και μερικός αγωνισμός
- 6 Σχέση δόσης-απόκρισης και θεραπευτικός δείκτης
- 7 Παράγοντες του ασθενούς και του φαρμάκου που τροποποιούν την απόκριση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η φαρμακοκινητική περιγράφει πρακτικά τι κάνει ο οργανισμός στο φάρμακο, ενώ η φαρμακοδυναμική τι κάνει το φάρμακο στον οργανισμό. Στην ψυχοφαρμακολογία, το κλινικά χρήσιμο πλαίσιο είναι απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός και αποβολή και στη συνέχεια η σύνδεση της συγκέντρωσης με τη δράση στους υποδοχείς, τη σχέση δόσης-απόκρισης και την ασφάλεια. Οι αρχές αυτές εξηγούν γιατί η ίδια δόση μπορεί να συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά σε διαφορετικούς ασθενείς ή μετά από μια φαρμακευτική αλληλεπίδραση.

Η **απορρόφηση** καθορίζει πόσο και πόσο γρήγορα ένα φάρμακο εισέρχεται στην κυκλοφορία, ενώ η **βιοδιαθεσιμότητα** περιγράφει το ποσοστό που φτάνει στη συστηματική κυκλοφορία. Μετά την απορρόφηση, η κατανομή επηρεάζεται μεταξύ άλλων από τα χαρακτηριστικά των ιστών, την πρωτεϊνική σύνδεση και τον φαινόμενο όγκο κατανομής. Μεταβολές στην πρωτεϊνική σύνδεση ή στην κατανομή μπορούν να αλλάξουν τη σχέση ανάμεσα στη συνολική συγκέντρωση του φαρμάκου και στη φαρμακολογικά ενεργή έκθεση.

Τα περισσότερα ψυχοτρόπα μεταβολίζονται στο ήπαρ. Οι **αντιδράσεις Φάσης I** συνήθως περιλαμβάνουν οξείδωση και ένζυμα CYP, ενώ οι **αντιδράσεις Φάσης II** περιλαμβάνουν σύζευξη. Η διάκριση αυτή είναι χρήσιμη, αλλά ο παλαιός κανόνας ότι η ηλικία ή η ηπατική νόσος απλώς επηρεάζουν τη Φάση I ενώ η Φάση II διατηρείται είναι υπερβολικά απλουστευτικός· οι επιδράσεις της ηλικίας και της οργανικής δυσλειτουργίας εξαρτώνται από το συγκεκριμένο φάρμακο και τη συγκεκριμένη μεταβολική οδό.

Οι αλληλεπιδράσεις μέσω CYP έχουν σημασία επειδή η ενζυμική αναστολή μπορεί να αυξήσει τη συστηματική έκθεση σε ένα ευαίσθητο φάρμακο, ενώ η ενζυμική επαγωγή μπορεί να τη μειώσει. Η αναστολή εμφανίζεται συνήθως ταχύτερα από την επαγωγή ή την απο-επαγωγή, επομένως έχει σημασία όχι μόνο η κατεύθυνση αλλά και ο χρονισμός της αλληλεπίδρασης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κάπνισμα. Οι **πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες του καπνού** — και όχι η νικοτίνη — επάγουν το CYP1A2, μειώνοντας δυνητικά την έκθεση σε φάρμακα όπως η κλοζαπίνη και η ολανζαπίνη.

Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί συνεπώς να αυξήσει την έκθεση ακόμη και όταν χορηγείται υποκατάσταση νικοτίνης. Άλλα χρήσιμα παραδείγματα είναι η φλουοξετίνη και η παροξετίνη ως κλινικά σημαντικοί αναστολείς του CYP2D6 και η καρβαμαζεπίνη ως κλασικός ενζυμικός επαγωγέας.

Η αποβολή μπορεί να είναι ηπατική, νεφρική ή και τα δύο. Ο χρόνος ημιζωής βοηθά να προβλέψουμε πόσο γρήγορα μειώνονται οι συγκεντρώσεις μετά τη διακοπή ή την αλλαγή δόσης και πόσο χρόνο απαιτεί η συσσώρευση. Η σταθερή κατάσταση επιτυγχάνεται μετά από αρκετούς χρόνους ημιζωής αποβολής, συνήθως περίπου 4–5 χρόνους ημιζωής ως πρακτικός κανόνας, αλλά ενεργοί μεταβολίτες και μη γραμμική κινητική μπορούν να μεταβάλουν αυτή την πρόβλεψη.

Φαρμακοδυναμικά, ο αγωνιστής ενεργοποιεί έναν υποδοχέα, ο ανταγωνιστής εμποδίζει τη δράση του αγωνιστή χωρίς δική του ενδογενή ενεργοποίηση, και ο μερικός αγωνιστής έχει μικρότερη ενδογενή αποτελεσματικότητα από έναν πλήρη αγωνιστή και μπορεί επομένως να λειτουργεί ως αγωνιστής ή ανταγωνιστής ανάλογα με το σύστημα. Ο αντίστροφος αγωνιστής μειώνει τη συστατική δραστηριότητα του υποδοχέα, ενώ ένας θετικός αλλοστερικός ρυθμιστής ενισχύει την απόκριση του υποδοχέα στον ενδογενή συνδέτη χωρίς να δρα στην κύρια θέση πρόσδεσης του αγωνιστή.

Οι σχέσεις δόσης–απόκρισης περιγράφουν πώς η αύξηση της έκθεσης μεταβάλλει το αποτέλεσμα, ενώ ο θεραπευτικός δείκτης εκφράζει την απόσταση ανάμεσα στην αποτελεσματική και την τοξική έκθεση και επηρεάζει το πόσο στενά πρέπει να παρακολουθείται μια θεραπεία.

Το βασικό σημείο στην προφορική εξέταση είναι να συνδέονται αυτές οι αρχές με τη συνταγογράφηση: ηλικία και λειτουργία οργάνων, κάπνισμα, αλληλεπιδρώντα φάρμακα, χρόνος ημιζωής και κάθαρση του φαρμάκου και φαρμακοδυναμικό περιθώριο ασφάλειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν ερμηνευτεί η ανταπόκριση ή η τοξικότητα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η σταθερή κατάσταση επιτυγχάνεται συνήθως μετά από περίπου 4–5 χρόνους ημιζωής αποβολής, ως πρακτικός κανόνας και όχι ακριβής νόμος.
- Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες του καπνού, όχι η νικοτίνη, επάγουν το CYP1A2 και μπορούν να μειώσουν την έκθεση σε κλοζαπίνη/ολανζαπίνη.
- Η φλουοξετίνη και η παροξετίνη είναι κλινικά σημαντικοί αναστολείς CYP2D6.
- Η καρβαμαζεπίνη είναι κλασικός ενζυμικός επαγωγέας.
- Η αναστολή CYP αναπτύσσεται συνήθως ταχύτερα από την επαγωγή ή την απο-επαγωγή.
- Μερικός αγωνιστής, αντίστροφος αγωνιστής και θετικός αλλοστερικός ρυθμιστής είναι διακριτές φαρμακοδυναμικές έννοιες.
- Τα συνήθη εμπορικά φαρμακογονιδιωμικά πάνελ δεν αποτελούν καθολική προϋπόθεση για συνταγογράφηση.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Παράθεση εξαντλητικού καταλόγου CYP αντί για εξήγηση των κλινικά σημαντικών αρχών.
- Υπόθεση ότι η ίδια η νικοτίνη προκαλεί την αλληλεπίδραση CYP1A2 του καπνίσματος.
- Αντιμετώπιση των 4–5 χρόνων ημιζωής ως μαθηματικά ακριβούς κανόνα για κάθε φάρμακο.
- Επανάληψη του υπεραπλουστευμένου κανόνα «Φάση I επηρεασμένη, Φάση II διατηρημένη» για κάθε ηλικιωμένο ή ασθενή με ηπατική δυσλειτουργία.
- Εφαρμογή μίας καθολικής προσαρμογής δόσης σε κάθε ασθενή με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλληλεπιδράσεις ψυχοτρόπων φαρμάκων;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επαγωγή και αναστολή CYP
- 2 Σεροτονινεργικοί συνδυασμοί και περίοδοι έκπλυσης MAOI
- 3 Αθροιστικός κίνδυνος παράτασης QT
- 4 Καταστολή ΚΝΣ και αναπνευστική καταστολή
- 5 Αύξηση έκθεσης στο λίθιο
- 6 Βαλπροϊκό, λαμοτριγίνη και ενζυμοεπαγωγικά αντιεπιληπτικά
- 7 Κίνδυνος αιμορραγίας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ασφαλέστερος τρόπος να προσεγγίζουμε τις αλληλεπιδράσεις ψυχοτρόπων είναι με βάση τον **μηχανισμό και την κλινική συνέπεια**, όχι με απομνημόνευση μεμονωμένων ζευγών φαρμάκων. Οι βασικές ομάδες είναι οι μεταβολικές αλληλεπιδράσεις μέσω CYP, η σεροτονινεργική τοξικότητα, ο αθροιστικός κίνδυνος παράτασης QT, η αθροιστική καταστολή του ΚΝΣ, η αύξηση της έκθεσης στο λίθιο, σημαντικές αλληλεπιδράσεις αντιεπιληπτικών και ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας.

Στις μεταβολικές αλληλεπιδράσεις, κλασικό παράδειγμα είναι το κάπνισμα. Οι **πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες του καπνού επάγουν το CYP1A2· η νικοτίνη όχι**. Το κάπνισμα μπορεί επομένως να μειώσει την έκθεση σε κλοζαπίνη ή ολανζαπίνη, ενώ η διακοπή του μπορεί να την αυξήσει. Η θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης δεν διατηρεί την επαγωγή που προκαλεί ο καπνός, άρα η φαρμακευτική αγωγή χρειάζεται επανεκτίμηση όταν αλλάζει το καπνιστικό καθεστώς.

Οι αναστολείς CYP μπορούν να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις ευαίσθητων φαρμάκων, αλλά οι άκαμπτοι πίνακες πολλαπλασιαστών είναι παραπλανητικοί, επειδή το μέγεθος της αλληλεπίδρασης εξαρτάται από το υπόστρωμα, τη δόση, τον γονότυπο, το κάπνισμα και τη συγχορηγούμενη αγωγή. Κλινικά χρήσιμα παραδείγματα είναι η φλουοξετίνη και η παροξετίνη ως σημαντικοί αναστολείς CYP2D6 και η φλουβοξαμίνη ως σημαντικός αναστολέας CYP1A2. Στην προφορική εξέταση έχει μεγαλύτερη αξία να αναγνωρίζεται ο μηχανισμός και να ελέγχονται οι πραγματικές πληροφορίες προϊόντος παρά να αναφέρονται καθολικοί πολλαπλασιαστές.

Δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι η **σεροτονινεργική τοξικότητα**. Οι μη αναστρέψιμοι MAOIs δεν πρέπει να συνδυάζονται με σεροτονινεργικά αντικαταθλιπτικά χωρίς την κατάλληλη περίοδο έκπλυσης. Ένα σημαντικό, ειδικό για το συγκεκριμένο προϊόν, ορόσημο ασφάλειας είναι ότι απαιτούνται **τουλάχιστον 5 εβδομάδες μετά τη διακοπή της φλουοξετίνης πριν από την έναρξη μη αναστρέψιμου MAOI**, λόγω της παρατεταμένης παραμονής της φλουοξετίνης και της νορφλουοξετίνης. Αντίστροφα, η ισχύουσα **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SmPC)** της φλουοξετίνης απαιτεί

τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά τη διακοπή μη αναστρέψιμου ΜΑΟΙ πριν αρχίσει η φλουοξετίνη. Άλλες αλλαγές θεραπείας εξαρτώνται από το συγκεκριμένο προϊόν και δεν πρέπει να συνάγονται από αυτά τα δύο διαστήματα.

Ο κίνδυνος παράτασης του QT είναι αθροιστικός. Ο συνδυασμός φαρμάκων που παρατείνουν το QT, ιδίως σε ασθενή με επιπλέον καρδιακούς ή ηλεκτρολυτικούς παράγοντες κινδύνου, μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία από κάθε φάρμακο μεμονωμένα. Ελέγχω επομένως ολόκληρη τη φαρμακευτική αγωγή και τους παράγοντες κινδύνου του ασθενούς, αντί να αντιμετωπίζω τον κίνδυνο QT ως ιδιότητα ενός μόνο φαρμάκου.

Η αθροιστική καταστολή και η αναπνευστική καταστολή είναι ιδιαίτερα σημαντικές με **βενζοδιαζεπίνες σε συνδυασμό με οπιοειδή ή αλκοόλ**. Πρόκειται για κλινικά σημαντική αλληλεπίδραση, επειδή οι κατασταλτικές επιδράσεις στο ΚΝΣ μπορούν να αθροιστούν ακόμη και όταν κάθε ουσία είναι οικεία στον ασθενή.

Το **λίθιο** έχει αρκετές σημαντικές φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις. Τα ΜΣΑΦ, οι αναστολείς ΜΕΑ ή οι ARBs και τα διουρητικά μπορούν να αυξήσουν την έκθεση στο λίθιο, με τα θειαζιδικά διουρητικά να αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική αλληλεπίδραση. Η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο, επομένως η διατρέχουσα νόσος και η απώλεια υγρών πρέπει να περιλαμβάνονται στο φαρμακευτικό ιστορικό.

Στους σταθεροποιητές διάθεσης και στα αντιεπιληπτικά, **το βαλπροϊκό αναστέλλει τη γλυκουρονιδίωση της λαμοτριγίνης και αυξάνει την έκθεση σε αυτήν**, γι' αυτό και το ακριβές σχήμα τιτλοποίησης της ΠΧΠ αλλάζει όταν συνδυάζονται. Αντίστροφα, τα ενζυμοεπαγωγικά αντιεπιληπτικά μπορούν να μειώσουν τις συγκεντρώσεις ευαίσθητων ψυχοτρόπων και να προκαλέσουν φαινομενική μη ανταπόκριση εάν η αλληλεπίδραση δεν αναγνωριστεί.

Τέλος, τα SSRI και SNRI μπορούν να αυξήσουν τον **κίνδυνο αιμορραγίας**, ιδίως όταν συνδυάζονται με ΜΣΑΦ, αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά. Η κλινική αντιμετώπιση εξαρτάται από τον ατομικό γαστρεντερικό και αιμορραγικό κίνδυνο· δεν είναι σωστό να θεωρείται ότι κάθε τέτοιος συνδυασμός απαιτεί αυτομάτως αναστολέα αντλίας πρωτονίων.

Ο πρακτικός κανόνας είναι να ελέγχουμε αλληλεπιδράσεις κάθε φορά που ένα ψυχότροπο αρχίζει, διακόπτεται ή αλλάζει και κάθε φορά που αλλάζουν το κάπνισμα, η σωματική κατάσταση ή η συγχωρηγούμενη αγωγή. Ο κίνδυνος αλληλεπιδράσεων είναι συχνά αθροιστικός και εξατομικευμένος.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η υποκατάσταση νικοτίνης δεν αναπαράγει την επαγωγή CYP1A2 του καπνού.
- Φλουοξετίνη → μη αναστρέψιμος ΜΑΟΙ: αναμονή τουλάχιστον 5 εβδομάδων.
- Μη αναστρέψιμος ΜΑΟΙ → φλουοξετίνη: αναμονή τουλάχιστον 2 εβδομάδων.
- Τα ακριβή αυτά διαστήματα είναι ειδικά για τα συγκεκριμένα προϊόντα, όχι καθολικός κανόνας για κάθε αντικαταθλιπτικό.
- Το **βαλπροϊκό αναστέλλει τη γλυκουρονιδίωση της λαμοτριγίνης**, αυξάνοντας την έκθεση και τον κίνδυνο εξανθήματος· ακολουθήστε την τιτλοποίηση της ΠΧΠ και όχι έναν απλό ποσοστιαίο κανόνα.

- Βενζοδιαζεπίνη + οπιοειδές/αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη **αθροιστική αναπνευστική καταστολή**.
- Η έκθεση στο λίθιο μπορεί να αυξηθεί με **ΜΣΑΦ, ACEi/ARBs, διουρητικά και αφυδάτωση**.
- Ο κίνδυνος αλληλεπιδράσεων είναι συχνά **αθροιστικός και εξατομικευμένος**, ιδίως για QT, καταστολή και αιμορραγία.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ισχυρισμός ότι η νικοτίνη επάγει το CYP1A2.
- Παράθεση σταθερών πολλαπλασιαστών CYP σαν να ισχύουν για κάθε ασθενή.
- Τυφλό cross-taper μέσω μη αναστρέψιμου MAOI.
- Εφαρμογή του διαστήματος έκπλυσης της φλουοξετίνης σε όλα τα αντικαταθλιπτικά χωρίς έλεγχο των πληροφοριών προϊόντος.
- Παράλειψη μη ψυχιατρικών φαρμάκων όπως ΜΣΑΦ, αντιυπερτασικά, οπιοειδή ή αντιπηκτικά.
- Υπόθεση ότι απαιτείται πάντοτε PPI όταν SSRI συνδυάζεται με ΜΣΑΦ ή αντιπηκτικό.

Πώς επιλέγετε ένα αντιψυχωσικό;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Προηγούμενη αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα
- 2 Μεταβολική ευαλωτότητα
- 3 Κίνδυνος EPS, υπερπρολακτιναιμίας και παράτασης QT
- 4 Καταστολή, σωματική συννοσηρότητα και αλληλεπιδράσεις
- 5 Συμμόρφωση και φαρμακοτεχνική μορφή
- 6 Προτιμήσεις και προτεραιότητες του ασθενούς
- 7 Κλοζαπίνη μετά από δύο επαρκείς αποτυχημένες δοκιμές

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιλογή αντιψυχωσικού πρέπει να είναι εξατομικευμένη και όχι να βασίζεται σε άκαμπτη ιεράρχηση αποτελεσματικότητας πρώτης γραμμής. Συνδυάζω την προηγούμενη ανταπόκριση, την ευαλωτότητα του ασθενούς σε ανεπιθύμητες ενέργειες και τη σωματική συννοσηρότητα, το φορτίο αλληλεπιδράσεων, τις ανάγκες συμμόρφωσης, τη διαθέσιμη φαρμακοτεχνική μορφή και τις προτεραιότητες του ίδιου του ασθενούς. Εάν η σχιζοφρένεια παραμένει ανεπαρκώς ανταποκρινόμενη μετά από δύο επαρκείς δοκιμές αντιψυχωσικών, η κλοζαπίνη γίνεται η βασική τεκμηριωμένη θεραπεία.

Πρώτα εξετάζω τι συνέβη με προηγούμενα αντιψυχωσικά: ποια ήταν αποτελεσματικά, ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες περιόρισαν τη θεραπεία, εάν η δοκιμή ήταν επαρκής και εάν η συμμόρφωση ήταν αξιόπιστη. Ένα φάρμακο που στο παρελθόν ήταν αποτελεσματικό και καλά ανεκτό μπορεί να αποτελεί ισχυρή επιλογή, εκτός εάν έχει αλλάξει το κλινικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια αντιστοιχίζω το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών στην ευαλωτότητα του ασθενούς. Ο **μεταβολικός κίνδυνος** είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ασθενείς με παχυσαρκία, διαβήτη ή άλλη καρδιομεταβολική ευαλωτότητα· η κλοζαπίνη και η ολανζαπίνη είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα υψηλής μεταβολικής επιβάρυνσης. Εάν υπάρχει ανησυχία για κινητικές διαταραχές, λαμβάνω υπόψη την ευαλωτότητα σε EPS. Η υπερπρολακτιναιμία έχει σημασία όταν υπάρχουν σεξουαλικά, αναπαραγωγικά, ενδοκρινικά ή οστικά ζητήματα· η ρισπεριδόνη, η παλιπεριδόνη και η αμισουλπρίδη είναι παραδείγματα που αυξάνουν την προλακτίνη, ενώ η αριπιπραζόλη είναι **σχετικά λιγότερο πιθανό να την αυξήσει**.

Μηχανιστικά, η ετικέτα «αντιψυχωσικό δεύτερης γενιάς» δεν πρέπει να υπεραπλουστεύεται. Πολλά φάρμακα συνδυάζουν **ανταγωνισμό D2 και 5-HT_{2A}**, αλλά η κατηγορία είναι ετερογενής και οι μερικοί αγωνιστές τύπου αριπιπραζόλης διαφέρουν. Η χαμηλότερη πιθανότητα EPS **εξαρτάται από το συγκεκριμένο φάρμακο και τη δόση** και δεν αποτελεί εγγυημένη ιδιότητα όλων των SGAs.

Λαμβάνω επίσης υπόψη τον **κίνδυνο παράτασης QT, την καταστολή και τη σωματική συννοσηρότητα**, μαζί με ολόκληρη τη φαρμακευτική αγωγή για πιθανές φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις. Δεν επιλέγω απλώς το φάρμακο με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες συνολικά, επειδή τα προφίλ διαφέρουν και η σχετική επιβάρυνση εξαρτάται από τον συγκεκριμένο ασθενή.

Η συμμόρφωση και η φαρμακοτεχνική μορφή είναι εξίσου σημαντικές. Εάν η συμμόρφωση είναι αβέβαιη, δεν μπορεί να κριθεί σωστά η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ένα **ενέσιμο αντιψυχωσικό μακράς δράσης (LAI)** μπορεί να είναι κατάλληλο όταν το προτιμά ο ασθενής ή όταν η διατήρηση αξιόπιστης έκθεσης αποτελεί κλινική προτεραιότητα. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως εξαναγκαστική επιλογή που προορίζεται μόνο για «δύσκολους» ασθενείς.

Η **από κοινού λήψη αποφάσεων** πρέπει να περιλαμβάνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που ανησυχούν περισσότερο τον ασθενή, την προηγούμενη υποκειμενική εμπειρία θεραπείας, πρακτικά ζητήματα δόσης ή μορφής και τις συνέπειες μιας υποτροπής. Αυτοί οι παράγοντες συχνά καθορίζουν εάν μια κατά τα άλλα λογική φαρμακολογική επιλογή θα είναι βιώσιμη.

Τέλος, η φαινομενική ανθεκτικότητα δεν πρέπει να οδηγεί σε ατελείωτες διαδοχικές αλλαγές. Στη σχιζοφρένεια, η αποτυχία **δύο επαρκών δοκιμών αντιψυχωσικών** πρέπει να οδηγήσει σε **εξέταση της κλοζαπίνης**, αντί να συνεχίζεται επ' αόριστον η συνήθης αλληλουχία αντιψυχωσικών.

Η συνοπτική προσέγγιση είναι επομένως: προηγούμενη ανταπόκριση, ευαλωτότητα σε ανεπιθύμητες ενέργειες, σωματικοί και αλληλεπιδραστικοί κίνδυνοι, συμμόρφωση και μορφή, προτίμηση του ασθενούς και κλοζαπίνη όταν τεκμηριώνεται πραγματική ανθεκτικότητα στη θεραπεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Πολλά SGAs συνδυάζουν **ανταγωνισμό D2 + 5-HT_{2A}**, αλλά η κατηγορία είναι μηχανιστικά ετερογενής και περιλαμβάνει **μερικούς αγωνιστές της οικογένειας D2**.
- Η χαμηλότερη πιθανότητα EPS **εξαρτάται από το φάρμακο και τη δόση**, όχι από μία καθολική ιδιότητα της κατηγορίας.
- Κλοζαπίνη και ολανζαπίνη είναι σημαντικά παραδείγματα υψηλής μεταβολικής επιβάρυνσης.
- Ρισπεριδόνη, παλιπεριδόνη και αμισουλπρίδη είναι παραδείγματα που **αυξάνουν την προλακτίνη**· η αριπιπραζόλη είναι σχετικά prolactin-sparing.
- Τα LAIs είναι κατάλληλα όταν **προτιμώνται** ή όταν η αξιόπιστη συμμόρφωση/έκθεση αποτελεί κλινική προτεραιότητα.
- Στη σχιζοφρένεια, η κλοζαπίνη είναι η βασική θεραπεία μετά από αποτυχία **δύο επαρκών δοκιμών αντιψυχωσικών**.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ακαμπτη συνηθισμένη ιεραρχία πρώτης γραμμής αντί για εξατομίκευση.
- Ισχυρισμός ότι όλα τα SGAs δρουν με τον ίδιο τρόπο μέσω ανταγωνισμού D2/5-HT_{2A}.
- Υπόθεση ότι κάθε SGA έχει χαμηλή πιθανότητα EPS.
- Παρουσίαση των LAIs ως εγγενώς εξαναγκαστικών.
- Συνέχιση πολλαπλών συνηθισμένων αντιψυχωσικών δοκιμών αφού έχει τεκμηριωθεί πραγματική ανθεκτικότητα στη θεραπεία.

Ποιες εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες προκαλούν τα αντιψυχωσικά και πώς τις αντιμετωπίζετε;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Οξεία δυστονία — επείγουσα αντιμουςκαρινική αγωγή
- 2 Φαρμακογενής παρκινσονισμός — μείωση επιβάρυνσης ή αλλαγή φαρμάκου
- 3 Ακαθησία — αναγνώριση της υποκειμενικής εσωτερικής ανησυχίας
- 4 Όψιμη δυσκινησία — ελαχιστοποίηση ντοπαμινεργικού αποκλεισμού
- 5 Αποφυγή περιττής χρόνιας αντιχολινεργικής αγωγής
- 6 Αναστολείς VMAT2 για κλινικά σημαντική όψιμη δυσκινησία

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα τέσσερα βασικά εξωπυραμιδικά σύνδρομα είναι η οξεία δυστονία, ο φαρμακογενής παρκινσονισμός, η ακαθησία και η όψιμη δυσκινησία. Η αντιμετώπιση αρχίζει από τη σωστή αναγνώριση του συνδρόμου, την επανεκτίμηση της ανάγκης και της δόσης του φαρμάκου που προκαλεί ντοπαμινεργικό αποκλεισμό και στη συνέχεια την εφαρμογή θεραπείας ειδικά για το συγκεκριμένο σύνδρομο. Η κλασική εξεταστική παγίδα είναι να αντιμετωπίζεται κάθε κινητική διαταραχή με αντιχολινεργικό.

Η οξεία δυστονία είναι σύνδρομο πρώιμης έναρξης με παρατεταμένες μυϊκές συσπάσεις μετά από ντοπαμινεργικό αποκλεισμό, συχνά στον τράχηλο, τη γνάθο, τους οφθαλμούς ή άλλες μυϊκές ομάδες. Χρειάζεται επείγουσα αντιμουςκαρινική αγωγή. Η λαρυγγική δυστονία αποτελεί επείγουσα κατάσταση του αεραγωγού, επομένως η ασφάλεια του αεραγωγού προηγείται της συνήθους αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.

Ο φαρμακογενής παρκινσονισμός προκαλεί παρκινσονικό κινητικό σύνδρομο κατά τη διάρκεια ντοπαμινεργικού αποκλεισμού. Η προτιμώμενη στρατηγική είναι να επανεκτιμηθεί εάν μπορεί να μειωθεί η δόση του αντιψυχωσικού ή εάν μπορεί να γίνει αλλαγή σε επιλογή χαμηλότερου κινδύνου χωρίς να αποσταθεροποιηθεί η ψυχιατρική νόσος. Βραχεία αντιχολινεργική αγωγή μπορεί να είναι χρήσιμη όταν χρειάζεται κλινικά, αλλά η αυτόματη μακροχρόνια προφυλακτική χορήγηση πρέπει να αποφεύγεται λόγω του δικού της φορτίου ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η ακαθησία είναι διαφορετική. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι μια υποκειμενική εσωτερική ανησυχία ή ανάγκη για κίνηση μαζί με παρατηρήσιμη κινητική ανησυχία, συχνά μετά την έναρξη ή αύξηση της δόσης ενός φαρμάκου. Μπορεί να παρερμηνευτεί ως άγχος, μανία ή επιδείνωση ψυχωτικής διέγερσης και να οδηγήσει στο ακριβώς λανθασμένο βήμα: περαιτέρω αύξηση του αντιψυχωσικού. Όπου είναι εφικτό, εξετάζω μείωση δόσης ή αλλαγή φαρμάκου, ενώ η προπρανολόλη αποτελεί σημαντική φαρμακολογική επιλογή όταν δεν αντενδείκνυται. Τα αντιχολινεργικά δεν αποτελούν αξιόπιστη θεραπεία ρουτίνας για αμιγή ακαθησία, αν και μπορεί να βοηθούν όταν συνυπάρχει κλινικά σημαντικός φαρμακογενής παρκινσονισμός.

Η **όψιμη δυσκινησία** είναι επίμονη υπερκινητική κινητική διαταραχή που εμφανίζεται αργότερα και σχετίζεται με έκθεση σε φάρμακα που αποκλείουν τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει επιβεβαίωση της διάγνωσης, διακοπή περιττής έκθεσης σε ντοπαμινεργικό αποκλεισμό, διατήρηση της χαμηλότερης αναγκαίας επιβάρυνσης όταν η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί και διακοπή περιττών αντιχολινεργικών. Τα αντιχολινεργικά μπορεί να επιδεινώσουν την όψιμη δυσκινησία και δεν πρέπει να χορηγούνται αντανεκλαστικά για αυτήν. Μπορεί να επιλεγεί αντιψυχωσική στρατηγική χαμηλότερου κινδύνου και, σε κλινικά σημαντική όψιμη δυσκινησία, μπορεί να εξεταστεί **αναστολή VMAT2**.

Σχετική σύγχρονη εξέλιξη είναι η **deutetrabenazine**, η οποία έλαβε ενωσιακή έγκριση τον Ιανουάριο του 2026 για μέτρια έως σοβαρή όψιμη δυσκινησία ενηλίκων. Η έγκριση αυτή δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτομάτως σε ισχυρισμό ότι υπάρχει καθιερωμένη διαθεσιμότητα ή αποζημίωση στην Ελλάδα.

Η ασφαλέστερη συνολική προσέγγιση είναι επομένως φαινομενολογική: η δυστονία είναι επείγον σύνδρομο μυϊκών συσπάσεων, ο παρκινσονισμός απαιτεί μείωση της επιβάρυνσης ή αλλαγή όπου είναι δυνατόν, η ακαθυσία απαιτεί αναγνώριση της εσωτερικής ανησυχίας και όχι αντανεκλαστική αύξηση δόσης, και η όψιμη δυσκινησία απαιτεί ελαχιστοποίηση της ντοπαμινεργικής επιβάρυνσης και εξέταση ειδικής θεραπείας με VMAT2.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η **λαρυγγική δυστονία** είναι επείγουσα κατάσταση του αεραγωγού.
- Ακαθυσία = υποκειμενική εσωτερική ανησυχία + παρατηρήσιμη κινητική ανησυχία.
- Η αμιγής ακαθυσία δεν αντιμετωπίζεται γενικά με αντιχολινεργικά· η **προπρανολόλη** είναι σημαντική επιλογή όταν ενδείκνυται.
- Τα αντιχολινεργικά μπορεί να βοηθούν σε συνυπάρχοντα φαρμακογενή παρκινσονισμό, αλλά μπορεί να **επιδεινώσουν την όψιμη δυσκινησία**.
- Η **deutetrabenazine** έχει ενωσιακή έγκριση για μέτρια–σοβαρή όψιμη δυσκινησία ενηλίκων· δεν έχει τεκμηριωθεί καθιερωμένη ελληνική πρόσβαση/αποζημίωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q77a. Πώς διακρίνετε την ακαθυσία από τη διέγερση;

Η ακαθυσία απαιτεί υποκειμενική εσωτερική ανησυχία ή ανάγκη για κίνηση **μαζί με παρατηρήσιμη κινητική ανησυχία**, συνήθως με χρονική σχέση προς την έναρξη ή αύξηση ενός υπεύθυνου φαρμάκου. Ρωτώ άμεσα εάν η κίνηση ανακουφίζει ένα εσωτερικό αίσθημα ανησυχίας και παρατηρώ βηματισμό, μετατόπιση του βάρους ή αδυναμία παραμονής σε ηρεμία.

Η ψυχωτική διέγερση, η μανία και το άγχος μπορούν επίσης να αυξήσουν την κινητικότητα, αλλά διαφοροποιούνται από τη συνοδό ψυχική κατάσταση και από την απουσία του χαρακτηριστικού εσωτερικού κινητικού αισθήματος που σχετίζεται χρονικά με τη φαρμακευτική αγωγή. Η διάκριση έχει πρακτική σημασία, επειδή η αύξηση του αντιψυχωσικού όταν η ακαθυσία έχει εκληφθεί ως διέγερση μπορεί να την επιδεινώσει.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση κάθε EPS με αντιχολινεργικό.
- Αύξηση του αντιψυχωσικού όταν η ακαθυσία εκλαμβάνεται ως διέγερση.
- Ισχυρισμός ότι τα αντιχολινεργικά είναι απολύτως άχρηστα σε κάθε εικόνα ακαθυσίας παρά την πιθανή συνύπαρξη παρκινσονισμού.
- Αυτόματη συνέχιση αντιχολινεργικών στην όψιμη δυσκινησία.
- Ταύτιση της ενωσιακής έγκρισης της deutetrabenazine με επαληθευμένη καθιερωμένη ελληνική πρόσβαση.

Ποιες μεταβολικές, ενδοκρινικές και καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιψυχωσικών πρέπει να παρακολουθείτε;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Σωματικό βάρος και περίμετρος μέσης
- 2 Αρτηριακή πίεση και σφύξεις
- 3 Γλυκόζη/HbA1c και λιπίδια
- 4 Προλακτίνη και σεξουαλικές/ενδοκρινικές επιδράσεις
- 5 ΗΚΓ και κίνδυνος QT όταν ενδείκνυται
- 6 Επαγρύπνηση για μυοκαρδίτιδα από κλοζαπίνη

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παρακολούθηση κατά τη θεραπεία με αντιψυχωσικά πρέπει να εστιάζει σε μεταβολική νόσο, επιδράσεις σχετιζόμενες με την προλακτίνη και καρδιαγγειακό κίνδυνο, παραμένοντας προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο φάρμακο και στον συγκεκριμένο ασθενή. Καταγράφω ένα κατάλληλο αρχικό προφίλ σωματικής υγείας, επαναλαμβάνω τον μεταβολικό έλεγχο κατά τη θεραπεία και προσθέτω ΗΚΓ ή εξειδικευμένες εξετάσεις όταν το φάρμακο, το κλινικό πλαίσιο ή ο ατομικός κίνδυνος το απαιτούν. Το αρχικό ΗΚΓ δεν αποτελεί καθολική απαίτηση για κάθε εξωτερικό ασθενή που λαμβάνει αντιψυχωσικό.

Η μεταβολική επιβάρυνση περιλαμβάνει αύξηση βάρους, κεντρική παχυσαρκία, υπεργλυκαιμία ή διαβήτη και δυσλιπιδαιμία. Στη σχιζοφρένεια, το σύγχρονο πλαίσιο παρακολούθησης του NICE αρχίζει με βάρος, περίμετρο μέσης, σφύξεις, αρτηριακή πίεση, γλυκόζη ή HbA1c, λιπίδια και προλακτίνη. Το βάρος ελέγχεται στη συνέχεια εβδομαδιαίως για τις πρώτες 6 εβδομάδες, ξανά στις 12 εβδομάδες, στο 1 έτος και έπειτα ετησίως. Η περίμετρος μέσης επαναλαμβάνεται ετησίως. Σφύξεις, αρτηριακή πίεση, γλυκόζη/HbA1c και λιπίδια επαναλαμβάνονται στις 12 εβδομάδες, στο 1 έτος και στη συνέχεια ετησίως μετά την αρχική μέτρηση.

Το βάρος από μόνο του δεν αρκεί. Ένας ασθενής μπορεί να εμφανίσει επιδείνωση του γλυκαιμικού ή λιπιδαιμικού κινδύνου ακόμη και χωρίς θεαματική μεταβολή του βάρους, επομένως το σύνολο της παρακολούθησης πρέπει να ερμηνεύεται συνολικά και σε σχέση με τον αρχικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η υπερπρολακτιναιμία μπορεί να προκαλέσει κλινικά σημαντικές σεξουαλικές, αναπαραγωγικές και ενδοκρινικές συνέπειες. Η προλακτίνη περιλαμβάνεται στον αρχικό έλεγχο, αλλά η ερμηνεία της πρέπει να συνδέεται με τα συμπτώματα, το συγκεκριμένο αντιψυχωσικό και το συνολικό κλινικό πλαίσιο και όχι να αντιμετωπίζεται ως απομονωμένο εργαστηριακό εύρημα. Η παρατεταμένη κλινικά σημαντική υπερπρολακτιναιμία μπορεί επίσης να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη γοναδική λειτουργία και την οστική υγεία.

Η καρδιαγγειακή εκτίμηση περιλαμβάνει αρτηριακή πίεση, σφύξεις και κίνδυνο παράτασης QT. Η χρήση ΗΚΓ καθοδηγείται από την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SmPC), το κλινικό πλαίσιο, τυχόν συγχωρηγούμενα φάρμακα

που παρατείνουν το QT και τον ατομικό καρδιακό κίνδυνο. **QTc >500 ms** είναι μείζον εύρημα υψηλού κινδύνου και πρέπει να οδηγεί σε επείγουσα επανεκτίμηση των φαρμάκων που παρατείνουν το QT, των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και του καρδιακού κινδύνου, αντί για απλή συνέχιση χωρίς επανεξέταση.

Η κλοζαπίνη απαιτεί επιπλέον επαγρύπνηση. Η **μυοκαρδίτιδα αποτελεί σημαντικό πρώιμο κίνδυνο της θεραπείας**, επομένως ανεξήγητη ταχυκαρδία ή άλλη ανησυχητική κλινική μεταβολή πρέπει να οδηγεί σε άμεση εκτίμηση. Εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιούν δομημένα πρωτόκολλα παρακολούθησης τροπονίνης και CRP, αλλά τα ακριβή χρονοδιαγράμματα δεν πρέπει να παρουσιάζονται σαν να είναι καθολικά νομοθετημένα ή υποχρεωτικά σε κάθε υπηρεσία.

Η πρακτική απάντηση είναι επομένως: καταγράφω τον αρχικό καρδιομεταβολικό και ενδοκρινικό κίνδυνο, εφαρμόζω το σύγχρονο χρονοδιάγραμμα επανελέγχου, ρωτώ ενεργά για ανεπιθύμητες ενέργειες, χρησιμοποιώ ΗΚΓ ανάλογα με τον κίνδυνο και όχι μηχανικά και διατηρώ ειδική πρώιμη επαγρύπνηση για μυοκαρδίτιδα από κλοζαπίνη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Αρχικά: **βάρος, περίμετρος μέσης, ΑΠ/σφύξεις, γλυκόζη ή HbA1c, λιπίδια και προλακτίνη.**
- **Βάρος:** εβδομαδιαίως για 6 εβδομάδες, μετά στις 12 εβδομάδες, στο 1 έτος και στη συνέχεια ετησίως.
- **Περίμετρος μέσης:** ετησίως μετά την αρχική μέτρηση.
- **Σφύξεις/ΑΠ, γλυκόζη/HbA1c και λιπίδια:** στις 12 εβδομάδες, στο 1 έτος και στη συνέχεια ετησίως μετά την αρχική μέτρηση.
- Το αρχικό ΗΚΓ εξαρτάται από τον κίνδυνο, το κλινικό πλαίσιο και την ΠΧΠ/SmPC και δεν είναι καθολικά υποχρεωτικό για κάθε εξωτερικό ασθενή.
- **QTc >500 ms** είναι μείζον όριο υψηλού κινδύνου που απαιτεί επείγουσα επανεκτίμηση.
- Η μυοκαρδίτιδα από κλοζαπίνη είναι σοβαρός πρώιμος κίνδυνος: τα πρωτόκολλα τροπονίνης/CRP είναι **εξειδικευμένα πρωτόκολλα** και όχι καθολικοί νομικοί κανόνες.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Παρακολούθηση μόνο του βάρους και παράλειψη γλυκόζης/HbA1c, λιπιδίων ή αρτηριακής πίεσης.
- Αντιμετώπιση του αρχικού ΗΚΓ ως υποχρεωτικού σε κάθε εξωτερικό ασθενή ανεξάρτητα από φάρμακο, κίνδυνο ή πλαίσιο.
- Παράβλεψη σεξουαλικών ή ενδοκρινικών συμπτωμάτων παρά την αύξηση της προλακτίνης.
- Αντιμετώπιση QTc >500 ms ως ήσσονος τυχαίου ευρήματος.
- Παρουσίαση ενός συγκεκριμένου προγράμματος εξετάσεων για μυοκαρδίτιδα από κλοζαπίνη ως καθολικά υποχρεωτικού.

Πώς επιλέγετε ένα αντικαταθλιπτικό;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επιβεβαίωση διάγνωσης και βαρύτητας
- 2 Προηγούμενη ανταπόκριση και ανεκτικότητα
- 3 Συννοσηρότητα και σωματική νόσος
- 4 Ύπνος, όρεξη και πόνος
- 5 Σεξουαλικές ανεπιθύμητες ενέργειες, καρδιακός κίνδυνος και ασφάλεια σε υπερδοσολογία
- 6 Αλληλεπιδράσεις και αναπαραγωγικό πλαίσιο
- 7 Προτίμηση του ασθενούς

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιλογή αντικαταθλιπτικού πρέπει να είναι εξατομικευμένη με βάση την καταθλιπτική νόσο, το προηγούμενο θεραπευτικό ιστορικό, τη συννοσηρότητα, την ευαλωτότητα σε ανεπιθύμητες ενέργειες, το φορτίο αλληλεπιδράσεων και τις προτιμήσεις του ασθενούς. Τα SSRIs αποτελούν σημαντική κατηγορία πρώτης γραμμής επειδή συνδυάζουν αποτελεσματικότητα με γενικά ευνοϊκή ανεκτικότητα και ασφάλεια σε υπερδοσολογία, αλλά τα SNRIs και η μιρταζαπίνη είναι επίσης καθιερωμένες επιλογές σε κατάλληλους ασθενείς. Τα TCAs και οι MAOIs διατηρούν σημαντικό ρόλο, αλλά χρησιμοποιούνται πιο επιλεκτικά.

Πρώτα επιβεβαιώνω ότι αντιμετωπίζω καταθλιπτική διαταραχή και εκτιμώ τη βαρύτητα, τους σχετικούς κινδύνους και τη συννοσηρότητα. Η προηγούμενη ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα πληροφοριακή: εάν ο ασθενής είχε σαφή και καλά ανεκτή ανταπόκριση σε συγκεκριμένο αντικαταθλιπτικό, αυτό μπορεί να είναι πιο χρήσιμο από μια αφηρημένη ιεραρχία κατηγοριών.

Στη συνέχεια, το προφίλ των συμπτωμάτων μπορεί να κατευθύνει περαιτέρω την επιλογή. Η διαταραχή ύπνου, οι μεταβολές της όρεξης και ο πόνος μπορούν να κάνουν κλινικά σημαντικές τις διαφορετικές ιδιότητες των αντικαταθλιπτικών. Παράλληλα, ρωτώ ενεργά ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες θα ήταν ιδιαίτερα προβληματικές για τον συγκεκριμένο ασθενή, όπως σεξουαλική δυσλειτουργία, καταστολή, καρδιαγγειακές επιδράσεις και ζητήματα σχετιζόμενα με το βάρος.

Η σωματική νόσος και ο κίνδυνος υπερδοσολογίας έχουν επίσης σημασία. Τα SSRIs είναι γενικά ελκυστικά όταν η ασφάλεια σε υπερδοσολογία αποτελεί σημαντική παράμετρο. Τα TCAs περιορίζονται από την αντιχολινεργική, καρδιακή και τοξική τους επιβάρυνση σε υπερδοσολογία, επομένως είναι λιγότερο κατάλληλα όταν αυτοί οι κίνδυνοι είναι κλινικά σημαντικοί. Οι MAOIs παραμένουν εξειδικευμένες επιλογές και όχι συνήθους θεραπείας πρώτης γραμμής, λόγω των αλληλεπιδράσεων και της πολυπλοκότητας στις αλλαγές θεραπείας.

Οι μηχανισμοί βοηθούν να εξηγηθούν οι κλινικές διαφορές χωρίς να μετατρέπεται η απάντηση σε κατάλογο υποδοχέων. Τα SSRIs αναστέλλουν τον SERT. Τα SNRIs αναστέλλουν SERT και NET, με τη σχετική νοραδρενεργική συμβολή να ποικίλλει ανάλογα με το φάρμακο και τη δόση και όχι να εμφανίζεται απότομα σε ένα καθολικό όριο. Η μιρταζαπίνη συνδυάζει προσυναπτικό ανταγωνισμό α2 με

ανταγωνισμό 5-HT₂/5-HT₃ και H₁, γεγονός που βοηθά να εξηγηθεί το κατασταλτικό και ορεξιογόνο προφίλ της. Η **τραζοδόνη** συνδυάζει **ανταγωνισμό 5-HT_{2A} με αναστολή επαναπρόσληψης σεροτονίνης**, ενώ δράσεις στους H₁ και α₁ συμβάλλουν κλινικά στις συνήθεις δόσεις.

Οι αλληλεπιδράσεις πρέπει να εξετάζονται πριν από τη συνταγογράφηση και όχι μετά την εμφάνιση ανεπιθύμητου συμβάντος. Ελέγχω όλα τα συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, το κάπνισμα όπου σχετίζεται και πιθανές φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις. Η εγκυμοσύνη ή άλλες αναπαραγωγικές παράμετροι μπορεί επίσης να μεταβάλουν ουσιαστικά την ισορροπία οφέλους-κινδύνου και πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα με το συγκεκριμένο φάρμακο και όχι με έναν γενικό κανόνα.

Έχει σημασία και το πλαίσιο της έγκρισης. Η **βουπροπιόνη αποτελεί συνήθη αντικαταθλιπτική επιλογή σε ορισμένες δικαιοδοσίες, αλλά όχι ομοιόμορφα σε όλη την Ευρώπη**, επομένως δεν πρέπει να εντάσσεται αυτομάτως σε μια ευρωπαϊκή θεραπευτική ιεραρχία. Ομοίως, κανένα μηχανιστικό δεδομένο δεν υποκαθιστά την πραγματική εγκεκριμένη ένδειξη και το προφίλ ασφάλειας του προϊόντος.

Η τελική επιλογή πρέπει να ενσωματώνει τις προτιμήσεις και την προηγούμενη υποκειμενική εμπειρία του ασθενούς. Ένα θεωρητικά κατάλληλο φάρμακο που ο ασθενής δεν αποδέχεται λόγω φόβου ή προηγούμενης ανεπιθύμητης ενέργειας δύσκολα θα αποτελέσει βιώσιμη θεραπεία.

Η συνοπτική δομή για την προφορική εξέταση είναι επομένως: διάγνωση και βαρύτητα, προηγούμενη ανταπόκριση, ψυχιατρική και σωματική συννοσηρότητα, προφίλ συμπτωμάτων, ευαλωτότητα σε ανεπιθύμητες ενέργειες και υπερδοσολογία, αλληλεπιδράσεις και αναπαραγωγικό πλαίσιο, και τέλος **από κοινού επιλογή**. Αυτό είναι κλινικά χρησιμότερο από την υπόθεση ότι υπάρχει ένα αντικαταθλιπτικό που είναι καθολικά «καλύτερο».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **SSRIs:** αναστολή του μεταφορέα σεροτονίνης (SERT).
- **SNRIs:** αναστολή SERT + NET· η νораδρενεργική συμβολή διαφέρει ανά φάρμακο και δόση, χωρίς ένα καθολικό απότομο όριο.
- **Μιρταζαπίνη:** προσυναπτικός ανταγωνισμός α₂ + ανταγωνισμός 5-HT₂/5-HT₃ και H₁.
- **Τραζοδόνη:** ανταγωνισμός 5-HT_{2A} + αναστολή επαναπρόσληψης σεροτονίνης, με κλινική συμβολή H₁/α₁.
- Η βουπροπιόνη δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως συνήθης ευρωπαϊκή αντικαταθλιπτική επιλογή χωρίς **πλαίσιο δικαιοδοσίας/έγκρισης**.
- Η επιλογή αντικαταθλιπτικού εξακολουθεί να καθορίζεται από προηγούμενη ανταπόκριση, συννοσηρότητα, ύπνο/όρεξη/πόνον, σεξουαλικές επιδράσεις, καρδιακό και υπερδοσολογικό κίνδυνο, αλληλεπιδράσεις και προτίμηση του ασθενούς.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Επιλογή αντικαταθλιπτικού από άκαμπτη ιεραρχία χωρίς συνεκτίμηση του συγκεκριμένου ασθενούς.
- Παράλειψη του κινδύνου υπερδοσολογίας, του καρδιακού κινδύνου ή των αλληλεπιδράσεων.
- Διδασκαλία ενός απότομου ορίου δόσης της βενλαφαξίνης στο οποίο «εμφανίζεται» ξαφνικά η δράση στον NET.
- Παρουσίαση ενός μηχανιστικού χάρτη σαν να καθορίζει την ιεράρχηση αποτελεσματικότητας.
- Αυτόματη εισαγωγή της βουπροπιόνης σε ευρωπαϊκό αλγόριθμο συνταγογράφησης.
- Παρουσίαση της συνήθους εμπορικής φαρμακογονιδιωματικής εξέτασης ως προϋπόθεσης για αντικαταθλιπτική θεραπεία.

Ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις των αντικαταθλιπτικών έχουν σημασία και πώς τα αλλάζετε ή τα διακόπτετε με ασφάλεια;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Σεροτονινεργική τοξικότητα
- 2 Υπονατριαιμία και σεξουαλική δυσλειτουργία
- 3 Αιμορραγικός κίνδυνος, αρτηριακή πίεση και QT
- 4 Πιθανότητα συμπτωμάτων διακοπής
- 5 Εξατομικευμένη σταδιακή μείωση
- 6 Άμεση αλλαγή, cross-taper ή περίοδος έκπλυσης
- 7 Περίοδοι έκπλυσης για ΜΑΟΙs

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ασφάλεια των αντικαταθλιπτικών απαιτεί προσοχή τόσο στις ανεπιθύμητες ενέργειες όσο και στις μεταβάσεις από το ένα φάρμακο στο άλλο. Σκέφτομαι τη σεροτονινεργική τοξικότητα, την υπονατριαιμία, τη σεξουαλική δυσλειτουργία, τον αιμορραγικό κίνδυνο και, όπου σχετίζονται, τις επιδράσεις στην αρτηριακή πίεση ή στο QT. Στη συνέχεια σχεδιάζω τη διακοπή και την αλλαγή με βάση το συγκεκριμένο ζεύγος φαρμάκων, όχι με έναν καθολικό κανόνα σταδιακής μείωσης ή cross-taper. Οι αλλαγές που αφορούν ΜΑΟΙs χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Οι σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες ποικίλλουν ανά κατηγορία και ανάλογα με την ευαλωτότητα του ασθενούς. Το σύνδρομο σεροτονίνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν σεροτονινεργικά φάρμακα συνδυάζονται ή αλλάζονται με μη ασφαλή τρόπο. Τα SSRIs και SNRIs μπορούν επίσης να συμβάλουν σε υπονατριαιμία, σεξουαλική δυσλειτουργία και αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, ιδιαίτερα όταν συγχωρηγούνται άλλα φάρμακα που αυξάνουν τον αιμορραγικό κίνδυνο. Η παρακολούθηση του νατρίου πρέπει να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερη ηλικία, χαμηλό σωματικό βάρος, χρήση διουρητικών ή άλλους παράγοντες ευαλωτότητας, και όχι να επιβάλλεται καθολικά σε κάθε ασθενή.

Τα συμπτώματα διακοπής δεν πρέπει να υποτιμώνται ως αμελητέα ή υποχρεωτικά βραχύβια. Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να είναι παρατεταμένα. Η παροξετίνη και η βενλαφαξίνη έχουν σχετικά υψηλή πιθανότητα συμπτωμάτων διακοπής, ενώ η φλουοξετίνη έχει χαμηλότερη λόγω του μεγάλου χρόνου ημιζωής της. Η σταδιακή μείωση πρέπει επομένως να εξατομικεύεται με βάση το φάρμακο, τη δόση, τη διάρκεια λήψης, προηγούμενες εμπειρίες διακοπής και τα συμπτώματα που εμφανίζονται, και όχι να επιβάλλεται ένα σταθερό πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων σε όλους.

Όταν αλλάζω αντικαταθλιπτικό, η σωστή μέθοδος εξαρτάται από τα δύο συγκεκριμένα φάρμακα. Ορισμένες αλλαγές μπορούν να γίνουν με άμεση μετάβαση, άλλες χρειάζονται cross-taper και άλλες περίοδο έκπλυσης. Η αρχή είναι

να αποφεύγονται τόσο τα περιττά θεραπευτικά κενά όσο και η μη ασφαλής αλληλεπικάλυψη. Οι MAOIs δεν πρέπει να συνδυάζονται τυφλά σε cross-taper με σεροτονινεργικά αντικαταθλιπτικά, λόγω του κινδύνου σοβαρής αλληλεπίδρασης.

Δύο ακριβή διαστήματα έκπλυσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην προφορική εξέταση. Μετά τη διακοπή της φλουοξετίνης πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5 εβδομάδες πριν από την έναρξη μη αναστρέψιμου μη εκλεκτικού MAOI. Στην αντίστροφη κατεύθυνση, μετά τη διακοπή μη αναστρέψιμου MAOI πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη φλουοξετίνης, σύμφωνα με την ισχύουσα **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SmPC)** της φλουοξετίνης. Άλλα διαστήματα αντικαταθλιπτικών/MAOI εξαρτώνται από το συγκεκριμένο προϊόν.

Η πρακτική προσέγγιση είναι επομένως να αναγνωρίζω τους κινδύνους ανεπιθύμητων ενεργειών του τρέχοντος και του νέου φαρμάκου, να εκτιμώ τις αλληλεπιδράσεις, να επιλέγω τη σωστή μέθοδο αλλαγής και να μειώνω σταδιακά με ρυθμό που είναι ανεκτός από τον ασθενή. Εάν εμφανιστούν κλινικά σημαντικά συμπτώματα διακοπής, επανεκτιμώ το πλάνο αντί να θεωρώ ότι όλα τα συμπτώματα αποτελούν υποτροπή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Φλουοξετίνη → μη αναστρέψιμος μη εκλεκτικός MAOI: αναμονή τουλάχιστον 5 εβδομάδων μετά τη διακοπή της φλουοξετίνης.
- Μη αναστρέψιμος MAOI → φλουοξετίνη: αναμονή τουλάχιστον 2 εβδομάδων μετά τη διακοπή του MAOI.
- Παροξετίνη και βενλαφαξίνη έχουν υψηλότερη πιθανότητα συμπτωμάτων διακοπής· η φλουοξετίνη χαμηλότερη λόγω του μεγάλου χρόνου ημιζωής.
- Η παρακολούθηση νατρίου είναι **ανάλογη με τον κίνδυνο**, όχι καθολικός αρχικός/πρώιμος κανόνας για κάθε ασθενή με SSRI/SNRI.
- Ο αιμορραγικός κίνδυνος των SSRI/SNRI αυξάνεται με ΜΣΑΦ, αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά· η γαστροπροστασία **εξατομικεύεται** και δεν είναι αυτόματη.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διδασκαλία ενός καθολικού taper τεσσάρων εβδομάδων.
- Αυτόματο cross-taper χωρίς εξέταση του συγκεκριμένου ζεύγους φαρμάκων.
- Παράλειψη περιόδου έκπλυσης κατά τη μετάβαση προς ή από μη αναστρέψιμο MAOI.
- Καθολικός έλεγχος νατρίου χωρίς εκτίμηση του σχετικού κινδύνου.
- Υπόθεση ότι κάθε συνδυασμός SSRI με ΜΣΑΦ ή αντιπηκτικό απαιτεί αυτομάτως PPI.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη συνταγογράφηση και την παρακολούθηση του λιθίου;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ενδείξεις
- 2 Επίπεδα ορού και αιμοληψία στις 12 ώρες
- 3 Αρχικός έλεγχος νεφρικής/θυρεοειδικής λειτουργίας και ασβεστίου
- 4 Συνεχιζόμενη παρακολούθηση επιπέδων και λειτουργίας οργάνων
- 5 Νεφρικές, θυρεοειδικές και σχετιζόμενες με το ασβέστιο ανεπιθύμητες ενέργειες
- 6 Χαρακτηριστικά τοξικότητας
- 7 Αλληλεπιδράσεις, αφυδάτωση και οξεία νόσος

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το λίθιο παραμένει σημαντική θεραπεία για την οξεία μανία, τη συντήρηση στη διπολική διαταραχή και την ενίσχυση αντικαταθλιπτικής αγωγής, με δεδομένα που υποστηρίζουν μείωση του κινδύνου αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού. Η ασφαλής συνταγογράφηση εξαρτάται από τη χρήση του σωστού εύρους συντήρησης, τη μέτρηση των επιπέδων στον σωστό χρόνο, την παρακολούθηση νεφρικής και θυρεοειδικής λειτουργίας και ασβεστίου και την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνου τοξικότητας σε αλληλεπιδράσεις ή αφυδάτωση. Κάθε τιμή λιθίου πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με την κλινική κατάσταση και τη νεφρική λειτουργία του ασθενούς.

Κατά την έναρξη λιθίου για συντήρηση στη διπολική διαταραχή, ο συνήθης στόχος κατά NICE είναι **0,6–0,8 mmol/L**. Εύρος **0,8–1,0 mmol/L** μπορεί να εξεταστεί όταν έχει υπάρξει υποτροπή ενώ ο ασθενής λάμβανε λίθιο ή όταν επιμένουν υποουδικά συμπτώματα. Δεν θα επινοούσα εδώ ξεχωριστό εύρος ορού για την οξεία μανία. Τα επίπεδα μετρώνται κατά σύμβαση περίπου 12 ώρες μετά τη δόση, επειδή η ασυνεπής χρονική στιγμή αιμοληψίας καθιστά αναξιόπιστη τη σύγκριση διαδοχικών μετρήσεων.

Πριν από την έναρξη ελέγχω νεφρική λειτουργία και ηλεκτρολύτες, θυρεοειδική λειτουργία, ασβέστιο, βάρος ή BMI και κατάσταση κήσης όπου σχετίζεται. ΗΚΓ ζητείται όταν υπάρχει κλινική ένδειξη και όχι αυτομάτως σε κάθε ασθενή.

Το συνεχιζόμενο σχήμα παρακολούθησης του NICE είναι επίσης χρήσιμο εξεταστικό ορόσημο. Τα επίπεδα λιθίου ελέγχονται κάθε 3 μήνες κατά τον πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια ελέγχονται γενικά κάθε 6 μήνες, αλλά παραμένουν κάθε 3 μήνες σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου. Η νεφρική λειτουργία και οι ηλεκτρολύτες, συμπεριλαμβανομένου του ασβεστίου, μαζί με τη θυρεοειδική λειτουργία ελέγχονται γενικά κάθε 6 μήνες.

Συχνές και σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ο τρόμος, τα γαστρεντερικά συμπτώματα και η αύξηση βάρους. Μακροπρόθεσμα μας απασχολούν υποθυρεοειδισμός, νεφρογενής άποιος διαβήτης, υπερπαραθυρεοειδισμός ή

υπερασβεστιαμία και χρόνια νεφρική επιβάρυνση. Επομένως, η παρακολούθηση δεν περιορίζεται στην τιμή του λιθίου αλλά περιλαμβάνει και επιτήρηση για επιδράσεις στα όργανα.

Η τοξικότητα μπορεί να εκδηλωθεί με επιδείνωση ή αδρό τρόμο, γαστρεντερικά συμπτώματα, αταξία, δυσαρθρία και σύγχυση, και σε σοβαρές περιπτώσεις να εξελιχθεί σε επιληπτικές κρίσεις ή κώμα. Τα ΜΣΑΦ, οι αναστολείς ΜΕΑ ή οι ARBs, τα διουρητικά και η αφυδάτωση μπορούν να αυξήσουν την έκθεση στο λίθιο. Επομένως, διατρέχοντες έμετοι, διάρροια ή μειωμένη πρόσληψη υγρών απαιτούν άμεση προσοχή.

Μια υψηλή συγκέντρωση λιθίου από μόνη της δεν πρέπει να μετατρέπεται σε αυτόματο κανόνα αιμοκάθαρσης. Η απόφαση για εξωσωματική θεραπεία συνδυάζει τη συγκέντρωση ορού, τη νεφρική λειτουργία, την κλινική τοξικότητα και την αναμενόμενη αποβολή. Το πλαίσιο EXTRIP συνιστά εξωσωματική θεραπεία όταν υπάρχει επηρεασμένη νεφρική λειτουργία με λίθιο πάνω από **4,0 mEq/L**, ή όταν υπάρχει μειωμένο επίπεδο συνείδησης, επιληπτική κρίση ή απειλητική για τη ζωή δυσρυθμία ανεξαρτήτως επιπέδου. Προτείνει θεραπεία όταν το λίθιο είναι πάνω από **5,0 mEq/L**, όταν υπάρχει σημαντική σύγχυση ή όταν ο αναμενόμενος χρόνος για να πέσει κάτω από **1,0 mEq/L** είναι περισσότερο από **36 ώρες**. Πρόκειται για εξειδικευμένα τοξικολογικά κριτήρια και όχι για έναν μονοδιάστατο αριθμητικό κανόνα.

Το πρακτικό μήνυμα είναι ότι το λίθιο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό αλλά απαιτεί συστηματική παρακολούθηση: γνωρίζουμε τους στόχους συντήρησης, χρησιμοποιούμε αιμοληψία στις 12 ώρες, παρακολουθούμε νεφρική/θυρεοειδική λειτουργία και ασβέστιο και αντιδρούμε έγκαιρα όταν νόσος, αφυδάτωση ή αλληλεπιδράσεις αυξάνουν τον κίνδυνο συσσώρευσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Στόχος συντήρησης κατά την έναρξη: **0,6–0,8 mmol/L**.
- **0,8–1,0 mmol/L** μπορεί να εξεταστεί σε υποτροπή ή επίμονα υποουδικά συμπτώματα.
- Αιμοληψία περίπου **12 ώρες μετά τη δόση**.
- Επίπεδα: **ανά 3 μήνες τον πρώτο χρόνο**, έπειτα γενικά **ανά 6 μήνες**, ή **ανά 3 μήνες σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου**.
- Νεφρική λειτουργία/ηλεκτρολύτες μαζί με ασβέστιο και θυρεοειδική λειτουργία: **γενικά ανά 6 μήνες**.
- Το EXTRIP χρησιμοποιεί συνδυαστικά κριτήρια: **μην διδάσκετε έναν μόνο αριθμό ως καθολικό όριο αιμοκάθαρσης**.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q81a. Τι κάνετε αν ασθενής που λαμβάνει λίθιο εμφανίσει γαστρεντερίτιδα και αφυδάτωση και έχει επίσης πάρει ΜΣΑΦ;

Πρόκειται για κατάσταση υψηλού κινδύνου για **συσσώρευση λιθίου και τοξικότητα**. Θα **διέκοπτα προσωρινά το λίθιο αμέσως** και θα οργάνωνα επείγουσα εκτίμηση επιπέδου λιθίου, ηλεκτρολυτών και νεφρικής λειτουργίας, ενυδάτωσης και νευρολογικής και γενικής κλινικής κατάστασης.

Ο ασθενής χρειάζεται οξεία ιατρική εκτίμηση ανάλογα με τα συμπτώματα και τη βαρύτητα. Δεν θα περίμενα να φτάσει σε κάποια αυθαίρετη συγκέντρωση λιθίου εάν είναι κλινικά άρρωστος. Το ΜΣΑΦ και η αφυδάτωση αυξάνουν και τα δύο την ανησυχία, επομένως προτεραιότητα είναι να σταματήσει περαιτέρω έκθεση στο λίθιο, να εκτιμηθεί η νεφρική κάθαρση και να διορθωθεί με ασφάλεια το οξύ ιατρικό πρόβλημα.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Επινόηση εύρους λιθίου για οξεία μανία που δεν έχει τεκμηριωθεί εδώ.
- Ερμηνεία επιπέδου λιθίου χωρίς έλεγχο της ώρας αιμοληψίας, της νεφρικής λειτουργίας και των συμπτωμάτων.
- Άμεση αντιστοίχιση της βαρύτητας της τοξικότητας με μία μόνο συγκέντρωση ορού.
- Χρήση μίας συγκέντρωσης ως αυτόματου ορίου αιμοκάθαρσης.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το βαλπροϊκό στην ψυχιατρική;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ένδειξη στη διπολική διαταραχή όπου είναι κατάλληλο
- 2 Αύξηση βάρους και μεταβολικές επιδράσεις
- 3 Τρόμος και αιματολογική τοξικότητα
- 4 Ηπατική, παγκρεατική και υπεραμμονιαμική τοξικότητα
- 5 Αρχικός και συνεχιζόμενος έλεγχος
- 6 Πρόγραμμα Πρόληψης Κύησης
- 7 Σύγχρονες αναπαραγωγικές προφυλάξεις για άνδρες

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το βαλπροϊκό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διπολική διαταραχή σε κατάλληλους ασθενείς, αλλά η συνταγογράφησης του καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους **μεταβολικούς, αιματολογικούς, ηπατικούς, παγκρεατικούς και αναπαραγωγικούς κινδύνους**. Θα το χρησιμοποιούσα αφού εξετάσω εναλλακτικές επιλογές, θα εξασφάλιζα τον απαιτούμενο αρχικό και συνεχιζόμενο έλεγχο και θα εφαρμόζα τους ισχύοντες αναπαραγωγικούς περιορισμούς τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Το πλαίσιο αναπαραγωγικής ασφάλειας πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια και όχι είτε με παρωχημένη χαλαρότητα είτε ως άνευ όρων απαγόρευση σε κάθε άτομο που θα μπορούσε να τεκνοποιήσει.

Σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η **αύξηση βάρους και η ευρύτερη μεταβολική επιβάρυνση**, ο τρόμος και αιματολογικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της θρομβοπενίας. Σοβαρότερες τοξικότητες περιλαμβάνουν **ηπατοτοξικότητα και παγκρεατίτιδα**. Η υπεραμμονιαμική εγκεφαλοπάθεια είναι επίσης σημαντική διάγνωση ασφάλειας και μπορεί να εμφανιστεί **ακόμη και όταν οι τρανσαμινάσες είναι φυσιολογικές**. Επομένως, σε ανεξήγητη εγκεφαλοπάθεια υπό βαλπροϊκό πρέπει να εξετάζεται η υπεραμμονιαμία και όχι να αποκλείεται το πρόβλημα επειδή τα ηπατικά ένζυμα είναι φυσιολογικά.

Ο αρχικός και ο συνεχιζόμενος έλεγχος πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SmPC)** και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Ένα πρακτικό ορόσημο του NICE στη σταθερή θεραπεία είναι **βάρους/BMI, γενική αίματος και έλεγχος ηπατικής λειτουργίας στους 6 μήνες και στη συνέχεια ετησίως** μετά την αρχική φάση, με πρόσθετο έλεγχο όταν το απαιτούν συμπτώματα ή κλινικός κίνδυνος.

Η σημαντικότερη σύγχρονη αλλαγή αφορά την αναπαραγωγική ασφάλεια. Για τη **διπολική διαταραχή, το βαλπροϊκό αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη**. Σε γυναίκες και κορίτσια που μπορούν να μείνουν έγκυες, δεν πρέπει να περιγράφεται ως απόλυτη απαγόρευση σε κάθε πιθανή περίπτωση: η χρήση αντενδείκνυται **εκτός εάν πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις του Προγράμματος Πρόληψης Κύησης** και οι εναλλακτικές θεραπείες είναι ακατάλληλες, αναποτελεσματικές ή μη ανεκτές υπό εξειδικευμένη

παρακολούθηση.

Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές προφυλάξεις αφορούν και τους **άνδρες που λαμβάνουν βαλπροϊκό**. Πρέπει να ενημερώνονται για τον πιθανό νευροαναπτυξιακό κίνδυνο που σχετίζεται με πατρική έκθεση. Οι συστάσεις για αντισύλληψη ισχύουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για **3 μήνες μετά τη διακοπή του βαλπροϊκού**, ενώ στο ίδιο διάστημα πρέπει να αποφεύγεται η δωρεά σπέρματος.

Μηχανιστικά, το βαλπροϊκό έχει πολλαπλές μοριακές δράσεις, μεταξύ των οποίων ενίσχυση της **GABAεργικής σηματοδότησης** και επιδράσεις σε διαύλους ιόντων. Δεν θα παρουσίαζα την αναστολή HDAC ή οποιαδήποτε μία μοριακή δράση ως την καθιερωμένη εξήγηση της αντιμανιακής αποτελεσματικότητας.

Τα αναπαραγωγικά ζητήματα πρέπει να εντάσσονται στην κανονική συνταγογράφηση και όχι να ανακύπτουν μόνο αφού συμβεί εγκυμοσύνη. Ο συνταγογράφος πρέπει να διευκρινίζει εάν η εγκυμοσύνη είναι σχετική με την περίπτωση, να συζητά εναλλακτικές λύσεις και αναπαραγωγικά σχέδια και να τεκμηριώνει ότι ο ασθενής κατανοεί τους ισχύοντες περιορισμούς και τις προφυλάξεις.

Η συνοπτική απάντηση είναι επομένως ότι το βαλπροϊκό είναι αποτελεσματική επιλογή σταθεροποίησης της διάθεσης σε επιλεγμένους ασθενείς με διπολική διαταραχή, αλλά απαιτεί προσοχή σε μεταβολική, αιματολογική, ηπατική, παγκρεατική και υπεραμμονιαμική τοξικότητα, κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο και αυστηρή εφαρμογή του σύγχρονου αναπαραγωγικού πλαισίου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Για τη διπολική διαταραχή, το βαλπροϊκό **αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη**.
- Σε γυναίκες/κορίτσια που μπορούν να μείνουν έγκυες, αντενδείκνυται εκτός εάν πληρούνται οι όροι του **Προγράμματος Πρόληψης Κύησης** και οι εναλλακτικές είναι ακατάλληλες, αναποτελεσματικές ή μη ανεκτές υπό εξειδικευμένη φροντίδα.
- Οι άνδρες χρειάζονται ενημέρωση και αντισυλληπτικές προφυλάξεις κατά τη θεραπεία και για **3 μήνες μετά τη διακοπή**· καμία δωρεά σπέρματος στο ίδιο διάστημα.
- Σταθερή παρακολούθηση κατά NICE: **βάρος/BMI, γενική αίματος και ηπατική λειτουργία στους 6 μήνες και μετά ετησίως**.
- Η υπεραμμονιαμική εγκεφαλοπάθεια μπορεί να εμφανιστεί με φυσιολογικές **τρανσαμινάσες**.
- Το βαλπροϊκό έχει πολλαπλές φαρμακολογικές δράσεις· μην διδάσκετε έναν ερευνητικό μηχανισμό όπως η αναστολή HDAC ως τη μοναδική κλινική εξήγηση της αντιμανιακής δράσης.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Παρουσίαση του βαλπροϊκού ως απόλυτης, άνευ όρων απαγόρευσης σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής δυνατότητας.
- Παράλειψη των σύγχρονων **αναπαραγωγικών προφυλάξεων για άνδρες**.
- Παράλειψη υπεραμμονιαιμίας επειδή οι τρανσαμινάσες είναι φυσιολογικές.
- Παράθεση παλαιών ποσοστών τερατογένεσης αντί για το σύγχρονο πλαίσιο συνταγογράφησης.
- Αναγωγή ενός σύνθετου μηχανισμού σε μία απλοϊκή υποδοχική ή επιγενετική εξήγηση.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη λαμοτριγίνη στη διπολική διαταραχή;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Διπολική κατάθλιψη και θεραπεία συντήρησης
- 2 Όχι θεραπεία οξείας μανίας
- 3 Εξάνθημα, SJS και TEN
- 4 Βραδεία τιτλοποίηση και κανόνες επανέναρξης
- 5 Αλληλεπιδράσεις με βαλπροϊκό και ενζυμικούς επαγωγείς
- 6 Αλληλεπίδραση με ορμονική αντισύλληψη
- 7 Μεταβολές συγκεντρώσεων στην εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η λαμοτριγίνη είναι χρήσιμη κυρίως στη διπολική κατάθλιψη και στη θεραπεία συντήρησης και όχι ως θεραπεία της οξείας μανίας. Η ασφαλής συνταγογράφηση βασίζεται στη βραδεία τιτλοποίηση λόγω του κινδύνου σοβαρού εξανθήματος, στην αναγνώριση της σημαντικής αλληλεπίδρασης με το βαλπροϊκό και στην πρόβλεψη μεταβολών της έκθεσης με ενζυμικούς επαγωγείς, οιστρογονούχα αντισυλληπτικά και εγκυμοσύνη. Δεν θα αυτοσχεδιάζα σχήμα τιτλοποίησης εάν δεν είχε επαληθευτεί το συγκεκριμένο σχήμα.

Το βασικό ζήτημα ασφάλειας είναι το εξάνθημα, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων αλλά σοβαρών συνδρόμων Stevens–Johnson και τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης. Η λαμοτριγίνη πρέπει επομένως να εισάγεται αργά και κάθε ανησυχητικό εξάνθημα απαιτεί επείγουσα κλινική εκτίμηση και όχι καθησυχασμό μόνο από την εμφάνιση ή τον χρόνο έναρξής του.

Η σημαντικότερη φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση είναι με το βαλπροϊκό. Το βαλπροϊκό αναστέλλει τη γλυκουρονιδίωση της λαμοτριγίνης και αυξάνει την έκθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι η λαμοτριγίνη πρέπει να εισάγεται πιο αργά και με χαμηλότερο σχήμα όταν τα δύο φάρμακα συνδυάζονται. Η ακριβής τιτλοποίηση ακολουθεί την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SmPC) και όχι έναν καθολικό ποσοστιαίο κανόνα. Αντίστροφα, οι ενζυμικοί επαγωγείς μπορούν να μειώσουν την έκθεση στη λαμοτριγίνη και να περιορίσουν την αποτελεσματικότητά της.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο κανόνας επανέναρξης. Εάν η λαμοτριγίνη έχει διακοπεί για διάστημα που υπερβαίνει περίπου πέντε χρόνους ημιζωής της λαμοτριγίνης, πρέπει να επανεκκινήσει με το αρχικό σχήμα σταδιακής αύξησης και όχι να επανέλθει στην προηγούμενη πλήρη δόση. Το ημερολογιακό διάστημα δεν είναι σταθερό, επειδή ο χρόνος ημιζωής της λαμοτριγίνης μεταβάλλεται σημαντικά από αλληλεπιδρώντα φάρμακα, όπως το βαλπροϊκό ή οι ενζυμικοί επαγωγείς.

Σημαντική είναι και η αλληλεπίδραση με την ορμονική αντισύλληψη. Τα συνδυασμένα ορμονικά αντισυλληπτικά που περιέχουν οιστρογόνο μπορούν περίπου να διπλασιάσουν την κάθαρση της λαμοτριγίνης. Η έναρξη ή διακοπή

τους μπορεί επομένως να μεταβάλει ουσιαστικά την έκθεση στη λαμοτριγίνη και απαιτεί επανεκτίμηση της αγωγής.

Η εγκυμοσύνη επίσης μεταβάλλει τη φαρμακοκινητική της. Οι συγκεντρώσεις μπορεί να μειωθούν κατά την εγκυμοσύνη και να αυξηθούν γρήγορα μετά τον τοκετό. Όταν η λαμοτριγίνη συνεχίζεται, αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την κλινική παρακολούθηση και, όπου χρειάζεται, την παρακολούθηση συγκεντρώσεων, με τις αποφάσεις για τη δόση να εξατομικεύονται.

Στην τακτική παρακολούθηση αξιολογώ την ανταπόκριση της διάθεσης, τη συμμόρφωση, τυχόν εξάνθημα ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, τα αλληλεπιδρώντα φάρμακα και το αναπαραγωγικό πλαίσιο. Εγκυμοσύνη, έναρξη ή διακοπή οιστρογονούχου αντισύλληψης ή προσθήκη/διακοπή βαλπροϊκού αποτελούν κλινικά σημαντικές μεταβολές που απαιτούν επανεκτίμηση.

Η συνοπτική απάντηση είναι επομένως: η λαμοτριγίνη ανήκει κυρίως στη διπολική κατάθλιψη και στη συντήρηση, όχι στην οξεία μανία· ο κίνδυνος σοβαρού εξανθήματος απαιτεί αργή τιτλοποίηση· το βαλπροϊκό αυξάνει την έκθεσή της, οι ενζυμικοί επαγωγείς τη μειώνουν, τα οιστρογονούχα αντισυλληπτικά μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κάθαρση, και διακοπή μεγαλύτερη από περίπου πέντε χρόνους ημιζωής απαιτεί επανατιτλοποίηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η λαμοτριγίνη είναι σημαντική για **διπολική κατάθλιψη/συντήρηση**, όχι για οξεία μανία.
- Το **βαλπροϊκό αναστέλλει τη γλυκουρονιδίωση της λαμοτριγίνης**· ακολουθείτε την ακριβή τιτλοποίηση της ΠΧΠ/SmPC και όχι έναν απλό ποσοστιαίο κανόνα.
- Μετά από διακοπή που υπερβαίνει περίπου 5 χρόνους ημιζωής της λαμοτριγίνης, επανεκκινήστε το αρχικό σχήμα σταδιακής αύξησης.
- Μην το μετατρέπετε σε σταθερό κανόνα «3–5 ημερών»: τα αλληλεπιδρώντα φάρμακα μεταβάλλουν τον χρόνο ημιζωής.
- Τα συνδυασμένα ορμονικά αντισυλληπτικά με οιστρογόνο μπορούν περίπου να διπλασιάσουν την κάθαρση της λαμοτριγίνης.
- Οι συγκεντρώσεις λαμοτριγίνης μπορεί να μειωθούν στην εγκυμοσύνη και να αυξηθούν γρήγορα μετά τον τοκετό.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Παρουσίαση της λαμοτριγίνης ως θεραπείας οξείας μανίας.
- Παράλειψη της αλληλεπίδρασης με το βαλπροϊκό.
- Επανάναρξη στην προηγούμενη πλήρη δόση μετά από κλινικά σημαντική διακοπή.
- Απομνημόνευση «3–5 ημερών» αντί της αρχής των πέντε χρόνων ημιζωής.
- Επινόηση ακριβούς σχήματος τιτλοποίησης που δεν έχει δοθεί.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές για τη συνταγογράφηση βενζοδιαζεπινών και υπνωτικών;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Θετική αλλοστερική ρύθμιση GABA-A
- 2 Βραχυχρόνιες κλινικές ενδείξεις
- 3 Καταστολή, πτώσεις και γνωστική έκπτωση
- 4 Ανοχή και εξάρτηση
- 5 Αναπνευστικός κίνδυνος με οπιοειδή/αλκοόλ
- 6 Στέρηση, συμπεριλαμβανομένων επιληπτικών κρίσεων και ντελίριου
- 7 Εξατομικευμένη σταδιακή μείωση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι βενζοδιαζεπίνες μπορεί να είναι χρήσιμες για επιλεγμένες βραχυχρόνιες ενδείξεις, αλλά η ασφαλής συνταγογράφησή τους απαιτεί να προβλέπουμε **καταστολή, πτώσεις, γνωστικές επιδράσεις, ανοχή, εξάρτηση, αναπνευστικές αλληλεπιδράσεις και στέρηση**. Δρουν ως θετικοί αλλοστερικοί ρυθμιστές του GABA-A και ο στόχος είναι συνήθως η χαμηλότερη αναγκαία έκθεση για το συντομότερο κλινικά κατάλληλο διάστημα, αντί για αόριστη θεραπεία ρουτίνας. Τα Z-drugs πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντίστοιχες αρχές όσον αφορά την εξάρτηση και την καταστολή.

Οι βενζοδιαζεπίνες συνδέονται σε βενζοδιαζεπινικές θέσεις των **υποδοχέων GABA-A** ως **θετικοί αλλοστερικοί ρυθμιστές**, ενισχύοντας τη δράση του ενδογενούς GABA. Οι άμεσες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν **καταστολή, ψυχοκινητική έκπτωση, πτώσεις και γνωστική έκπτωση**. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε ευπαθείς ασθενείς, σε συγχρόνηση άλλων κατασταλτικών ή όταν η μειωμένη εγρήγορση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί παράδοξη άρση αναστολών.

Με επαναλαμβανόμενη χρήση μπορεί να αναπτυχθούν **ανοχή και σωματική εξάρτηση**. Η εξάρτηση δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής έχει διαταραχή χρήσης ουσιών, αλλά σημαίνει ότι η απότομη διακοπή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η στέρηση μπορεί να περιλαμβάνει έντονο άγχος, αυτόνομα συμπτώματα και αϋπνία και, σε σοβαρές περιπτώσεις, να εξελιχθεί σε **επιληπτικές κρίσεις ή ντελίριο**.

Σημαντική αλληλεπίδραση υπάρχει με **οπιοειδή και αλκοόλ**. Ο συνδυασμός κατασταλτικών του ΚΝΣ μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο αναπνευστικής καταστολής, επομένως η συγχρόνηση φαρμάκων και η χρήση ουσιών πρέπει να ελέγχονται ενεργά και όχι να θεωρείται ότι μια οικεία βενζοδιαζεπίνη παραμένει ασφαλής όταν έχει αλλάξει το συνολικό φαρμακευτικό πλαίσιο.

Η διάρκεια χρειάζεται προσεκτική διατύπωση. Ο γνωστός κανόνας των «2-4 εβδομάδων» είναι χρήσιμος ως εμπειρικός οδηγός βραχυχρόνιας συνταγογράφησης και έκκρισης για πολλές ενδείξεις άγχους ή αϋπνίας· **δεν αποτελεί καθολικό νομοθετικό ανώτατο όριο**. Η μακροχρόνια χρήση απαιτεί

σαφή ένδειξη, τακτική επανεκτίμηση και πλάνο για εξάρτηση και στέρηση και όχι απλή συνέχιση από αδράνεια.

Τα Z-drugs δεν αποτελούν υποκατάστατα χωρίς κίνδυνο εξάρτησης. Δρουν επίσης σε βενζοδιαζεπινικά ευαίσθητες θέσεις των GABA-A υποδοχέων, με προτίμηση για συγκεκριμένους υποτύπους, και μπορούν να προκαλέσουν ανοχή, εξάρτηση, ψυχοκινητική έκπτωση και σύνθετες συμπεριφορές ύπνου. Οι φαρμακολογικές τους διαφορές δεν τα εξαιρούν από τις βασικές αρχές ασφάλειας των υπνωτικών.

Εάν μια βενζοδιαζεπίνη έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά ώστε να είναι πιθανή η σωματική εξάρτηση, η διακοπή πρέπει να είναι **σταδιακή και εξατομικευμένη**. Δεν υπάρχει ένα σχήμα μείωσης κατάλληλο για όλους. Ο ρυθμός εξαρτάται από το φάρμακο, τη δόση, τη διάρκεια έκθεσης, τα συμπτώματα στέρησης, τη συννοσηρότητα και το πόσο καλά ανέχεται ο ασθενής τη μείωση.

Η βασική προφορική απάντηση είναι επομένως: επιλεκτική χρήση βενζοδιαζεπινών, επίγνωση της καταστολής και των πτώσεων, αποφυγή επικίνδυνων συνδυασμών κατασταλτικών του ΚΝΣ, πρόβλεψη ανοχής και εξάρτησης και εξατομικευμένη σταδιακή μείωση όταν διακόπτονται. Τα Z-drugs δεν είναι θεμελιωδώς ακίνδυνη εναλλακτική.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Οι βενζοδιαζεπίνες είναι **θετικοί αλλοστερικοί ρυθμιστές σε βενζοδιαζεπινικές θέσεις του GABA-A**.
- Η στέρηση μπορεί να περιλαμβάνει επιληπτικές κρίσεις και ντελίριο.
- Οι «2–4 εβδομάδες» είναι χρήσιμος συνταγογραφικός εμπειρικός κανόνας και όχι καθολικό νομοθετικό ανώτατο όριο.
- Τα Z-drugs δρουν επίσης σε βενζοδιαζεπινικά ευαίσθητους GABA-A υποδοχείς και εξακολουθούν να ενέχουν κίνδυνο εξάρτησης και έκπτωσης.
- Βενζοδιαζεπίνη + οπιοειδές/αλκοόλ = επικίνδυνη **αθροιστική αναπνευστική καταστολή**.
- Η σταδιακή μείωση πρέπει να είναι **εξατομικευμένη**.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση των 2–4 εβδομάδων ως καθολικού νομικού ανώτατου ορίου.
- Υπόθεση ότι τα Z-drugs δεν προκαλούν ανοχή, εξάρτηση ή έκπτωση.
- Απότομη διακοπή σε ασθενή με σωματική εξάρτηση.
- Παράλειψη συγχορήγησης οπιοειδών ή χρήσης αλκοόλ κατά την εκτίμηση της ασφάλειας μιας βενζοδιαζεπίνης.

Πώς χρησιμοποιείτε φαρμακευτική αγωγή στη ΔΕΠ-Υ ενηλίκων;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Επιβεβαίωση διάγνωσης και ένδειξης
- 2 Αρχική καρδιαγγειακή εκτίμηση
- 3 Μεθυλφαινιδάτη ή λισδεξαμφεταμίνη ως πρώτες επιλογές
- 4 Δοκιμή του άλλου διεγερτικού εάν χρειάζεται
- 5 Ατομοξετίνη όταν και τα δύο είναι ακατάλληλα ή αναποτελεσματικά
- 6 Παρακολούθηση ΑΠ, σφύξεων και βάρους
- 7 Κίνδυνος κατάχρησης και παράνομης διάθεσης σε τρίτους

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όταν ενδείκνυται φαρμακευτική θεραπεία για ΔΕΠ-Υ ενηλίκων, η σύγχρονη αδρή αλληλουχία είναι **λิสδεξαμφεταμίνη ή μεθυλφαινιδάτη ως φαρμακολογικές επιλογές πρώτης γραμμής**, ακολουθούμενες από δοκιμή του άλλου διεγερτικού εάν μια επαρκής δοκιμή είναι αναποτελεσματική ή ακατάλληλη. Η **ατομοξετίνη** αποτελεί την κύρια μη διεγερτική επιλογή μετά από δυσανεξία ή μη ανταπόκριση και στα δύο διεγερτικά. Η θεραπεία πρέπει να ακολουθεί επιβεβαιωμένη αναπτυξιακή διάγνωση ΔΕΠ-Υ και να συνοδεύεται από καρδιαγγειακή εκτίμηση, παρακολούθηση βάρους και εκτίμηση κινδύνου κατάχρησης ή παράνομης διάθεσης σε τρίτους.

Πριν από την έναρξη, ελέγχω το σωματικό και ψυχιατρικό ιστορικό, τα τρέχοντα φάρμακα και τη χρήση ουσιών. Η αρχική εκτίμηση περιλαμβάνει **καρδιαγγειακό ιστορικό, σφύξεις, αρτηριακή πίεση και βάρος**, καθώς και εκτίμηση κινδύνου κατάχρησης ή παράνομης διάθεσης. **Δεν απαιτείται ΗΚΓ σε κάθε ασθενή ως εξέταση ρουτίνας**· ζητείται όταν το ιστορικό, η εξέταση ή άλλοι κλινικοί παράγοντες το καθιστούν ενδεδειγμένο.

Η επιλογή μεταξύ μεθυλφαινιδάτης και λισδεξαμφεταμίνης εξατομικεύεται. Χρήσιμο ορόσημο στην αλληλουχία του NICE είναι να δοθούν **ξεχωριστές επαρκείς δοκιμές των δύο διεγερτικών, συνήθως περίπου 6 εβδομάδων σε επαρκή δόση**, πριν θεωρηθεί ότι και τα δύο είναι αναποτελεσματικά. Εάν και τα δύο είναι αναποτελεσματικά ή δεν γίνονται ανεκτά, η ατομοξετίνη αποτελεί την κύρια μη διεγερτική επιλογή στην τρέχουσα αλληλουχία.

Μηχανιστικά, η μεθυλφαινιδάτη αναστέλλει DAT και NET, ενώ η λισδεξαμφεταμίνη είναι **προφάρμακο που μετατρέπεται σε δεξαμφεταμίνη**, η οποία αυξάνει την απελευθέρωση κατεχολαμινών και την αντίστροφη μεταφορά. Η **ατομοξετίνη αναστέλλει εκλεκτικά τον NET**. Αυτές οι διαφορές βοηθούν να κατανοηθεί η διάκριση διεγερτικών και μη διεγερτικών, αλλά δεν υποκαθιστούν την κλινική επιλογή και παρακολούθηση.

Στην παρακολούθηση πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η αγωγή βελτιώνει **κλινικά ουσιαστική λειτουργικότητα** και όχι μόνο μια βαθμολογία ερωτηματολογίου. Ελέγχω **αρτηριακή πίεση και σφύξεις** πριν και μετά από κάθε αλλαγή δόσης και

κάθε 6 μήνες, μαζί με βάρος και ανεπιθύμητες ενέργειες, και επανεκτιμώ τη συμμόρφωση και το κατά πόσο η φαρμακοτεχνική μορφή ταιριάζει στις καθημερινές ανάγκες του ασθενούς.

Ο κίνδυνος κατάχρησης και **παράνομης διάθεσης του φαρμάκου σε τρίτους** πρέπει να αξιολογείται ρητά, χωρίς να υποτίθεται ότι κάθε ενήλικας που ζητά θεραπεία κάνει κατάχρηση. Σκευάσματα μακράς δράσης ή προφάρμακα μπορεί να είναι χρήσιμα όταν ο κίνδυνος αυτός προκαλεί ανησυχία, αλλά δεν έχουν μηδενικό δυναμικό κατάχρησης.

Η ψυχιατρική συννοσηρότητα έχει επίσης σημασία. Εάν υπάρχει **ενεργός ψύχωση ή μανία**, η αγωγή για τη ΔΕΠ-Υ διακόπτεται και αντιμετωπίζεται το οξύ επεισόδιο· η θεραπεία της ΔΕΠ-Υ επανεκτιμάται μετά την ύφεσή του. Προηγούμενη ψύχωση ή διαταραχή χρήσης ουσιών δεν αποτελεί αυτομάτως μόνιμη αντένδειξη στα διεγερτικά, αλλά απαιτεί εξειδικευμένη εκτίμηση κινδύνου και κατάλληλη παρακολούθηση.

Η συνοπτική προφορική απάντηση είναι επομένως: σωστή επιβεβαίωση της ΔΕΠ-Υ ενηλίκων, καρδιαγγειακή και ουσιολογική εκτίμηση, μεθυλφαινιδάτη ή λισδεξαμφεταμίνη πρώτα, δοκιμή του άλλου διεγερτικού εάν χρειάζεται, ατομοξετίνη όταν και τα δύο είναι ακατάλληλα ή αναποτελεσματικά και παρακολούθηση καρδιαγγειακών παραμέτρων, βάρους, ανταπόκρισης και κινδύνου κατάχρησης/παράνομης διάθεσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Αλληλουχία NICE στους ενήλικες: **λิสδεξαμφεταμίνη ή μεθυλφαινιδάτη πρώτης γραμμής**, δοκιμή του άλλου εάν χρειάζεται, και στη συνέχεια **ατομοξετίνη** μετά από δυσανεξία/μη ανταπόκριση και στα δύο.
- Οι ξεχωριστές επαρκείς δοκιμές διεγερτικών είναι συνήθως περίπου **6 εβδομάδες** η καθεμία στην αλληλουχία του NICE.
- **Μεθυλφαινιδάτη**: αναστολή επαναπρόσληψης DAT/NET.
- **Λισδεξαμφεταμίνη**: προφάρμακο δεξαμφεταμίνης· αυξάνει απελευθέρωση/αντίστροφη μεταφορά κατεχολαμινών.
- **Ατομοξετίνη**: εκλεκτική αναστολή NET.
- **ΑΠ/σφύξεις**: πριν και μετά από κάθε αλλαγή δόσης και στη συνέχεια **κάθε 6 μήνες**.
- Σε οξεία ψύχωση/μανία: διακοπή της αγωγής ΔΕΠ-Υ και **επανεκτίμηση μετά την ύφεση**· προηγούμενη ψύχωση/SUD δεν αποτελεί αυτομάτως μόνιμη αντένδειξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Q85a. Τι κάνετε αν ο ασθενής έχει ιστορικό ψύχωσης ή διαταραχής χρήσης ουσιών;

Ούτε το ιστορικό ψύχωσης ούτε η διαταραχή χρήσης ουσιών αποτελούν αυτομάτως **απόλυτη αντένδειξη για διεγερτικό**. Σημασία έχουν η τρέχουσα κλινική κατάσταση και η διατύπωση κινδύνου.

Εάν υπάρχει ενεργός ψύχωση ή μανία, σταθεροποιώ πρώτα το οξύ επεισόδιο και στη συνέχεια επανεκτιμώ τη θεραπεία της ΔΕΠ-Υ. Σε διαταραχή χρήσης ουσιών αξιολογώ την τρέχουσα χρήση και τον κίνδυνο κατάχρησης ή παράνομης

διάθεσης, προτιμώ μακράς δράσης σκεύασμα ή προφάρμακο όπου είναι κατάλληλο, εξετάζω μη διεγερτική θεραπεία εφόσον ταιριάζει στην περίπτωση και παρακολουθώ στενά. Η ΔΕΠ-Υ και η διαταραχή χρήσης ουσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται καθεμία με βάση τα δικά της δεδομένα και όχι να αποκλείεται θεραπεία μόνο από το ιστορικό.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Έναρξη φαρμακευτικής αγωγής μόνο από θετικό screening ερωτηματολόγιο χωρίς επιβεβαιωμένη διάγνωση ΔΕΠ-Υ.
- Αντιμετώπιση του ΗΚΓ ρουτίνας ως υποχρεωτικού για κάθε ενήλικα.
- Δήλωση αποτυχίας διεγερτικών μετά από μία μόνο κατηγορία διεγερτικού.
- Παρουσίαση των μακράς δράσης σκευασμάτων/προφαρμάκων ως αδύνατον να καταχραστούν.
- Αντιμετώπιση παλαιότερης ψύχωσης ή χρήσης ουσιών ως αυτόματης ισόβιας αντένδειξης στα διεγερτικά.

Πώς προσεγγίζετε την ψυχοφαρμακολογία στην εγκυμοσύνη και στην αναπαραγωγική περίοδο;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Μητρική νόσος και κίνδυνος υποτροπής
- 2 Εμβρυϊκός και νεογνικός κίνδυνος από τα φάρμακα
- 3 Αποφυγή αντανεκλαστικής απότομης διακοπής
- 4 Ελάχιστο αποτελεσματικό θεραπευτικό σχήμα
- 5 Αναπαραγωγικά δεδομένα ανά συγκεκριμένο φάρμακο
- 6 Εξειδικευμένη περιγεννητική συμβολή σε υψηλό κίνδυνο
- 7 Αποφάσεις για τον θηλασμό ανά συγκεκριμένο φάρμακο

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ψυχοφαρμακολογία στην εγκυμοσύνη είναι ζήτημα **στάθμισης οφέλους και κινδύνου και όχι απλή άσκηση αποφυγής φαρμάκων**. Η σοβαρή ψυχιατρική νόσος χωρίς θεραπεία ενέχει επίσης σημαντικούς κινδύνους για τη μητέρα και το έμβρυο, επομένως ένα αποτελεσματικό φάρμακο δεν πρέπει να διακόπτεται αντανεκλαστικά μόνο επειδή προέκυψε εγκυμοσύνη. Συγκρίνω τον κίνδυνο υποτροπής με τους εμβρυϊκούς και νεογνικούς κινδύνους του συγκεκριμένου φαρμάκου, απλοποιώ όπου είναι δυνατόν στο ελάχιστο αποτελεσματικό σχήμα και ζητώ εξειδικευμένη περιγεννητική συμβολή όταν η απόφαση είναι υψηλού κινδύνου.

Πρώτα προσδιορίζω τη βαρύτητα και την υποτροπιάζουσα φύση της ψυχιατρικής διαταραχής, την προηγούμενη ανταπόκριση στη θεραπεία και τις συνέπειες μιας υποτροπής. Η απότομη διακοπή μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει κλινικό κίνδυνο. Στόχος είναι επομένως η **ενημερωμένη από κοινού λήψη αποφάσεων** και όχι η παραδοχή ότι η απουσία φαρμάκου είναι πάντοτε ασφαλέστερη.

Το **βαλπροϊκό** αποτελεί τον σαφέστερο μείζονα περιορισμό στη διπολική θεραπεία: αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη και υπόκειται σε αυστηρό αναπαραγωγικό πλαίσιο και εκτός εγκυμοσύνης. Ιδανικά, αυτό αντιμετωπίζεται πριν από τη σύλληψη και όχι μόνο όταν έχει ήδη εγκατασταθεί η εγκυμοσύνη.

Το **λίθιο** δεν πρέπει να περιγράφεται με τον παλαιό απλουστευτικό κανόνα ότι απαγορεύεται επειδή προκαλεί ανωμαλία Ebstein. Τα σύγχρονα δεδομένα υποστηρίζουν **μικρή αύξηση του κινδύνου καρδιακών δυσπλασιών**, μικρότερη από ό,τι υπονοούσε η ιστορική διδασκαλία. Σε ασθενή με σημαντικό κίνδυνο υποτροπής, επιλεγμένη συνέχιση του λιθίου μπορεί επομένως να εξεταστεί υπό εξειδικευμένη παρακολούθηση αντί να επιβάλλεται αυτόματη απαγόρευση.

Τα **SSRIs** μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν ενδείκνυνται κλινικά. Η ενημέρωση πρέπει να παρουσιάζει αναλογικά τις πιθανές νεογνικές εκδηλώσεις προσαρμογής και τον πιθανό **μικρό απόλυτο κίνδυνο εμμένουσας πνευμονικής υπέρτασης του νεογνού**, μαζί με τους κινδύνους της μη θεραπευόμενης μητρικής νόσου. Η συζήτηση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε κινδυνολογική απαρίθμηση ποσοστών.

Η **λαμοτριγίνη** απαιτεί επίγνωση ότι η κάθαρσή της μπορεί να αλλάξει κατά την

εγκυμοσύνη και πάλι μετά τον τοκετό, επομένως η έκθεση δεν παραμένει κατ' ανάγκη σταθερή όταν η συνταγογραφούμενη δόση είναι ίδια. Και η φαρμακοκινητική του λιθίου μεταβάλλεται στην εγκυμοσύνη. Οι αλλαγές δόσης πρέπει να βασίζονται στην κλινική κατάσταση και, όπου ενδείκνυται, στη θεραπευτική παρακολούθηση και όχι σε ένα αυτόματο σχήμα εγκυμοσύνης ή τοκετού.

Ο θηλασμός είναι επίσης ζήτημα του συγκεκριμένου φαρμάκου. Η σερτραλίνη προτιμάται συχνά όταν χρειάζεται SSRI κατά τον θηλασμό, επειδή η έκθεση του βρέφους είναι χαμηλή. Το λίθιο μπορεί να περάσει σημαντικά στο μητρικό γάλα· εάν εξεταστεί, απαιτεί εξειδικευμένη εκτίμηση οφέλους-κινδύνου και παρακολούθηση του βρέφους και όχι ένα απλό καθολικό όριο σχετικής βρεφικής δόσης. Τα αντιψυχωσικά και οι βενζοδιαζεπίνες χρειάζονται επίσης εκτίμηση ανά συγκεκριμένο προϊόν και βρέφος.

Η γενική αρχή είναι να διατηρείται η ψυχιατρική σταθερότητα της μητέρας ενώ ελαχιστοποιείται ο αποτρεψίμος αναπαραγωγικός κίνδυνος: σχεδιασμός πριν από τη σύλληψη όπου είναι εφικτό, αποφυγή περιττής πολυφαρμακίας, όχι αντανάκλαστική απότομη διακοπή αποτελεσματικής θεραπείας, εξειδικευμένη συμβολή για φάρμακα υψηλού κινδύνου ή σοβαρή νόσο και επανεκτίμηση του πλάνου κατά την εγκυμοσύνη, μετά τον τοκετό και στον θηλασμό.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η συνταγογράφηση στην εγκυμοσύνη είναι **στάθμιση οφέλους-κινδύνου**, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου της μη θεραπευόμενης μητρικής νόσου.
- Το **βαλπροϊκό** αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη για τη διπολική διαταραχή.
- Το λίθιο συνδέεται με **μικρή αύξηση του κινδύνου καρδιακών δυσπλασιών**, όχι με τον παλαιό απλουστευτικό κανόνα «απαγορεύεται λόγω ανωμαλίας Ebstein».
- Η εγκυμοσύνη μπορεί να μεταβάλει τη **φαρμακοκινητική λιθίου και λαμοτριγίνης**: οι αλλαγές δόσης εξατομικεύονται και δεν είναι αυτόματες.
- Η **σερτραλίνη** προτιμάται συχνά μεταξύ των SSRIs στον θηλασμό λόγω χαμηλής έκθεσης του βρέφους.
- Η χρήση λιθίου στον θηλασμό, εάν εξετάζεται, απαιτεί **εξειδικευμένη εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου και παρακολούθηση του βρέφους**: δεν χρησιμοποιείται ένα μόνο όριο RID ως καθολική απαγόρευση.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση της εγκυμοσύνης ως αυτόματης ένδειξης για απότομη διακοπή όλων των ψυχοτρόπων.
- Περιγραφή του λιθίου με την απλουστευτική ιστορική διδασκαλία περί ανωμαλίας Ebstein.
- Παρουσίαση αναπαραγωγικού κινδύνου χωρίς στάθμιση του κινδύνου σοβαρής μη θεραπευόμενης μητρικής νόσου.
- Αυτόματη αύξηση ή μείωση λιθίου/λαμοτριγίνης σύμφωνα με μία φόρμουλα εγκυμοσύνης.
- Χρήση ενός ορίου σχετικής βρεφικής δόσης ως καθολικού κανόνα για τον θηλασμό.
- Μετατροπή της απάντησης σε εξαντλητικό κατάλογο φαρμάκων της εγκυμοσύνης.

Πώς διαφοροδιαγιγνώσκετε και πώς αντιμετωπίζετε το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο και το σεροτονινεργικό σύνδρομο;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αναγνώριση της υπεύθυνης φαρμακευτικής έκθεσης
- 2 NMS: δυσκαμψία και ντοπαμινεργικός μηχανισμός
- 3 Σεροτονινεργικό σύνδρομο: κλόνοι και υπερρεφλεξία
- 4 Υπερθερμία, αστάθεια αυτονόμου και μεταβολή ψυχικής κατάστασης
- 5 CK και ιατρικές επιπλοκές
- 6 Διακοπή των υπεύθυνων φαρμάκων
- 7 Άμεση/εντατική υποστηρικτική φροντίδα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τόσο το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο όσο και το σεροτονινεργικό σύνδρομο είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή φαρμακευτικές αντιδράσεις με **μεταβολή της ψυχικής κατάστασης, αστάθεια του αυτονόμου και υπερθερμία**, αλλά το φαρμακευτικό ιστορικό και η νευρομυϊκή εξέταση συνήθως τα διακρίνουν. Το NMS σχετίζεται με ντοπαμινεργικό αποκλεισμό ή διακοπή ντοπαμινεργικής αγωγής και χαρακτηρίζεται από έντονη γενικευμένη δυσκαμψία. Το σεροτονινεργικό σύνδρομο ακολουθεί σεροτονινεργική υπερδραστηριότητα και διακρίνεται ιδιαίτερα από **κλόνοι και υπερρεφλεξία**. Και στα δύο, η θεραπεία αρχίζει με διακοπή του υπεύθυνου παράγοντα και άμεση υποστηρικτική ιατρική φροντίδα.

Στο NMS, αναζητώ πρόσφατη έκθεση σε φάρμακο που αποκλείει τη ντοπαμίνη ή σχετική διακοπή ντοπαμινεργικής αγωγής, μαζί με υπερθερμία, αστάθεια του αυτονόμου, μεταβολή της ψυχικής κατάστασης και έντονη γενικευμένη δυσκαμψία. Η CK είναι συχνά αυξημένη και βοηθά να εκτιμηθεί η συστηματική μυϊκή βλάβη, αλλά η διάγνωση είναι κλινική και δεν εξαρτάται από μία εργαστηριακή τιμή. Το NMS συχνά εξελίσσεται περίπου σε **1–3 ημέρες**, αλλά ο χρονισμός υποστηρίζει και δεν καθορίζει μόνος του τη διάγνωση.

Το **σεροτονινεργικό σύνδρομο** συνήθως εξελίσσεται πολύ ταχύτερα μετά από σεροτονινεργική έκθεση ή αλλαγή δόσης, συχνά μέσα σε **ώρες**. Τα πιο χρήσιμα διακριτικά σημεία στην κλινική εξέταση είναι η νευρομυϊκή υπερδραστηριότητα — ιδίως ο **κλόνος και η υπερρεφλεξία** — και όχι απλώς ο πυρετός και η σύγχυση. Είναι ιδιαίτερα διακριτικά και κεντρικά στη λογική τύπου Hunter, αλλά δεν θα ισχυριζόμουν ότι ένα μόνο σημείο αποτελεί καθολικά το μοναδικό πιο ευαίσθητο και ειδικό χαρακτηριστικό.

Η αντιμετώπιση και των δύο συνδρόμων αρχίζει με **άμεση διακοπή των υπεύθυνων φαρμάκων**. Ακολουθούν στενή ιατρική παρακολούθηση, υγρά, ψύξη και αντιμετώπιση επιπλοκών, με κλιμάκωση σε ΜΕΘ όταν η εικόνα είναι σοβαρή. Ο πυρήνας της θεραπείας είναι η υποστηρικτική και εντατική φροντίδα· τα ειδικά φάρμακα είναι επικουρικά και όχι υποχρεωτικά «αντίδοτα».

Στο NMS, **βρωμοκρυπτίνη, αμανταδίνη ή δαντρολένιο** μπορεί να εξεταστούν σε επιλεγμένες ή σοβαρές περιπτώσεις και η ECT μπορεί να έχει ρόλο σε σοβαρές/ανθεκτικές εικόνες. Στο σεροτονινεργικό σύνδρομο, η **κυπροεπταδίνη**, ανταγωνιστής 5-HT_{2A}, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάλληλες περιπτώσεις, αν και τα υψηλής ποιότητας δεδομένα αποτελεσματικότητας είναι περιορισμένα.

Η διαφοροδιάγνωση παραμένει κλινική και δυναμική, επειδή και τα δύο σύνδρομα μπορεί να επιδεινωθούν γρήγορα και να μοιάζουν με άλλες ιατρικές επείγουσες καταστάσεις. Η εξεταστική αλληλουχία είναι: αναγνώριση του υπεύθυνου φαρμακολογικού μηχανισμού, εξέταση του νευρομυϊκού προτύπου, διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου, **εντατική υποστηρικτική φροντίδα** και ειδικές επικουρικές θεραπείες μόνο όταν είναι κλινικά κατάλληλες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **NMS:** ντοπαμινεργικός αποκλεισμός/διακοπή ντοπαμινεργικής αγωγής + έντονη δυσκαμψία· συχνά εξελίσσεται σε 1–3 ημέρες.
- **Σεροτονινεργικό σύνδρομο:** συνήθως ταχεία έναρξη μετά από σεροτονινεργική έκθεση/μεταβολή, συχνά μέσα σε ώρες.
- **Κλόνος και υπερρεφλεξία** είναι ιδιαίτερα διακριτικά σημεία σεροτονινεργικής τοξικότητας.
- **Κυπροεπταδίνη:** ανταγωνιστής 5-HT_{2A} που χρησιμοποιείται επικουρικά σε επιλεγμένη σεροτονινεργική τοξικότητα.
- **Βρωμοκρυπτίνη/αμανταδίνη/δαντρολένιο:** επιλεγμένες επιλογές στο NMS και όχι υποχρεωτικά αντίδοτα.
- Η άμεση διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου και η **υποστηρικτική/εντατική φροντίδα** αποτελούν τη βάση της θεραπείας και στα δύο.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Διάγνωση σεροτονινεργικού συνδρόμου μόνο από πυρετό και σύγχυση χωρίς αναζήτηση κλόνου/υπερρεφλεξίας.
- Υπερβολική έμφαση σε άκαμπτα χρονικά όρια ή σε κόρες/γαστρεντερικά ευρήματα αντί για το νευρομυϊκό πρότυπο.
- Παρουσίαση της κυπροεπταδίνης, του δαντρολενίου ή της βρωμοκρυπτίνης ως υποχρεωτικού αντιδότη.
- Εστίαση σε ένα ειδικό φάρμακο με παράλειψη υγρών, ψύξης και εντατικής υποστηρικτικής φροντίδας.

Πώς αναγνωρίζετε και πώς αντιμετωπίζετε την υπερδοσολογία τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Αντιχολινεργική τοξικότητα και τοξικότητα ΚΝΣ
- 2 Αποκλεισμός ταχέων διαύλων νατρίου
- 3 ΗΚΓ και διεύρυνση QRS
- 4 Επιληπτικές κρίσεις, υπόταση και κοιλιακή δυσρυθμία
- 5 Ενδοφλέβιο διττανθρακικό νάτριο
- 6 Αεραγωγός, κυκλοφορία και οξεοβασική ισορροπία
- 7 Αντιμετώπιση σε πλαίσιο εντατικής φροντίδας/τοξικολογίας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η υπερδοσολογία τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών είναι **ιατρικό τοξικολογικό επείγον**, επειδή συνδυάζει αντιχολινεργική και κεντρική νευρική τοξικότητα με δυνητικά θανατηφόρο καρδιαγγειακό αποκλεισμό των διαύλων νατρίου. Θα έκανα ΗΚΓ νωρίς, θα αναζητούσα ειδικά διεύρυνση του QRS, υπόταση, επιληπτικές κρίσεις και κοιλιακές δυσρυθμίες και θα χρησιμοποιούσα **ενδοφλέβιο διττανθρακικό νάτριο** όταν υπάρχει σημαντική καρδιοτοξικότητα. Η αντιμετώπιση ανήκει σε παρακολουθούμενο πλαίσιο εντατικής φροντίδας/τοξικολογίας και όχι σε πρωτόκολλο ψυχιατρικής κλινικής.

Το τοξικό σύνδρομο περιλαμβάνει αντιχολινεργικά χαρακτηριστικά μαζί με καταστολή ή διέγερση του ΚΝΣ και **επιληπτικές κρίσεις**. Ο πιο επικίνδυνος μηχανισμός είναι ο αποκλεισμός των ταχέων καρδιακών διαύλων νατρίου, ο οποίος επιβραδύνει την κοιλιακή αγωγή και μπορεί να προκαλέσει υπόταση και κακοήθεις δυσρυθμίες.

Το **ΗΚΓ** είναι **κεντρικό**, επειδή δίνει άμεση εικόνα της τοξικότητας της αγωγής. **QRS >100 ms** παραμένει χρήσιμο ορόσημο μείζονος τοξικότητας και κινδύνου επιληπτικών κρίσεων. Κλασικά ευρήματα, όπως τελικό κύμα R στην aVR, μπορούν να υποστηρίξουν τη διάγνωση και την εκτίμηση βαρύτητας, αλλά δεν πρέπει να μετατρέπονται σε ξεχωριστά υποχρεωτικά όρια παρέμβασης.

Το **ενδοφλέβιο διττανθρακικό νάτριο** είναι **θεραπεία πρώτης γραμμής** για σημαντική διεύρυνση QRS, κοιλιακή δυσρυθμία ή υπόταση στη δηλητηρίαση από TCA. Ένα συχνό πρωτόκολλο κέντρου δηλητηριάσεων χρησιμοποιεί περίπου **1 mmol/kg IV ως αρχικό bolus**, επαναλαμβανόμενο ανάλογα με την ηλεκτροκαρδιογραφική και αιμοδυναμική ανταπόκριση, με τη θεραπεία να τιτλοποιείται προς στένωση του QRS, κλινική σταθερότητα και ήπια αλκαλαιμία — συχνά περίπου **pH 7,50–7,55**. Οι ακριβείς λεπτομέρειες bolus/έγχυσης εξαρτώνται από το πρωτόκολλο και είναι κατάλληλη η εξειδικευμένη τοξικολογική καθοδήγηση.

Μηχανιστικά, το διττανθρακικό προσφέρει **φόρτιση νατρίου και αλκαλοποίηση του ορού**, οι οποίες μειώνουν την καρδιοτοξικότητα από τον αποκλεισμό των ταχέων διαύλων νατρίου. Αυτό εξηγεί γιατί η θεραπεία στοχεύει στη διαταραχή

της αγωγής και όχι απλώς στο αντιχολινεργικό σύνδρομο.

Η υποστηρικτική θεραπεία εφαρμόζεται παράλληλα. Διασφαλίζονται αεραγωγός και αερισμός όταν χρειάζεται, αντιμετωπίζονται οι επιληπτικές κρίσεις, υποστηρίζεται η κυκλοφορία και παρακολουθείται η οξεοβασική κατάσταση. Επειδή η επιδείνωση μπορεί να είναι ταχεία, η σημαντική δηλητηρίαση απαιτεί στενή παρακολούθηση και έγκαιρη εμπλοκή εντατικής θεραπείας ή τοξικολογίας.

Ορισμένες φαινομενικά εύλογες θεραπείες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Τα **ανταρρυθμικά τάξης Ia και Ic που αποκλείουν διαύλους νατρίου πρέπει να αποφεύγονται**, επειδή μπορεί να επιδεινώσουν την υποκείμενη διαταραχή αγωγής. Η **φυσιοστιγμίνη πρέπει επίσης να αποφεύγεται στην οξεία καρδιοτοξική δηλητηρίαση από TCA**.

Η προφορική απάντηση πρέπει επομένως να μένει εστιασμένη: η υπερδοσολογία TCA προκαλεί αντιχολινεργική/ΚΝΣ τοξικότητα και καρδιοτοξικότητα μέσω διαύλων νατρίου· ΗΚΓ και QRS είναι κεντρικά· σημαντική διαταραχή αγωγής, δυσρυθμία ή υπόταση αντιμετωπίζεται με IV διττανθρακικό νάτριο· και ο ασθενής χρειάζεται εντατική υποστηρικτική και παρακολουθούμενη ιατρική φροντίδα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **QRS >100 ms** είναι χρήσιμο ορόσημο μείζονος τοξικότητας/κινδύνου επιληπτικών κρίσεων.
- **IV διττανθρακικό νάτριο** είναι πρώτης γραμμής για σημαντική διεύρυνση QRS, κοιλιακή δυσρυθμία ή υπόταση.
- Συχνό ορόσημο κέντρων δηλητηριάσεων: περίπου **1 mmol/kg IV bolus**, επαναλαμβανόμενο ανάλογα με την ανταπόκριση· το ακριβές πρωτόκολλο ποικίλλει.
- Συχνός στόχος ήπιας αλκαλαιμίας: περίπου **pH 7,50–7,55**, μαζί με στένωση QRS και αιμοδυναμική σταθερότητα.
- Το διττανθρακικό δρα μέσω **φόρτισης νατρίου + αλκαλοποίησης** για τη μείωση της καρδιοτοξικότητας από ταχείς διαύλους νατρίου.
- Αποφύγετε **ανταρρυθμικά τάξης Ia/Ic που αποκλείουν διαύλους νατρίου και φυσιοστιγμίνη** στην οξεία καρδιοτοξική δηλητηρίαση από TCA.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αναγωγή της αντιμετώπισης σε μία απομνημονευμένη δόση διττανθρακικού αντί για τιτλοποίηση με βάση ΗΚΓ/αιμοδυναμική ανταπόκριση.
- Παράλειψη ΗΚΓ επειδή η προσοχή έχει στραφεί στα αντιχολινεργικά συμπτώματα.
- Αντιμετώπιση των τελικών ευρημάτων στην aVR ως αυτοτελούς υποχρεωτικού ορίου παρέμβασης.
- Χρήση άλλου ανταρρυθμικού που αποκλείει διαύλους νατρίου για την κοιλιακή διαταραχή αγωγής.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την ηλεκτροσπασμοθεραπεία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Σοβαρή κατάθλιψη, ψυχωσική κατάθλιψη και κατατονία
- 2 Χρήση όταν απαιτείται ταχεία ανταπόκριση υψηλής πιθανότητας
- 3 Γενική αναισθησία και μυοχάλαση
- 4 Ετερόπλευρη έναντι αμφοτερόπλευρης στρατηγικής
- 5 Γνωστικές και βραχυχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες
- 6 Ιατρική και αναισθησιολογική εκτίμηση κινδύνου
- 7 ECT συνέχισης ή συντήρησης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ECT είναι **ιδιαίτερα αποτελεσματική βιολογική θεραπεία** για τη σοβαρή κατάθλιψη, ιδίως την ψυχωσική κατάθλιψη, και για την κατατονία, και έχει ιδιαίτερη σημασία όταν χρειάζεται ταχεία ανταπόκριση με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένη σοβαρή ή ανθεκτική μανία. Χορηγείται υπό γενική αναισθησία και μυοχάλαση, με την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων και τη στρατηγική ερεθισμού να επιλέγονται ώστε να εξισορροπείται η αποτελεσματικότητα με τη γνωστική επιβάρυνση.

Η ισχυρότερη κλινική ένδειξη δεν είναι απλώς η «ανθεκτικότητα στη θεραπεία». Η ECT μπορεί να είναι κατάλληλη όταν η νόσος είναι σοβαρή, ψυχωσική ή κατατονική ή όταν η κλινική κατάσταση καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές την ταχύτητα και την πιθανότητα ανταπόκρισης. Η προηγούμενη ανταπόκριση και οι συνέπειες της αναμονής για βραδύτερες θεραπείες έχουν επομένως σημασία στην απόφαση.

Η διαδικασία γίνεται σε ελεγχόμενο ιατρικό περιβάλλον υπό **γενική αναισθησία με μυοχάλαση**. Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Η δεξιά ετερόπλευρη θεραπεία υψηλής δόσης και οι ultrabrief στρατηγικές γενικά μειώνουν τη γνωστική επιβάρυνση, ενώ η αμφοτερόπλευρη ή αμφοτεροκροταφική θεραπεία συχνά προσφέρει ταχύτερη ή υψηλότερη οξεία αποτελεσματικότητα με μεγαλύτερες γνωστικές επιδράσεις. Η τεχνική εξατομικεύεται· καμία στρατηγική δεν είναι καθολικά ανώτερη.

Συχνές βραχυχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η **κεφαλαλγία και η παροδική σύγχυση**. Οι γνωστικές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν κεντρική θέση στην ενημέρωση και περιλαμβάνουν εμπροσθόδρομη και οπισθόδρομη διαταραχή μνήμης, με πιθανές επιδράσεις και στην αυτοβιογραφική μνήμη. Οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να συζητούνται αναλογικά μαζί με τη βαρύτητα της νόσου και τα αναμενόμενα οφέλη.

Η ECT δεν πρέπει να διδάσκεται μέσω μιας απλοϊκής λίστας απόλυτων ιατρικών αντενδείξεων. Οι σωματικές και νευρολογικές παθήσεις συνήθως μεταβάλλουν τον **αναισθησιολογικό και διαδικαστικό κίνδυνο** και απαιτούν κατάλληλη ιατρική εκτίμηση, βελτιστοποίηση και διαχείριση κινδύνου. Ομοίως, ο έλεγχος της

φαρμακευτικής αγωγής εξατομικεύεται: οι βενζοδιαζεπίνες και τα αντιεπιληπτικά μπορούν να αυξήσουν τον ουδό των σπασμών και το λίθιο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξήσει τον κίνδυνο ντελίριου, αλλά κανένα από αυτά δεν αποτελεί καθολικά φάρμακο που «πρέπει να διακόπτεται» χωρίς να εξεταστεί το συγκεκριμένο πλάνο ECT και αναισθησίας.

Σημαντική σύγχρονη διόρθωση είναι ότι η επαρκής ECT δεν ορίζεται από μία ελάχιστη διάρκεια σπασμού, όπως 25–30 δευτερόλεπτα. Η ποιότητα του σπασμού, η μορφολογία στο ΗΕΓ και, κυρίως, η κλινική ανταπόκριση έχουν μεγαλύτερη σημασία από ένα μόνο χρονικό όριο.

Η ανταπόκριση σε έναν οξύ κύκλο δεν εξαλείφει τον κίνδυνο υποτροπής. ECT συνέχισης ή συντήρησης μπορεί να εξεταστεί όταν ο κίνδυνος υποτροπής είναι υψηλός και το ατομικό ιστορικό το υποστηρίζει, ενταγμένη στο ευρύτερο πλάνο συντήρησης.

Η συνοπτική προφορική απάντηση είναι επομένως: η ECT είναι ισχυρή θεραπεία για σοβαρή κατάθλιψη, ψυχωσική κατάθλιψη και κατατονία, ιδιαίτερα όταν η ταχεία ανταπόκριση έχει σημασία· χορηγείται υπό αναισθησία και μυοχάλαση· η τεχνική εξισορροπεί αποτελεσματικότητα και γνωστική επιβάρυνση· οι επιδράσεις στη μνήμη απαιτούν σαφή ενημέρωση· η σωματική νόσος απαιτεί διαχείριση κινδύνου και όχι μια άκαμπτη λίστα αντενδείξεων· και η θεραπεία συνέχισης μπορεί να είναι κατάλληλη σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η ECT είναι ιδιαίτερα σημαντική για **σοβαρή/ψυχωσική κατάθλιψη και κατατονία**, ιδίως όταν απαιτείται ταχεία ανταπόκριση υψηλής πιθανότητας.
- Δεξιά ετερόπλευρη θεραπεία υψηλής δόσης/ultrabrief στρατηγικές γενικά μειώνουν τη γνωστική επιβάρυνση· η αμφοτερόπλευρη/αμφοτεροκροταφική μπορεί να έχει ταχύτερη/υψηλότερη οξεία αποτελεσματικότητα αλλά περισσότερες γνωστικές επιδράσεις.
- **Μην ορίζετε μια επαρκή συνεδρία ECT από ελάχιστη διάρκεια σπασμού 25–30 δευτερολέπτων.**
- Η διακοπή ή μείωση φαρμάκων γύρω από την ECT **εξατομικεύεται**· δεν υπάρχει καθολικός κανόνας διακοπής βενζοδιαζεπινών/αντιεπιληπτικών/λιθίου.
- Η σωματική συννοσηρότητα συνήθως μεταβάλλει τον διαδικαστικό/αναισθησιολογικό κίνδυνο και δεν λειτουργεί ως απλή λίστα απόλυτων αντενδείξεων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι ισχύει για τη συναίνεση, την έλλειψη ικανότητας λήψης απόφασης και την ακούσια θεραπεία στην Ελλάδα;

Ένας ενήλικας που έχει ικανότητα λήψης της συγκεκριμένης απόφασης πρέπει κατά κανόνα να δώσει **προηγούμενη ενημερωμένη συναίνεση** για ECT. Η ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία δεν εξουσιοδοτεί από μόνη της τη διενέργεια ECT και δεν τεκμηριώνει γενική ανικανότητα· η ικανότητα λήψης απόφασης πρέπει να εξετάζεται ειδικά για τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Η ελληνική νομοθεσία περιέχει γενικές διατάξεις για υποκατάσταση συναίνεσης και επείγουσα θεραπεία και ειδική ψυχιατρική διάταξη για θεραπεία παρά τη θέληση του ασθενούς σε σοβαρές περιστάσεις. Ωστόσο, η **ειδική διαδικασία εξουσιοδότησης της ECT όταν ο ασθενής δεν έχει ικανότητα λήψης απόφασης ή εξετάζεται επείγουσα μη συναινετική ECT παραμένει μη επιλυμένη στο επαληθευμένο σύνολο πηγών**. Η ασφαλής τρέχουσα απάντηση είναι επομένως να δηλώνονται οι επαληθευμένες αρχές συναίνεσης και να μην επινοείται εάν απαιτείται δικαστήριο, εισαγγελέας, δικαστικός συμπαραστάτης, ανεξάρτητη δεύτερη γνώμη ή άλλη ειδική εγγύηση. Οι διαδικασίες του βρετανικού Mental Health Act δεν πρέπει να μεταφέρονται στην ελληνική πρακτική.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς συγκρίνεται το rTMS με την ECT;

Το rTMS είναι καθιερωμένη μη επεμβατική θεραπεία για την κατάθλιψη και αποτελεί επιλογή στην ανθεκτική κατάθλιψη. Γενικά χορηγείται χωρίς γενική αναισθησία. Ο κίνδυνος επιληπτικής κρίσης είναι χαμηλός αλλά υπαρκτός.

Δεν πρέπει να περιγράφεται απλώς ως «κατώτερη ECT». Οι δύο θεραπείες διαφέρουν ως προς τη διαδικασία, την επιβάρυνση και τον κλινικό τους ρόλο. Η ECT παραμένει προτιμότερη όταν απαιτείται **ταχεία ανταπόκριση υψηλής πιθανότητας** σε σοβαρή, ψυχωσική ή κατατονική νόσο, ενώ το rTMS προσφέρει μια μη επεμβατική επιλογή για την κατάθλιψη χωρίς γενική αναισθησία.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση της ECT ως έσχατης λύσης μόνο αφού αποτύχει κάθε φάρμακο.
- Απαίτηση διάρκειας σπασμού 25–30 δευτερολέπτων για να θεωρηθεί επαρκής η θεραπεία.
- Χρήση άκαμπτης λίστας απόλυτων αντενδείξεων χωρίς διατύπωση αναισθησιολογικού κινδύνου.
- Αυτόματη διακοπή κάθε βενζοδιαζεπίνης, αντιεπιληπτικού ή λιθίου χωρίς εξατομικευμένο πλάνο ECT.
- Υπόθεση ότι η ακούσια νοσηλεία εξουσιοδοτεί από μόνη της ECT στην Ελλάδα.
- Μεταφορά των βρετανικών διαδικασιών συναίνεσης για ECT στο ελληνικό δίκαιο.

Τι είναι η CBT και πώς χρησιμοποιείται στην ψυχιατρική;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Δομημένη και συνεργατική
- 2 Η διατύπωση συνδέει κατάσταση, εκτίμηση, συναίσθημα και συμπεριφορά
- 3 Κοινοί στόχοι και συνεργατικός εμπειρισμός
- 4 Συμπεριφορικές και γνωσιακές τεχνικές
- 5 Εξάσκηση μεταξύ συνεδριών
- 6 Εφαρμογή ειδική για τη διαταραχή
- 7 Πρόληψη υποτροπής

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η CBT είναι μια δομημένη, συνεργατική, προσανατολισμένη σε στόχους ψυχοθεραπεία που βασίζεται στη διατύπωση του περιστατικού. Συνδέει τις καταστάσεις και τις εκτιμήσεις του ατόμου με τις συναισθηματικές, σωματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις και χρησιμοποιεί αυτή τη διατύπωση για να εντοπίσει διεργασίες που συντηρούν το πρόβλημα και μπορούν να ελεγχθούν και να αλλάξουν. Θεραπευτής και ασθενής εργάζονται με συνεργατικό εμπειρισμό και όχι με τον θεραπευτή απλώς να λέει στον ασθενή τι πρέπει να σκέφτεται.

Μια τυπική διαδικασία CBT αρχίζει με κοινή κατανόηση των τρεχόντων προβλημάτων και των μηχανισμών που τα συντηρούν. Οι θεραπευτικοί στόχοι συμφωνούνται ρητά και οι συνεδρίες οργανώνονται γύρω από αυτούς. Η διατύπωση μπορεί, για παράδειγμα, να δείχνει πώς μια απειλητική ερμηνεία αυξάνει το άγχος, τη σωματική διέγερση και την αποφυγή ή πώς η απόσυρση και η αδράνεια συντηρούν την κατάθλιψη. Η χρησιμότητα της διατύπωσης είναι πρακτική: καθοδηγεί ποιες παρεμβάσεις είναι πιθανότερο να βοηθήσουν τον συγκεκριμένο ασθενή στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Βασικές τεχνικές είναι η συμπεριφορική ενεργοποίηση, η έκθεση, η γνωσιακή αναδόμηση και τα συμπεριφορικά πειράματα. Δεν εφαρμόζονται μηχανικά ούτε είναι μεταξύ τους ισοδύναμες. Η συμπεριφορική ενεργοποίηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η μειωμένη δραστηριότητα και η μειωμένη ενίσχυση συντηρούν τη χαμηλή διάθεση· η έκθεση στοχεύει στον φόβο και την αποφυγή· η γνωσιακή αναδόμηση εξετάζει τα δεδομένα και το νόημα των εκτιμήσεων· και τα συμπεριφορικά πειράματα ελέγχουν προβλέψεις σε πραγματικές συνθήκες. Η επιλογή της τεχνικής ακολουθεί επομένως τη διατύπωση και τη διαταραχή που αντιμετωπίζεται.

Η CBT βασίζεται επίσης στην εξάσκηση μεταξύ των συνεδριών, συχνά αποκαλούμενη εργασία για το σπίτι, επειδή η αλλαγή πρέπει να γενικεύεται πέρα από τη θεραπευτική ώρα. Ο ασθενής μπορεί να παρακολουθεί πρότυπα, να εξασκεί νέες συμπεριφορές, να ελέγχει προβλέψεις ή να εφαρμόζει στρατηγικές αντιμετώπισης μεταξύ συνεδριών. Η πρόοδος επανεκτιμάται συνεργατικά και η διατύπωση αναθεωρείται εάν δεν προκύπτει η αναμενόμενη αλλαγή.

Στην ψυχιατρική, η CBT έχει καθιερωμένες εφαρμογές σε πολλές σημαντικές διαταραχές, μεταξύ άλλων στην **κατάθλιψη**, **στις αγχώδεις διαταραχές**, **στην ΙΨΔ** και **στην ψύχωση**, όταν είναι κλινικά κατάλληλη. Η μορφή της CBT διαφέρει ανάλογα με το πρόβλημα· η θεραπεία πρέπει να παραμένει ειδική για τη διαταραχή και τη διατύπωση και όχι να μετατρέπεται σε γενικό κατάλογο γνωσιακών τεχνικών.

Η τελική φάση πρέπει να εδραιώνει όσα έχουν μαθευτεί και να περιλαμβάνει **πρόληψη υποτροπής**. Αυτό σημαίνει αναγνώριση του ατομικού προτύπου πρώιμων προειδοποιητικών σημείων, διατήρηση των στρατηγικών που βοήθησαν, πρόβλεψη καταστάσεων υψηλού κινδύνου και σχεδιασμό της αντίδρασης εάν επανεμφανιστούν δυσκολίες.

Η σύγχρονη CBT περιλαμβάνει επίσης τεκμηριωμένες επεκτάσεις και τρόπους παροχής. Η **γνωσιακή θεραπεία βασισμένη στην ενσυνειδητότητα (MBCT)** αποτελεί αναγνωρισμένη εξέλιξη, ιδιαίτερα για την πρόληψη υποτροπής σε υποτροπιάζουσα κατάθλιψη ή κατάθλιψη με υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής. Η υποστηριζόμενη ψηφιακή CBT και η καθοδηγούμενη αυτοβοήθεια μπορούν επίσης να είναι αποτελεσματικές σε επιλεγμένες διαταραχές και πλαίσια, αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται αυτομάτως ισοδύναμες με πλήρη CBT από θεραπευτή για κάθε ασθενή. Δεν χρειάζεται να προστίθεται ACT ή άλλο υλικό «τρίτου κύματος» μόνο για να φαίνεται σύγχρονη η απάντηση, εκτός εάν σχετίζεται με την πραγματική ένδειξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η CBT είναι **συνεργατική, βασισμένη στη διατύπωση, δομημένη και προσανατολισμένη σε στόχους**.
- Βασικές μέθοδοι: **συμπεριφορική ενεργοποίηση, έκθεση, γνωσιακή αναδόμηση και συμπεριφορικά πειράματα**.
- Η συμπεριφορική ενεργοποίηση αυξάνει την εμπλοκή σε ενισχυτικές, στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες· η έκθεση μειώνει την αποφυγή και επιτρέπει διορθωτική μάθηση.
- Η **MBCT** είναι αναγνωρισμένη σύγχρονη επέκταση, ιδιαίτερα για πρόληψη υποτροπής σε υποτροπιάζουσα ή υψηλότερου κινδύνου κατάθλιψη.
- Η υποστηριζόμενη ψηφιακή CBT μπορεί να είναι τεκμηριωμένη σε επιλεγμένα πλαίσια, αλλά δεν είναι αυτομάτως ισοδύναμη με πλήρη CBT από θεραπευτή.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Περιγραφή της CBT ως καταλόγου τεχνικών χωρίς διατύπωση ή συνεργασία.
- Περιγραφή της γνωσιακής αναδόμησης ως απλής αντικατάστασης «αρνητικών σκέψεων» με θετικές.
- Αντιμετώπιση της εργασίας μεταξύ συνεδριών ως προαιρετικής διακόσμησης και όχι ως συμπεριφορικής μάθησης εκτός συνεδρίας.
- Προσθήκη ACT ή γενικού υλικού «τρίτου κύματος» μόνο για να ακούγεται η απάντηση σύγχρονη αντί να απαντά στο ερώτημα για την CBT.

Τι είναι η μεταβίβαση και η αντιμεταβίβαση και γιατί έχουν κλινική σημασία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Μεταβίβαση = σχεσιακές προσδοκίες που μεταφέρονται στη θεραπεία
- 2 Αντιμεταβίβαση = αντιδράσεις του κλινικού μέσα στη σχέση
- 3 Και οι δύο εμπλουτίζουν τη διατύπωση
- 4 Καμία δεν αποτελεί αντικειμενική αλήθεια
- 5 Αναστοχασμός πάνω στις ευαλωτότητες του κλινικού
- 6 Εποπτεία και σαφή όρια
- 7 Πρόληψη enactment

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η **μεταβίβαση** αφορά προσδοκίες, συναισθήματα και σχεσιακά πρότυπα που έχουν διαμορφωθεί σε προηγούμενες σχέσεις και επανενεργοποιούνται στη θεραπευτική σχέση. Η **αντιμεταβίβαση** αφορά τις συναισθηματικές και γνωστικές αντιδράσεις του κλινικού μέσα σε αυτή τη σχέση. Και οι δύο μπορούν να προσφέρουν κλινικά χρήσιμες πληροφορίες, αλλά αποτελούν δεδομένα που γεννούν υποθέσεις και όχι αντικειμενική απόδειξη για τον ασθενή.

Η μεταβίβαση μπορεί να φανεί στον τρόπο με τον οποίο ο ασθενής βιώνει τον κλινικό — για παράδειγμα ως απορριπτικό, ελεγκτικό, σωτήρα, εξιδανικευμένο ή αναξιόπιστο — ιδιαίτερα όταν το πρότυπο αυτό μοιάζει με ευρύτερες διαπροσωπικές προσδοκίες. Το ζητούμενο δεν είναι να θεωρήσουμε ότι κάθε αντίδραση αποτελεί επανάληψη παιδικών σχέσεων, αλλά να εξετάσουμε εάν αναπαράγεται ένα επαναλαμβανόμενο σχεσιακό πρότυπο στο παρόν θεραπευτικό πλαίσιο και πώς εντάσσεται στην ευρύτερη διατύπωση.

Η αντιμεταβίβαση περιλαμβάνει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις που εμφανίζονται στον κλινικό. Μπορεί μερικές φορές να αντανakλούν κάτι σημαντικό για το διαπροσωπικό πεδίο — για παράδειγμα, ο κλινικός να νιώθει ασυνήθιστα προστατευτικός, επικρινόμενος, αβοήθητος, θυμωμένος ή αποστασιοποιημένος — αλλά μπορεί επίσης να προέρχονται από το προσωπικό ιστορικό, τις ευαλωτότητες, τις αξίες, την κόπωση ή τις τρέχουσες συνθήκες του ίδιου του κλινικού. Γι' αυτό η αντιμεταβίβαση χρειάζεται αναστοχασμό και δεν πρέπει να θεωρείται άμεση απόδειξη για τον ασθενή.

Σχετική ψυχοδυναμική έννοια είναι η **προβλητική ταύτιση (projective identification)**: ο ασθενής μπορεί να εξωτερικεύει ή να εκδραματίζει μια σχεσιακή ή συναισθηματική κατάσταση με τρόπο που συμβάλλει στην εμφάνιση χαρακτηριστικής διαπροσωπικής αντίδρασης. Κλινικά, αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη υπόθεση στη διατύπωση, αλλά το συναίσθημα του κλινικού **δεν αποδεικνύει αντικειμενικά** ότι ο ασθενής «έβαλε» ένα συναίσθημα μέσα του. Πρέπει να ελέγχεται σε σχέση με το πλαίσιο, τη συμπεριφορά, την ευρύτερη διατύπωση και την εποπτεία.

Οι έννοιες αυτές έχουν κλινική σημασία επειδή οι μη αναγνωρισμένες σχεσιακές

δυναμικές μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση, τα όρια και τις θεραπευτικές αποφάσεις. Ένας κλινικός που νιώθει ότι πρέπει να «σώσει» τον ασθενή μπορεί να κάνει εξαιρέσεις που υπονομεύουν το θεραπευτικό πλαίσιο· ένας κλινικός που νιώθει επανειλημμένα μαινωμένος μπορεί να γίνει απορριπτικός ή τιμωρητικός. Το ζητούμενο είναι να παρατηρείται η αντίδραση, να ελέγχεται σε σχέση με τη διατύπωση και τα πραγματικά κλινικά δεδομένα και να αποφεύγεται η αυτόματη εκδραμάτισή της.

Χρήσιμες δικλίδες είναι τα **σαφή όρια, η αναστοχαστική πρακτική, η τακτική επικοινωνία της ομάδας και η εποπτεία**. Η εποπτεία βοηθά να διαχωριστεί τι μπορεί να προκύπτει από το σχεσιακό πρότυπο του ασθενούς και τι ανήκει περισσότερο στον κλινικό ή στο πλαίσιο της υπηρεσίας. Μια κοινή διατύπωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν διαφορετικά μέλη της ομάδας αναπτύσσουν έντονα αντίθετες αντιδράσεις.

Η πρακτική αξία της μεταβίβασης και της αντιμεταβίβασης δεν είναι ότι αποκαλύπτουν από μόνες τους κάποια κρυμμένη αλήθεια. Είναι επιπλέον σχεσιακά δεδομένα που μπορούν να εμπλουτίσουν τη διατύπωση, να αυξήσουν την επίγνωση των θεραπευτικών δυναμικών και να μειώσουν τον κίνδυνο οι κλινικοί να εκδραματίσουν ασυνείδητα δυσλειτουργικά πρότυπα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι κάνετε αν ένας ασθενής εξιδανικεύει ορισμένα μέλη του προσωπικού και απαξιώνει άλλα και η ομάδα πολώνεται;

Το άμεσο πρόβλημα είναι η **πόλωση της ομάδας**: ορισμένοι επαγγελματίες μπορεί να υιοθετούν ρόλο διάσωσης ή να κάνουν εξαιρέσεις, ενώ άλλοι να γίνονται απορριπτικοί, θυμωμένοι ή τιμωρητικοί. Δεν θα κατηγορούσα τον ασθενή ότι «διχάζει την ομάδα».

Η απάντηση είναι **κοινή διατύπωση, τακτική επικοινωνία, συνεπή όρια και συνεκτικό πλάνο φροντίδας**. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να συγκρίνουν παρατηρήσεις, να αναγνωρίζουν τις δικές τους αντιδράσεις, να συμφωνούν τι δικαιολογείται κλινικά και να αποφεύγουν τόσο αντιδραστικές τιμωρητικές συμπεριφορές όσο και ειδικές εξαιρέσεις που καθοδηγούνται κυρίως από τη σχεσιακή πίεση. Η εποπτεία βοηθά την ομάδα να χρησιμοποιεί τις αντιδράσεις της αναστοχαστικά αντί να τις εκδραματίζει.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς διαφέρουν η υποστηρικτική και η διερευνητική ψυχοθεραπεία;

Η **υποστηρικτική ψυχοθεραπεία** δίνει έμφαση στη σταθεροποίηση, τη συγκράτηση, την αντιμετώπιση δυσκολιών, τον έλεγχο της πραγματικότητας, την επίλυση προβλημάτων και τη διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικότητας, συχνά με πιο ενεργή στάση του θεραπευτή.

Η **διερευνητική ψυχοθεραπεία** δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον αναστοχασμό και την ερμηνεία υποκείμενων προτύπων και συγκρούσεων. Απαιτεί επαρκή σταθερότητα, αναστοχαστική ικανότητα, έλεγχο παρορμήσεων, θεραπευτική

συμμαχία και ικανότητα ανοχής του συναισθήματος και της αμφισημίας.

Δεν είναι άκαμπτα αλληλοαποκλειόμενες σχολές. Υποστηρικτικά και διερευνητικά στοιχεία μπορούν να μεταβάλλονται με τον χρόνο ανάλογα με την κατάσταση, τους στόχους και την ικανότητα του ασθενούς για αναστοχαστική εργασία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση είναι δεδομένα για τη διατύπωση, όχι αντικειμενική αλήθεια.
- Η προβλητική ταύτιση είναι ψυχοδυναμική έννοια διατύπωσης· τα συναισθήματα του προσωπικού παραμένουν υποθέσεις που χρειάζονται αναστοχασμό και εποπτεία.
- Η πόλωση της ομάδας αντιμετωπίζεται με κοινή διατύπωση, επικοινωνία, εποπτεία και συνεπή όρια.
- Η υποστηρικτική εργασία δίνει προτεραιότητα σε σταθεροποίηση/αντιμετώπιση/λειτουργικότητα· η διερευνητική απαιτεί επαρκή σταθερότητα και αναστοχαστική ικανότητα για βαθύτερη ερμηνευτική εργασία.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση της αντιμεταβίβασης ως απόδειξης για τον ασθενή.
- Χρήση της «προβλητικής ταύτισης» για να δικαιολογηθεί μια ανεπεξέργαστη αντίδραση του κλινικού.
- Κατηγορία του ασθενούς για τη διαίρεση της ομάδας αντί για διαχείριση της ομαδικής διεργασίας.
- Επιθετική ερμηνεία όταν ο ασθενής χρειάζεται πρώτα σταθεροποίηση και υποστηρικτική εργασία.

Τι είναι η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία και πότε είναι χρήσιμη;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Δομημένη και χρονικά περιορισμένη
- 2 Σύνδεση των συμπτωμάτων με το τρέχον διαπροσωπικό πλαίσιο
- 3 Πένθος/απώλεια
- 4 Μεταβάσεις ρόλων
- 5 Διαφωνίες ρόλων
- 6 Διαπροσωπικές δυσκολίες
- 7 Η κατάθλιψη είναι η κύρια ένδειξη

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία, **IPT**, είναι μια δομημένη, χρονικά περιορισμένη και εγχειριδιοποιημένη ψυχοθεραπεία που συνδέει τα ψυχιατρικά συμπτώματα με το **τρέχον διαπροσωπικό πλαίσιο** του ασθενούς. Η βασική εξεταστική ένδειξη είναι η κατάθλιψη. Η θεραπεία εστιάζει λιγότερο στην ανακατασκευή ολόκληρης της προσωπικότητας ή του αναπτυξιακού ιστορικού και περισσότερο στον εντοπισμό του διαπροσωπικού πεδίου που συνδέεται στενότερα με το τρέχον επεισόδιο και στην άμεση εργασία πάνω σε αυτό.

Οι τέσσερις κλασικοί τομείς της IPT είναι **πένθος ή απώλεια, μεταβάσεις ρόλων, διαφωνίες ρόλων και διαπροσωπικές δυσκολίες ή ελλείμματα**. Στο πένθος, η θεραπεία εστιάζει στη σχέση με την απώλεια και στην προσαρμογή στη ζωή μετά από αυτήν. Στις μεταβάσεις ρόλων, η εργασία αφορά σημαντικές αλλαγές στους κοινωνικούς ή προσωπικούς ρόλους και τις απαιτήσεις που τις συνοδεύουν. Οι διαφωνίες ρόλων αφορούν σημαντικές σχέσεις στις οποίες υπάρχουν ασύμβατες προσδοκίες ή ανεπίλυτη σύγκρουση. Οι διαπροσωπικές δυσκολίες αφορούν επίμονα προβλήματα στη δημιουργία ή διατήρηση ικανοποιητικών σχέσεων.

Ο θεραπευτής αναπτύσσει αρχικά μια διαπροσωπική διατύπωση που συνδέει τα συμπτώματα με έναν ή περισσότερους από αυτούς τους τρέχοντες διαπροσωπικούς τομείς. Στη συνέχεια η θεραπεία δουλεύει ενεργά πάνω στην επικοινωνία, στις προσδοκίες των ρόλων, στη συναισθηματική έκφραση, στην επίλυση προβλημάτων και στην αξιοποίηση της κοινωνικής υποστήριξης, ανάλογα με την επιλεγμένη εστίαση. Η δομή είναι σκόπιμα εστιασμένη και χρονικά περιορισμένη και όχι ανοικτού τέλους.

Η κλασική εγχειριδιοποιημένη IPT διδάσκεται συχνά ως περίπου **12–16 συνεδρίες οργανωμένες σε αρχική, ενδιάμεση και τελική φάση**. Αυτό αποτελεί χρήσιμη δομή εγχειριδίου και εξετάσεων, όχι καθολικά υποχρεωτική διάρκεια: οι προσαρμογές διαφέρουν ανάλογα με τη διαταραχή, το πλαίσιο και την κλινική ανάγκη.

Σε μια προφορική απάντηση, η **κατάθλιψη πρέπει να παραμένει η κύρια ένδειξη**. Η IPT αποτελεί επίσης αναγνωρισμένη επιλογή στην **περιγεννητική κατάθλιψη**, χρήσιμη σύγχρονη επέκταση της βασικής απάντησης. Δεν πρέπει να περιγράφεται

ως καθολική ψυχοθεραπεία για κάθε ψυχιατρική διαταραχή.

Είναι επίσης σημαντικό να διακρίνεται η κλασική IPT από σχετικές προσαρμογές. Η **διαπροσωπική και κοινωνικών ρυθμών θεραπεία, IPSRT**, είναι προσαρμογή για τη **διπολική διαταραχή** που συνδυάζει διαπροσωπική εργασία με προσοχή στους κοινωνικούς ρυθμούς· δεν είναι ταυτόσημη με την απλή IPT. Ομοίως, παρότι διαπροσωπικές προσεγγίσεις μπορεί να έχουν θέση σε άλλα πεδία, η IPT δεν πρέπει να παρουσιάζεται σαν να υποκαθιστά τις ειδικές ψυχοθεραπείες πρώτης γραμμής στις διαταραχές πρόσληψης τροφής.

Η συνοπτική απάντηση είναι επομένως ότι η IPT είναι εστιασμένη ψυχοθεραπεία για ψυχιατρικά συμπτώματα — κυρίως την κατάθλιψη — οργανωμένη γύρω από την αλληλεπίδραση του τρέχοντος επεισοδίου με τις σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις και τις αλλαγές ρόλων του ασθενούς.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Οι τέσσερις κλασικοί τομείς της IPT είναι **πένθος/απώλεια, μεταβάσεις ρόλων, διαφωνίες ρόλων και διαπροσωπικές δυσκολίες/ελλείμματα**.
- Η **κατάθλιψη** είναι η κύρια εξεταστική ένδειξη.
- Η κλασική IPT διδάσκεται συχνά ως περίπου **12–16 συνεδρίες σε 3 φάσεις**, αλλά αυτό είναι τυπική δομή εγχειριδίου και όχι καθολική διάρκεια θεραπείας.
- Η IPT είναι επίσης αναγνωρισμένη επιλογή στην **περιγεννητική κατάθλιψη**.
- Η **IPSRT** είναι προσαρμογή για τη διπολική διαταραχή και όχι απλώς άλλη ονομασία της IPT.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Μετατροπή των 12–16 συνεδριών του κλασικού εγχειριδίου σε άκαμπτο καθολικό κανόνα.
- Παρουσίαση του ιστορικού «sick role» ως υποχρεωτικής σύγχρονης διατύπωσης.
- Ταύτιση IPT και IPSRT.
- Ισχυρισμός ότι η IPT είναι η προτιμώμενη ψυχοθεραπεία για κάθε διαταραχή που συνοδεύεται από διαπροσωπικό στρες.

Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση και πώς βελτιώνει την ψυχιατρική θεραπεία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Πολύ περισσότερο από την απλή ανακοίνωση μιας διάγνωσης
- 2 Κατανόηση της νόσου και της θεραπείας
- 3 Από κοινού λήψη αποφάσεων
- 4 Συμμόρφωση, θεραπευτική συμφωνία και αυτοδιαχείριση
- 5 Ατομικό πρότυπο πρώιμων σημείων υποτροπής
- 6 Σχεδιασμός για κρίσεις και υποτροπές
- 7 Συμμετοχή οικογένειας/φροντιστών όπου είναι κατάλληλη

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ψυχοεκπαίδευση είναι μια δομημένη θεραπευτική διαδικασία που βελτιώνει την κατανόηση της νόσου, της θεραπείας και της αυτοδιαχείρισης από τον ασθενή, και όχι απλώς η ανακοίνωση μιας διαγνωστικής ετικέτας. Σκοπός της είναι να κάνει τη θεραπεία πιο συνεργατική, να βελτιώνει τη θεραπευτική συμφωνία και τη συμμόρφωση, να ενισχύει την αντιμετώπιση των δυσκολιών και να βοηθά τον ασθενή να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει νωρίτερα τον κίνδυνο υποτροπής.

Μια καλή ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση εξηγεί τη φύση των δυσκολιών του ασθενούς σε γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει, συμπεριλαμβάνοντας την πιθανή πορεία, τις θεραπευτικές επιλογές και τον ρόλο της φαρμακοθεραπείας, της ψυχολογικής θεραπείας και των συμπεριφορικών ή σχετιζόμενων με τον τρόπο ζωής στρατηγικών όπου είναι σχετικές. Η πληροφόρηση πρέπει να υποστηρίζει την από κοινού λήψη θεραπευτικών αποφάσεων και όχι να την αντικαθιστά. Ο ασθενής πρέπει να κατανοεί γιατί προτείνεται μια θεραπεία, τι αναμένεται να κάνει και πώς θα αναγνωριστούν το όφελος ή οι δυσκολίες.

Η ψυχοεκπαίδευση υποστηρίζει επίσης τη **συμμόρφωση και τη θεραπευτική συμφωνία**, αντιμετωπίζοντας πρακτικά εμπόδια, πεποιθήσεις για τη θεραπεία και προηγούμενες εμπειρίες. Στόχος δεν είναι η παθητική υπακοή, αλλά να βοηθηθεί ο ασθενής να πάρει ενημερωμένες αποφάσεις και να αναπτύξει ένα ρεαλιστικό πλάνο που μπορεί να ακολουθήσει.

Ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο είναι η αναγνώριση του **ατομικού προτύπου πρώιμων προειδοποιητικών σημείων της υποτροπής**. Αυτό σημαίνει να εντοπίζονται τα προσωπικά πρώιμα σημεία, οι συνήθεις εκλυτικοί παράγοντες ή οι αλλαγές στον ύπνο, τη συμπεριφορά, τη διάθεση ή τη λειτουργικότητα που είχαν προηγηθεί προηγούμενων επεισοδίων. Ο ασθενής και η ομάδα μπορούν τότε να συμφωνήσουν τι θα ακολουθεί — για παράδειγμα επικοινωνία με τις υπηρεσίες, ενίσχυση της υποστήριξης ή εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης που είχαν βοηθήσει στο παρελθόν — πριν εξελιχθεί πλήρης υποτροπή.

Η ίδια αρχή ισχύει για τον **σχεδιασμό κρίσεων**. Η ψυχοεκπαίδευση πρέπει να αφήνει τον ασθενή με πρακτική κατανόηση του τι θα κάνει αν τα συμπτώματα

επιδεινωθούν, με ποιον θα επικοινωνήσει και πώς θα κινητοποιηθούν οι υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές. Έτσι συμβάλλει στην αυτονομία και την αυτοδιαχείριση και όχι μόνο στην αύξηση των γνώσεων.

Η οικογένεια ή οι φροντιστές μπορούν να συμμετέχουν όταν αυτό είναι κατάλληλο και αποδεκτό, ιδιαίτερα όταν έχουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση της υποτροπής ή στην παροχή υποστήριξης. Η συμμετοχή τους πρέπει να σέβεται την αυτονομία και το απόρρητο του ασθενούς. Στη σχιζοφρένεια και τη διπολική διαταραχή, η **οικογενειακή παρέμβαση είναι τεκμηριωμένη και πρέπει να προσφέρεται όπου είναι σχετική**, αλλά το ότι προσφέρεται δεν σημαίνει ότι η συμμετοχή της οικογένειας είναι υποχρεωτική.

Τα δεδομένα υποστηρίζουν την ψυχοεκπαίδευση και την οικογενειακή εργασία ως χρήσιμα συστατικά πρόληψης υποτροπής σε επιλεγμένους πληθυσμούς, αλλά δεν θα παρέθετα ένα σταθερό ποσοστό μείωσης υποτροπών σαν να ισχύει σε όλες τις διαταραχές, τις παρεμβάσεις και τα πλαίσια υπηρεσιών.

Συνολικά, η ψυχοεκπαίδευση βελτιώνει την ψυχιατρική θεραπεία μετατρέποντας την κλινική πληροφόρηση σε κοινό πλαίσιο για την κατανόηση της νόσου, τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων, τη διαχείριση συμπτωμάτων, την αναγνώριση υποτροπής και την έγκαιρη αντίδραση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η ψυχοεκπαίδευση περιλαμβάνει **κατανόηση της νόσου, από κοινού λήψη αποφάσεων, συμμόρφωση/θεραπευτική συμφωνία, αυτοδιαχείριση, αναγνώριση υποτροπής και σχεδιασμό κρίσεων.**
- Η αναγνώριση του **ατομικού προτύπου πρώιμων σημείων υποτροπής** μετατρέπει τη γενική πληροφορία σε εφαρμόσιμο πλάνο πρόληψης.
- Η **οικογενειακή παρέμβαση** είναι τεκμηριωμένη στη σχιζοφρένεια και στη διπολική διαταραχή και πρέπει να προσφέρεται όπου είναι σχετική.
- Το να προσφέρεται οικογενειακή εργασία **δεν καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή της οικογένειας.**
- Μην παγιώνετε το όφελος ψυχοθεραπείας/οικογενειακής παρέμβασης σε ένα καθολικό ποσοστό μείωσης υποτροπών.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ταύτιση της ψυχοεκπαίδευσης με την παράδοση ενός ενημερωτικού φυλλαδίου.
- Αντιμετώπιση της θεραπευτικής συμφωνίας ως παθητικής συμμόρφωσης.
- Γενικές συμβουλές για υποτροπή χωρίς αναγνώριση των προσωπικών πρώιμων προειδοποιητικών σημείων.
- Υποχρεωτική συμμετοχή της οικογένειας επειδή η οικογενειακή παρέμβαση είναι τεκμηριωμένη.
- Παράθεση ενός σταθερού ποσοστού μείωσης υποτροπών για διαφορετικές ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Ποια μετωποϋποφλοιώδη και μεταιχμιακά κυκλώματα είναι σημαντικότερα για την ψυχιατρική;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 DLPFC/μετωποραβδωτό = εκτελεστική λειτουργία
- 2 Κογχομετωπιαίος/κοιλιοέσω προμετωπιαίος = κρίση και αναστολή
- 3 Πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου/έσω μετωπιαίος = έναρξη και κίνητρο
- 4 Αμυγδαλή = συναισθηματική σημασία και απειλή
- 5 Ιππόκαμπος = επεισοδιακή και πλαίσιακή μνήμη
- 6 Κοιλιακό ραβδωτό = ανταμοιβή και ενίσχυση

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πιο χρήσιμη ψυχιατρική νευροανατομία είναι να σκεφτόμαστε με όρους λειτουργικών κυκλωμάτων και όχι μεμονωμένων εγκεφαλικών περιοχών. Τα μετωποϋποφλοιώδη κυκλώματα οργανώνουν τον εκτελεστικό έλεγχο, τη συμπεριφορά και το κίνητρο, ενώ τα μεταιχμιακά και τα συστήματα ανταμοιβής συμβάλλουν στη συναισθηματική σημασία των ερεθισμάτων, τη μνήμη και την ενίσχυση. Πρόκειται για χρήσιμες συσχετίσεις και όχι για αιτιοκρατικούς χάρτες «μία περιοχή-ένα σύμπτωμα».

Το ραχιοπλάγιο προμετωπιαίο/μετωποραβδωτό κύκλωμα, DLPFC/frontostriatal, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εκτελεστικές λειτουργίες: εργαζόμενη μνήμη, σχεδιασμό, οργάνωση, εναλλαγή νοητικών συνόλων και γνωστική ευελιξία. Η δυσλειτουργία του προκαλεί δυσεκτελεστική εικόνα, με δυσκολία στην οργάνωση της συμπεριφοράς, στη διατήρηση στόχων και στην προσαρμογή στρατηγικών.

Τα κογχομετωπιαία και κοιλιοέσω προμετωπιαία συστήματα σχετίζονται περισσότερο με την κοινωνική κρίση, την αξιολόγηση ανταμοιβής και τιμωρίας και τον έλεγχο των παρορμήσεων. Η δυσλειτουργία τους μπορεί επομένως να προκαλέσει άρση αναστολών, πτωχή κρίση και συμπεριφορά που δεν τροποποιείται επαρκώς από τις συνέπειές της.

Ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου και τα έσω μετωπιαία συστήματα είναι σημαντικά για την έναρξη, το κίνητρο, την κατανομή της προσπάθειας και την επιλογή δράσης. Η δυσλειτουργία τους συνδέεται με απάθεια ή, σε βαρύτερες μορφές, αβουλία και όχι πρωτίστως με διαταραχή της μυϊκής ισχύος.

Από τις μεταιχμιακές δομές, η αμυγδαλή είναι κεντρική για τη συναισθηματική σημασία των ερεθισμάτων, την απειλή, τη μάθηση φόβου και την ευρύτερη συναισθηματική επεξεργασία. Ο ιππόκαμπος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την επεισοδιακή και δηλωτική μνήμη και για την αναπαράσταση του πλαισίου μέσα στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα.

Το κοιλιακό ραβδωτό, συμπεριλαμβανομένου του επικλινούς πυρήνα, έχει σημαντικό ρόλο στην ανταμοιβή, την κινητροδοτική σημασία των ερεθισμάτων και την ενίσχυση. Είναι επομένως σημαντικό σε ψυχιατρικά μοντέλα που αφορούν

το κίνητρο, τη μάθηση μέσω ανταμοιβής και τη δυσπροσαρμοστική ενίσχυση.

Το πρακτικό σημείο στην προφορική εξέταση είναι να συνδέουμε κάθε κύκλωμα με έναν χαρακτηριστικό λειτουργικό τομέα: τα ραχιοπλάγια συστήματα με τον εκτελεστικό έλεγχο, τα κογχομετωπιαία με την αναστολή και την κοινωνική κρίση, τα έσω μετωπιαία/πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου με την έναρξη και το κίνητρο, την αμυγδαλή με τη συναισθηματική σημασία και την απειλή, τον ιππόκαμπο με την επεισοδιακή/πλαισιακή μνήμη και το κοιλιακό ραβδωτό με την ανταμοιβή και την ενίσχυση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **DLPFC/μετωποραβδωτό:** εκτελεστικός έλεγχος, εργαζόμενη μνήμη, σχεδιασμός και γνωστική ευελιξία.
- **Κογχομετωπιαίος/κοιλιοέσω προμετωπιαίος:** αναστολή, κοινωνική κρίση, αξιολόγηση ανταμοιβής/τιμωρίας.
- **Πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου/έσω μετωπιαίος:** έναρξη, προσπάθεια και κίνητρο· δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει απάθεια/αβουλία.
- **Αμυγδαλή:** συναισθηματική σημασία, απειλή και μάθηση φόβου.
- **Ιππόκαμπος:** επεισοδιακή/δηλωτική και πλαισιακή μνήμη.
- **Κοιλιακό ραβδωτό/επικλινής πυρήνας:** ανταμοιβή, κινητροδοτική σημασία και ενίσχυση.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Το κύκλωμα του Papez παραμένει χρήσιμο κλασικό διδακτικό πλαίσιο της μεταιχμιακής νευροανατομίας, αλλά τα σύγχρονα συστήματα συναισθήματος και μνήμης εκτείνονται πολύ πέρα από αυτό. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως πλήρες σύγχρονο μοντέλο ούτε της μνήμης ούτε του συναισθήματος.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση αυτών των συσχετίσεων ως ακριβούς εντόπισης «μία περιοχή—ένα σύμπτωμα».
- Παράβλεψη ότι οι ψυχιατρικές λειτουργίες αναδύονται από αλληλεπιδρώντα κυκλώματα και όχι από απομονωμένες δομές.
- Παρουσίαση του κυκλώματος του Papez ως πλήρους σύγχρονου μοντέλου μνήμης ή συναισθήματος.

Ποιες είναι οι κύριες ντοπαμινεργικές οδοί και ποια είναι η κλινική τους σημασία;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Μεσομεταιχμιακή = ανταμοιβή / κινητροδοτική σημασία
- 2 Μεσοφλοιώδης = γνωστικές λειτουργίες / κίνητρο
- 3 Μελανοραβδωτή = κίνηση
- 4 Φυματοχοανική = ρύθμιση προλακτίνης
- 5 Ο αποκλεισμός D2 συνδέει τις οδούς με ανεπιθύμητες ενέργειες
- 6 Αποφυγή του μοντέλου «περίσσεια ντοπαμίνης παντού»

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι τέσσερις ντοπαμινεργικές οδοί με τη μεγαλύτερη σημασία στην ψυχιατρική είναι η μεσομεταιχμιακή, η μεσοφλοιώδης, η μελανοραβδωτή και η φυματοχοανική οδός. Έχουν σημασία επειδή η ντοπαμινεργική σηματοδότηση συμβάλλει στην ανταμοιβή, την απόδοση σημασίας στα ερεθίσματα, τις γνωστικές λειτουργίες και την κίνηση, ενώ ο αποκλεισμός των ντοπαμινεργικών υποδοχέων εξηγεί αρκετές σημαντικές θεραπευτικές και ανεπιθύμητες επιδράσεις των αντιψυχωσικών. Η σχιζοφρένεια δεν πρέπει να ανάγεται σε «υπερβολική ντοπαμίνη παντού».

Η μεσομεταιχμιακή οδός εμπλέκεται στενά στην ανταμοιβή και στην κινητροδοτική σημασία των ερεθισμάτων. Στην ψύχωση, η αυξημένη προσυναπτική ντοπαμινεργική σηματοδότηση στο ραβδωτό σώμα έχει συσχετιστεί έντονα, ιδιαίτερα με τα θετικά ψυχωσικά συμπτώματα. Το κλινικά χρήσιμο μοντέλο είναι επομένως η δυσρύθμιση της ντοπαμινεργικής σηματοδότησης που σχετίζεται με την απόδοση σημασίας και όχι μια μη ειδική περίσσεια ντοπαμίνης σε ολόκληρο τον εγκέφαλο.

Η μεσοφλοιώδης οδός συμβάλλει στις γνωστικές λειτουργίες και στο κίνητρο. Η κλασική διδασκαλία είναι ότι σχετικά μειωμένη φλοιώδης ντοπαμινεργική λειτουργία μπορεί να συμβάλλει στα αρνητικά και γνωστικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας. Το μοντέλο αυτό παραμένει χρήσιμο ως ευρετικό σχήμα, αλλά τα ευρήματα για τη φλοιώδη ντοπαμίνη είναι πιο σύνθετα και δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως πλήρης μηχανισμός των αρνητικών συμπτωμάτων.

Η μελανοραβδωτή οδός είναι κεντρική για την κινητική λειτουργία. Ο αποκλεισμός των υποδοχέων D2 σε αυτή την οδό αποτελεί τον βασικό φαρμακολογικό σύνδεσμο με εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ο παρκινσονισμός και άλλα κινητικά σύνδρομα.

Η φυματοχοανική οδός ρυθμίζει την έκκριση προλακτίνης. Η ντοπαμίνη φυσιολογικά καταστέλλει την έκκριση προλακτίνης, επομένως ο αποκλεισμός D2 μπορεί να άρει αυτή την ανασταλτική επίδραση και να προκαλέσει υπερπρολακτιναιμία, με κλινικά σημαντικές ενδοκρινικές και σεξουαλικές συνέπειες.

Ένα κλασικό διδακτικό σημείο από μελέτες PET είναι ότι η αντιψυχωσική

ανταπόκριση και οι ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται με την κατάληψη των D2 υποδοχέων στο ραβδωτό: η θεραπευτική ανταπόκριση συχνά παρατηρείται σε μια ενδιάμεση ζώνη κατάληψης, ενώ ο κίνδυνος EPS και υπερπρολακτιναιμίας αυξάνεται σε υψηλότερη κατάληψη. Ωστόσο, τα συνήθως αναφερόμενα αριθμητικά όρια είναι **ευρετικοί κανόνες και όχι στόχοι ρουτίνας της θεραπείας** και διαφέρουν ανάλογα με το φάρμακο, τον ασθενή και τη φαρμακολογία των μερικών αγωνιστών.

Μια σύντομη προφορική διατύπωση είναι επομένως: η μεσομεταιχμιακή ντοπαμίνη σχετίζεται με την ανταμοιβή, την κινητροδοτική σημασία και τη θετική ψυχοπαθολογία· η μεσοφλοιώδης με τις γνωστικές λειτουργίες και το κίνητρο· η μελανοραβδωτή με την κίνηση και τα EPS από αποκλεισμό D2· και η φυματοχοανική με την ανασταλτική ρύθμιση της προλακτίνης, ώστε ο αποκλεισμός D2 να μπορεί να προκαλέσει υπερπρολακτιναιμία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Μεσομεταιχμιακή:** ανταμοιβή/κινητροδοτική σημασία· η δυσρύθμιση της προσυναπτικής ντοπαμίνης στο ραβδωτό έχει ισχυρή συσχέτιση με την ψύχωση.
- **Μεσοφλοιώδης:** γνωστικές λειτουργίες/κίνητρο· η κλασική υπόθεση υποντοπαμινεργικής λειτουργίας είναι ευρετικό σχήμα και όχι πλήρης μηχανισμός.
- **Μελανοραβδωτή:** κίνηση· αποκλεισμός D2 → EPS.
- **Φυματοχοανική:** η ντοπαμίνη αναστέλλει την προλακτίνη· αποκλεισμός D2 → υπερπρολακτιναιμία.
- Οι αριθμοί κατάληψης D2 ανήκουν σε **κλασικούς ευρετικούς κανόνες PET**, όχι σε μετρούμενους στόχους συνταγογράφησης ρουτίνας.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Ισχυρισμός ότι η σχιζοφρένεια προκαλείται απλώς από **υπερβολική ντοπαμίνη παντού**.
- Αντιμετώπιση του κλασικού μοντέλου μεσοφλοιώδους υποντοπαμινεργίας ως πλήρους εξήγησης των αρνητικών και γνωστικών συμπτωμάτων.
- Χρήση ενός ποσοστού κατάληψης D2 ως καθολικού ορίου αποτελεσματικότητας ή EPS για όλα τα φάρμακα, ιδίως τους μερικούς αγωνιστές.

Τι σημαίνουν η κληρονομησιμότητα, ο οικογενειακός κίνδυνος και ο πολυγονιδιακός κίνδυνος στην ψυχιατρική;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Η κληρονομησιμότητα είναι στατιστικό μέγεθος πληθυσμού
- 2 Δεν ισοδυναμεί με ατομική γενετική αιτιότητα
- 3 Οικογενειακή συσσώρευση = γονίδια + κοινές/αναπτυξιακά συσχετισμένες περιβαλλοντικές επιδράσεις
- 4 Οι περισσότερες διαταραχές είναι έντονα πολυγονιδιακές
- 5 Οι σπάνιες παραλλαγές έχουν σημασία σε επιλεγμένες περιπτώσεις
- 6 Η γενετική επικάλυψη υπερβαίνει τα διαγνωστικά όρια
- 7 Τα PRS δεν είναι αυτόνομες εξετάσεις ρουτίνας

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην ψυχιατρική, η κληρονομησιμότητα, ο οικογενειακός κίνδυνος και ο πολυγονιδιακός κίνδυνος περιγράφουν διαφορετικές πλευρές της γενετικής ευαλωτότητας και δεν πρέπει να συγχέονται με το ατομικό πεπρωμένο. Η κληρονομησιμότητα είναι εκτίμηση σε επίπεδο πληθυσμού για το πόση από τη διακύμανση ενός χαρακτηριστικού, μέσα σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, συνδέεται με γενετική διακύμανση. Δεν σημαίνει ότι ένα σταθερό ποσοστό της νόσου ενός συγκεκριμένου ανθρώπου είναι «γενετικό».

Η **οικογενειακή συσσώρευση** σημαίνει ότι μια διαταραχή εμφανίζεται συχνότερα μεταξύ συγγενών από όσο θα αναμενόταν τυχαία. Το πρότυπο αυτό μπορεί να αντανakλά κοινή γενετική ευαλωτότητα, αλλά και κοινές ή αναπτυξιακά συσχετισμένες περιβαλλοντικές επιδράσεις. Επομένως, το οικογενειακό ιστορικό πληροφορεί για τον κίνδυνο, αλλά δεν αποτελεί άμεση ανάγνωση του γονότυπου ούτε καθορίζει την έκβαση.

Οι περισσότερες μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές είναι έντονα πολυγονιδιακές. Αυτό σημαίνει ότι η ευαλωτότητα κατανέμεται σε πολλές κοινές γενετικές παραλλαγές, καθεμία από τις οποίες συνήθως έχει πολύ μικρή επίδραση. Η κλινική συνέπεια είναι ότι σπάνια υπάρχει μία κοινή παραλλαγή που να εξηγεί μια συνηθισμένη ψυχιατρική διαταραχή ενηλίκων σε έναν μεμονωμένο ασθενή.

Υπάρχουν επίσης **σπάνιες παραλλαγές και παραλλαγές αριθμού αντιγράφων, CNVs**, που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επίδραση σε επιλεγμένες κλινικές εικόνες. Επαναλαμβανόμενα CNVs μπορεί, για παράδειγμα, να είναι κλινικά σημαντικά σε ορισμένες νευροαναπτυξιακές ή ψυχωσικές παρουσιάσεις, αλλά εξηγούν μόνο μια μειονότητα της συνήθους ψυχιατρικής νοσηρότητας ενηλίκων και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υπονοηθεί ότι οι περισσότερες ψυχιατρικές διαταραχές έχουν μία αναγνωρίσιμη γενετική αιτία.

Άλλη σημαντική έννοια είναι η **πλειοτροπία και η γενετική επικάλυψη**. Ορισμένες γενετικές ευαλωτότητες μοιράζονται μεταξύ διαφορετικών συμβατικών διαγνώσεων, κάτι που συμφωνεί με την παρατήρηση ότι οι ψυχιατρικές

κατηγορίες δεν αντιστοιχούν σε πλήρως απομονωμένες βιολογικές αρχιτεκτονικές.

Οι **πολυγονιδιακοί δείκτες κινδύνου, PRS**, συνδυάζουν πληροφορίες από πολλές παραλλαγές σε μια στατιστική εκτίμηση γενετικής ευαλωτότητας. Είναι χρήσιμα ερευνητικά εργαλεία και μπορεί στο μέλλον να συμβάλουν σε στρατηγικές διαστρωμάτωσης, αλλά **δεν αποτελούν αυτόνομες διαγνωστικές ή προγνωστικές εξετάσεις ρουτίνας στην καθημερινή ψυχιατρική πράξη**. Ένα υψηλό PRS δεν θέτει διάγνωση και ένα χαμηλό δεν την αποκλείει.

Το συμπέρασμα για την προφορική εξέταση είναι ότι η ψυχιατρική γενετική είναι πιθανολογική: η κληρονομησιμότητα περιγράφει διακύμανση σε έναν πληθυσμό, το οικογενειακό ιστορικό αντανακλά τόσο κληρονομικές όσο και περιβαλλοντικές επιδράσεις, οι περισσότερες κοινές διαταραχές είναι πολυγονιδιακές, ορισμένες σπάνιες παραλλαγές έχουν μεγαλύτερη επίδραση και καμία από αυτές τις έννοιες δεν μεταφράζεται σε ντετερμινιστική πρόβλεψη για τον μεμονωμένο ασθενή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Η **κληρονομησιμότητα είναι στατιστικό μέγεθος πληθυσμού**, όχι το ποσοστό της ασθένειας ενός ατόμου που «προκαλείται από γονίδια».
- Οι **μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές είναι γενικά πολυγονιδιακές**: πολλές κοινές παραλλαγές μικρής επίδρασης συμβάλλουν στην ευαλωτότητα.
- **Σπάνιες παραλλαγές/CNVs** μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επίδραση σε επιλεγμένους ασθενείς, αλλά δεν εξηγούν τις περισσότερες συνήθεις ψυχιατρικές διαταραχές ενηλίκων.
- **Πλειοτροπία** σημαίνει ότι η γενετική ευαλωτότητα μπορεί να υπερβαίνει τα συμβατικά διαγνωστικά όρια.
- Τα **PRS είναι ερευνητικά εργαλεία**, όχι αυτόνομες εξετάσεις ρουτίνας για διάγνωση ή πρόγνωση.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Αντιμετώπιση της υψηλής κληρονομησιμότητας ως ατομικού γενετικού πεπρωμένου.
- Παράθεση σταθερού πίνακα κληρονομησιμότητας ή οικογενειακής υποτροπής σαν να προβλέπει τον κίνδυνο ενός συγκεκριμένου ασθενούς.
- Αντιμετώπιση της οικογενειακής συσσώρευσης ως απόδειξης αμιγώς γενετικής αιτιότητας.
- Παγίωση ενός μεταβαλλόμενου ποσοστού διακύμανσης που εξηγείται από τα τρέχοντα PRS.
- Παρουσίαση ενός PRS ως διαγνωστικού από μόνο του.

Πώς αξιολογείτε κριτικά μια ψυχιατρική μελέτη και αποφασίζετε αν πρέπει να αλλάξει την κλινική πρακτική;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ερευνητικό ερώτημα και σχεδιασμός
- 2 Πληθυσμός και ομάδα σύγκρισης
- 3 Εσωτερική εγκυρότητα
- 4 Μέγεθος επίδρασης και ακρίβεια εκτίμησης
- 5 Κλινική έναντι στατιστικής σημαντικότητας
- 6 Βλάβες και γενικευσιμότητα
- 7 Προοπτική καταχώριση, αναφορά και συνολικό σώμα τεκμηρίωσης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα αξιολογούσα μια ψυχιατρική μελέτη θέτοντας τρία βασικά ερωτήματα: **Μπορεί ο σχεδιασμός της να απαντήσει στο κλινικό ερώτημα; Είναι τα αποτελέσματα εσωτερικά έγκυρα; Και είναι τα ευρήματα αρκετά σημαντικά και εφαρμόσιμα ώστε να δικαιολογούν αλλαγή της πρακτικής;** Η στατιστική σημαντικότητα είναι μόνο ένα μέρος αυτής της κρίσης.

Αρχικά ορίζω το **κλινικό ερώτημα**, συνήθως με όρους PICO: πληθυσμός, παρέμβαση ή έκθεση, συγκριτική παρέμβαση και εκβάσεις. Στη συνέχεια εξετάζω αν ο σχεδιασμός είναι κατάλληλος για το ερώτημα και αν οι συμμετέχοντες και η ομάδα σύγκρισης αντιστοιχούν επαρκώς στην κλινική απόφαση που με ενδιαφέρει.

Έπειτα εξετάζω την **εσωτερική εγκυρότητα**. Σε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή αυτό περιλαμβάνει την ποιότητα της τυχαιοποίησης και της απόκρυψης της κατανομής, την τυφλοποίηση όπου είναι εφικτή, τις απώλειες και τα ελλιπή δεδομένα, καθώς και το αν η ανάλυση διατήρησε την τυχαιοποιημένη σύγκριση, για παράδειγμα με προσέγγιση intention-to-treat. Στις μελέτες παρατήρησης δίνω μεγαλύτερο βάρος στους συγχυτικούς παράγοντες, στο σφάλμα επιλογής και σε άλλες συστηματικές διαφορές που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη συσχέτιση.

Μετά εξετάζω **τα ίδια τα αποτελέσματα**: το μέγεθος επίδρασης, τα διαστήματα εμπιστοσύνης και άρα την ακρίβεια της εκτίμησης, καθώς και το απόλυτο και το σχετικό αποτέλεσμα. Όπου έχει νόημα, οι δείκτες NNT και NNH βοηθούν να μεταφραστεί το εύρημα σε κλινικούς όρους. Μια μικρή τιμή p δεν μου λέει αν το όφελος είναι αρκετά μεγάλο ώστε να έχει κλινική σημασία.

Οι βασικοί υπολογισμοί είναι απλοί. **ARR = ποσοστό συμβάντων στην ομάδα ελέγχου – ποσοστό συμβάντων στην πειραματική ομάδα**. **NNT = 1/ARR**, όταν το ARR εκφράζεται ως αναλογία. Αντίστοιχα, το NNH προκύπτει από την απόλυτη αύξηση του κινδύνου βλάβης. Για διαγνωστικές δοκιμασίες: **LR+ = ευαισθησία / (1 – ειδικότητα)** και **LR– = (1 – ευαισθησία) / ειδικότητα**. Οι τύποι αυτοί έχουν νόημα μόνο μαζί με τα διαστήματα εμπιστοσύνης, τον αρχικό κίνδυνο και το κλινικό πλαίσιο.

Η θετική και η αρνητική προγνωστική αξία εξαρτώνται έντονα από τον επιπολασμό ή την προ της δοκιμασίας πιθανότητα. Επομένως, ένας δεδομένος συνδυασμός ευαισθησίας και ειδικότητας δεν συνεπάγεται την ίδια PPV σε κάθε πλαίσιο.

Στη συνέχεια σταθμίζω οφέλη, βλάβες, επιβάρυνση και εφικτότητα. Εξετάζω τις ανεπιθύμητες ενέργειες, το θεραπευτικό βάρος και αν πολλαπλές εκβάσεις ή επαναλαμβανόμενες αναλύσεις αυξάνουν την πιθανότητα τυχαίων ευρημάτων. Ελέγχω επίσης την εξωτερική εγκυρότητα: κατά πόσο ο πληθυσμός, το πλαίσιο και η παρέμβαση μοιάζουν αρκετά με τους δικούς μου ασθενείς και την υπηρεσία μου ώστε τα αποτελέσματα να είναι γενικεύσιμα.

Η επιλεκτική αναφορά αποτελεί επίσης κρίσιμο ζήτημα. Εξετάζω αν η μελέτη ή το πρωτόκολλο είχε καταχωριστεί προοπτικά, αν οι εκβάσεις και οι αναλύσεις είχαν προκαθοριστεί και αν η δημοσίευση συμφωνεί με αυτά. Συνεκτιμώ επίσης χρηματοδότηση και συγκρούσεις συμφερόντων, επειδή μπορούν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό, την ανάλυση ή την ερμηνεία.

Τέλος, εντάσσω τη μελέτη στο σύνολο των διαθέσιμων τεκμηρίων. Μία θετική μελέτη θα πρέπει να αλλάξει την πρακτική μόνο όταν το αποτέλεσμα είναι κλινικά ουσιαστικό, επαρκώς ακριβές, εφαρμόσιμο και ασφαλές, και συμφωνεί αρκετά με την ευρύτερη τεκμηρίωση. Όσο μεγαλύτερη αλλαγή πρακτικής συνεπάγεται ένας ισχυρισμός, τόσο ισχυρότερη πρέπει να είναι η συνολική αποδεικτική βάση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **ARR = ποσοστό συμβάντων στην ομάδα ελέγχου – ποσοστό συμβάντων στην πειραματική ομάδα.**
- **NNT = $1/ARR$** · το NNT βασίζεται στην αντίστοιχη απόλυτη αύξηση βλάβης.
- **LR+ = ευαισθησία / (1 – ειδικότητα).**
- **LR- = (1 – ευαισθησία) / ειδικότητα.**
- Οι προγνωστικές αξίες εξαρτώνται από την προ της δοκιμασίας πιθανότητα/τον επιπολασμό.
- Τα διαστήματα εμπιστοσύνης αποτυπώνουν την ακρίβεια της εκτίμησης.
- Η προοπτική καταχώριση και η συμφωνία με το πρωτόκολλο βοηθούν στην ανίχνευση επιλεκτικής αναφοράς εκβάσεων ή αναλύσεων.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Θεώρηση του **p < 0,05** ως απόδειξης κλινικά σημαντικού αποτελέσματος.
- Παράβλεψη του απόλυτου μεγέθους επίδρασης και της ακρίβειας.
- Αναφορά NNT χωρίς τον αρχικό κίνδυνο ή τον χρονικό ορίζοντα όταν αυτά αλλάζουν ουσιαστικά την ερμηνεία.
- Θεώρηση μιας δεδομένης ευαισθησίας/ειδικότητας ως πηγής μίας καθολικής PPV.
- Παράβλεψη βλαβών, εξωτερικής εγκυρότητας, προεγγραφής ή επιλεκτικής αναφοράς.
- Αλλαγή πρακτικής από ένα μεμονωμένο αποτέλεσμα χωρίς συνεκτίμηση του συνολικού σώματος τεκμηρίωσης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ψυχιάτρου ως προς το ιατρικό απόρρητο στην Ελλάδα;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 N. 3418/2005, Άρθρο 13
- 2 Αυστηρή υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου
- 3 Συναίνεση ή επαρκής νόμιμη βάση για αποκάλυψη
- 4 Οι συγγενείς δεν έχουν αυτόματο δικαίωμα πρόσβασης
- 5 Κοινοποίηση μόνο όσων είναι αναγκαία για τη θεραπεία
- 6 Αναγκαιότητα, αναλογικότητα και ελαχιστοποίηση δεδομένων
- 7 Τεκμηρίωση του σκεπτικού

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην Ελλάδα, αφετηρία είναι ο Ν. 3418/2005, Άρθρο 13 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Ο ψυχίατρος έχει αυστηρή υποχρέωση τήρησης του απορρήτου για όσα πληροφορείται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του σχετικά με τον ασθενή και τους οικείους του, είτε οι πληροφορίες προέρχονται από τον ίδιο είτε από τρίτους. Η υποχρέωση αυτή συνεχίζεται και μετά τη λήξη της θεραπείας, τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος ή τον θάνατο του ασθενούς.

Ο ψυχίατρος οφείλει να προστατεύει το απόρρητο και στην πράξη: να εποπτεύει συνεργάτες και βοηθητικό προσωπικό και να διασφαλίζει την ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών. Η πρόσβαση και η κοινοποίηση ψυχιατρικών δεδομένων πρέπει να υπηρετούν συγκεκριμένο κλινικό σκοπό και όχι την περιέργεια ή την ευκολία.

Η σαφέστερη βάση για αποκάλυψη πληροφοριών είναι η **έγκυρη συναίνεση του ασθενούς**. Χωρίς συναίνεση, απαιτείται άλλη επαρκής νόμιμη βάση. Το ίδιο το Άρθρο 13 επιτρέπει αποκάλυψη όταν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση, όταν δικαιολογημένο υπέρτερο δημόσιο συμφέρον ή συμφέρον τρίτου δεν μπορεί να προστατευθεί διαφορετικά, και σε περιστάσεις που εμπίπτουν στις αρχές της κατάστασης ανάγκης ή της άμυνας. Το **Άρθρο 25 του Ποινικού Κώδικα** είναι η σχετική διάταξη περί κατάστασης ανάγκης που μπορεί να αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης· το Άρθρο 32 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια βάση για άρση του απορρήτου. Εφόσον το επαγγελματικό απόρρητο προστατεύεται ποινικά και από το **Άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα**, κάθε αποκάλυψη πρέπει να έχει σαφή νομική και κλινική αιτιολόγηση.

Συχνό πρακτικό λάθος αφορά τους συγγενείς. **Τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν αυτόματο δικαίωμα πρόσβασης στις εμπιστευτικές ψυχιατρικές πληροφορίες ενός ικανού ενήλικα.** Μπορούν να δώσουν χρήσιμες ετεροαναφορικές πληροφορίες στην ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα έχει δικαίωμα να τους αποκαλύψει αντίστοιχα πληροφορίες του ασθενούς. Το απόρρητο συνεχίζεται και μετά τον θάνατο, παρότι μπορεί να υπάρχουν ιδιαίτερα εκ του νόμου δικαιώματα πρόσβασης στον φάκελο για κληρονόμους.

Μέσα στη νόμιμη θεραπευτική ομάδα, οι αναγκαίες πληροφορίες μπορούν να

κοινοποιούνται μόνο στον βαθμό που χρειάζονται για τη φροντίδα και για συγκεκριμένο θεραπευτικό σκοπό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επαγγελματίας ή υπηρεσία χρειάζεται ολόκληρο τον ψυχιατρικό φάκελο. Η ίδια αρχή ισχύει και για δικαιολογημένη αποκάλυψη εκτός της άμεσης θεραπευτικής ομάδας: δίνω μόνο τις απολύτως αναγκαίες πληροφορίες, στον κατάλληλο αποδέκτη, για τον συγκεκριμένο προστατευτικό ή νομικό σκοπό.

Τα δεδομένα υγείας αποτελούν επίσης ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα. Ο GDPR και ο Ν. 4624/2019 ρυθμίζουν τη νόμιμη επεξεργασία και την ασφάλειά τους, χωρίς να υποκαθιστούν το ουσιαστικό ιατρικό καθήκον εχεμύθειας. Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιατρικό απόρρητο λειτουργούν παράλληλα.

Όταν εξετάζω αποκάλυψη χωρίς συναίνεση, ρωτώ: ποιος είναι ο κίνδυνος ή η νομική υποχρέωση; Μπορεί ο σκοπός να επιτευχθεί χωρίς αποκάλυψη; Ποιος χρειάζεται πραγματικά την πληροφορία; Ποια είναι η ελάχιστη αναγκαία πληροφορία; Και καταγράφω προσεκτικά το σκεπτικό μου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ο Ν. 3418/2005, Άρθρο 13 είναι το βασικό ελληνικό θεμέλιο του ιατρικού απορρήτου.
- Το Άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα προστατεύει το επαγγελματικό απόρρητο· το Άρθρο 25 παρέχει, όπου συντρέχει, τη σχετική αρχή της κατάστασης ανάγκης.
- Τα δεδομένα υγείας διέπονται επίσης από τον GDPR και τον Ν. 4624/2019.
- Οι συγγενείς δεν έχουν αυτόματο δικαίωμα σε εμπιστευτικές πληροφορίες ικανού ενήλικα.
- Η αποκάλυψη χωρίς συναίνεση πρέπει να είναι αναγκαία, αναλογική και περιορισμένη στο ελάχιστο αναγκαίο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι κάνετε αν ένας ασθενής διατυπώνει αξιόπιστη και άμεσα επικείμενη απειλή βίας κατά αναγνωρίσιμου προσώπου;

Πρώτα αξιολογώ κλινικά την απειλή: στόχο, συγκεκριμενοποίηση, πρόθεση, σχεδιασμό, πρόσβαση σε μέσα, αμεσότητα, προηγούμενη βία, μέθη ή ψύχωση, κλιμάκωση και προστατευτικούς παράγοντες. Παράλληλα μειώνω, όπου είναι δυνατό, την πρόσβαση σε ευκαιρίες βίας, εντατικοποιώ τη θεραπεία και την υποστήριξη και τεκμηριώνω τη διατύπωση του κινδύνου και τις ενέργειές μου.

Δεν θα δίδασκα ότι το ελληνικό δίκαιο περιέχει γενική υποχρέωση προειδοποίησης τύπου Tarasoff. Το Άρθρο 13 επιτρέπει αναλογική προστατευτική αποκάλυψη όταν πληρούνται οι εξαιρέσεις του απορρήτου και η λογική της κατάστασης ανάγκης. Επιπλέον, το Άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ειδική υποχρέωση αναφοράς στις αρχές όταν κάποιος πληροφορείται αξιόπιστα σχεδιαζόμενο ή εξελισσόμενο κακούργημα ενώ μπορεί ακόμη να αποτραπεί, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης.

Δεν υπάρχει ένας καθολικός κανόνας που να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση άμεση προειδοποίηση του απειλούμενου προσώπου αντί αναφοράς στις αρχές ή άλλης

προστατευτικής αποκάλυψης. Η ασφαλής απάντηση είναι να ενεργώ αναλογικά με τη σοβαρότητα και την αμεσότητα, να χρησιμοποιώ το ισχύον πλαίσιο του Άρθρου 13/κατάστασης ανάγκης και του Άρθρου 232, να κοινοποιώ μόνο ό,τι χρειάζεται στον κατάλληλο αποδέκτη και να τεκμηριώνω το σκεπτικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Πώς πρέπει να χειρίζεται ο ψυχίατρος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Το απόρρητο ισχύει στο διαδίκτυο όπως ακριβώς και εκτός διαδικτύου. Αναγνωρίσιμο υλικό ασθενών δεν δημοσιεύεται χωρίς κατάλληλη νόμιμη βάση και συναίνεση. Τα επαγγελματικά όρια επίσης πρέπει να προστατεύονται: ιδιωτικές αλληλεπιδράσεις, διπλοί ρόλοι και αιτήματα φιλίας ή ακολούθησης από ασθενείς αντιμετωπίζονται μέσα σε σαφές επαγγελματικό πλαίσιο.

Η αναζήτηση πληροφοριών για ασθενείς στο διαδίκτυο από απλή περιέργεια δεν αποτελεί ορθή κλινική πρακτική. Ο διαχωρισμός προσωπικών και επαγγελματικών λογαριασμών μπορεί να μειώσει προβλήματα ορίων, αλλά δεν καταργεί τις υποχρεώσεις απορρήτου. Δεν χρειάζεται να επινοηθεί ειδικός ελληνικός νόμος για τα social media προκειμένου να ισχύσουν αυτές οι συνήθεις αρχές απορρήτου και ορίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι ισχύει για την υποχρεωτική αναφορά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ανηλίκων;

Η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις αναφοράς και όχι έναν ενιαίο αδιαφοροποίητο κανόνα για κάθε μορφή κακοποίησης ανηλίκου. Κατά το Άρθρο 23 του Ν. 3500/2006, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 5090/2024 και 5172/2025, οι ιατροί και άλλοι οριζόμενοι επαγγελματίες έχουν άμεση υποχρέωση αναφοράς ενδείξεων αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ανηλίκων, με πρόσθετες ειδικές προβλέψεις για αντικειμενικά ευρήματα σε ενήλικες. Στις εξετάσεις αναφέρω ακριβώς αυτό και δεν επεκτείνω τη διάταξη πέρα από το πεδίο εφαρμογής της.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Να θεωρείται ότι οι συγγενείς έχουν αυτόματα πρόσβαση στις ψυχιατρικές πληροφορίες ικανού ενήλικα.
- Να παρουσιάζεται το **Tarasoff** ως ελληνικό δίκαιο.
- Να χρησιμοποιείται το Άρθρο 32 ΠΚ ως κύρια βάση της αναγκαιότητας για άρση απορρήτου.
- Να κοινοποιούνται περισσότερες πληροφορίες από όσες απαιτεί ο προστατευτικός ή νομικός σκοπός.
- Να γενικεύεται η ειδική διάταξη περί ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε πιθανό σενάριο παιδικής προστασίας χωρίς έλεγχο της εφαρμοστέας διάταξης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Μια γενική απάντηση βασισμένη στο common law ή στο βρετανικό πλαίσιο δεν

επαρκεί για την Ελλάδα. Η προφορική απάντηση πρέπει να ξεκινά από τον Ν. 3418/2005, Άρθρο 13 και στη συνέχεια να εξηγεί τη συναίνεση, τις νόμιμες εξαιρέσεις, την αναλογική αποκάλυψη, το Άρθρο 371 για το επαγγελματικό απόρρητο και, όπου αφορά απειλούμενη βία, την υποχρέωση αναφοράς του Άρθρου 232.

Πώς προσεγγίζει το ελληνικό δίκαιο τον ποινικό καταλογισμό και πώς διαφέρει αυτό από την κλινική ψυχιατρική εκτίμηση;

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Ποινικός Κώδικας, Άρθρα 34 και 36
- 2 Εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης κατά τον χρόνο της πράξης
- 3 Ικανότητα αντίληψης του αδίκου ή δράσης σύμφωνα με αυτήν
- 4 Η διάγνωση από μόνη της δεν επαρκεί
- 5 Αναδρομική ανασύνθεση από πολλαπλές πηγές
- 6 Συνεκτίμηση ουσιών και προσποίησης
- 7 Διάκριση από ικανότητα λήψης αποφάσεων, κίνδυνο και ικανότητα συμμετοχής στη διαδικασία

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην Ελλάδα, ο ποινικός καταλογισμός όταν υπάρχει ψυχική διαταραχή ρυθμίζεται κυρίως από τα **Άρθρα 34 και 36 του Ποινικού Κώδικα**. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αναδρομικό και συνδέεται με τη συγκεκριμένη πράξη: εξαιτίας ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης της συνείδησης, μπορούσε το άτομο κατά τον χρόνο της πράξης να αντιληφθεί το άδικο της και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή την αντίληψη; Μια ψυχιατρική διάγνωση από μόνη της δεν απαντά στο νομικό αυτό ερώτημα.

Το **Άρθρο 34** αφορά την κατάργηση της σχετικής ικανότητας. Η έκπτωση μπορεί να αφορά είτε την ικανότητα αντίληψης του αδίκου είτε την ικανότητα δράσης σύμφωνα με αυτή την αντίληψη. Επομένως, η εκτίμηση πρέπει να συνδέει την ψυχική κατάσταση με τη συγκεκριμένη πράξη και με τις λειτουργικές ικανότητες του προσώπου εκείνη τη χρονική στιγμή, όχι απλώς να απαριθμεί διαγνώσεις ή συμπτώματα.

Το **Άρθρο 36** αφορά ουσιωδώς μειωμένη, και όχι καταργημένη, ικανότητα και συνδέεται με μειωμένη ποινή. Η διάκριση, λοιπόν, δεν είναι ανάμεσα σε «ψυχιατρική νόσο» και «απουσία νόσου», αλλά στον βαθμό στον οποίο η σχετική διαταραχή επηρέασε τις νομικά κρίσιμες ικανότητες κατά τον χρόνο της πράξης.

Η δικαστικοψυχιατρική εκτίμηση είναι κατ' ανάγκην **αναδρομική**. Ανασυνθέτω την ψυχική κατάσταση στον κρίσιμο χρόνο από τη συνέντευξη, ετεροαναφορικές πληροφορίες, ιατρικούς και ψυχιατρικούς φακέλους, μαρτυρικές καταθέσεις όπου υπάρχουν και τη συμπεριφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Εξετάζω τη χρονική σχέση των συμπτωμάτων με την πράξη, αν η συμπεριφορά ήταν οργανωμένη ή αποδιοργανωμένη και αν υπάρχουν στοιχεία ότι το άτομο αντιλαμβανόταν τις συνέπειες ή επιχείρησε να σχεδιάσει, να αποκρύψει ή να αντιδράσει στην πράξη. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι στοιχεία που ερμηνεύονται στο σύνολο του πλαισίου και όχι αυτόματα νομικά κριτήρια.

Η χρήση ουσιών και η πιθανή **προσποίηση** πρέπει επίσης να εξετάζονται όπου είναι σχετικές, χωρίς να προϋποτίθενται από τη διάγνωση ή την κατηγορία. Η

τελική ψυχιατρική γνώμη οφείλει να διακρίνει τα παρατηρούμενα ή ανασυσταθέντα ψυχιατρικά φαινόμενα από την τελική νομική κρίση.

Ο ποινικός καταλογισμός πρέπει ακόμη να διακρίνεται από άλλα ψυχιατρικά ερωτήματα. Δεν είναι το ίδιο με την **τρέχουσα διάγνωση**, την τρέχουσα ικανότητα λήψης αποφάσεων, την τρέχουσα επικινδυνότητα ή την ικανότητα συμμετοχής στη δικαστική διαδικασία. Ένα άτομο μπορεί σήμερα να έχει σοβαρή ψυχική διαταραχή και παρ' όλα αυτά να είχε ποινικό καταλογισμό κατά τον χρόνο προγενέστερης πράξης, ή το αντίστροφο.

Εξίσου σημαντικό είναι τι ακολουθεί μετά από κρίση σχετική με το Άρθρο 34. **Η εφαρμογή του Άρθρου 34 δεν συνεπάγεται αυτομάτως εγκλεισμό ή νοσηλεία κατ' Άρθρο 69.** Οποιοδήποτε επακόλουθο μέτρο ασφαλείας αποτελεί ξεχωριστή δικαστική απόφαση με δικά του νομοθετικά κριτήρια. Δεν πρέπει, επομένως, να συγχέονται η διάγνωση, η έλλειψη καταλογισμού και η ανάγκη μεταγενέστερου μέτρου ασφαλείας.

Η σύντομη απάντηση στις εξετάσεις είναι: χρησιμοποιώ τα Άρθρα 34 και 36, ανασυνθέτω την ψυχική κατάσταση κατά τον χρόνο της πράξης, εκτιμώ πώς τυχόν σχετική διαταραχή επηρέασε την αντίληψη του αδίκου και την ικανότητα δράσης σύμφωνα με αυτήν, και δεν συνάγω ποτέ τον καταλογισμό ή τα μεταγενέστερα αναγκαστικά μέτρα απευθείας από τη διάγνωση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- **Άρθρο 34:** η σχετική διαταραχή μπορεί να καταργεί είτε την ικανότητα αντίληψης του αδίκου είτε την ικανότητα δράσης σύμφωνα με αυτή την αντίληψη.
- **Άρθρο 36:** ουσιωδώς μειωμένη, και όχι καταργημένη, ικανότητα συνδέεται με μειωμένη ποινή.
- Η εκτίμηση είναι **αναδρομική και ειδική για τη συγκεκριμένη πράξη.**
- Η διάγνωση από μόνη της **δεν καθορίζει** τον ποινικό καταλογισμό.
- Η εφαρμογή του Άρθρου 34 **δεν ενεργοποιεί αυτόματα το Άρθρο 69·** τυχόν μέτρο ασφαλείας απαιτεί ξεχωριστή δικαστική απόφαση βάσει των δικών του κριτηρίων.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Παρουσίαση του M'Naghten ή άλλου βρετανικού κριτηρίου ως ελληνικού δικαίου.
- Ταύτιση της ψύχωσης ή άλλης διάγνωσης με έλλειψη ποινικού καταλογισμού.
- Εκτίμηση μόνο της σημερινής ψυχικής κατάστασης αντί ανασύνθεσης της κατάστασης κατά τον χρόνο της πράξης.
- Θεώρηση των Άρθρων 34 και 69 ως αυτόματης ενιαίας αλληλουχίας.
- Σύγχυση ποινικού καταλογισμού με τρέχουσα ικανότητα λήψης αποφάσεων, κίνδυνο ή ικανότητα συμμετοχής στη δικαστική διαδικασία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ο ποινικός καταλογισμός στην Ελλάδα πρέπει να απαντάται με βάση τα **Άρθρα 34 και 36 του Ποινικού Κώδικα**. Τα κριτήρια M'Naghten ή άλλες βρετανικές διατυπώσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως ελληνικό δίκαιο, και κρίση βάσει

του Άρθρου 34 δεν πρέπει να περιγράφεται ως αυτόματα συνεπαγόμενη δικαστικοψυχιατρική νοσηλεία.

Ποιες είναι οι αρχές της κοινοτικής φροντίδας για ενήλικες με σοβαρή ψυχική νόσο;

ΑΞΙΟΝΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

- 1 Διεπιστημονική κοινοτική φροντίδα
- 2 Συνέχεια της φροντίδας και συντονισμός της περίπτωσης
- 3 Αντιμετώπιση κρίσεων και έγκαιρη παρέμβαση
- 4 Αποκατάσταση, στέγαση και απασχόληση
- 5 Οικογένεια, σωματική υγεία και χρήση ουσιών
- 6 Ανάρρωση, κοινωνική ένταξη και ελάχιστος αναγκαίος περιορισμός
- 7 Σύγχρονη αρχιτεκτονική του ελληνικού δικτύου

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κοινοτική ψυχιατρική επιδιώκει **συνεχή, συντονισμένη και διεπιστημονική φροντίδα όσο γίνεται πιο κοντά στην καθημερινή ζωή του ασθενούς**, με το λιγότερο περιοριστικό επίπεδο παρέμβασης που είναι συμβατό με την ασφάλεια και τις ανάγκες του. Για τους ενήλικες με σοβαρή ψυχική νόσο, ο στόχος δεν είναι μόνο ο έλεγχος των συμπτωμάτων αλλά και η πρόληψη υποτροπών, η αποκατάσταση, η σωματική υγεία, η κοινωνική ένταξη και η ανάρρωση.

Πρώτη αρχή είναι η **συνέχεια της φροντίδας**. Οι ασθενείς με σοβαρή και υποτροπιάζουσα νόσο συχνά μετακινούνται μεταξύ υπηρεσιών οξείας νοσηλείας, εξωτερικής παρακολούθησης, πρωτοβάθμιας φροντίδας και κοινωνικών υπηρεσιών. Χρειάζονται, επομένως, σαφής συντονισμός και κατανομή ευθύνης στις μεταβάσεις. Η λειτουργία της διαχείρισης περίπτωσης έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι ανάγκες είναι σύνθετες και εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες.

Δεύτερη αρχή είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης της επιδείνωσης **πριν η νοσηλεία γίνει η μόνη επιλογή**. Η κοινοτική παρέμβαση σε κρίση και η κατ' οίκον θεραπεία αξιοποιούνται όπου είναι εφικτές και ασφαλείς, ενώ οι υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης στοχεύουν στη γρήγορη σύνδεση με τη φροντίδα και στη μείωση αποτρέψιμης καθυστέρησης στη θεραπεία. Η νοσηλεία παραμένει αναγκαία όταν η κοινότητα δεν μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες του ασθενούς, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί το οργανωτικό κέντρο της μακροχρόνιας φροντίδας.

Η κοινοτική θεραπεία πρέπει επίσης να αφορά **τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας**. Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, η υποστηριζόμενη στέγαση και η υποστηριζόμενη απασχόληση βοηθούν τον ασθενή να διατηρήσει ή να ανακτήσει συνήθεις κοινωνικούς ρόλους. Ο προσανατολισμός στην ανάρρωση σημαίνει ότι δουλεύουμε με τους στόχους, τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις του ίδιου του ασθενούς και δεν ορίζουμε την επιτυχία αποκλειστικά ως μείωση συμπτωμάτων.

Η συνεργασία με την οικογένεια ή τους φροντιστές είναι σημαντική όπου είναι κατάλληλη, όπως και η **φροντίδα της σωματικής υγείας και η αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών**. Η σοβαρή ψυχική νόσος δεν πρέπει να οδηγεί σε κατακερματισμένη φροντίδα όπου αντιμετωπίζονται μόνο τα ψυχιατρικά

συμπτώματα και παραμελούνται καρδιαγγειακές, μεταβολικές, σχετιζόμενες με ουσίες ή άλλες ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο συντονισμός με την πρωτοβάθμια φροντίδα και τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι, συνεπώς, βασικό στοιχείο του μοντέλου.

Η ευρύτερη φιλοσοφία των υπηρεσιών πρέπει να στηρίζεται στη λιγότερο περιοριστική δυνατή φροντίδα, την κοινωνική ένταξη και την πρόληψη υποτροπών. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση πρώιμων προειδοποιητικών σημείων, τη διατήρηση της θεραπευτικής σύνδεσης και την πρόσβαση σε πρακτική υποστήριξη πριν η κρίση γίνει σοβαρή.

Στην Ελλάδα, η ανώτερη οργανωτική αρχιτεκτονική έχει αλλάξει. Ο Ν. 5129/2024 θέσπισε το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), το οποίο διαρθρώνεται σε επτά Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), αντίστοιχα προς τις Υ.Πε., και άρχισε επίσημα να λειτουργεί το 2025. Οι γενικές κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας ενηλίκων πρέπει να αναφέρονται ως Κέντρα Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ). Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα στο ευρύτερο δίκτυο. Δεν θα ισχυριζόμαστε ότι κάθε παλαιότερη αναφορά σε ΤοΨΥ έχει εξαφανιστεί από όλα τα τοπικά ή κανονιστικά συμφραζόμενα.

Η προφορική απάντηση, επομένως, πρέπει να συνδυάζει τις καθολικές αρχές — συνέχεια, διεπιστημονική φροντίδα, ανταπόκριση σε κρίση, αποκατάσταση, ανάρρωση, κοινωνική ένταξη και ολοκλήρωση της φροντίδας — με τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική υπηρεσιών, αντί να αναπαράγει αποκλειστικά ένα παλιό τομεακό ή εισαγόμενο βρετανικό μοντέλο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Ο Ν. 5129/2024 θέσπισε το Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ., με επτά Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.: το δίκτυο άρχισε επίσημα να λειτουργεί το 2025.
- Ο σύγχρονος γενικός όρος για τις κοινοτικές δομές ενηλίκων είναι Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) και όχι ΚοΚεΨΥ ως γενική ονομασία υπηρεσίας ενηλίκων.
- Βασικές αρχές: συνέχεια, διεπιστημονική φροντίδα, αντιμετώπιση κρίσεων/κατ'οίκον θεραπεία όπου είναι εφικτή, αποκατάσταση, ανάρρωση, υποστηριζόμενη στέγαση/απασχόληση, οικογενειακή παρέμβαση, σωματική υγεία και φροντίδα για χρήση ουσιών.
- Η νέα αρχιτεκτονική δεν σημαίνει ότι κάθε ιστορικός όρος ΤοΨΥ έχει εξαφανιστεί από κάθε τοπική ή κανονιστική χρήση.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Τι είναι το Individual Placement and Support;

Το Individual Placement and Support (IPS) είναι τεκμηριωμένο μοντέλο υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με σοβαρή ψυχική νόσο. Στόχος του είναι η ανταγωνιστική απασχόληση με βάση τις προτιμήσεις του ατόμου, με την εργασιακή υποστήριξη ενσωματωμένη στη φροντίδα ψυχικής υγείας, αντί να απαιτείται παρατεταμένη προεπαγγελματική εκπαίδευση πριν επιχειρηθεί εργασία. Στις εξετάσεις, το βασικό σημείο είναι ότι η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελεί μέρος της ψυχιατρικής θεραπείας και όχι προαιρετικό κοινωνικό συμπλήρωμα.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ / ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

- Περιορισμός της κοινοτικής ψυχιατρικής σε εξωτερική συνταγογράφηση.
- Παράθεση αποκλειστικά ενός εισαγόμενου βρετανικού χάρτη υπηρεσιών CMHT/AOT/CRHT.
- Χρήση του όρου ΚοΚεΨΥ για κάθε γενική κοινοτική υπηρεσία ενηλίκων στην Ελλάδα.
- Αντιμετώπιση αποκατάστασης, στέγασης, απασχόλησης, σωματικής υγείας ή φροντίδας για χρήση ουσιών ως περιφερειακών θεμάτων.
- Ισχυρισμός ότι όλη η παλαιότερη ορολογία ΤοΨΥ έχει εξαφανιστεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VS ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Παλαιότερες απαντήσεις μπορεί να οργανώνονται γύρω από την ιστορική τομεακή ορολογία ή βρετανικά μοντέλα υπηρεσιών. Η σύγχρονη ελληνική απάντηση πρέπει να διατηρεί τις καθολικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και ταυτόχρονα να αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική **Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.** → **επτά Π.ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.** και τον συνεχιζόμενο ρόλο των **ΚΨΥ**, των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών.